한눈에 쏙!

건강하고 행복한 학교 만들기를 위한

2026 건강관리업무

충청남도교육청
CHUNGCHEONGNAMDO OFFICE OF EDUCATION



건강하고 행복한 학교 만들기를 위한
2026 건강관리업무

※ 제목 클릭 시 해당 쪽으로 이동함

I 보건실 운영

1. 2026 학교 보건실 관리계획 ·····
2. 보건실 관리 ····· 9
3. 보건교사 2인 배치 운영 모델 ····· 1·
4. 4세대 지능형 나이스(NEIS) 기초자료 구성 ····· 3··
※ 연간 월별 주요 업무 안내(예시) ····· 4·
※ 학교보건 연간 예산(예시) ····· 6·

II 보건교육

1. 2026 보건교육 내실화 계획 ····· 9 2
2. 2022 개정 교육과정의 이해(총론) ····· 4··
3. 2022 개정 보건교육과정의 이해 ····· 7·
4. 보건교육의 실제 ····· 65
5. 2026학년도 범교과 학습 주제 교육과정 반영 시수 ····· 9··

III 학생건강검사 추진·결과 관리

1. 2026년 학생 건강검사 추진·결과 관리계획 ····· 4··
2. 학생건강검사 ····· 37
3. 요보호학생 관리 ····· 89
4. 학생 건강기록부 관리 ····· 0
5. 학교 건강검사 표본학교 운영 ····· 71

IV 감염병 예방관리

1. 감염병 예방관리 ·····
2. 결핵예방관리 개요 ·····

CONTENTS

V 학교 내 응급상황 관리 및 건강취약학생 관리체계 강화

1. 2026 학교 내 응급상황 및 건강취약학생 관리체계 강화 ····· 36
2. 학교 응급상황 대응 ····· 46

VI 마약류·흡연·음주포함 약물 오남용 예방

1. 2026 마약류 및 흡연·음주 포함 약물 오·남용 예방 계획 ····· 40
2. 학생 마약류 포함 흡연·음주 약물 오·남용 관련 실태조사 서식 ····· 44

VII 건강증진

1. 2026 비만 예방 추진 계획 ····· 20
2. 2026 불균형 체형 예방 및 관리 지원 계획 ····· 42
3. 교육자료 안내 ····· 78
※ 척추옆굽음증 1차 검진 가정통신문(예시) ····· 91

VIII 부록

1. 행정사항 및 보고서식 ····· 2



‘한 눈에 쏙’
건강하고 행복한 학교 만들기를 위한
2026 건강관리업무

I

보건실 운영

Ⅰ 보건실 운영

※참고·서식 클릭 시 해당 쪽으로 이동함

단위업무	주요내용	참고·서식자료
계획	1. 보건실 운영 계획 수립 ▪ 보건실 시설 및 기구, 의약품, 소모품, 교구 등 현황 파악 ▪ 보건실 운영 예산 확인 ▪ 전년도 보건실 이용 현황 평가자료 확인 ▪ 보건교사 부재 시 업무대행자 지정 및 계획에 반영	• 2026 학교 보건실 관리 계획 (p.7) • 보건교사 2인 배치 운영 모델(p.21)
운영	1. 보건실 방문 학생 관리 ▪ 응급처치 및 통상 증상 처치 ▪ 건강상담 및 개별 보건교육: 상담결과는 나이스(NEIS)에 등록하여 활용 ▪ 안정 및 휴식: 1시간 요양 원칙이며 장기간 요양 필요할 경우 병원 진료 및 가정 요양하도록 보호자에 인계 ▪ 추후 관리: 안전사고, 학교폭력, 질병 등으로 응급처치를 받은 경우 담임교사와 협의 후 보호자에 연락(단, 상태가 위중하거나 아동학대 의심은 즉시 관리자에 보고) ▪ 보건교사 부재 시 환자 관리: 업무대행자 지정 및 안내 ▪ 보건실 이용 안내: 학년 초 학생, 교직원, 학부모에게 안내	• 보건실 방문 학생 관리 (p.9) • 4세대 지능형 나이스(NEIS) 기초자료 구성 (p.23)
	2. 보건실 의약품 관리 ▪ 의약품 사용 시 주의사항에 유의하여 투여 ▪ 의약품 유효기간 관리, 유효기한 지날 시 약품 적시 폐기 ▪ 사용분은 즉시 재고에서 보충하며 부족한 물건이 없도록 관리 ▪ 주요 물품, 약품보관장 등 특별한 관리를 요하는 경우 시건장치를 마련하여 관리 ▪ 보건교사(간호사 면허를 소지한 보조인력 포함)가 아닌 교직원은 보건실 내 일반의약품의 취급 불가(의약외품에 한하여 취급 가능)	• 보건실 의약품 관리 (p.12)
	3. 보건실 시설 및 기구 관리 ▪ 보건실 구조는 영역별로 처치 공간, 안정 공간, 업무 공간, 수납 공간, 상담 공간 등으로 구분 ▪ 보건실에 갖춰야 할 필수 기구 준수 ▪ 보건실 의료기구 적절한 멸균 및 소독방법에 의해 관리	• 보건실 시설 및 기구 관리 (p.15)
	4. 보건실 기록물 관리 ▪ 법정 장부: 학생건강기록부, 학생건강기록부 정정대장(보존기간 5년) ▪ 비법정 장부: 보건일지(보존기간 5년, 수기 또는 전산프로그램 결제) ▪ 기타: 건강상담일지, 응급후송관리대장, 감염병 관리대장 등	• 보건실 기록물 관리 (p.20)
	5. 학교 의사·약사 위촉 ▪ 학교에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 학생과 교직원의 건강관리를 지원하는 「의료법」 제2조제1항에 따른 의료인과 「약사법」 제2조제2호에 따른 약사를 둘 수 있음	
평가	1. 평가 및 차기년도 계획에 반영 ▪ 연간 보건실 이용 현황을 평가하여 차기년도 학교 내 안전사고 발생원인 파악 및 보건교육 자료로 활용	
	2. 보고	[서식10] 보건실 설치현황

	▪ 보건실 설치 현황 보고(4.3.(금))	

1 2026학교 보건실 관리 계획

가 관련근거

- 학교보건법 제3조(보건시설)
- 학교보건법 시행령 제2조(보건실의 설치기준)
- 학교보건법 시행규칙 제2조(보건실의 시설과 기구), 별표1
- 충청남도교육청 학교보건실 시설 및 기구에 관한 규칙(충청남도 교육규칙 제678호, 2018. 4 10.)

나 목 적

- 보건실 설치 및 관리를 위한 세부 기준 마련으로 학생 및 교직원의 건강보호·증진
- 감염병 위기 상황에서 감염병 예방 활동의 구심점 역할을 위한 쾌적한 보건실 환경 조성

다 기본방침

- 학생 및 교직원의 응급상황 발생 시 신속한 응급처치 대응
- 건강한 학교 만들기를 위한 업무 수행 장소로 활용

라 추진방향

1) 보건실의 기능

- 학생과 교직원의 건강을 관리하는 보건교육의 핵심 장소
- 건강상담실, 응급처치실, 안정실의 역할

2) 보건실 설치 기준

- 보건실 면적은 66㎡ 이상으로 하되, 학교 실정상 부득이한 경우 최소 교실 33㎡까지 완화 가능
- 위치는 학생들이 이용하기 편리하고 채광·통풍이 좋은 곳으로 응급처치 등이 신속하게 이루어질 수 있도록 교문에서 가까운 교사 전체의 중심부에 위치한 본관 1층 중앙 또는 중간층이나 교사로부터 가까운 별도의 건물에 위치
- 냉·난방, 수도, 컴퓨터, 전기시설의 설비를 반드시 설치하고, 충분한 조명시설 및 환기 시설과 적정한 온·습도 유지
- 학생들의 건강상담 및 응급처치에 불편함이 없도록 안락한 분위기 조성
- 보건실 운영에 필요한 시설 및 약품 구비

3) 보건실의 구조

- 처치공간, 안정공간, 업무처리 공간, 수납공간, 상담 공간 등으로 구분하되, 학교 실정에 맞게 구성
- 각 영역의 구분을 위해 칸막이를 설치하고 학생 관찰이 가능하도록 칸막이를 높지 않게 설치
- 안정공간은 남·여를 구분하고 건강상담을 비롯한 개인상담을 위한 공간 마련
- 면적 협소로 불가피할 시는 상담실과 처치실 겸용
- 보건교사의 업무처리를 위한 책상은 학생 관찰이 가능한 곳에 위치하되, 학생이 보건실 문을 열고 들어오면서 전신을 관찰할 수 있는 곳
- 주요 물품, 약품 보관장 등 특별한 관리를 요하는 경우 시건장치를 마련하여 관리

4) 학교 일반의약품 취급

– 보건실 구비 의약품에 대한 관리(보관방법, 유효기간, 복약요령 준수 등)을 철저히 하고 불필요한 의약품 투여·수여에 의한 오·남용 주의

<의약품 관리사항>

▲ 의약(외)품 사용 및 보관 기준 준수
– 의약품, 의약외품 등 분류하여 보관
– 의약(외)품 보관 용기 또는 첨부문서에 명기된 유효기간, 사용 방법, 보관 방법* 등을 준수
*온·습도 조절, 직사광선 차단, 냉장보관 등 의약품 효능이 떨어지지 않도록 보관 방법 주의
– 용기나 포장이 개봉된 상태의 의약품을 서로 섞어서 보관하지 아니할 것
▲ 의약품의 안전관리, 오·남용 방지를 위하여 보관·관리에 철저

– 보건교사(간호사 면허를 소지한 보조인력 포함)가 아닌 교직원은 보건실 내 일반의약품의 취급과 보건실 이외의 장소에 일반의약품함을 비치하는 것은 불가하나, 의약외품은 취급·비치 가능
*「약사법」 제2조제7호 가목 및 나목, 의약외품 범위 지정(식약처고시 제2020-48호)
– 다만, 보건교사의 출장 등 부재 시 학생 건강 및 학습권보호, 학부모 불편 최소화 등 지속적으로 제기되어 온 학교현장 어려움의 최소화를 위해, 필요한 학교에서는 학교장의 관리·감독 범위(학교보건계획, 의약품 보관장소, 취급 주의사항 등) 내에서 학부모 동의절차 등을 거쳐 제한적으로 취급가능

5) 보건실 환경개선 사업

– 보건실 시설·설비 권장 기준
– 처치공간, 안정공간, 업무처리 공간, 수납공간, 상담공간 등으로 구분
– 학교 보건실 노후시설을 개선하여 신속한 응급 처치가 가능하도록 보건실에 갖추어야 하는 기구 및 시설비 지원

※ 정수기, 청소기, PC, 프린터기 등 사무실 용품과 고가의 인바디 등 구입 자제

6) 기타사항

– 교실 부족 등의 이유로 보건실을 타 용도(특별실, 창고 등)로 사용 금지
– 보건실에서 갖추어야 하는 필수 기구 중 부족한 품목은 학교기본운영비로 확보

※ 2026학년도 학교회계 예산편성 기본지침(학교장 권장사업) 참조

2 보건실 관리

가 보건실 방문 학생 관리

구분	내용
보건실 이용 안내	• 매 학년 초에 학생, 교직원, 학부모를 대상으로 안내하며 가정통신문, 학교 홈페이지, 학부모 총회, 보건실 앞 안내 게시판, 교직원 연수 등을 활용한다.
응급처치 및 통상질환 처치	• 응급상황의 경우 신속하고 적절하게 대처할 수 있도록 「보건실에 갖추어야 하는 시설과 기구 및 용품의 기준」에 의거한 시설·기구를 구비한다. • 필요시 학교 인근 의료기관 및 가정과 긴밀하게 협조한다. • 통상질환자에 대한 처치 및 투약을 실시하고, 상병자에 대해서는 지속적인 추후관리를 한다.
안정 및 휴식	• 안정되고 쾌적한 분위기를 조성하여 아픈 학생이 최적의 안정을 취하여 빠른 회복으로 학습활동에 복귀할 수 있도록 돕는다. • 안정실은 남·여를 구분하고 관찰이 쉽게 하며, 학생이 요양 중일 때는 수시로 환자 상태를 확인한다. • 증상의 악화를 우려하여 안정실은 1시간 요양을 원칙으로 하며, 장시간 요양이 필요할 경우에는 병원 진료 및 가정 요양하도록 보호자에게 인계한다. 특히, 발열의 경우 감염병 예방을 위해 가급적 보호자에게 인계하고, 결과를 확인한다. • 안정실 이용이 출결사항과 관계될 경우 학년 초 사전 협의 후 교직원 연수 시 안내한다. • 안정실 이용 시에는 이용 사유를 파악하여 입실 지도하고, 출입 확인증 또는 내부 메신저 등을 사용하여 담임(교과)교사가 학생의 건강상태를 확인할 수 있도록 한다. – 출입 확인증은 출결사항의 질병 결과에 대한 증빙자료로 이용할 수 있을 뿐 아니라 학생 소재파악에 중요한 증빙자료이다.(무단 외출, 결과, 조퇴 예방) – 출입확인증은 수업 중 보건실 이용 학생에 대한 처치 확인으로 갈음할 수 있어 학생과 교사와의 소통자료로 이용할 수 있다. [보건실 출입 확인증(예시)]
건강상담 및 개별 보건교육	• 보건실 방문학생에 대한 건강상담으로 건강문제를 조기에 발견·조치하여 자기건강관리 능력을 배양한다. • 요보호학생 방문 시에는 건강상담기록이나 보건일지 요보호학생란 등에 주기적으로 기록하며, 일반 학생도 필요한 경우는 건강상담 기록을 작성하여 보관한다.

보건실 확인증

학년 반 번 이름:

일 시: 월 일 교시

위 학생은 해당 시간에 보건실에서 안정을 취하였음을 확인합니다.

보건교사_____(인)

담임교사_____(인)

보건실 입실 의뢰 및 확인서

학년 반 번 이름:

위 학생은 질병( ), 부상으로 인해

( )교시 보건실에서 침상안정을 요합니다.

★보건실 입실은 1시간만 가능합니다.

20 년 월 일

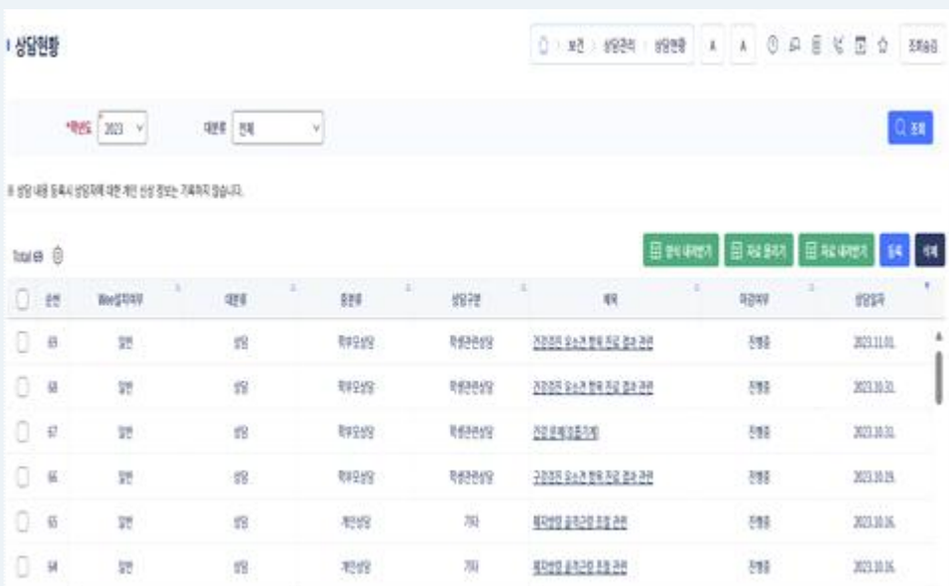
담임 교사: (인)

교과담당교사: (인)

( )교시 상기 학생 입실 확인

입실 시간(:)/퇴실 시간(:)

보건교사 (인)

구분	내용
	• 보호자 유선 연락(건강문제) 및 학생 건강상담을 한 후 나이스(NEIS)에 실적을 꾸준히 등록하여 추후 교사 다면평가 및 자기실적평가의 증거 자료로 활용할 수 있다. ※ 나이스(NEIS) 메뉴경로: [나이스(NEIS)-보건-상담관리- 상담현황](학교마다 다를 수 있음) [상담결과 나이스(NEIS) 등록 화면(예시)] 
추후 관리	• 연계가 필요한 경우 가정통신문(건강쪽지 등)이나 전화 상담을 활용한다. • 학생이 학교 안전사고, 학교폭력, 질병 등으로 보건실에서 응급처치를 받는 경우 담임교사와 협의하여 빠른 시간 내에 보호자에게 연락하도록 조치한다.(단, 상태가 위중하거나 아동학대 의심은 즉시 관리자에게 보고한다.) • 특별한 배려가 요구되는 학생은 명단을 작성하여 유의사항과 함께 교사들에게 공유하되 과잉 관심이나 개인정보 유출은 피하도록 한다.(문서 비밀번호 설정 등) • 모든 보건활동 후에는 기록을 남기고 각종 민원 대응 및 학교보건 사업평가나 계획 수립, 교육, 상담, 보고 시 활용할 수 있도록 기록 및 보관·관리를 철저히 한다. • 교직원 및 학부모와 상담을 할 경우 나이스(NEIS)에 등록하여 활용한다.
보건교사 부재 시 대책	• 학기 초에 수업, 응급환자 이송, 출장, 연가 등의 사유로 보건교사 부재 시 '업무대행자' 지정 등 관리 방안에 대하여 학교 자체계획을 수립하고, 학생 및 교직원에게 안내한다. • 응급상황에 대처할 수 있도록 상황별 응급처치 등에 대해 전체 교직원 연수를 실시한다. • 보건수업 중 응급환자 관리 - 부재 시 보건실 문 앞에 행선지 및 업무대행자 등의 안내문 부착, 수업 시간표 게시 등으로 긴급을 요하는 경우 연락이 용이하게 한다. - 보건 수업시 보건교사 부재로 인한 보건실의 공백 시간을 최소화하기 위해 해당 학급 담임교사(초등에 해당) 또는 대체 인력이 보건실에서 응급 연락 체계를 유지한다. ※ 보건교사 및 간호사면허를 소지한 보조인력 외 교직원은 보건실 내 의약품 취급 불가 → 의약외품*에 한하여 취급 가능(「약사법」 제2조제7호 가목 및 나목, 의약외품 범위 지정(식약처고시 제2020-48호) - 보건수업 시간은 교육과정 담당자와 협의하여 학생들의 보건실 이용률이 적은 시간대로 확보하여 응급환자 관리의 결손을 최소화한다.

[보건실 이용 안내(예시)]

보건실은 이렇게 이용해요.

♣ 보건실 이용 시간 – 08:30~16:30 (학교마다 상이)

♣ 보건실 이용 방법

1. 응급상황이 아니면 쉬는 시간이나 점심시간을 이용합니다.
2. 부축이 필요한 경우가 아니면 혼자서 옵니다.
3. 보건실에서 요양하고 있는 학생들을 위해 조용히 노크하고 들어옵니다.
4. 집에서 약을 먹고 온 경우에는 꼭 알려 줍니다.
5. 건강상의 문제가 있어 병원에 다니고 있거나, 약 알레르기나 부작용이 있다면 보건선생님께 꼭 알려줍니다.
6. 보건실 기구와 약품은 함부로 만지지 않으며, 안정실 사용 후 스스로 침구류 정리정돈을 합니다.

♣ 급한 응급처치가 필요하지 않은 경우 - 쉬는 시간, 점심시간을 이용합니다.

1. 아주 사소한 외상이나 전날 다친 상처의 재소독, 모기물림, 피부염 등
2. 전날부터 이어지는 근육통, 지속적이고 과도한 운동으로 인한 관절통
   (잠을 잘 못자서 목이 뻐근하다. 어제 운동을 해서 근육통이 있다. 등)
3. 기침, 인후통 등의 일반적인 감기증상
4. 구토, 설사를 동반하지 않는 단순 복통

♣ 급한 응급처치가 필요한 경우 - 즉시 보건실로 이동

1. 출혈을 동반한 심한 외상, 갑작스러운 코피
2. 체육시간, 스포츠 시간 등의 근골격계 부상
3. 고열을 동반한 호흡기 증상
4. 구토, 설사를 동반한 심한 복통

♣ 보건실 요양 절차

1. 보건실에서 침상안정을 원하는 학생은 보건실 입실 의뢰 및 확인서를 받은 후 요양을 할 수 있습니다.
2. 1일 1시간 이내에 한하여 이용할 수 있으며, 그 이상의 안정이 필요한 때에는 담임선생님 및 보호자와 상의 후 귀가하거나 병원에 방문하여 치료받도록 합니다.

♣ 보건선생님이 부재중인 경우

1. 보건선생님의 출장 등으로 자리에 계시지 않을 때에는 간단한 응급처치는 OOO과 OOO이 도와주십니다.
2. 응급상황인 경우에는 즉시 119 안전신고센터의 도움을 받도록 합니다.

※ 보건실 운영은 학교별 상황에 따라 달리 운영할 수 있습니다.

나 보건실 약품 및 소모품 관리

보건실 의약품 사용 근거

근거	내용
「학교보건법 시행령」 제23조 제4항 제3호	보건교사(간호사 면허를 가진 자)의 의료행위에 따른 의약품 투여
「약사법」 제23조 「약사법 시행령」 제23조 제5호	학교 보건실에서는 의약품 조제가 불가하며 일반의약품만 사용
「학교보건법」 제15조2	학교장은 사전에 학부모의 동의와 전문의약품을 처방한 의사의 자문을 받아 보건교사 또는 순회 보건교사로 하여금 제1형 당뇨로 인한 저혈당쇼크 또는 아나필락시스 쇼크로 인하여 생명이 위급한 학생에게 투약행위 등 응급처치를 제공할 수 있다.

보건실 의약품 사용 보관

- 학교 특성에 따라 연간계획을 세운 후 의약품을 구입하고 부족하지 않도록 관리한다.
- 약품 사용 시 주의사항을 유의하여 투여하고 학생들이 직접 약품을 다루는 일이 없도록 하며 약품을 보관하는 약장은 잠금장치를 한다.
- 약품은 해당 학생에게 보건교사가 직접 투여하고 복용을 확인하며, 다른 학생 편에 전달·복용하지 않도록 한다.
- 의약품과 의약품이 아닌 것은 구분하여 보관(냉장 보관 시 포함)하고 의약품을 보관하는 약장은 잠금장치를 한다.
- 의약품 저장방법에 기재된 내용에 적합하도록 보관하며 유효기간이 경과된 약품은 구입한 곳에서 교환하거나 폐기할 수 있다.
- 의약품 사용 과정에서 품질 손상 여부가 확인되고 문제가 발견된 경우 유효(사용)기간이 남아 있다 하더라도 즉시 폐기한다.
- 개봉한 의약품은 용기 및 포장에 개봉여부 및 일자를 표기하여 뚜껑을 닫은 상태로 보관하며, 미개봉 제품과 구별될 수 있도록 한다.
- 사용 빈도가 낮거나, 사용 규모가 작은 의약품은 소포장 단위 제품을 구입하여 사용하도록 노력한다.

의약품 유효기간 및 개봉 후 사용기한

소분류	개봉 후 사용가능기간	비고
병포장 (Bulk Packs)	원 약품에 용기에 표기된 유효기간 (약품에 따라 보관 조건 및 사용 가능 기간이 달라질 수 있으므로 반드시 제조사의 허가사항 확인이 필요함)	▸대부분의 가이드는 개봉 의약품에 대한 사용기간 재설정을 권장(원래 의약품의 사용기한 내에서 1년을 권고하고 있음) – WHO: 개봉 후 재설정 – NHS: 1년 – USP24–NF 19: 1년 – 일본 병원약제사회: 1년
Blister 포장, PTP 포장	원 약품 용기에 표기된 유효기간	▸포장이 제거된 경우 개봉된 약과 동일하게 관리
시럽(보존제 함유)	6개월	▸반드시 뚜껑을 닫아 보관
멸균 안약 및 안연고 (보존제 함유)	1개월	▸반드시 뚜껑을 닫아 보관
점이/점비제	1개월	
연고/크림	6개월	▸반드시 뚜껑을 닫아 보관
가글제	1개월	▸반드시 뚜껑을 닫아 보관
흡입제	약품 용기에 표기된 유효기간	
인슐린	28일	▸약품에 따라 보관방법이 상이하므로 반드시 제품설명서를 확인할 것

※출처: 의료기관 내 개봉 의약품 관리 지침(한국병원약사회 질향상위원회, 2019)

의약품 보관 일반 기준

1. 온도: 25℃ 이하의 서늘한 곳 (냉장보관이 필요한 약의 경우 2~8℃ 유지)
2. 습도: 건조한 상태 (보통 60% 이하를 말함)
3. 광선: 차광이 필요한 약은 빛 차단된 상태로 보관
4. 개봉 후 일정 기간 내 사용해야 하는 경우 개봉일과 사용가능 기간을 용기나 포장에 표시한다.
   ※의약품 보관 용기 또는 첨부 문서에 명기된 유효기간, 사용 가능 연령, 보관방법, 사용방법 등을 준수
5. 가급적 소아와 성인 사용 의약품 구분 관리

보건실 의약품 사용

1) 투약 전 확인 사항

– 환자의 전반적인 상태를 살핀다.
  ☑ 불편한 증상 중에서 가장 심한 증상이 무엇인지(모든 증상을 치유하기보다는 심한 증상 1~2개를 파악하여 소량의 약을 투여한다.)
  ☑ 약에 대한 부작용의 경험이 있는지
  ☑ 현재 증상 이외에 다른 질병이 있는지
  ☑ 요즘 복용하고 있는 약이 있는지
– 의약품 겉포장 표시정보나 포장 내 첨부문서를 확인한다.
  ☑ [약 이름] 사용하려는 약이 맞는지
  ☑ [효능·효과] 증상에 맞는 약인지
  ☑ [주의사항] 사용해도 되는 약인지
  ☑ [용량·용법] 얼마나, 언제, 어떻게 사용해야 하는 약인지

2) 투약 중 유의 사항

- 충분한 물과 함께 섭취하도록 한다.
- 투약 내용을 보건일지에 기록한다.
- 다치거나 아픈 학생에게 보건교사가 직접 투여하여 복용을 확인하며 다른 학생 편에 전달하여 복용시키는 일이 없도록 한다.
- 의약품 사용에 있어서는 응급처치를 주목적으로 하므로 과다한 사용은 줄인다.

3) 투약 후 지도 사항

- 투약 후 일정시간(약 20~30분 후)이 지나야 약의 효능이 나타남을 설명해준다.
- 알레르기 부작용 등이 나타날 수 있음을 설명하고 증상 발현 시 즉시 알리도록 한다.

※ 약물 알레르기 발생 시

- 병원으로 이송하고 보건일지에 기록한다.
- 사용 약물에 관하여 학생 및 학부모에게 알려주어 유사 성분의 약물에 재차 노출되지 않도록 지도한다.

※ 기타 호흡곤란 쇼크 발생 시 학교 내 응급이송관리체계에 따라 신속히 대처한다.

4) 대표 증상별 약의 부작용과 주의사항

의약품	부작용과 주의사항
진통제	위장을 자극시키므로 소화성궤양 환자는 복용을 금하며 비스테로이성 소염진통제에 의해 천식이나 병력이 있는 경우는 다른 소염진통제도 천식이 유발될 가능성이 있다. 또한 공복을 피하여 복용하고 매일 세잔 이상 술을 마시는 사람도 복용을 금해야 한다.
소화제와 위장약	자주 복용하는 것은 위를 자극하거나 위장기능을 저하시킬 수 있으며 변비나 설사를 유발할 수 있다. 위장약은 다른 약물의 흡수를 방해할 수 있으므로 복용간격이 필요하며, 이산화탄소가 함유되어있는 물약은 일시적 소화불량이 아닌 만성 소화불량 환자나 속쓰림 환자는 복용을 삼가야 한다.
감기약	다른 감기약이나 해열진통제 등과 같이 복용하는 것은 금해야 하며 종합감기약은 증상에 필요 없는 성분이 복합되어 있기 때문에 참고하여 사용한다.
파스류	광과민 반응이 일어날 수 있으므로 햇빛에 노출하는 것을 자제하고 파스의 성분 자체가 진통제이므로 진통제의 부작용과 접착제의 부작용을 감안해서 사용하여야 한다.

다 보건실 시설 및 기구 관리

보건실 위치

- 응급처치 및 환자이송이 신속히 이루어지도록 교사 전체의 중심부에 위치한 본관 1층 중앙 또는 중간층이나 교사로부터 가까운 별도의 건물에 배치한다.
- 옥내외 운동시설과의 연계 및 학생, 교직원들의 출입이 편리한 곳으로 한다.
- 출입문은 실내뿐 아니라 응급상황 시 구급차량의 접근이 용이하도록 별도의 실외 출입문 설치도 고려한다.
- 교무실(교직원 연락) 및 화장실과의 연계를 고려한다.
- 조용하고 일광, 채광, 통풍이 잘되는 남향으로 한다.

보건실 규모

- 보건실 면적은 66㎡ 이상으로 하되, 학교 실정상 부득이한 경우 최소 교실 33㎡까지 완화 가능하다.
- 보건실의 기능이나 역할의 강화, 이용자의 증가에 따라 그 규모를 확장할 수 있다.

보건실 구조

구분	내용
처치공간	• 드레싱카, 처치대, 처치용 의자를 비치한다. • 처치대는 학생의 키 높이를 고려하여 너무 높지 않게 한다. (높이: 550~650mm, 길이 1,800mm, 폭 600~700mm) • 처치대 하부 수납장은 양옆으로 배치하고 중앙부는 비워서 작업 기능도를 높인다. • 처치대는 추락방지를 위한 한쪽 벽 막힘을 고려한다. • 처치대의 수납 손잡이는 돌출되지 않도록 한다. • 처치대의 상단표면은 치료 중 오염에 대비하는 재료를 선택한다.(비닐 벽지류, 인조가죽 등) • 치료 학생의 프라이버시 존중을 위해 칸막이를 설치한다. • 치료 중에도 출입구 및 대기실 상황에 대응 가능한 곳에 배치한다. ※ 부상당한 학생의 운반 및 장애학생이 이용하기 편리하고 이동 가능한 처치대도 고려해 본다.
안정실	• 두꺼운 재질의 칸막이(가림벽)을 설치한다. • 칸막이(가림벽)의 높이는 1,800mm을 넘지 않도록 하며, 학생 관찰을 위해 안정실 내부를 들여다 볼 수 있는 창을 설치한다.(단, 벽을 천정과 연결할 경우에는 답답한 느낌이 들지 않도록 창을 넓게 설치한다.) • 침대는 1인용으로 구비하고, 학교 규모에 맞는 적정수(18학급 미만: 2개, 18학급 이상: 2개 이상)를 비치하며, 남·여 공학은 안정실을 칸막이(가림벽)로 구분한다. • 침대 길이는 학생 신장을 고려하여 학교 급별(초·중·고)에 맞게 설치한다. • 학생의 안정을 위해 조명은 간접조명 또는 조명 조절장치를 설치한다.
업무 공간	• 출입구와 안정실을 바라볼 수 있는 보건실의 중심에 위치하도록 하며 처치공간과의 동선을 짧게 한다. • 책상 앞의 칸막이(가림벽)는 학생을 파악하기 쉬운 높이(바닥에서 1,000mm)로 한다. • 책상의 구조는 동선을 생각하여 ㄴ자형 또는 ㄷ자형이 되도록 배치한다. • 보건업무 공간의 조도는 300Lux 이상으로 한다. • 전화상담이나 응급상황 시 긴급한 연락(hot-line)을 위해 수발신이 되는 별도의 직통 전화선을 설치한다.

구분	내용	
수납 공간	• 수납물의 종류, 크기 등을 고려하여 수납장을 설치한다. (약장, 의료 소모품 보관장, 교육자료 보관장, 서류 보관장, 이불장 등) • 처치공간 및 업무공간과 가깝게 약장, 서류 보관장을 설치하고 잠금장치를 한다. • 응급처치도구(들것, 산소, 부목 등)는 누구나 이용할 수 있도록 보이는 곳에 비치한다. • 기타 수납공간을 확보하여 책, 기타 비품을 정리할 수 있도록 한다.	
수세 공간	• 수세공간은 상처를 세척하기 위한 필수공간으로 세면기, 세족기와 더불어 냉.온 급수 및 배수 시설을 갖춘다. • 학교 급별 학생 신장을 고려하여 세면기, 세족기를 설치하며, 세족기의 높이는 높지 않게 바닥에서 500mm 정도로 한다. • 세면기, 세족기 주위 바닥은 물이 흘러도 미끄러지지 않는 바닥재를 사용하며, 코브라식 줄 사워기를 설치한다. • 처치실에 가까운 곳에 설치하여 처치가 쉽게 하며, 세면대 앞에 벽거울 및 종이타월을 설치한다.	
대기 공간	• 업무실과 처치실에서 보이는 곳에 대기공간을 확보한다. • 팔걸이가 없는 3~4인용 의자를 설치하여 응급 시에 간이침대로 활용한다. (의자길이 1,500~2,000mm) • 대기 공간 주변에 건강검사에 필요한 기구(비만도 자동 측정기, 시력계 등) 비치 및 보건 교육자료를 게시한다.	
건강상담실	• 작은 테이블, 의자 3~4개, 시청각 기자재(TV, DVD), 교육자료 수납장 및 아늑한 느낌이 들도록 화분, 벽장식 등을 설치한다. • 이용자와 상담내용의 프라이버시 보호를 위해 천정까지 밀폐하되 상부는 유리벽으로 하여 답답하지 않게 하며, 별도의 냉.난방시설을 설치한다.	
보건실 입구 및 게시판	• 보건실 입구는 신체불편 아동 및 응급침대가 출입하기 쉬운 문으로 설치한다. • 보건게시판은 벽면을 이용하여 보건자료 및 건강정보를 제공하며 게시물은 교체가 용이하도록 설치한다.	
보건교육실 (권장)	• 보건교육과 체험중심 보건교육 활동을 할 수 있는 장소로 사용한다. • 보건실과 인접한 곳으로, 교육 시 보건실 상황을 볼 수 있도록 벽을 유리창으로 설치하고 1개 반이 수업할 수 있도록 교실 1실(66㎡) 규모로 구성한다.	
	강의 공간	1개 반이 수업을 할 수 있도록 책상, 의자를 적정 수량 확보하고 책상 배치는 상황에 따라 일제식, 그룹식으로 배치하여 사용한다.
	수납 공간	교육자료를 충분히 수납할 수 있도록 붙박이 서랍장과 장을 설치한다.
	수도 시설	손 씻기 및 구강보건교육이 이루어질 수 있도록 설치하며 수도꼭지는 6개 정도, 높이는 700mm, 길이는 2,000mm정도로 한쪽 벽면에 설치한다.

보건실에 갖추어야 하는 시설 및 기구의 기준

영 역	시설 및 기구명	보건교사 배치교	보건교사 미배치교
1. 일반 시설 및 기구 등	사무용책상·의자	필수	필수
	서류 보관장	필수	필수
	약품 및 의료기구보관장	필수	필수
	소독(멸균)기	필수	필수
	(냉동)냉장고	필수	필수
	가습기	권장	권장
	수도시설 및 세면대(씽크대)	필수	필수
	세족기(샤워기부착)	필수	권장
	냉·난방시설	필수	필수
	전화기(착발신)	필수	필수
	컴퓨터·프린터기	필수	필수
	교육기자재 보관용 교구장	필수	필수
	온·습도계	필수	필수
	순간온수기(온수설비)	필수	필수
	핸드타월	필수	필수
	물 끓이는 기구	권장	권장
	스탠드라이트	권장	권장
	적외선램프	권장	권장
	진공청소기	권장	권장
	온장고 또는 전자레인지	권장	권장
	불소용액 양치 기자재	권장	권장
2. 환자안정용 기구	침대	필수	필수
	침구류(침대커버, 이불, 베개)	필수	필수
	침구 보관장	필수	필수
	칸막이(파티션)	필수	필수
	보온기구(전기요 등)	권장	권장
3. 건강진단 및 상담용 기구	신장계	권장	권장
	체중계	권장	권장
	줄자	권장	권장
	비만측정기(신장, 체중자동측정)	필수	필수
	시력표, 눈가리개, 시력검사용지시봉	필수	필수
	색각검사표	권장	권장
	청력계	권장	권장
	혈압계	필수	권장
	청진기	필수	권장

영 역	시설 및 기구명	보건교사 배치교	보건교사 미배치교
3. 건강진단 및 상담용 기구	펜라이트	필수	권장
	상담용 의자・탁자	필수	권장
	체온계	필수	필수
	혈당측정기	권장	권장
	스톱워치	권장	권장
	검안경, 이경, 비경	권장	권장
	치과용 거울, 탐침	권장	권장
	척추측만증 측정자(각도기)	권장	권장
	소아용 혈압계	권장	권장
4. 응급처치용 기구	핀셋, 핀셋통	필수	필수
	의료용 가위	필수	필수
	농반	필수	권장
	가제통(드레싱캔, 스폰지캔)	필수	권장
	드레싱카	필수	권장
	부목	필수	필수
	구급낭(휴대용구급기구)	필수	필수
	들것	필수	필수
	(냉・온)찜질기(팩)	필수	필수
	진찰용의자, 진찰대	필수	권장
	소독 접시	권장	권장
	목발	권장	권장
	세안수수기	권장	권장
	비염 세정기	권장	권장
	켈리(지혈감자)	권장	권장
	휴대용산소기	권장	권장
	경추보호대	권장	권장
	휠체어	권장	권장
5. 환경위생 및 식품위생 검사용 기구	조도계	권장	권장
	먼지측정기	권장	권장
	수질검사용 기구 등	권장	권장
	소음계	권장	권장
6. 보건교육용 기구	보건교육용 교구	필수	필수
	성교육용 교구	필수	필수
	약물오남용 및 흡연예방용 교구	필수	필수
	심폐소생술 실습용 인형	필수	필수
	기타 보건교육용 모형	권장	권장
7. 기타	학생 및 교직원의 보건관리에 필요한 시설・기구 등	권장	권장

출처: 충청남도교육청 학교보건실 시설 및 기구에 관한 규칙 제4조

보건실 의료기구 소독

주요 용어 정리

1. 세척(Cleaning)은 대상물로부터 모든 이물질(토양, 유기물 등)을 제거하는 과정을 말하며, 소독과 멸균의 가장 기초 단계로서 일반적으로 물과 기계적인 마찰, 세제를 같이 사용한다.
2. 소독(Disinfection)은 생물체가 아닌 환경으로부터 세균의 아포를 제외한 미생물을 제거하는 과정을 말하며, 일반적으로 액체 화학제나 습식 저온 살균제의 의해 이루어진다.
3. 멸균(Sterilization)은 물리적, 화학적 과정을 통하여 모든 미생물을 완전하게 제거하고 파괴시키는 것을 말하며, 고압증기멸균법, 가스멸균법, 건열멸균법, 과산화수소 가스플라즈마멸균법 및 액상 화학제 등을 이용한다.
4. 높은 수준 소독(High-level disinfection): 모든 미생물과 일부 세균의 아포를 사멸할 수 있는 것을 말한다.
5. 중간 수준 소독(intermediate-level disinfection): 결핵균과 영양성 세균, 대부분의 바이러스와 진균을 사멸시키나 아포는 사멸시키지 못한다.
6. 낮은 수준 소독(Low-level disinfection): 10분 이내에 대부분의 영양성 세균과 일부 진균과 바이러스를 제거할 수 있으나 결핵균과 아포는 사멸시키지 못한다.

의료기구가 감염성 미생물에 의해 오염되면 감염전파의 경로가 된다. 환자의 처치에 사용되는 기구 및 물품(1회용품 제외)은 환자의 접촉 방법이나 상황에 따라 고위험 기구(critical items), 준위험 기구(Semicritical items) 및 비위험 기구(Non-critical items)로 분류되며 필요한 개념에 따라 적절한 멸균 및 소독방법에 의해 관리되어야 한다. 보건실에서 주로 사용되는 기구 및 물품은 준위험 기구와 비위험 기구에 해당한다.

보건실 내 주요 물품 및 장비별 소독 기준

소독 수준	물품 및 장비	소독 부분	소독 시기	비고
멸균	핀셋·핀셋통, 가위, 의료용쟁반, 가제통, 소독접시, 비경 등		매 사용 후	체액 등 눈에 보이는 오염물이 있을 경우 소독
낮은 수준 소독	청진기	벨과 관		
	검안경·검이경	손잡이, 팁		
	고막 체온계	팁		
	목발, 휠체어, 진찰용 의자, 침대, 간호영역에서 접촉하는 물품 등	사람들과 접촉한 표면	마지막 학생 진료 후	

※「학교보건법」 별표 1 근거에 의한 보건실 물품기구를 명시하였으며, 그 외 진료 관련 등 물품 기구 소재 시 적합하게 소독 권장

라 보건실 기록물 관리

보건실 기록물 관리의 목적은 학교보건 활동에 대한 증거 서류, 활동 계획을 위한 기본자료, 의사소통 수단, 연구 및 통계자료와 평가도구로 활용하기 위함이다.

구분		내용	보존기간
법정 장부	학생건강기록부 (정정대장 포함)	• 「학생건강검사규칙」에 의거한 검사 결과 및 예방접종력 등을 기록 – 학년말 건강기록부 자료검증을 안내하여 전입생 등 누락된 자료를 기재하고, 반별 마감 후 전체 마감 상신 • 학생건강기록부 정정사항 발생 시 정정대장에 입력 및 상신 • 나이스(NEIS)로 관리, 출력하여 보관할 필요가 없고, 상급학교 진학 시 별도의 출력 및 이관 불필요(유예나 재적·휴학 시 학적 담당자가 출력하여 다른 서류와 함께 보관) • 전학이나 상급 학교 진학 시 나이스(NEIS) 담당자가 해당 학교에 이관 송부하여야 하며, 고등학교 졸업 시 본인이나 보호자에게 교부(전산매체는 5년간 보관), 휴학, 퇴학, 사망, 상급학교 미진학 시에는 당해 학교에서 5년간 보존(졸업생에게 교부 시 수령증 서명받아 내부결재하여 보관) • 병무청 또는 기타 사유로 당사자(또는 보호자)가 건강기록부 제공 요구 시, 행정실 경유하여 학교 기록물 처리 절차에 따라 제공 가능(제3자에게 제공 시 동의서 필요)	5년 「학교건강검사규칙」 제9조6항 「학생건강기록부 전산처리 및 관리지침」
비법정 장부	보건일지 (응급후송기록지 포함) *전산프로그램 활용하여 관리	• 「학교보건법 시행령」 제23조에 의거 보건교사가 제공한 의료행위를 기록한 것으로 「의료법」 제22조에 의거 상세히 기록하고 보존해야 할 책무가 있음 – 안전사고 및 응급처치에 대한 법적 분쟁 시 근거 자료 – 개인정보 보호에 유의하여 보건일지는 전산프로그램으로 관리 가능(업체 계약 시 정보보호 내용 추가) – 내부결재 시 '비공개' 설정, 전산프로그램은 학교 밖 시스템 연계관리 불가 • 매일의 업무 활동을 기록하고, 매월 통계 작성하여 출력 또는 파일로 보관 • 학교의 건강문제를 파악, 진단하는 도구로 다음 연도 계획 수립 및 보건업무 예산 편성의 객관적인 기준이 됨 • 「의료법」 제21조에 의거 학생(또는 보호자)이 보험회사, 학교안전공제회 등 보건일지 사본 요구 시 개인정보보호 관련하여 보건일지 사본 제공 요건이 갖추어지면 다른 학생의 이름과 정보는 비공개 처리하고 결재를 득한 후 제공(제3자에게 제공 시 동의서 필요) • 응급후송기록지는 별도의 양식 또는 보건일지 전산프로그램의 양식을 활용하여 관리	5년 「의료법」 제22조 「의료법 시행규칙」 제15조
	건강상담일지 (건강요보호자)	• 요보호학생 상담의 누락 방지 및 지속적인 건강상담을 위해 필요 시 보건일지 전산프로그램 내에서의 별도 양식에 따른 기록 또는 '요보호학생 건강상담록'을 활용하여 관리 가능	
	감염병관리대장	• 감염병 발생 현황을 등록하여 환자 관리 및 통계 활용	NEIS활용
	기타	• 업무상 필요하다고 생각되는 기록 양식 체계를 개발하여 활용 가능 • '약품 대장'은 '비치 약품표'로 대신하고 약품 소모관계는 '보건일지'에 기록 • 예산 사용과 관련이 있는 장부는 5년, 관련이 없는 장부는 통계 보고 등으로 필요할 경우가 있으므로 3~5년간 보관·이관한다. – 해당 학년도에 비전자문서 처리하며 장부 종류와 절차에 따라 이관 또는 파쇄처리 해야 한다. ※ 보유기록물을 관리 담당자에게 비전자기록물 종류 및 현황을 파악한 후 교육청의 절차에 따르며, 임의대로 폐기하기 않도록 한다.(「공공기록부 관리에 관한 법률」 제13조 및 제19조, 동법 시행령 제33조)	

3 보건교사 2인 배치 운영 모델

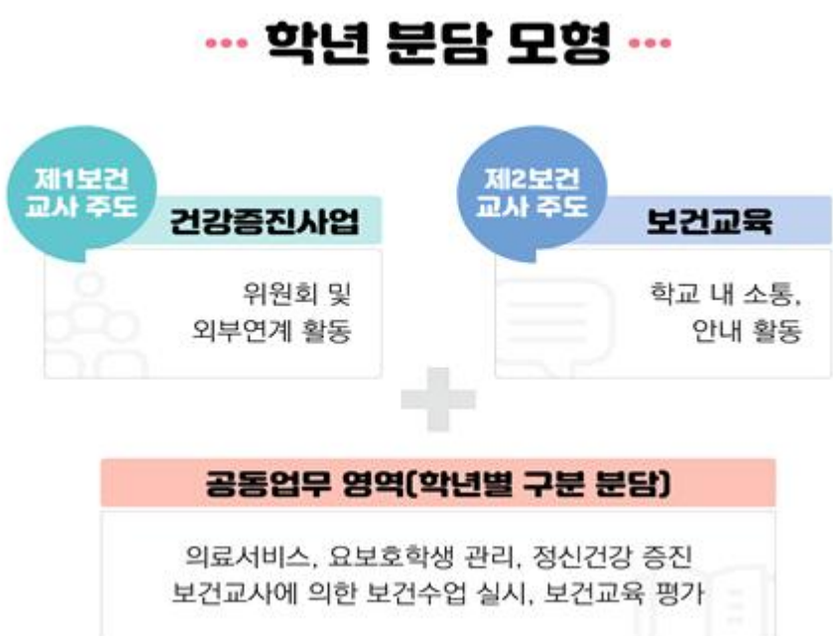
「학교보건법」 제15조 3항 및 「학교보건법 시행령」 제23조 3항 신설로 36학급 규모 이상의 학교에서는 2명 이상의 보건교사를 두어야 한다. 보건교사 2인 배치로 인한 학교 현장의 혼란을 줄이고 안정적인 운영을 지원하기 위해 효율적인 운영 모델과 역할 정립이 필요하다. 다음은 2022년도 보건교사 2인 배치 학교 업무 실태 분석에 따른 보건교사 2인 배치 운영 모형 제안이다.

가 업무 분담 모형



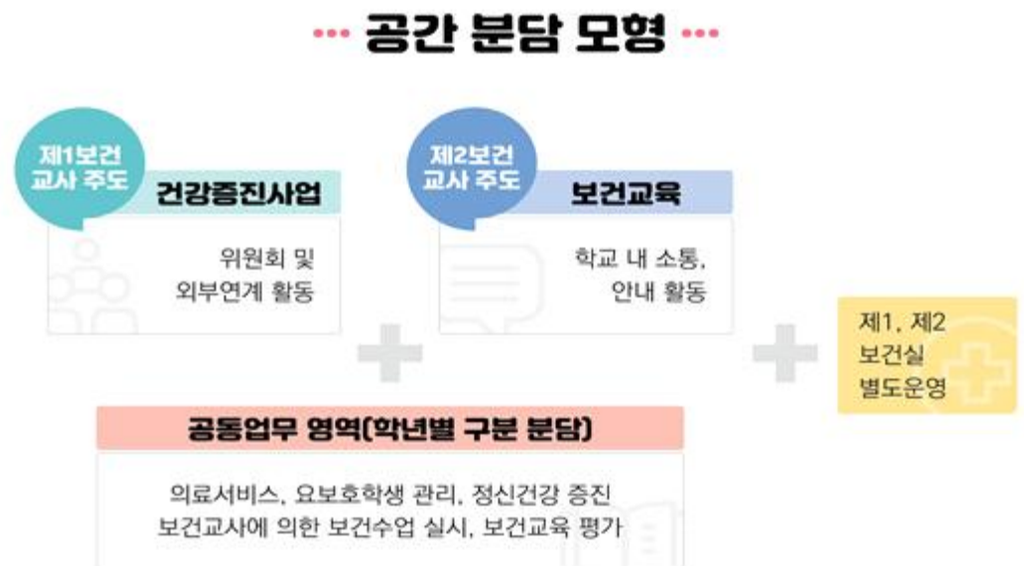
- 업무를 크게 건강관리 및 건강증진 업무와 보건교육 업무 2가지로 제시하고, 학교 내 소통 업무와 외부연계 업무 2가지를 추가로 제시하여 총 4가지 기준을 종합적으로 적용한 업무 분담 모형이다.
- 구체적으로 건강증진사업 업무는 제1보건교사, 보건교육 업무는 제2보건교사가 주도적으로 분담한다. 또한 위원회 활동과 외부연계의 대표성을 띄는 업무는 제1보건교사가 주도적으로 담당하고 학교 내 구성원들과의 소통과 안내가 필요한 업무는 제2보건교사가 주도적으로 수행하도록 한다.
- 아울러 매 학년도 제1보건교사와 제2보건교사의 업무는 매해 학교 전체 업무 분장 시기에 학교 사정에 맞게 상호 협의하여 유동적으로 분담하도록 한다.

나 학년 분담 모형



- 제1보건교사와 제2보건교사가 학년을 분담하여 담당하는 모형이다. 학급 수와 학급별 학생 수를 고려하여 학년을 분담하여 담당한다.(예: 초등학교의 경우 학급수가 학년별로 동일하다는 가정 하에 1, 3, 5학년과 2, 4, 6학년으로 나누어 담당한다. 중, 고등학교의 경우 학급수를 고려하여 1학년과 2학년 일부 및 2학년 일부와 3학년을 담당한다.)
- 업무 분담 모형에서 제시한 직무분류 기준을 기본으로 적용하되 학년 분담 구분이 명확한 영역을 뽑아내어 공동업무로 분담하고 해당 학년과 학급을 나누어 수행한다.
- 구체적으로 건강증진사업 영역의 의료서비스, 요보호학생 관리와 보건교육 영역의 보건교사의 의한 보건수업 실시와 보건교육 평가는 제1보건교사와 제2보건교사가 공동업무로 담당하되 각각 학년과 학급을 분담하여 수행한다.

다 공간 분담 모형



- 대규모 학교로 교실에서 보건실까지 거리가 먼 경우 학생들의 동선을 고려하여 접근성이 좋은 위치에 보건실 2개를 설치하는 모형이다. 접근성이 편리해지면서 응급상황에 더 빠르게 대처하여 학교안전을 꾀할 수 있다. 또한 이동시간을 줄여 시간적인 효율성을 높일 수 있다.(예: 본관, 후관을 구분하거나 동측, 서측 혹은 저층과 고층으로 공간을 구분)
- 학년 분담 모형과 비슷하게 업무 분담 모형에서 제시한 직무분류 기준을 기본으로 적용하되 교실 배치와 보건실과의 거리 및 접근성에 따라 제1보건교사와 제2보건교사 담당하는 학급을 나누어 직무를 수행한다. 또한 공간이 분리되어 2개의 보건실이 운영되는 바, 각각의 보건실을 운영관리하게 된다.

라 융합 모형

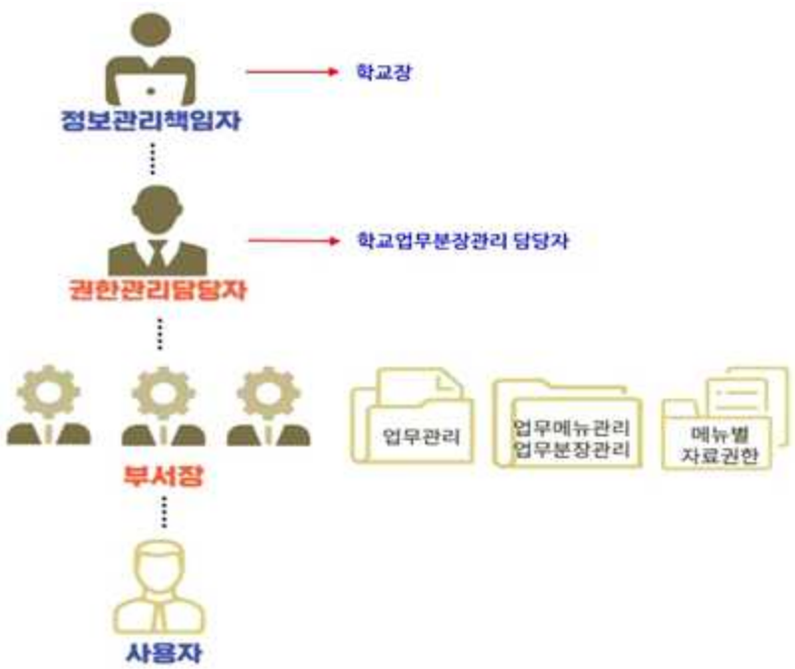
개별학교의 사정에 따라 업무 분담, 학년 분담, 공간 분리 모형을 적절하게 융합하여 운영하는 모델이다. 학교 상황에 맞추어 업무 분담이나 학년 분담 및 공간 분리 등의 방안을 융한한 다양한 방안을 활용하여 단위학교에 적합한 유형을 만들어 근무할 수 있다.

출처: 서울특별시교육청(2025), 한눈에 보는 보건업무 길라잡이

4 4세대 지능형 나이스(NEIS) 기초자료 구성

가 4세대 지능형 나이스(NEIS) 권한부여 체계

단위학교 부서단위 업무분장별로 나이스(NEIS) 권한을 부여한다.



출처: 교육부(2023), 4세대 지능형 나이스(NEIS) 사용자 설명서

나 4세대 지능형 나이스(NEIS) 권한 요청

건강관리 업무담당자는 해당 부서장에게 건강관리 업무와 관련된 작업을 진행하는데 필요한 페이지 권한과 자료 권한을 요청한다.(담당업무에 따라 권한 범위는 달라짐)

[건강관리 업무담당자 4세대 지능형 나이스(NEIS) 필수 권한(예시)]

대분류	소분류
교무학사	• 학교정보 - 학교기본정보조회* * 학교기본정보조회: 학생수 현황 확인가능 • 기본학적관리 – 명렬표출력
보건* *학년, 반 권한 필요	• 학생건강검사관리 • 예방접종연계관리 • 건강기록부관리 • 감염병환자관리
상담관리	• 상담현황(학생 및 학부모 상담기록시 사용) • 상담통계(상담기록 통계 조회시 사용)
정보공시	• 공시항목관리 • 공시자료관리

연간 월별 주요 업무 안내 (예시)

월별	업무 내용	비고
매월	1. 보건일지 작성 및 관리 2. 의약품 및 비품 관리(유효기간 주기적으로 확인) 3. 보건교육 및 보건소식지 발송 4. 학생 응급처치 및 건강 상담 5. 감염병환자 발생 시 나이스보고	
3월	1. 학교보건 기본계획 및 필요한 계획서 기안 및 결재 2. 보건실 정비 (보건실 환경정리 및 비품 확인) 3. 보건실 의약품 및 소모품, 교육자료 구입 4. 학생 건강상태 실태조사 및 요보호 학생 선정 및 관리 5. 반별 건강기록부 확인 및 점검 6. 학교 감염병 관리 계획 수립 및 교직원 연수 7. 학교 응급환자 관리 계획 수립 및 교직원 연수 8. 학생건강검사(건강(구강)검진 포함) 실시 계획 수립 9. 가정통신, 보건소식지 (보건실 이용 안내 등) 10. 교육과정에 의한 보건교육 실시	요보호 학생 건강관리 관련 교직원 연수 실시
4월	1. 교육과정에 의한 보건교육 실시 2. 요보호 학생 건강 상담 3. 학생건강(구강)검진 실시기관 선정	- 보건의 날(4월 7일)
5월	1. 교육과정에 의한 보건교육 실시 2. 학생건강(구강)검진 실시 3. 신체발달상황·별도검사 실시 및 추후관리 4. 신입생 예방접종 관리 5. 교직원 연수-심폐소생술 등 응급처치교육 6. 세계 금연의 날(5.31.) 금연행사 운영	- 학생건강(구강)검진 실시 시기는 학교 실정에 맞게 조정 - 심폐소생술 등 응급처치교육 실시 시기는 학교 실정에 맞게 조정
6월	1. 교육과정에 의한 보건교육 실시 2. 건강검진 결과 배부 및 추후 관리 대상자 가정통신문 발송 3. 요보호 학생 건강 상담	- 구강보건의 날(6월 9일) - 마약퇴치의 날(6월 26일)
7-8월	1. 교육과정에 의한 보건교육 실시 2. 건강검진 결과 추후관리 대상자 추후관리 3. 생활습관병 등 질병 고위험군 대상자 교육 4. 건강기록부 입력 확인 및 관리	- 여름방학 준비가정통신)
9월	1. 교육과정에 의한 보건교육 실시 2. 요보호 학생 상담 및 생활습관병 등 질병 고위험군 교육 3. 보건실 의약품 및 소모품, 교육자료 구입	- 귀의 날(9월 9일)

월별	업무 내용	비고
10월	1. 교육과정에 의한 보건교육 실시 2. 가을철 유행 감염병예방 교육 3. 생활습관병 등 질병 고위험군 상담, 교육 및 관리	– 세계 눈의 날 (10월 두 번째 목요일) 손씻기의 날(10월 15일) 척추의 날(10월 16일) – 독감예방 및 접종 안내
11월	1. 교육과정에 의한 보건교육 실시 2. 요보호 학생 상담 및 생활습관병 등 질병 고위험군 교육	– 약의 날(11월 18일)
12월	1. 교육과정에 의한 보건교육 실시 2. 생활습관병 등 질병 고위험군 상담, 교육 및 관리 3. 건강기록부 기록 최종 점검 4. 다음 학년도 보건실 예산 수립 5. 보건 관련 각종 파일 정리 및 공문서 이관	– 겨울방학 준비 가정통신문 – 에이즈의 날(12월 1일)
1–2월	1. 보건수업 및 보건업무 종합평가 2. 건강기록부 마감 3. 보건실 비품, 약품정리	

학교보건 연간 예산(예시)

연번	예산 목록	사용 내용
1	의약품 구입	– 학생 응급처치 및 치료를 위한 의약품 구입
2	학생 건강검진	– 학생건강검진 비용 지원
3	학생 별도검사	– 소변검사, 결핵검사 비용 지원
4	학생 구강검진	– 구강검진 비용 지원
5	보건교육 자료	– 보건교육 자료 구입
6	성교육 활성화	– 학생 및 교직원 성교육 강사료 및 교육자료 구입
7	감염병 예방 물품구입	– 감염병 예방을 위한 물품 구입
8	보건실 일반운영	– 보건실 운영을 위한 예산
9	의료인 보수교육	– 의료인 면허 유지를 위한 보수교육 예산 지원
10	의료용품 및 기기 구입	– 응급처치 및 신체사정, 보건실 의료용품 및 기구 구입
11	교직원 심폐소생술 강사수당	– 교직원 심폐소생술 및 응급처치 연수 강사료
12	교직원 결핵 검진	– 교직원 결핵(잠복결핵) 검진 비용 지원
13	응급환자 이송 및 초기 진료비	– 응급환자 이송비용 및 초기 진료비 지원
14	학생 응급관리	– 학생 응급관리에 필요한 지원
16	기타	– 보건업무 관련 예산 수립

II

보건
교육

단위업무	주요내용	참고·서식자료
계획	1. 보건교육 계획 수립·보고 ▪ 보건교육 실시 근거 확인 ▪ 전년도 보건교육 평가 결과 보건교육 계획에 반영 ▪ 금년도 건강조사 결과 보건교육에 반영 ▪ 학교교육과정 운영계획 수립 시 보건교육 반영 ▪ 보건교육 예산 확보	•2026년 보건교육 내실화 계획 (p.29) [서식1] 보건교육 실시현황 (계획)
운영	1. 학교교육과정 편성·운영 ▪ 학교교육과정 운영계획 수립 시 반영하여 연중 체계적이고 지속적인 교육 실시 * 초·중등학교 교육과정 총론 관련 내용 Ⅲ. 학교급별 교육과정 편성·운영의 기준 2. 초등학교: 나. 교육과정 편성·운영 기준 5) 학교는 학생의 발달 특성을 고려하여 학교 교육과정을 편성·운영한다. 다) 정보통신활용 교육, 보건 교육, 한자 교육 등은 관련 교과(군)와 창의적 체험활동시간을 활용하여 체계적인 지도가 이루어질 수 있도록 한다. 3. 중학교: 나. 교육과정 편성·운영 기준 1) 학교는 교과(군)과 창의적 체험활동의 수업 시수를 학년별, 학기별로 자율적으로 편성할 수 있다. 라) 학교는 선택 과목을 개설할 경우, 2개 이상의 과목을 동시에 개설하여 학생의 선택권을 보장한다.(후략) 4. 고등학교: 나. 교육과정 편성 1) 공통사항 사) 학교는 일정 규모 이상의 학생이 이 교육과정에 제시된 선택 과목의 개설을 요청할 경우 해당 과목을 개설해야 한다.(후략) ▪ 학교급별 최소한 1개 학년 이상을 대상으로 관련 교과와 창의적 체험활동을 통해 연간 17차시 이상 체계적·지속적 보건교육 운영 ※ 범교과 학습 주제(건강·안전) 내 관련 세부 주제와 통합 운영하도록 학교 교육계획 수립 가능/2022 개정교육과정 적용 학년은 연간 16차시 이상 ※ (중·고등학교) 학생건강 관리에 대한 중요성 및 요구도 증가를 고려하여 선택과목(보건)을 통해 체계적인 보건교육 실시	•2026년 범교과 학습 주제 편성·운영 안내(p.59)
	2. 보건교육 중 응급관리 대책 및 지원 방안 마련 ▪ 보건교육 실시 중 보건실 대체 인력 확보 ▪ 교내 응급관리대책 및 후송체계 확립, 이에 따른 교직원 연수 실시 ▪ 보건실 옆 또는 인접 교실에 보건교육실을 설치하여 보건교육 중 응급상황 시 신속하게 대응할 수 있도록 지원 ▪ 보건교사 수업 중 학생건강관리 및 응급상황에 대한 대응체계 구축 (보건 업무 담당자 대행 지정)	
	3. 체계적 보건교육을 위한 교재·교구 확보 및 연수 참여 ▪ 보건인정도서 활용 및 교구 확보 ▪ 보건교과(교육)연구회 4팀 운영 ▪ 보건교사 보수교육 (2026. 7. 29.(수) / 7. 30.(목) / 7. 31.(금) (충남교통교육원)	•2026년 보건교사 대상 연수 일정 (p.32)

평가	1. 연도별 보건교육 평가 및 차기년도 계획에 반영 ▪ 보건교육 실시결과 보고	[서식1] 보건교육 실시현황 (실적)

1 2026 보건교육 내실화 계획

가 관련근거

- 학교보건법 제9조(학생의 보건관리) 및 제9조의 2(보건교육)
- 충청남도교육청 학생 보건교육 진흥에 관한 조례 제4354호
- 충청남도교육청 고시 제2025-19호, 25호, 26호
- 2022개정 교육과정(교육부 고시 제2022-33호, 초·중등학교 교육과정 총론)에 따른 보건교육 및 '보건' 선택과목 운영
- 교육부 학교교수학습혁신과-7262(25.10.16.), 2026학년도 범교과 학습주제 편성·운영 안내
- 2026년 학생건강증진 분야 주요업무 추진방향(교육부)

나 기본방침

- 성장기 학생들의 자기 건강관리 능력 함양을 위하여 시·도교육청 및 단위학교 여건에 맞게 실질적인 보건교육 내실화 방안 수립·추진
- 학교 보건교육 내실화를 위한 교사연수, 보건교육실 설치, 보건교사 보조인력 배치, 학교별 교육과정 운영과 교수·학습방법에 대한 장학 등 지원 강화

다 현 황

보건교육 실시

(기준: 2025. 12. 1.)

학교급	전체 학교수	보건교육 현황						최소 1개 학년 17차시 이상 실시	
		1학년	2학년	3학년	4학년	5학년	6학년	실시 학교수	실시비율
초	411	14.9	14.9	15.1	15.5	20.8	16.8	411	100
중	187	19.8	18.9	16.7				186	99.46
고	119	16.1	18.9	19.6				118	99.15
특수	11	24.5	25.4	18.4	20.4	23.4	21.8	10	90.90
각종	3	19.5	19.5	19.5				3	100
합계	731	23.7	24.3	22.7	17.8	22.6	19.8	728	99.58

보건과목 선택 현황

(기준: 2025. 12.)

중학교		고등학교		특수학교		계	
학교수	선택율	학교수	선택율	학교수	선택율	총학교수	선택현황
187	103(55.0%)	119	54(45.4%)	11	3(27.3%)	317	160(50.5%)

- 학교에서 보건교육 및 학생건강관리에 필요한 전문 인력 확보 부족

충남 보건교사 배치

(기준: 2026. 3.)

구 분	학교수(교)				보건교사 배치학교수(교)				
	국립	공립	사립	계	국립	공립	사립	배치	배치율
초	1	408	1	410	1	320	0	321	78.10
중	1	144	42	187	1	109	23	133	71.12
고	1	82	35	118	1	81	33	115	87.45
특수학교	1	8	2	11	1	8	1	10	90.90
각종학교		4	1	5		2	0	2	50.00
계	4	646	81	731	4	520	57	581	79.48

라 주요업무

학교보건법 제9조의2 (보건교육 등)
교육부장관은 학교에서 모든 학생들을 대상으로 심폐소생술 등 응급처치에 관한 교육을 포함한 보건교육을 체계적으로 실시하여야 한다.

1) 학교교육과정 편성·운영

가) 학교교육과정 운영계획 수립 시 실질적인 교육내용, 방법 및 대상 등 학교 여건을 고려하여 체계적·지속적인 보건교육이 가능하도록 학교 교육과정 편성

※ 보건교육 내실화를 위한 참고 자료
1. 에듀넷(www.edunet.net): 창의적체험활동 – 주제별사진영상자료 – 보건안전교육
2. 에듀넷(www.edunet.net): 학습자료 – 주제별 학습자료 – 범교과학습주제(안전·건강교육)
3. 에듀넷(www.edunet.net): 교육정책 – 교육과정 – 국가교육과정
4. 학생건강정보센터(www.schoolhealth.kr) → 학교보건
5. 각 시·도교육청의 교육과정 및 교육청 개발 자료

나) 학교급별 최소한 1개 학년 이상을 대상으로 관련 교과와 창의적 체험활동을 통해 연간 17차시 이상 체계적·지속적 보건교육 운영

※ 범교과 학습 주제(건강·안전) 내 관련 세부 주제와 통합 운영하도록 학교 교육계획 수립 가능/2022 개정교육과정 적용 학년은 연간 16차시 이상

※ (중·고등학교) 학생건강 관리에 대한 중요성 및 요구도 증가를 고려하여 선택과목(보건)을 통해 체계적인 보건교육을 실시하는 방안 적극 검토

2) 보건교육에 대한 지원장학 강화

가) (시·군 교육지원청) 교육감(장)은 각급 학교에서 초중등학교 교육과정에 따른 체계적인 보건교육이 실시될 수 있도록 행·재정적 지원 적극 추진

- 교육감(장)은 보건교육 내실화 방안을 시도교육청 단위 교육과정 편성운영 지침에 포함하여 안내하고, 교육과정 운영과 교수·학습방법 등에 대한 장학강화
- 학생 참여형·체험형 교육 활성화를 위한 교재 및 교구지원, 교육자료 개발·공유 확대 등 실효성 있는 대책 마련

- 보건교사 수업전문성 향상을 위한 연수, 보건교과(교육)연구회, 교사동아리, 보건교육 우수교원 표창, 보건수업 연구대회 운영으로 우수사례 발굴·공유

3) 보건교육 및 건강관리를 위한 지원

가) 과대학교 보건교사 추가 배치(공립, 61교)

(기준: 2026. 3.)

학교급	전체 학교수	36학급 이상 학교수	과대학교 배치			
			정원2명	정원외	시기제	합계
초	410	36	7	29		36
중	187	9		9		9
고	118	16		16		16
특수학교	11					
각종학교	5					
합계	731	61	7	54		61

나) 거점학교 순회보건교사 운영(26교)

(기준: 2026. 3.)

지역	천안	공주	보령	아산	서산	논계	당진	금산	서천	부여	청양	홍성	예산	태안	계
미배치교	15	6	6	9	5	6	6	4	4	3	1	5	8	4	82
거점학교	4	2	2	3	2	2	2	1	1	1		2	2	2	26

- 교육지원청은 보건교사 미배치교 파악 및 거점학교 선정
- 거점학교 근무일은 주 2~3일으로 하되, 탄력적으로 운영할 수 있음
- 거점학교는 순회 근무 연간계획을 순회학교와 협조하여 수립 및 안내
- 순회근무 대상학교는 최소 1개 학년 이상 연간 17차시 이상 교육 시수 확보

다) 공립 중학교 과밀학급(30~35학급)이상 보건수업 선택 운영교 대상 정원외, 시간제기간제 보건교사 지원

- 공립 중학교 과밀학급(30~35학급) 보건과목 선택 운영교 정원외, 시간제기간제 보조인력으로 2인 배치(7교)

라) 초등학교 저학년 1형 당뇨학생 지원 시간제기간제 보건교사 지원(16교)

마) 교재 및 교구지원 확충(충청남도교육청 학교보건실 시설 및 기구에 관한 규칙 전부 개정 규칙)

바) 학생 건강관리 서비스 제고 및 응급상황 발생 시 신속한 대응을 위하여 보건실 내 또는 인근에 보건교육실 설치 등 지원

사) 보건교사 수업 중 학생건강관리 및 응급상황에 대한 대응체계 구축(보건 업무 담당자 대행 지정)

4) 보건교육 내실화를 위한 연수

가) 전문성 강화 연수

연수 과정	대상	기간	장소	시간	비고
보건교사 미배치교 업무담당교사	2026년 보건교사 미배치교 업무담당교사	2026. 2.25	충남교육청 교육연수원	4	대면
초등 거점학교 순회보건교사 연수	2026 초등 거점학교 순회보건교사	2026. 3.	학생건강 교육센터	4	대면
신규 보건교사 직무연수	2026년 신규 보건교사	2026. 3. 27.(금) ~ 3. 28.(토)	한국문화 연수원	15	대면
학교흡연예방사업 및 마약류 예방교육 담당자 연수	2026년 업무담당교사	2026. 4.	미정	4	대면
「움직이는 교실, 건강한 학교」 및 불균형체형 예방 프로그램 운영교 업무담당자 연수	「움직이는 교실, 건강한 학교」 및 불균형체형 예방 프로그램 운영교	2026. 3.	충청남도교육 연수원	4	대면
건강증진학교 업무담당자 연수	2026년 업무담당교사	2026. 3.	충남교육청	4	대면
보건교사 직무연수 (보수교육)	보건교사	2026. 7. 29.(수) ~ 7. 31.(금)	충남교통 교육원	8	대면
행복한 보건수업 함께하기	초·중·고 보건교사 50명	2026. 7.~ 8.	도고교원 연수원	15	대면
보건교사 대상 BLS연수	250명 내외	2026. 7.~ 8.	공주대학교 외	8	대면
제6회 참살이, 바른성장 한마당		2026. 11. 24.(화)	공주 고마아트센터	4	대면

※ 교육청 사정에 따라 일정 및 장소는 일부 변경될 수 있음

나) 지원장학 활성화를 통한 교수법, 교육자료 공유 등 실질적인 연찬 기회 확대

※「초중등교육법」 제7조 및 동법 시행령 제8조에 따라 교육감은 관할 학교를 대상으로 교육과정 운영과 교수학습 지도 등에 장학지도를 할 수 있음. 장학은 단위학교의 교육과정, 수업, 교원의 전문성, 학교 조직 운영, 교육정책 수행 정도 등을 지도·평가하는 활동으로, 전국 학교의 교육력을 일정 수준 이상 유지하기 위한 국가 위임사무임

다) '학생중심' 수업방법 개선 및 교과연구회 운영

라) 보건교육 지원단 운영으로 미배치교 및 저경력 교사 지원

마) 참살이, 바른 성장 한마당을 통한 우수사례 발굴 및 공유

※ 학생건강정보센터(http://schoolhealth.kr), 교육청·학교 홈페이지 등 활용(저작재산권 유의)

마 행정사항

- 보건교육 실시 현황 자료 제출 [서식1]
- 보건교사의 각종 대외 체육행사 및 대회 의료지원 동원 지양과 관련된 '학교업무 최적화 추진 계획' 안내
  - 매 수업일에 시행되는 각종 대외 행사(대회)에 출전하지 않는 학교의 보건교사가 대회 운영을 위해 의료지원을 하는 것은 지양하되, 대회 출전 학교에서 소속 학생들의 의료지원을 위한 자발적 참석은 예외로 하고, 수업일이 아닌 공휴일·일요일 등에 개최되는 각종 대외행사(대회)에는 의료지원에 동의한 보건교사만 참석이 가능
- 보조인력 추가 배치 현황 자료 제출 [서식3]
- 보건일지 자료 보관 안내
  - '학교업무 최적화 추진 계획' 안내에 따라 보건일지는 학교 정보공시 증빙자료(연간 보건실 이용 학생 수)로 활용되고 있으므로, 수기 또는 전산프로그램 등을 활용하여 자료를 결재·보관

바 기대효과

- 보건교육과정 운영 정상화로 학생 건강증진과 건강권 보호
- 자기건강관리 능력 향상과 바른 성장으로 삶의 질 향상
- 안전하고 건강한 학교문화 조성으로 교육공동체 건강성 회복

2 2022 개정 교육과정의 이해(총론)

가 2022 개정 교육과정의 개정방향과 중점사항

2022 개정 교육과정은 학습자들이 디지털 전환, 기후환경 변화 및 학령인구 감소 등 미래 사회 변화에 적극적으로 대응할 수 있는 기초소양과 역량을 함양하여, '포용력과 창의성을 갖춘 주도적인 사람'으로 성장할 수 있도록 개발·2022년 12월 22일에 고시되었다.

학교급별 적용 시

2024	2025	2026	2027
초등1, 2	초등3, 4 중1, 고1	초등5, 6 중2, 고2	중3, 고3

1) 개정방향

가) 미래 사회가 요구하는 역량 함양이 가능한 교육과정을 개발한다.
- 이를 위해 삶과 연계한 깊이 있는 학습과 탐구 능력을 강조하고, 디지털 기초소양과 생태전환·민주시민교육을 강화한다.
- 학습 부진 학생, 특수교육 대상 학생과 다문화 학생 등 다양한 특성을 가진 학생을 지원하는 모두를 위한 교육을 강화한다.

나) 학습자의 삶과 성장을 지원하는 맞춤형 교육과정을 개발한다.
- 학습자 주도성을 강화하고, 진로연계 교육과정 운영 및 고교학점제 등 모든 학생의 개별 성장 맞춤형 교육과정을 구현한다.

다) 지역·학교 교육과정 자율성 확대 및 책임 교육을 구현한다.
- 학교 자율시간을 도입하여 다양한 지역 연계 교육과정 운영이 가능하도록 선택과목 개발·운영, 교사의 교육과정 운영 자율권을 확대하고,
- 지역사회와 교육공동체 간 상호 협조 체제 마련을 통해 지역·학교 간 교육격차를 완화할 수 있도록 지원한다.

라) 디지털·인공지능 교육환경에 맞는 교수·학습 및 평가체제를 구축한다.
- 실생활 맥락과 연계한 수업, 온·오프라인 연계 수업 및 평가, 창의력 및 비판적 사고력 함양을 위한 교수·학습 및 평가로 개선한다.

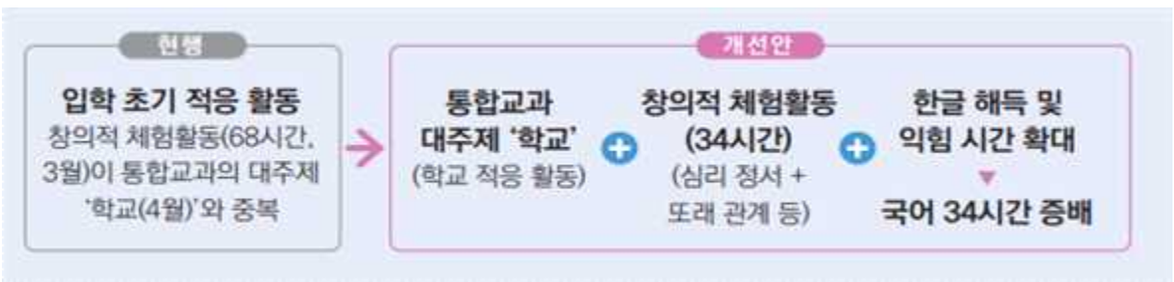
2) 개정 중점사항

❶ 미래 변화에 대응하는 역량 및 기초소양 함양	• 삶과 연계한 개념적 학습과 탐구 • 지속가능한 발전을 위한 공동체 가치 및 역량 강화 • 디지털 기초소양 강화 • 기초학력 보장 지원 및 특수학교·다문화 등 모두를 위한 교육과정 강화
❷ 학습자의 삶과 성장을 지원하는 맞춤형 교육 강화	• 초·중고등학교의 학교급간 진로교육 연계 강화 • 고교학점제 안착 • 직업계고 교육과정 개선
❸ 지역·학교 학교교육 자율성 확대 및 책임교육 구현	• 학교 교육과정 자율성 확대 • 지역·학교 간 교육격차 완화 • 자기주도적 학습능력과 기초소양 함양 지원 • 지역사회와 교육공동체 간 협조 체제 마련
❹ 디지털·AI 교육환경에 맞는 교수·학습 및 평가 체제 구축	• 자발적·능동적 참여 수업 설계 • 미래형 교수·학습 방법과 평가 체제 구축 • 학습자별 맞춤형 학습 지원 및 평가 강화 • 교사의 디지털 에듀테크 역량 함양

나 학교급별 주요 개정 내용

1) 초등학교

가) 입학 초기 적응 활동 개선 및 한글 해득 및 익힘 학습 강화: 초등학교 1학년은 입학 초 3월 통합교과와 창의적 체험활동 내용을 구분하여 체계화하고 한글 해득 교육을 위한 국어 교과 시수 확대하여 기초학습의 토대 마련



나) 교과와 연계한 생활 중심 안전교육으로 개선: 현재 초1~2학년 안전한 생활(68시간) → 바른 생활(16) + 슬기로운 생활(32) + 즐거운 생활(16)의 교과 연계한 생활 중심 안전교육으로 개선. 초3학년 이상은 과학, 체육, 보건 등 관련 교과(목)의 '안전' 대단원을 통해 체계적인 안전교육 실시



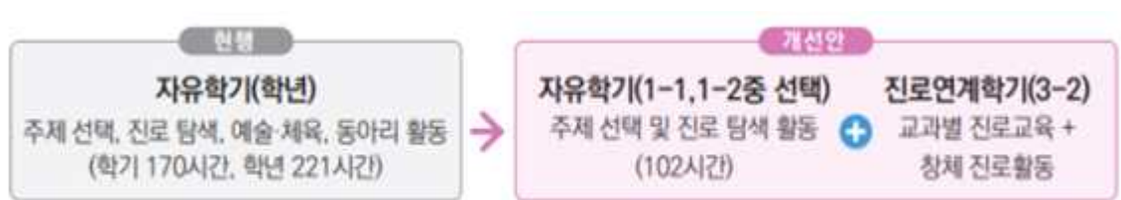
다) 저학년의 실외 놀이 및 신체활동 강화: 즐거운 생활(음·미·체)를 유지하며 신체활동 시간을 강화하고, 안전한 생활 재구화로 신체활동 시수 확보하여 주 2회 이상 실외놀이 및 신체활동을 할 수 있도록 즐거운 생활 교과 재구조화

라) 정보교육 강화: 실과의 정보영역 시수와 학교자율시간 등을 활용하여 34시간 이상 편성·운영

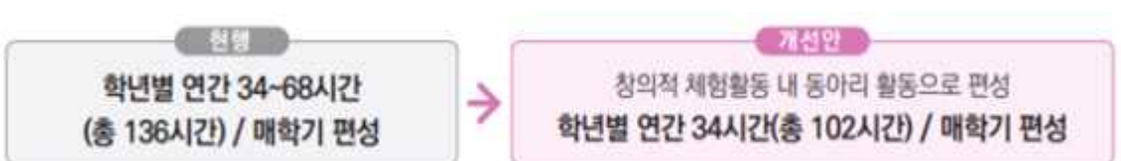
마) 학교급 전환 시기에 진로연계 교육 강화: 1학년 입학 초기와 6학년 2학기에, 교과 및 창의적 체험활동, 학교 자율시간 등을 활용하여 진로연계학기 운영

2) 중학교

가) 자유학기제 편성·운영 개선: 자유학기 운영 시기 및 방법 등을 지역·학교 상황에 맞게 운영하고 창의적 체험활동과의 중복 최소화



나) 학교 스포츠클럽 활동 개선: 학교 교육과정 편성·운영의 어려움을 고려하여 의무 편성 시간 축소



다) 정보교육 강화: 정보 수업 시수와 학교자율시간 등을 활용하여 68시간 이상 편성·운영
라) 학교급 전환 시기에 진로연계 교육 강화: 1학년 자유학기 및 3학년 2학기에 진로연계학기를 운영하여 고등학교 생활 이해 및 고교학점제 등 고교생활을 준비함

3) 고등학교

가) 고교학점제 기반 교육과정 운영(고교학점제 전면 도입 및 안착)
- 수업량 기준을 '단위'에서 '학점'으로 전환. 3년간 192학점 이상 이수* 시 졸업
  * 과목 이수 기준: 수업 횟수의 2/3 이상 출석과 학업성취율 40% 이상 충족
- 성취평가제를 19년 진로 선택과목에서 25년 전체 선택과목으로 확대
- 다양한 선택과목 개설 및 교육과정 편성의 유연성 확보
- 교과별 기본이수학점 축소(5단위→4단위) 및 이수학점 증감 범위 조정
- 필수이수학점 조정(94단위→84단위) 및 자율이수학점 이수 범위 확대(86학점→90단위)
- 소인수과목의 경우 인근 고교와 온·오프라인 공동교육과정 운영
- 학교 밖 교육 학점 인정으로 학교 밖 자원을 활용한 학습 경험 제공

나) 정보교육 강화: 정보 교과를 신설하고, 진로·적성에 따른 다양한 선택과목 편성
다) 학교급 전환 시기에 진로연계 교육 강화: 1학년 1학기에 진로집중학기 운영 및 수능 이후 대학생활 이해 및 사회진출 관련 교육



3 2022 개정 보건교육과정의 이해

가 2022 개정 보건 교육과정의 주요 개정 사항

2022 개정 보건 교육과정은 보건과의 성격 및 정체성에 기초하여 2022 개정 교육과정 총론을 반영하며, **'포용적이고 협력적으로 건강을 추구하는 사람'**을 인간상으로, 학생들이 건강역량을 함양하여 생활 속에서 건강을 실천하며 건강하고 행복한 시민으로 성장하는데 필요한 자질을 갖추도록 설계하였다.

- 2015 개정 보건 교육과정의 기본 성격을 유지하면서 미래사회를 전망하여 민주시민교육, 생태전환 교육, 디지털 소양 교육, 인권 등 국가·사회적 요구 사항을 반영
- 학습자의 삶과 연계되고 사회적 변화에 능동적으로 대응할 수 있으며 학생의 소질과 적성을 바탕으로 미래 핵심역량을 갖출 수 있는 보건 교육과정이 되도록 설계
- '성격'은 학문 측면, 학습자의 삶·생활 측면과 학생 주도성 측면을 바탕으로 보건과의 본질과 필요성, 역할 및 기능으로 구성
- '목표'는 2022 개정 교육과정이 지향하는 인간상과 핵심역량을 연계한 교육목표, 학생이 달성해야 할 학습의 도달점을 제시
- '학습량 적정화'를 시도하고 현장의 자율성을 고려하여 성취기준을 상위 개념으로 포괄적으로 기술하는 등 강화하는 한편 성취기준을 26개로 조정
- '내용' 중 건강 안전 위험요인을 사전에 파악하고 예방하며, 질병에 개인적으로만 대처하는 것이 아니라 공동체가 함께 대처하도록 주도하며 '질병과 함께 건강하기 살아가기'를 배울 수 있도록 구성

보건과의 핵심역량

2015 개정 보건 교육과정		2022 개정 보건 교육과정
– 건강 관리 능력 – 건강 정보 자원 활용 능력 – 건강 의사소통 능력 – 건강 의사결정 능력 – 건강·안전 위험 인식 능력 – 건강 사회·문화 공동체 의식	→	건강 문해력(health literacy), 협력적 의사소통 능력, 심미적 감성, 창의력, 건강정보와 건강자원의 활용 능력 등을 토대로 건강역량 강화 – 건강관리 역량 – 건강 옹호 역량 – 건강문제해결 역량

건강역량
건강관리 역량: 일상의 건강을 관리할 수 있는 능력
건강 옹호 역량: 자신만이 아니라 공동체의 건강을 함께 옹호하며 사회적 환경을 개선할 수 있는 능력
건강문제해결 역량: 건강문제가 있을 때 이를 해결할 수 있는 능력

내용 체계의

2015 개정 보건 교육과정		2022 개정 보건 교육과정
4대 영역, 11개 **핵심개념,** 일반화된 지식, 내용 요소, 기능의 5가지 항목으로 구성	→	**5대 영역**, 11개의 핵심 아이디어*와 내용 요소를 지식·이해 – 과정·기능 –가치·태도의 3개 범주로 구성

* 모든 내용 요소를 포괄하면서 내용 요소 간의 연계를 보여주는 상위 조직자를 의미

대영역과 내용 요소의

‘정서와 정신건강’과 ‘성과 건강’ 대영역으로 독립, 영역 간 내용 이동과 총론의 내용 반영

2015 개정 보건 교육과정			2022 개정 보건 교육과정	
대영역	핵심개념 – 내용 요소		대영역	중영역 – 내용 요소
1. 건강의 이해와 질병예방	건강증진		1. 건강증진과 질병예방	건강과 건강증진
	생활주기			건강신호와 생활주기
	질병예방 – 생활습관과 질병 – 감염병의 예방 및 관리	**4영역으로 이동**		질병예방과 건강생활기술
2. 생활 속의 건강한 선택	약물・담배・술	2영역으로 이동	2. 정서와 정신건강	중독과 건강
	성 건강	**대영역으로 독립**		정서・정신건강
	정서・정신건강	**대영역으로 독립**	3. 성과 건강	성과 성 발달
	건강생활 기술	1영역으로 이동		사랑, 권리와 책임
				성문화와 위험관리
3. 안전과 응급처치	생활안전		4. 건강안전과 응급처치	건강 안전 – 건강 안전의 의미와 위험요인 – 급・만성 질병 및 관리 – 면역과 감염병 예방 및 관리
	응급처치			사고예방 응급처치
4. 건강자원과 사회문화	건강권	**총론 반영하여 추가된 내용 요소**	5. 건강자원과 건강문화	건강권과 건강자원 – 디지털・인공지능 시대 건강자원의 변화・위험
	건강문화			건강문화 **– 기후변화와 사회적 건강문제**



[보건과 교육과정 설계의 개요]

나 학교급별 2022 개정 보건 교육과정의 내용

1) 초등학교(5~6학년) 보건 교육과정

※ 중·고등학교 보건과 교육과정과의 위계를 고려하여 초등 보건 교육과정 내용체계 및 성취기준을 연구안으로 제시한 자료

› 대영역1: 건강증진과 질병예방

성취기준	[6보01-01] 건강의 의미와 영향요인을 이해하고, 건강 습관을 점검하여 건강생활 실천 계획을 수립한다. [6보01-02] 생활주기와 건강의 관계를 알아보고, 일상생활 속에서 건강한 수면, 식습관, 신체 활동을 건강하게 관리하는 방안을 탐색한다. [6보01-03] 흔한 아동기 질병과 건강문제를 알아보고 예방관리를 위해 건강생활기술을 적용한다. [6보01-04] 건강옹호활동을 알아보고 자신과 주변의 건강증진을 위한 건강옹호활동을 탐구하여 제안하고 실천한다.	
핵심 아이디어	• 우리 삶의 질에 중요한 건강을 유지, 증진하기 위해서는 건강의 연속성과 항상성 및 다양한 영향 요인을 고려한 건강관리가 중요하다. • 건강관리의 생활화를 위해서는 몸과 마음의 신호를 알아차리고, 건강관리 모델과 전략, 건강생활기술, 정보, 자원을 활용할 수 있는 건강관리역량과 사회적 지지가 중요하다.	
범주	내용 요소	
[지식·이해]	건강과 건강증진	• 건강의 의미와 중요성 • 건강 영향요인
	몸과 마음	• 건강한 몸과 마음 • 생활주기와 생활습관 관리
	질병예방과 건강생활기술	• 질병 예방관리 • 건강생활기술과 건강옹호
[과정·기능]	건강이해	• 건강 상태 평가하기 • 수면, 식습관, 신체 활동 습관 평가하기
	건강탐구	• 질병 예방과 대처방안 탐색하기 • 건강관리 목표설정과 계획 세우기
	실천적용	• 건강생활기술 적용하기 • 건강옹호활동 계획하기
[가치·태도]	• 건강과 생활습관의 중요성 내면화 • 실천적 태도 내면화와 건강 향상 추구하기 • 건강생활기술 활용 및 건강옹호 실천 자세 갖기	

› 대영역2: 정서와 정신건강

성취기준	[06보02-01] 흡연과 음주의 문제점 및 대처 방안을 알아보고 또래의 권유나 압력 등의 위기 상황에서 건강생활기술과 건강옹호를 활용한다. [06보02-02] 약물·남용의 사례 및 문제점을 탐색하고, 올바른 약 사용법 및 약물 오·남용 예방 방안을 정보 및 자원과 연계하여 설명한다. [06보02-03] 자아 존중감의 의미, 감정의 이해를 토대로 관계 속에서 감정을 표현하고, 존중과 공감하는 방법을 나타낸다. [06보02-04] 서로의 차이를 인정하고, 다양성 존중을 토대로 건강한 관계 형성 방안을 제시한다.
핵심 아이디어	• 자신과 삶의 소중함에 대한 인식, 다양성 존중, 적절한 유대와 지지적 환경은 청소년기와 성인기의 건강하고 행복한 삶의 기초가 된다. • 흡연·음주 및 의약품의 오·남용은 개인과 사회의 건강 및 사회문제와 관련이 있으므로 내적인 힘과 생활기술 및 지지체계가 중요하다.

범주	내용 요소	
[지식・이해]	중독과 건강	• 흡연・음주와 중독 • 의약품 오・남용
	정서・정신건강	• 자아 존중감과 감정의 이해 • 다양성 존중과 건강한 관계 맺기
[과정・기능]	건강 이해와 탐구	• 약물의 문제점과 대처방안 탐색하기 • 건강생활기술 적용하기 • 약 사용법 및 약물・남용 예방 방안 조사하기
	실천 적용	• 자아 존중감 향상 방안 탐색하기 • 감정을 표현하고 공감하며 조절하기 • 타인과 건강한 관계 맺기 연습
[가치・태도]	• 건강한 자기효능감 향상과 행복 추구 • 유대 강화하기 • 건강한 선택 지지하기	

• 대영역3: 성과 건강

성취기준	[6보03-01] 성의 개념을 이해하고 성인지적 관점에서 성의 다양한 모습을 탐색한다. [6보03-02] 사춘기의 신체・심리・성적 발달과 생명의 탄생에 관해 탐구하며, 자아 개념 및 자신의 성장과 변화를 긍정적으로 수용하여 발전시킨다. [6보03-03] 성적자기결정권과 관련하여 경계와 차이를 존중하고, 생활 속에서 동의와 거절 등 적절한 의사소통으로 건강한 관계를 시도한다. [6보03-04] 성 상품화 음란물, 그루밍 등 위험요인을 알아보고 다양한 매체 속의 성 정보에 대한 비판적인 대처 방안을 제시한다. [6보03-05] 성 건강에 영향을 주는 위험요인을 탐색하고, 성인지 감수성을 토대로 평등한 사회 실현 및 성폭력 예방・대처를 위해 안전한 문화와 환경을 탐색한다.
핵심 아이디어	• 성 건강은 개인과 가족의 행복, 국가 발전에 기본이 된다. • 성 건강관리는 몸과 마음의 변화, 성인지 관점과 서로 다른 입장에 대한 균형 있는 접근, 규범의 이해를 필요로 한다.

범주	내용 요소	
[지식・이해]	성과 성 발달	• 성의 개념과 성 건강 • 사춘기와 성적 발달
	사랑, 권리와 책임	• 경계 존중과 이성교제 • 생명의 탄생
	성문화와 성적 위험	• 성 표현물과 음란물 • 차별과 고정관념 • 그루밍・디지털 성폭력과 미디어 문해력
[과정・기능]	건강이해와 탐구	• 성 건강의 의의와 증진 사례를 성인지적 관점에서 탐색하기 • 경계를 존중하며 친밀한 관계 탐색하기
	실천적용	• 성 건강문제와 위험・영향요인 탐구하기 • 건강한 성문화 형성 방안 제시하기
[가치・태도]	• 성 건강증진으로 건강한 자아와 행복 추구 • 성장과 변화에 대한 긍정적 수용 • 성인지 감수성 향상	

• 대영역4: 건강안전과 응급처치

성취기준	[06보04-01] 아동기에 흔히 발생하는 주요 급·만성 질병의 증상과 특성에 대해 알아보고, 질병 예방관리, 함께 살아가기를 위한 생활수칙을 도출한다. [06보04-02] 면역과 질병, 감염병의 관계에 대해 알아보고, 면역력 향상을 포함한 질병과 감염병 예방관리 방안을 설명한다. [06보04-03] 생활 속 건강·안전 위험요인을 탐색하고, 폭력, 학대, 따돌림 및 건강·안전 위험 상황에서 적절히 대처하고 협력할 수 있는 건강·안전 수칙을 정한다. [06보04-04] 흔히 발생하는 응급사례와 응급처치를 탐구하고 하임리히법과 심폐소생술 및 자동심장충격기 사용 등 대응 능력을 익혀 위험 상황에서 협력적으로 대처한다.	
핵심 아이디어	• 생활 속에는 늘 위험이 있을 수 있고, 다양한 건강위험은 문제가 되기 전 대체로 신호가 있으며, 도미노처럼 주변의 건강문제로 이어질 수 있으므로, 개인과 공동체의 안전 감수성 및 참여와 협력에 기반한 예방과 관리가 중요하다. • 위급 상황에서 공동체의 준비된 안전수칙 및 응급처치의 적용과 협력은 개인과 공동체의 사망 및 손상 악화 방지와 질병 회복의 결정 요인으로 작용한다.	
범주	내용 요소	
[지식·이해]	건강 안전	• 알레르기, 당뇨 등 아동기 질병의 이해와 예방 • 면역과 감염병
	사고예방 응급처치	• 학대, 따돌림과 생활 안전 • 응급처치와 하임리히법 및 심폐소생술·자동심장충격기
[과정·기능]	건강이해와 탐구	• 급·만성 질병에 대해 알아보기 • 급·만성 질병이 안전에 미치는 위험 이해하기
	실천적용	• 질병 예방 관리 및 안전 수칙 정하기 • 응급처치 방법 알아보고 시연하기
[가치·태도]	• 건강과 안전에 대한 감수성 갖기 • 안전 위협·응급상황에서 적극적으로 대처하고 협력하는 자세 • 질병예방과 건강안전 수칙을 익히고 적용하려는 태도	

• 대영역5: 건강자원과 건강문화

성취기준	[6보05-01] 건강권과 건강정보 및 자원의 개념을 이해하고, 활용 방안을 탐색한다. [6보05-02] 디지털·인공지능 시대의 건강정보와 자원, 건강문화를 탐색하여 건강관리 활용 및 바람직한 건강문화 형성을 위한 방안을 제시한다. [6보05-03] 기후·환경의 변화가 건강과 질병에 미치는 영향을 알아보고, 변화에 대처하고 생활 속에서 실천하는 방안을 추론한다. [6보05-04] 공동체의 건강문제와 건강에 영향을 미치는 건강문화를 탐색하여 공동으로 대처하고 건강하게 개선할 방안을 제시한다.	
핵심 아이디어	• 건강 수준은 가정환경, 성, 경제 수준 등에 따라 차이가 있으므로 건강을 옹호하고 지지하는 건강지향적인 사회 환경이 필요하다. • 디지털 기술과 미디어, 인공지능 시대의 보건의료 환경 및 의료서비스의 변화는 사람들의 건강정보와 건강자원의 선택 및 활용에 영향을 미친다. • 인류의 건강을 위협하는 기후변화는 지속 가능한 사회를 위한 건강문화 조성 및 공동체의 책임감과 연대를 필요로 한다.	
범주	내용 요소	
[지식·이해]	건강권과 건강자원	• 건강권 • 디지털·인공지능 시대의 건강정보와 자원
	건강문화	• 건강 문해력과 디지털 리터러시 • 기후환경 변화와 개인·공동체의 건강 • 건강문화와 사회적 건강문제
[과정·기능]	건강이해와 탐구	• 건강권과 건강정보·건강자원 알아보고 활용하기 • 디지털 미디어가 건강에 미치는 영향 탐색하기
	실천적용	• 사회적 건강문제를 탐색하여 건강문화 발전시키기 • 디지털 미디어 활용 방안 탐색하기
[가치·태도]	• 건강권 및 건강정보·자원을 중시하는 태도 • 건강문제에 공동으로 대처하고 건강문화를 추구하는 자세	

2) 중학교 보건 교육과정

중학교 보건 과목에서는 초등학교에서 습득한 건강생활습관을 강화하는 한편, 몸과 마음에 대한 이해와 존중, 올바른 건강 지식과 기술, 정보를 토대로 건강생활을 실천하고 나아가 약물, 성, 정서의 조절능력을 기르고 협력적으로 건강문제와 위험에 대처하며 서로의 건강을 옹호함으로써 개인과 공동체의 건강역량을 기른다.

중학교 하위목표
(1) 건강을 중시하고 건강 개념 및 몸과 마음의 신호를 이해하며 건강생활을 실천하고 삶의 질 향상과 행복을 추구하며 건강을 관리할 수 있다.
(2) 건강생활기술을 단련하여 약물, 성, 정서에 대한 조절 능력을 기르고, 건강문제 상황에서 행복하고 건강한 선택을 지지하는 한편, 창의적이고 협력적으로 문제를 해결할 수 있다.
(3) 건강 안전을 위협하는 각종 질병과 위험요인을 사전에 파악하고 대비하며, 질병이 있어도 함께 건강하게 살아가며 응급건강권에 대한 이해를 바탕으로 다양한 건강정보와 건강자원을 탐색하고 건강 문해력과 디지털 문해력을 배양하며, 상황에 안전하게 대처할 수 있다.
(4) 개인과 공동체의 건강증진과 환경 개선을 위한 건강옹호를 할 수 있다.
(5) 기후변화, 감염병 등 사회·문화적 환경 변화가 건강에 미치는 영향과 건강문제들을 탐색하고 건강에 유익하지 못한 관행 등 건강문화의 변화를 도모하며, 국제적이고 통합적인 건강역량을 기른다.

- 대영역1: 건강증진과 질병예방

성취기준	[9보01-01] 건강의 개념과 영향요인, 건강관리 모델을 탐구하여 건강을 관리하는 태도를 갖는다. [9보01-02] 몸과 마음의 신호와 건강지표를 통해 건강상태를 평가하여 건강관리에 적용한다. [9보01-03] 건강한 수면, 식습관, 신체활동에 대해 알아보고 건강생활습관을 계획하고 실천한다. [9보01-04] 건강문제와 건강생활기술을 탐색하여 질병을 예방할 수 있도록 건강을 관리한다. [9보01-05] 건강에 대한 사회적 지지의 중요성을 인식하고 개인과 공동체의 건강옹호활동을 협력적으로 탐색한다.	
핵심 아이디어	• 우리 삶의 질에 중요한 건강을 유지, 증진하기 위해서는 건강의 연속성과 항상성 및 다양한 영향요인을 고려한 건강관리가 중요하다. • 건강관리의 생활화를 위해서는 몸과 마음의 신호를 알아차리고, 건강관리 모델과 전략, 건강생활기술, 정보, 자원을 활용할 수 있는 건강관리 역량과 사회적 지지가 중요하다.	
범주	내용 요소	
[지식・이해]	건강과 건강증진	• 건강 개념과 영향요인 • 건강관리모델 • 건강에 대한 사회적지지
	건강신호와 생활주기	• 몸과 마음의 신호와 건강지표 • 생활주기와 건강생활습관
	질병예방과 건강생활기술	• 건강문제 및 질병 예방과 건강관리 • 건강생활기술 • 건강옹호와 협력
[과정・기능]	건강이해	• 건강 개념 및 가치와 영향요인 탐색하기 • 몸과 마음의 신호 이해하기
	건강탐구	• 건강상태를 확인하고 건강관리 방안 제시하기 • 건강관리 모델을 알아보고 생활에 적용하기 • 건강관리 목표와 전력을 세우고 평가하기
	실천적용	• 건강문제와 건강생활기술을 탐색하여 건강관리 실천하기 • 건강옹호활동을 이해하여 사례에 적용하기
[가치・태도]	• 건강과 행복의 소중함 • 건강의 가치와 내면화 및 건강을 관리하려는 태도 • 몸과 마음의 신호에 대한 민감성 • 건강생활기술 활용 및 옹호와 협력에 대한 적극성	

• 대영역2: 정서와 정신건강

성취기준	[9보02-01] 약물 오·남용과 흡연, 음주의 유혹과 압력에 대해 안전하게 선택하고 대처·옹호한다. [9보02-02] 행위 중독이 건강에 미치는 영향과 위험요인 및 대처방안을 탐색하여 예방하고 관리하려는 태도를 갖는다. [9보02-03] 자아 존중감에 대해 이해하고 생활 속에서 자아 존중감을 높이는 상황과 저하시키는 상황을 탐색하여 대처하고 지지하여 건강한 자아상을 추구한다. [9보02-04] 감정과 스트레스의 적절한 인식과 표현, 지지와 공감 및 다양성 존중을 통해 관계 속에서 행복함과 건강한 관계 맺기를 보여준다. [9보02-05] 삶과 죽음, 상실의 의미에 대한 성찰을 바탕으로, 삶의 소중함을 깨닫고 죽음·상실에 건강하게 대처하는 자세를 지지한다.
핵심 아이디어	• 자신과 삶의 소중함에 대한 인식, 다양성 존중, 적절한 유대와 지지적 환경은 청소년기와 성인기의 건강하고 행복한 삶의 기초가 된다. • 흡연·음주 및 의약품의 오·남용은 개인과 사회의 건강 및 사회문제와 관련이 있으므로 내적인 힘과 생활기술 및 지지체계가 중요하다.

범주		내용 요소
[지식·이해]	중독과 건강	• 흡연·음주·약물 오·남용 • 행위 중독
	정서·정신건강	• 감정·공감 및 지지 • 자아존중감 • 스트레스 관리 • 삶·죽음·상실의 의미
[과정·기능]	건강이해 건강탐구 실천적용	• 정서와 정신건강 및 영향요인 알아보기 • 약물과 중독의 기전을 이해하고 조절하기 • 감정을 이해하고 적절하게 표현하여 행복한 관계 맺기 • 건강하고 안전한 선택 지지하기 • 유혹과 압력 등에 대처 및 옹호하기 • 다양성을 존중하며 유대 강화 및 환경 개선하기
[가치·태도]		• 자신과 타인의 삶을 소중히 여기고 존중하는 태도 • 건강한 자아·유대와 행복 추구 • 위험요인 감수성과 중독에 대한 비판적 태도

• 대영역3: 성과 건강

성취기준	[9보03-01] 성의 개념과 성역할 및 영향요인에 대해 성인지적 관점에서 탐색하여 안전하고 행복한 성문화와 성의식의 필요성을 이해한다. [9보03-02] 청소년기 성적 발달과 관계, 신체상에 대해 알아보고 사회적 조건을 이해하며 건강하게 관리한다. [9보03-03] 성적자기결정권을 균형 있게 탐색하여 안전하고 행복한 대처전략을 세우고 이성 교제 시 경계를 존중하고 배려하는 자세를 갖는다. [9보03-04] 성폭력·성매개감염병 등 성 건강 위험요소를 미디어 문해력 및 성문화와 관련지어 탐색하고 건강하게 관리·옹호한다. [9보03-05] 임신, 피임에 대한 이해를 바탕으로 십대의 임신과 미혼 부모 문제가 개인과 사회에 미치는 영향을 분석하고 건강에 유익한 선택과 자원을 지지한다. [9보03-06] 청소년의 성 건강과 관련하여 사회적 쟁점이 있는 이슈들에 대해 다양한 입장의 근거와 맥락, 고정 관념, 차별, 불평등한 상황을 파악하여 균형 있고 평등한 성문화를 조성하려는 자세를 갖는다.
핵심 아이디어	• 성 건강은 개인과 가족의 행복, 국가 발전에 기본이 된다. • 성 건강관리는 성인지 관점 및 서로 다른 입장에 대한 균형 있는 접근과 이해를 필요로 한다.

범주	내용 요소

[지식・이해]	성과 성 발달	• 성의 개념 • 성적 발달과 신체상
	사랑, 권리와 책임	• 성적자기결정권 • 이성교제와 경계 존중 • 성역할 및 임신과 피임
	성문화와 위험관리	• 성폭력・성매매감염병 등 성 건강위험 • 성 건강문제와 관리・옹호 • 성문화
[과정・기능]	건강이해 건강탐구 실천적용	• 성 건강과 관련된 생리와 주제, 제도, 권리 탐색하기 • 성적 발달에 대해 알아보고 건강하게 관리하기 • 디지털 미디어와 성문화를 탐색하여 개선하기 • 안전하고 행복한 선택을 위한 균형있는 관점으로 대처전략 세우기 • 청소년 성 건강문제를 알아보고 예방・관리하기 • 성과 관련된 차별, 고정관념, 평등, 존중에 대해 알아보고 평가하기
[가치・태도]	• 안전하고 행복한 성의식과 성문화 함양 • 성인지 감수성 및 차이를 존중하고 공감・배려하는 자세 • 성 건강을 근거를 가지고 관리하는 태도 • 성 미디어 문해력 함양	

• 대영역4: 건강안전과 응급처치

성취기준	[9보04-01] 건강안전의 의미와 위험요인을 탐구하여 질병과 사고를 예방하고 관리하며 건강안전 지향적 환경 개선에 적극적인 태도를 갖는다. [9보04-02] 급・만성 질병의 위험요인과 건강에 미치는 영향을 탐색하여, 질병과 함께 건강하게 살아가기 위한 방안을 세우고 실천한다. [9보04-03] 감염병과 면역의 원리를 이해하고 개인과 공동체가 지켜야 할 건강수칙을 탐색하여 근거와 함께 제안하고 실천한다. [9보04-04] 상황에 따른 응급처치의 원리와 방법을 이해하고, 다양한 위기 및 응급 상황에서 적절한 응급처치와 협력적 대응 방안을 탐색하여 적용한다. [9보04-05] 응급의료체계의 활용 방안을 탐색하고 심폐소생술과 자동심장충격기의 원리와 사용법을 익혀 협력적으로 바르게 적용한다.	
핵심 아이디어	• 생활 속에는 늘 위험이 있을 수 있고, 다양한 건강위험은 문제가 되기 전 대체로 신호가 있으며, 도미노처럼 주변의 건강문제로 이어질 수 있으므로, 개인과 공동체의 안전 감수성 및 참여와 협력에 기반한 예방과 관리가 중요하다. • 위급 상황에서 공동체의 준비된 안전수칙 및 응급처치의 적용과 협력은 개인과 공동체의 사망 및 손상 악화 방지와 질병 회복의 결정 요인으로 작용한다.	
범주	내용 요소	
[지식・이해]	건강 안전	• 건강 안전의 의미와 위험요인 • 급・만성 질병 및 관리 • 면역과 감염병 예방 관리
	사고예방 응급처치	• 공동체의 문화와 건강 안전 및 관리 • 건강수칙・응급처치・협력
[과정・기능]	건강이해 건강탐구 실천적용	• 건강 안전의 개념과 위험요인을 탐구하여 예방・대처방안 탐색하기 • 질병과 면역의 원리를 이해하고 건강수칙 탐색하기 • 위급 상황에서 협력적 건강 안전관리 방안을 탐색하고 실천하기 • 질병과 함께 건강하게 살아갈 방안을 탐색하여 생활에 적용하기 • 다양한 응급상황에서 협력적 응급처치와 심폐소생술・자동심장충격기 사용 방법을 익히고 실천하기
[가치・태도]	• 건강과 안전에 대한 감수성 내면화 • 건강안전 관리 방안에 대한 탐색적 태도 • 질병 예방과 응급처치에 대한 관심과 참여	

• 대영역5: 건강자원과 건강문화

<table>
<tr><td>성취기준</td><td colspan="2">[9보05-01] 건강권 발전을 위한 노력과 건강자원을 탐색하여 공동체의 건강권 향상을 위한 활동에 관심을 가지고 참여한다.
[9보05-02] 디지털·인공지능 시대에 따른 보건의료서비스와 건강정보를 포함한 건강자원의 변화를 알아보고 건강에 유익하게 활용하며 개선방안을 탐색한다.
[9보05-03] 기후변화와 건강의 관계를 탐색하고, 지속가능한 사회를 위한 개인과 공동체의 건강옹호활동을 탐구하고 실천한다.
[9보05-04] 건강 신념과 규범·관행 및 미디어 등이 건강에 미치는 영향을 탐색하고 건강하게 개선하려는 태도를 발전시켜 건강관리와 건강문제 해결에 적용한다.
[9보05-05] 다양성 존중과 사회적 소수자 배려를 포함하여 건강지향적 문화와 환경을 지지·옹호한다.</td></tr>
<tr><td>핵심
아이디어</td><td colspan="2">• 건강 수준은 가정환경, 성, 경제 수준 등에 따라 차이가 있으므로 건강을 옹호하고 지지하는 건강지향적인 사회 환경이 필요하다.
• 디지털 기술과 미디어, 인공지능 시대의 보건의료 환경 및 의료서비스의 변화는 사람들의 건강정보와 건강자원의 선택 및 활용에 영향을 미친다.
• 인류의 건강을 위협하는 기후변화는 지속가능한 사회를 위한 건강문화 조성 및 공동체의 책임감과 연대를 필요로 한다.</td></tr>
<tr><td>범주</td><td colspan="2">내용 요소</td></tr>
<tr><td rowspan="2">[지식·이해]</td><td>건강권과
건강자원</td><td>• 건강권
• 건강정보와 보건의료서비스건강자원
• 디지털·인공지능 시대 건강자원의 변화·위험</td></tr>
<tr><td>건강문화</td><td>• 건강 문해력과 디지털 문해력
• 기후변화와 사회적 건강문제
• 건강 신념과 규범·관행 등 건강문화와 지속가능한 환경</td></tr>
<tr><td rowspan="2">[과정·기능]</td><td>건강이해
건강탐구</td><td>• 건강권 발전을 위한 노력과 자원 탐색하기
• 디지털·인공지능 건강정보와 보건의료서비스 및 건강자원의 변화와 활용 탐색하기
• 문화와 기후변화가 건강에 미치는 영향 탐색하기</td></tr>
<tr><td>실천적용</td><td>• 건강옹호활동 주도하기
• 건강지향적 문화와 환경 지지·옹호하기</td></tr>
<tr><td>[가치·태도]</td><td colspan="2">• 건강에 대한 권리와 책임 인식
• 건강한 환경 변화를 위한 참여의식 내면화
• 건강의 가치화와 다양성 존중</td></tr>
</table>

3) 고등학교 보건 교육과정

고등학교 보건 과목에서는 중학교에서 습득한 건강에 대한 가치, 지식, 태도, 기술 및 역량을 강화하고 건강 영향요인과 건강정보 및 자원을 분석, 평가하여 건강예방 및 건강증진의 개인적·사회적 실천을 탐색한다.

고등학교 하위목표
(1) 다양한 건강 개념을 토대로 몸과 마음의 상태와 건강 영향요인을 고려하여 건강생활을 실천하고 균형 있게 삶의 질 향상과 행복을 추구하며 건강을 관리할 수 있다.
(2) 건강생활기술을 단련하여 성, 정서, 중독 등 다양한 건강문제에 대해 안전하고 행복한 선택을 할 수 있고, 위험요인과 지지·협력 체계를 평가하여 창의적으로 건강문제를 해결할 수 있다.
(3) 건강 안전을 위협하는 각종 질병과 위험요인을 사전에 파악하고 대비하며 공동체의 대응 체계를 발전시켜, 질병이 있어도 함께 건강하게 살아가며 응급상황에 안전하게 대처할 수 있다.
(4) 건강권의 역사, 건강정보, 건강자원 및 법과 제도를 탐색하고 건강 문해력과 디지털 문해력을 배양하여, 개인과 공동체의 건강증진과 건강지향적 환경을 옹호할 수 있다.
(5) 건강문화와 기후변화, 감염병 등 사회·문화적 환경 변화가 건강에 미치는 영향 및 대응 방안을 비교·분석하고 건강문화를 건강지향적으로 개선하려는 태도로 개선방안과 국제연대를 탐색할 수 있다.

- 대영역1: 건강증진과 질병예방

<table>
<tr><td>성취기준</td><td colspan="2">[12보건01-01] 건강 개념과 건강영향요인을 다양한 관점으로 탐구하여 개인과 공동체의 건강 증진을 추구하는 태도를 갖는다.
[12보건01-02] 몸과 마음의 신호와 건강지표를 통해 개인적, 사회적 건강상태를 평가하여 건강관리를 계획하고 생활화한다.
[12보건01-03] 생애주기별 건강 특성을 고려한 건강관리 전략을 건강관리 제도와 연관지어 탐색한다.
[12보건01-04] 건강관리의 역사를 통해 건강관리에 대한 관점과 전략을 비판적으로 검토하여 건강관리 및 제도 변화 모색에 시사점을 적용한다.
[12보건01-05] 개인·공동체의 질병예방과 건강관리에 건강생활기술과 건강관리모델을 적용하여 평가하고, 국가적·국제적 수준의 건강문제와 이에 대한 건강옹호 방안을 탐색한다.</td></tr>
<tr><td>핵심
아이디어</td><td colspan="2">• 건강은 우리 삶의 질에 중요한 가치를 가지며 총체적으로 행복한 상태를 추구하는 공통성이 있지만 여러 측면이 있으므로 해석과 수용이 다양하다.
• 개인과 공동체의 건강증진은 건강에 영향을 미치는 다양한 요인을 고려한 포용성, 시민성을 토대로 건강관리 역량을 강화하고, 공동체가 함께 전략을 수립하며 협력적으로 실천할 때 가능하다.</td></tr>
<tr><td>범주</td><td colspan="2">내용 요소</td></tr>
<tr><td rowspan="4">[지식·이해]</td><td>건강과
건강증진</td><td>• 다차원적 건강 개념과 건강영향요인
• 건강지표와 건강 평가
• 건강관리의 역사와 제도 및 모델
• 건강에 대한 사회적 지지와 역할 및 책임</td></tr>
<tr><td>신호와
생활주기</td><td>• 몸과 마음의 신호와 변화
• 생애주기별 건강 특성과 건강관리 및 제도</td></tr>
<tr><td>질병예방과
건강생활 기술</td><td>• 개인과 공동체, 국가의 질병예방과 건강관리
• 건강생활기술과 건강자원
• 개인·공동체·국가의 건강옹호와 협력 및 네트워크</td></tr>
<tr><td rowspan="3">건강이해</td><td>• 건강의 가치와 다차원적 개념 탐구하기
• 건강요구와 지지·장애요인 분석하기
• 생애주기별 건강 특성을 제도와 연관하여 이해하기</td></tr>
<tr><td rowspan="2">[과정·기능]</td><td>건강탐구</td><td>• 몸과 마음의 신호를 평가하고 해석하기
• 건강상태 및 건강관리 모델을 평가하여 건강관리 계획하기
• 건강 지표를 분석하여 활용하기</td></tr>
<tr><td>실천적용</td><td>• 건강관리하기
• 네트워크 활용 및 건강옹호하기</td></tr>
<tr><td>[가치·태도]</td><td colspan="2">• 건강 가치화와 건강관리 및 건강증진 실천 의지
• 건강지향적 환경 개선 의지
• 소통과 협력하며 반성과 개선 인식
• 건강관리의 생활화</td></tr>
</table>

• 대영역2: 정서와 정신건강

성취기준	[12보건02-01] 의약품 오·남용의 개인적, 사회적 위험과 영향요인을 분석하고 문화적 제도적 변화를 고려하여 의약품을 안전하게 선택할 수 있다. [12보건02-02] 물질 및 행위 중독의 특성, 위험과 영향 요인을 분석하고, 개인적, 사회적 측면에서 중독 예방과 지지체계를 탐색하여 제시한다. [12보건02-03] 정서·정신건강을 이루는 요소와 관련된 개인적, 사회적 요인을 연계하여 탐구하고, 자아 존중감과 회복 탄력성 및 유대 증진 방안을 도출하여 건강을 관리한다. [12보건02-04] 감정 및 정서가 삶에 미치는 영향과 행복 및 스트레스, 우울·불안·질병 등을 초래하는 상황의 조건과 의미를 탐구하여, 개인과 공동체의 행복한 삶의 양식을 지지한다. [12보건02-05] 삶과 죽음 및 상실의 개인적, 사회적, 문화적 의미와 이에 대한 질문을 스스로 구성하고 응답하여, 삶의 소중함을 깨닫고 죽음·상실에 대한 쟁점에 대해 의사결정을 할 수 있다.
핵심 아이디어	• 물질 오·남용과 행위 중독은 개인과 사회의 건강 및 사회문제와 관련이 있으므로 문제에 대처할 수 있는 내적인 힘, 생활기술과 지지체계 및 환경 조성이 중요하다. • 감정, 성격, 유대 등 정신건강을 이루는 요소들은 개인적 특성과 사회, 문화, 환경적 요인의 상호작용에 영향을 받으며 삶의 질에 영향을 준다.

범주		내용 요소
[지식·이해]	중독과 건강	• 의약품 오·남용 • 물질 및 행위 중독
	정서·정신건강	• 정서·정신건강 이해 • 감정과 성격의 이해와 관리 • 우울 및 불안과 스트레스 관리 • 삶과 죽음·상실의 개인적·사회·문화적 의미
[과정·기능]	개념이해 건강탐구 실천적용	• 정서·정신건강의 의의와 영향 요인을 탐색하여 관리하기 • 약물과 중독의 기전을 이해하고 조절하기 • 건강하고 안전한 선택을 지지하고 다양성을 존중하며 지지체계 및 제도 개선하기 • 정서·정신건강의 문제와 위험을 사회적 환경과 연계하여 관리하기 • 감정과 성격을 사회적 조건과 관련지어 이해하고 행복한 삶의 양식 발전시키기 • 내적인 힘, 생활기술 및 미디어와 자원을 활용하여 유혹과 압력, 폭력에 대처·옹호하기
[가치·태도]		• 건강한 자아상과 유대 및 행복 추구 • 자아 존중감과 회복 탄력성 • 위험 요인 감수성 및 중독에 대한 사회적 관점과 비판적 태도

• 대영역3: 성과 건강

<table>
<tr><td>성취기준</td><td colspan="2">[12보건03-01] 성의 개념과 생애주기별 성적 특성을 성인지적 관점에서 탐색하여 건강하고 행복한 성 의식과 성문화 및 환경을 추구한다.
[12보건03-02] 성적 발달과 신체상 및 몸에 대한 권리에 대해 알아보고 성건강을 관리하며 개선방안을 제안한다.
[12보건03-03] 사랑과 성적 자기 결정권을 사회적 조건과 연계하여 균형 있게 탐색하여 안전하고 행복한 선택을 위한 대처전략을 세우고 실천·옹호한다.
[12보건03-04] 성 건강 및 권리의 사회적 맥락을 탐색하여 생리, 임신과 피임, 미혼부모 등 건강관리에 균형 있게 적용하고 대안을 모색하는 태도를 갖는다.
[12보건03-05] 성매개감염병을 포함하여 성 건강을 위협하는 문제들을 성문화 및 성역할과 관련지어 비판적으로 탐색하여 건강관리에 적용하고 성미디어 문해력 향상을 포함한 개인적·사회적 대안과 제도 개선을 제안한다.
[12보건03-06] 성폭력을 포함한 성 건강 관련 쟁점 이슈들에 대해 다양한 입장의 근거와 맥락, 고정관념, 차별, 불평등한 상황을 파악하여 건강관리에 적용하고, 법과 제도·문화 등 변화 방안을 제안·옹호한다.</td></tr>
<tr><td>핵심
아이디어</td><td colspan="2">• 성 건강은 개인과 가족의 행복과 국가 발전에 중요한 토대가 된다.
• 성의 다양한 측면에 대해 사회적 맥락을 고려하여 평등하고 균형 있는 시각으로 이해하는 것이 성 건강관리의 기초가 된다.</td></tr>
<tr><td>범주</td><td colspan="2">내용 요소</td></tr>
<tr><td rowspan="3">[지식·이해]</td><td>성과
성 발달</td><td>• 성의 다양한 개념
• 생애주기별 성적 특성과 관리
• 성적 발달과 건강관리
• 신체상과 몸에 대한 권리</td></tr>
<tr><td>사랑,
권리와 책임</td><td>• 사랑과 성적자기결정권
• 성 건강 및 권리와 임신·피임·미혼부모
• 성 역할과 성인지 감수성</td></tr>
<tr><td>성문화와
성적 위험</td><td>• 성 건강문제와 성매개감염병 및 위험 이슈
• 성문화와 성폭력·성매매 예방대책
• 성미디어 문해력
• 성 건강 관련 제도와 정책</td></tr>
<tr><td>[과정·기능]</td><td>건강이해
실천적용</td><td>• 성 건강문제를 균형 있게 탐색하여 건강을 관리하고 개선하기
• 성과 건강, 발달, 사랑, 위험, 담론에 작용하는 요인 탐색하기
• 안전하고 행복한 선택이 가능한 조건을 탐색하여 관리하고 실천하기
• 성 건강 관련 제도와 정책 및 환경을 탐색하여 건강관리에 적용하고 개선·옹호하기</td></tr>
<tr><td>[가치·태도]</td><td colspan="2">• 개인과 공동체의 행복과 안전·평등 추구
• 비판적이고 균형 있는 태도
• 공감과 객관화 및 균형
• 건강을 저해하는 편견과 차별 및 위험요인 감수성
• 취약성에 대한 주의</td></tr>
</table>

• 대영역4: 건강안전과 응급처치

성취기준	[12보건04-01] 건강안전의 의미와 위험요인을 평가하고, 개인·공동체·국가 수준의 예방과 대처, 안전 문화를 포함한 건강안정 지향적 환경 개선을 탐색하고 실천한다. [12보건04-02] 인체의 기초 생리와 병리에 대한 이해를 바탕으로 주요 급·만성 질병의 위험요인을 사회적 조건과 관련지어 탐색하고 대비하여 질병이 있어도 함께 건강하게 살아가 수 있도록 관리한다. [12보건04-03] 감염병과 면역의 원리를 이해하고 개인과 공동체가 지켜야 할 건강수칙과 대응 방안을 사회적 차원에서 비판적으로 탐색하여 생활에 적용한다. [12보건04-04] 직업과 근로 조건, 작업 환경을 포함한 영향요인 및 법과 제도를 분석하여 안전 수칙을 포함한 예방관리 방안 및 개선방안을 제안한다. [12보건04-05] 다양한 응급상황에서 심폐소생술 및 자동심장충격기 사용을 포함한 응급처치 방법을 익혀서 협력적으로 적용하며, 응급의료체계와 자원의 활용을 포함한 건강 안전 방안을 탐색하고 발전시킨다.
핵심 아이디어	• 생활 속에는 늘 위험이 있을 수 있고, 다양한 건강위험은 문제가 되기 전 대체로 신호가 있으며, 도미노처럼 주변의 건강문제로 이어질 수 있으므로, 건강안전을 위해서는 개인과 공동체의 안전 감수성 및 참여와 협력에 기반한 예방 및 대비 체계가 필요하다. • 위급 상황에서 골든타임 내 안전수칙 및 응급처치의 신속하고 정확한 적용과 적절한 자원 및 협력 체계는 사망 및 손상 방지와 질병 회복의 결정요인으로 작용한다.

범주		내용 요소
[지식·이해]	건강 안전	• 건강 안전의 의미와 위험요인 • 암·심혈관계 질환 등 주요 급·만성 질병과 직업병 안전관리·제도 • 면역과 감염병 관리체계 및 제도
	사고예방 응급처치	• 공동체의 문화와 건강 안전 및 자원 • 안전수칙과 응급처치·협력체계 및 제도
[과정·기능]	건강이해	• 개인과 공동체의 위험요인을 평가하고 예방·대처방안 탐색하기 • 인체와 주요 급·만성 질병의 기초 생리와 병리 이해하기 • 질병과 함께 건강하게 살아가며 건강한 환경 추구하기
	건강탐구 실천적용	• 위급 상황에서 협력적으로 건강과 안전을 지키는 수칙, 제도를 탐색하여 활용하기 • 다양한 응급처치와 심폐소생술 및 자동심장충격기 사용 익히고 협력체계와 자원을 탐색하여 다양한 응급상황에 대처하기
[가치·태도]		• 건강과 안전에 대한 공동체 감수성 • 공감과 협력적 소통 • 응급처치 및 협력적 대처 방안 탐색 및 실천 의지

• 대영역5: 건강안전과 건강문화

<table>
<tr><td>성취기준</td><td colspan="2">[12보건05-01] 건강권과 건강자원 관련 제도의 발전 과정을 이해하고 비판적으로 탐색한다.
[12보건05-02] 권리의식과 책임감을 가지고 건강증진을 위한 건강자원의 활용 가능성, 제도와 정책 개선 방안 제안 등 건강 지향적 환경을 탐색하고 옹호한다.
[12보건05-03] 디지털·인공지능 시대에 따른 보건의료 서비스 및 제도, 건강 정보의 변화를 탐색하고 관련된 쟁점을 종합하여 균형 있게 활용하고 개선 방안을 제안한다.
[12보건05-04] 기후변화가 건강에 미치는 영향을 탐색하고, 지속가능한 사회를 위한 개인·국가·세계의 협력과 연대, 옹호 활동의 실천 방안을 탐색한다.
[12보건05-05] 개인과 사회의 건강 인식·선택·행위에 미치는 건강 신념·규범·관행·미디어의 영향을 분석하여 개인과 공동체의 건강관리에 유익한 건강문화 형성과 확산 방안을 제시한다.</td></tr>
<tr><td>핵심 아이디어</td><td colspan="2">• 건강 수준은 성, 가정환경, 경제 수준 등에 따라 차이가 있으므로 건강에 대한 권리 의식과 책임의식, 균형 있는 가치관에 기반한 건강옹호와 사회적 환경 개선이 필요하다.
• 디지털 기술과 미디어, 인공지능 시대의 보건의료 환경 및 의료서비스의 급격한 변화는 사람들의 건강 정보와 건강자원의 선택 및 활용에 영향을 미친다.
• 인류의 건강을 위협하는 부적절한 관행 및 기후·생태환경의 변화는 지속가능한 사회를 위한 건강문화와 환경조성에 공동체의 책임감과 연대를 필요로 한다.</td></tr>
<tr><td>범주</td><td colspan="2">내용 요소</td></tr>
<tr><td rowspan="2">[지식·이해]</td><td>건강권과
건강자원</td><td>• 건강권의 역사와 의료보장
• 건강정보와 보건의료서비스 체계
• 건강자원과 건강정책 및 제도·건강지향적 환경
• 디지털·인공지능 시대 건강자원</td></tr>
<tr><td>건강문화</td><td>• 건강 문해력과 건강 데이터·디지털 문해력
• 기후변화와 사회적 건강문제 및 국제 연대
• 건강 신념·규범·관행 등 건강문화와 지속 가능한 환경</td></tr>
<tr><td>[과정·기능]</td><td>건강이해
건강탐구
실천적용</td><td>• 건강권 보장을 위한 사회·제도적 노력과 건강지향적 환경 개선을 탐색하고 제안하기
• 디지털·인공지능 건강정보와 보건의료서비스를 포함한 건강자원의 변화와 활용 방안을 제안하기
• 건강문화와 기후변화가 개인과 공동체의 건강과 윤리에 미치는 영향을 탐색하여 지속가능한 발전을 위한 협력과 연대, 옹호하기</td></tr>
<tr><td>[가치·태도]</td><td colspan="2">• 건강정보·자원의 비판적 탐색과 활용 생활화
• 건강과 상호 작용하는 사회적·문화적 요인에 대한 감수성
• 공동체 건강문제에 대한 심미적 감수성</td></tr>
</table>

다 교수·학습 방향 및 방법

1) 교수·학습 방향

- 단순 지식의 암기가 아니라 일상생활과 연계하여 주도적으로 건강을 탐구하고 건강문제를 파악하여 건강관리 계획 및 전략을 수립하며 건강에 유익한 선택을 생활화하도록 한다.
- 유의미한 맥락을 제공하여 학습한 내용을 다양한 상황에서 발생하는 유혹과 압력, 편견과 고정 관념에 대처하며, 지지요인을 강화할 수 있도록 한다.
- 다양한 상황과 맥락 속에서 건강에 영향을 미치는 사회문화적 요인들을 탐구하고 건강에 유익한 변화를 도모하며, 건강관리를 위해 생활 속에서 활용할 수 있는 경험, 기술, 역량을 발전시키도록 한다.
- 개인, 가족, 공동체의 건강문제에 감수성을 높이며, 건강을 옹호하고 다양성과 차이를 존중하며, 모두가 건강한 삶을 유지하는 방안과 권리, 제도를 모색하도록 한다.
- 최소 성취수준 보장을 위해 낮은 성취의 원인을 파악, 학습 상황을 점검하고 예방 차원의 과제 부여 및 상담 등을 통해 학업을 정상적으로 수행할 수 있도록 한다.

2) 교수·학습 방법

- 학습자가 삶과 연계하여 주도적으로 탐구하고 친구들과 경험과 결과를 나누며 종합하는 과정에서 배움이 일어나도록 한다.
- 수업의 결과가 건강에 유익한 태도와 건강생활습관 형성, 건강생활 실천으로 이어지도록 한다.
- 학습 과정에서 건강역량이 반복적으로 연습되어 평생 건강과 공동체 건강을 도모하는 기본으로 다져지도록 한다.
- 교수·학습 자료는 다양하고 생활과 연계성이 높은 구체적인 것을 사용하고 디지털·인공지능 교수매체를 특성을 살려 온·오프라인 수업에 효과적으로 활용한다.
- 온·오프라인 수업에서 다양한 디지털 기기와 프로그램을 활용하여 학생들의 요구와 학습 내용 차이를 고려하며 학습자들의 적극적인 참여를 유도한다.
- 조사, 토의, 토론, 주제 발표, 개별학습과 소집단 협동 수업, 디지털 기기 활용 수업, 팀 게임 활용 수업, 쌍방향 의사소통 수업, 지역사회 전문가 협력 수업, 시범, 역할놀이, 실습, 지역사회 기관 견학 등 다양한 학습 방법을 활용한다.

라 평가 방향 및 방법

1) 평가 방향

- 과정 평가를 중심으로 학습자의 주도성, 학습자 간 상호작용, 맥락의 적절성을 평가한다.
- 습득한 건강 지식, 태도, 건강역량을 새로운 상황에서 적용할 수 있는지를 평가한다.
- 개인 평가, 동료 평가, 소집단·공동체 활동에 대한 평가를 적절하게 활용한다.
- 디지털 도구를 활용한 평가 방안을 마련한다.
- 학습 속도가 느린 학습자 등 다양한 학습자에 대한 맞춤형 평가 방안을 마련한다.

2) 평가 방법

- 평가 목표와 내용은 교육과정의 내용 체계와 내용 요소를 근거로 설정하되 학습자의 성취 수준을 고려하여 학습 전후 내용을 분석하고 학습자의 수준을 진단할 수 있는 준거를 마련하여 평가한다.
- 과정 평가를 중심으로 수행평가, 서술형 및 논술형 평가, 활동평가, 학생 간 평가, 개별 맞춤형 피드백 강화 등 다양한 평가 방식을 적절하게 혼합하여 평가하되 일회적인 평가는 지양한다.
- 루브릭, 포트폴리오, 모둠 토론 내용 관찰, 개별 면담, 전체 활동을 통한 직접 평가 등 다양한 평가 방식을 활용하여 학습자의 지식·기능·태도를 아우르는 종합적이고 균형 있게 평가한다.
- 개인 및 공동체의 건강역량을 구성하는 능력과 소양을 평가할 수 있는 여러 가지 사례를 제시하고 그에 따른 활동을 평가하여 그 결과 건강에 유익한 방향으로 강화하도록 한다.
- 대면 수업 또는 원격 수업 과정에서 다양한 디지털 도구를 활용하여 평가 방법의 다양화를 모색한다.

※ 2022 개정 보건 교육과정 원문은 '에듀넷·티-클리어(www.edunet.net)에서 다운로드 가능

마 보건교육의 평가

1) 성취기준, 성취수준의 의미

가) 교육과정 성취기준

- 국가 교육과정에 진술된 성취기준
- 학생들이 각 교과(목)의 영역별 내용 요소(지식・이해, 과정・기능, 가치・태도)를 학습한 결과 궁극적으로 할 수 있거나 할 수 있기를 기대하는 도달점
- 학교 현장에서 수업의 방향을 설정하고 교수・학습 내용 선정뿐만 아니라 교과서 개발 및 검・인정을 위한 중요한 기준으로도 활용. 또한 단위 학교에서 학생의 학업성취 정도를 확인하기 위한 기준으로도 활용 가능함

나) 성취수준

- 학생들이 각 교과목의 성취기준에 도달한 정도
- 도달한 정도는 몇 개의 수준으로 구분하고, 각 수준에 속한 학생들이 무엇을 알고 할 수 있는지를 기술

① 영역별 성취수준

– 영역 단위 성취수준으로, 영역 내 성취기준들을 포괄하는 전반적인 특성을 학교급, 교과목의 특성에 따라 3수준 또는 5수준으로 구분하여 진술

– 보건은 '학교생활기록부 작성 및 관리지침'에 근거한 P/F 평가 과목으로, 영역별 성취수준은 P로 개발

② 성취기준별 성취수준

– 성취기준 단위 성취기준으로, 학교급, 교과목, 성취기준의 특성에 따라 3수준, 5수준으로 구분하여 진술

– 보건은 '학교생활기록부 작성 및 관리지침'에 근거하여 성취기준별 성취수준을 3수준(A, B, C)로 개발

다) 성취수준의 일반적 특성

- 3수준 구분 성취수준의 일반적 특성

성취수준	일반적 특성	성취율
A	교과목의 교수・학습을 통해 기대하는 지식・이해, 과정・기능, 가치・태도에 도달한 능력 정도가 우수한 수준 • 개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 높음 • 기대하는 가치와 태도를 조직화하고 실천과 적용 범위가 높음	80% 이상
B	교과목의 교수・학습을 통해 기대하는 지식・이해, 과정・기능, 가치・태도에 도달한 능력 정도가 보통 수준 • 개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통이거나 지식 습득이 다소 제한적임 • 배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준이거나 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음 • 기대하는 가치와 태도를 일부 조직화 하고, 실천과 적용 범위가 다소 제한적임	60% 이상 80% 미만
C	교과목의 교수・학습을 통해 기대하는 지식・이해, 과정・기능, 가치・태도에 도달한 능력 정도가 제한된 수준 • 위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임 • 연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음 • 기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음	40% 이상 60% 미만

• 내용 체계 범주에 따른 3수준 구분 성취수준의 일반적 특성

범주	성취수준	일반적 특성
지식 · 이해	A	개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 높음
	B	개념에 대한 이해와 지식 수준이 보통이거나 지식 습득이 다소 제한적임
	C	위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임
과정 · 기능	A	배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙함
	B	배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준이거나 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음
	C	연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음
가치 · 태도	A	기대하는 가치와 태도를 조직화하고, 실천과 적용 범위가 넓음
	B	기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고 실천과 적용 범위가 보통이거나 다소 제한적임
	C	기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음

2) 영역별 성취수준

교과 교육과정의 내용 체계와 성취기준(들)을 분석하여 지식 · 이해, 과정 · 기능, 가치 · 태도의 위계 수준을 고려하여 영역별로 성취수준을 작성한다.

가) 개발절차

• 교육과정이 영역을 중심으로 내용 요소를 제시하므로 영역을 개발 단위로 결정한다.
• 영역의 내용 체계와 성취기준(들)의 지식 · 이해, 과정 · 기능, 가치 · 태도의 내용 요소 추출 및 위계를 분석한다.
• 영역별로 지식 · 이해, 과정 · 기능, 가치 · 태도의 범주를 중심으로 포괄적이고 전형적인 능력을 포함하여 영역별 성취수준 진술문을 작성한다. 또한, 영역 내 성취기준별 성취수준을 각 수준과 연계한다.
• 영역별 성취수준을 작성 후 각 영역 간 성취 수준의 진술 정도, 전후 학년(군)과의 능력 진술 위계 등을 점검한다.

중학교

영역	영역별 성취수준		
건강증진과 질병예방	P	지식 · 이해	건강의 연속성과 다양한 영향 요인을 체계적으로 이해하고, 건강관리를 위한 건강지표와 건강관리 모델 및 전략, 건강 생활 기술, 건강 정보와 자원을 활용하는 방법을 설명할 수 있다.
		과정 · 기능	몸과 마음의 신호인 건강지표를 통해 자신의 건강 상태를 파악하여 그에 맞는 건강관리 목표와 전략을 세우고 평가할 수 있으며, 다양한 건강 문제 상황에서 건강 생활 기술을 건강관리에 적용할 수 있다.
		가치 · 태도	건강과 행복의 소중함을 이해하고, 자기 몸과 마음의 신호에 대한 민감성을 바탕으로 건강 생활 기술을 실천하며, 건강 옹호 활동에 적극성을 가지고 협력하여 건강의 가치를 내면화하려는 태도를 지닌다.
정서와 정신건강	P	지식 · 이해	유혹과 압력과 행위 중독에 대해 안전하게 대처하는 방법을 설명할 수 있다. 또한 삶과 죽음의 의미를 이해하고, 자신과 타인의 감정을 인식할 수 있으며, 적절한 스트레스 관리 방법을 설명할 수 있다.
		과정 · 기능	흡연 · 음주의 유혹과 압력 등에 적절하게 대처 및 옹호하고, 건강하고 안전한 선택을 지지할 수 있다. 또한 건강한 관계 맺기를 위해 정서와 정신건강 및 영향 요인을 알아보고, 감정을 적절하게 표현하는 기술을 적용할 수 있다.
		가치	자신과 타인의 삶을 소중히 여기고 존중하며, 약물 및 행위 중독과

영역	영역별 성취수준		
		· 태도	이에 따른 위험 요인에 대한 비판적인 태도를 바탕으로 건강한 자아상 및 유대와 행복을 추구하며 행복한 삶의 가치를 내면화하려는 태도를 지닌다.
성과 건강	P	지식 · 이해	성의 개념, 성적 발달과 신체상, 성적 자기 결정권과 성 역할에 대해 명확하게 이해하며, 임신과 피임의 원리를 체계적으로 설명할 수 있다. 또한 성폭력·성 매개 감염병 등 성 건강 위험 요인에 따른 성 건강 문제 관리 방법을 설명할 수 있다.
		과정 · 기능	청소년 성 건강 문제, 디지털 미디어와 성 문화를 탐색하여 안전하고 행복한 선택을 할 수 있으며, 성 건강관리를 위해 균형 있는 관점으로 대처 전략을 세울 수 있다.
		가치 · 태도	성 인지 감수성과 차이를 존중하고 공감·배려하는 자세를 바탕으로 성 미디어 문해력과 안전하고 행복한 성 의식을 함양하여 성을 건강하게 관리하는데 주체적인 태도를 지닌다.
건강안전과 응급처치	P	지식 · 이해	건강 안전의 의미와 위험 요인, 응급처치, 질병과 면역의 원리를 명확하게 이해하며, 개인과 공동체의 참여와 협력에 기반한 예방과 관리의 중요성을 인식하고, 급·만성 질병 및 감염병 예방을 위한 방법 및 건강 수칙을 설명할 수 있다.
		과정 · 기능	위급 상황에서 협력적 건강 안전 관리 방안을 탐색하고, 질병과 함께 건강하게 살아갈 방안을 생활에 적용할 수 있다. 또한, 다양한 응급 상황에서 응급처치와 심폐소생술, 자동심장충격기 사용 방법을 익혀 적용할 수 있다.
		가치 · 태도	건강과 안전에 대한 감수성을 바탕으로 질병 예방과 응급처치, 건강안전을 지향하는 환경 개선과 관리 방안에 관심을 가지고 안전한 사회를 적극적으로 추구하는 태도를 지닌다.
건강자원과 건강문화	P	지식 · 이해	건강권, 건강 신념과 규범·관행 등 건강 문화, 건강 정보 및 보건 의료 서비스, 건강 자원, 기후변화와 사회적 건강 문제에 대해 명확하게 이해하고, 디지털·인공지능 시대의 보건 의료 환경 및 의료 서비스의 변화가 건강에 미치는 영향을 설명할 수 있다.
		과정 · 기능	건강 문해력과 디지털 문해력을 통해 디지털 인공지능 건강 정보와 보건 의료 서비스 및 건강 자원의 변화를 탐색하고 건강에 유익한 방향으로 이를 활용할 수 있다.
		가치 · 태도	건강에 대한 권리와 책임 의식을 바탕으로 기후변화에 따른 사회적 건강 문제 및 사회적 소수자 배려를 포함한 공동체의 건강권 향상에 관심을 가지고 건강 옹호 활동을 주도적으로 실천할 수 있으며, 건강 지향적 문화와 사회 환경을 위한 참여 의식을 내면화하려는 태도를 지닌다.

고등학교

영역	영역별 성취수준		
건강증진과 질병예방	P	지식 · 이해	건강 개념과 건강 영향 요인에 대한 이해를 바탕으로 건강지표, 건강 생활 기술과 건강 자원, 생애 주기별 건강 특성을 고려하여 건강 관련 역사·제도와 관련지어 개인·공동체·국가의 건강 옹호와 협력 및 네트워크 구성 과정에 대한 종합적 관점을 가질 수 있다.
		과정 · 기능	건강의 가치와 다차원적 개념을 타구할 수 있고, 몸과 마음의 신호, 건강 요구와 지지·장애 요인을 평가·해석하고 네트워크를 활용한 건강증진 전략을 수립할 수 있다.

영역	영역별 성취수준		
		가치 · 태도	건강관리·건강증진에 대한 실천 의지를 갖고, 건강 지향적 환경 개선 및 건강 옹호 활동에 적극적으로 참여하고 건강관리를 생활화할 수 있다.
정서와 정신건강	P	지식 · 이해	의약품 오남용, 물질 및 행위 중독을 이해하고, 정서·정신건강 관련하여 감정과 성격·스트레스 관리, 삶과 죽음, 상실의 의미를 개인·사회·문화적 맥락에서 통찰력 있는 시각을 가질 수 있다
		과정 · 기능	정서·정신건강의 의의와 영향 요인을 탐색하여, 행복한 삶의 양식을 위해 개인·사회·공동체가 합리적인 선택을 하고, 유혹과 합력, 폭력으로부터 안전하고 건강한 지지 체계 및 제도 개선에 참여하고 옹호할 수 있다.
		가치 · 태도	위험 요인 감수성 및 중독에 대한 비판적 태도를 지니고, 자아 존중감·회복 탄력성을 바탕으로 건강한 자아상을 형성하여 행복을 추구할 수 있다.
성과 건강	P	지식 · 이해	생애 주기별 성적 특성 및 성적 발달을 고려하여 성적 자기 결정권, 성폭력 예방을 포함한 성 건강관리, 임신·피임·미혼 부모, 성인지 감수성, 성 매개 감염병 및 성 미디어 문해력을 이해하고, 사회·문화적 맥락에서 성 건강증진 관련 제도와 정책을 설명할 수 있다.
		과정 · 기능	성 건강 문제와 안전하고 행복한 선택이 가능한 조건을 탐색하여, 성 관련 제도·정책·환경을 개선·옹호하고 성 건강관리를 실천할 수 있다.
		가치 · 태도	성과 사랑에 대하여 비판적이고 균형 있는 태도를 지니고, 편견과 차별, 위험 요인에 대한 감수성을 기르고 개인과 공동체의 행복과 안전·평등을 추구할 수 있다.
건강안전과 응급처치	P	지식 · 이해	건강 안전과 위험 요인, 급·만성 질병, 직업병 면역과 감염병 관리 체계를 이해하고, 인체 기초 생리·병리에 근거한 응급처치 방법을 숙지하여 개인·사회적 응급관리 및 협력 체계를 종합적으로 설명할 수 있다.
		과정 · 기능	건강과 안전을 지키는 수칙과 제도, 협력 체계와 자원을 탐색하여, 개인과 공동체의 위험 요인과 대처 방안을 제시하여 다양한 응급 상황에 적용할 수 있다.
		가치 · 태도	공감과 협력적 소통을 기반으로 건강·안전에 대한 공동체 감수성을 지니고, 응급처치를 실천하려는 의지를
건강자원과 건강문화	P	지식 · 이해	건강권·건강 자원의 역사와 건강 정책 및 제도를 고려하여 건강 문해력과 건강 지향적 환경을 이해하고, 기후변화와 건강 문제 및 지속 가능한 환경을 위한 국제 연대의 필요성을 인지할 수 있다.
		과정 · 기능	건강 문화 및 기후변화와 관련지어 개인과 공동체의 건강 보장을 위한 건강 지향적 환경 개선 방안을 제안하고, 지속 가능한 발전을 위해 디지털·인공지능 시대의 건강 자원과 정보를 탐색하고 활용할 수 있다.
		가치 · 태도	건강 정보 및 자원에 대한 비판적 탐색과 활용을 생활화하고, 공동체 건강 문제 및 건강 문화에 대한 심미적 감수성을 바탕으로 건강 증진을 추구할 수 있다.

4 보건교육의 실제

가 수업 설계하기

수업 설계에 앞서 '내 수업 속에 어떤 가치를 담을 것인가', '내 수업으로 어떻게 학생의 성장을 도울 것인가'와 같은 수업에 대한 성찰은 좋은 수업에 밑거름이 된다.

1) 목표 설정하기

- 학생을 배움의 주체로, 중단기 학습목표를 학생과 공유하고 나아가 학생 스스로 학습목표를 세울 수 있도록 돕는다.
- 교사의 지원 모습, 피드백 계획, 학생 개별 맞춤 교육 계획, 학생이 자신의 학습을 어떻게 평가하고 성찰할 것인가에 대한 계획이 필요하다.
- 과정 중심 평가로 학생들이 자신의 도달점을 알도록 한다.

2) 학습자 분석하기

- 학생의 연력, 성별, 사회적 배경, 이전 학습 경험이나 학습 수준, 흥미 등 학생을 이해하고 이를 고려한 수업 설계는 효과적인 수업에 필수적이다.

3) 교육과정 및 교과서 분석과 재구성하기

- 교육과정과 교과서를 분석하고 학생의 특성과 학습 수준, 교육 환경 등을 고려하여 교육과정을 재구성한다.

교과 교육과정 재구성(예시)

교과 교육 특성 및 교과 목표 확인	→ • 2022 개정 교육과정의 교과 목표와 일반 목표 확인 • 2교과 교육과정, 학생 수준 등 분석하여 교육 목표 수립
↓	
교육과정 및 교과서 분석, 성취기준 분석	→ • 2022 개정 교육과정의 교과 목표와 일반 목표 확인 • 2교과 교육과정, 학생 수준 등 분석하여 교육 목표 수립
↓	
성취기준 중심의 교육과정 재구성	→ • 2022 개정 교육과정의 교과 목표와 일반 목표 확인 • 2교과 교육과정, 학생 수준 등 분석하여 교육 목표 수립
↓	
활동 중심 수업 모형 구안, 평가 계획 수립	→ • 2022 개정 교육과정의 교과 목표와 일반 목표 확인 • 2교과 교육과정, 학생 수준 등 분석하여 교육 목표 수립
↓	
최소 성취기준 중심의 교수·학습 및 평가 예시 자료 개발	→ • 2022 개정 교육과정의 교과 목표와 일반 목표 확인 • 2교과 교육과정, 학생 수준 등 분석하여 교육 목표 수립

출처: 교육부(2021), 중고등학교 교과별 교육과정 재구성 예시 자료집

4) 내용 선정하기

- 성취 기준과 핵심 아이디어, 학습 목표, 수업 분량(차시), 내용 요소 및 학생 활동, 학습 자료 교수·학습 방법 및 전략 등을 선정한다.

깊이 있는 학습을 위한 교수·학습 방향

핵심 아이디어 중심의 수업 설계	• 2핵심 아이디어를 중심으로 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소를 유기적 연계, 학생의 발달 단계에 따라 학습 경험의 폭과 깊이를 확장하도록 설계한다.
↓	
교육 내 영역 간, 교과 간 내용 연계성 고려	• 교과 내 영역 간, 교과 간 내용 연계성을 고려하여 수업을 설계·지도함으로써 학생들이 융합적으로 사고하고 창의적으로 문제를 해결하는 능력을 함양할 수 있도록 한다.
↓	
삶과 연계한 의미 있는 학습	• 학습 내용을 실생활 맥락 속에서 이해하고 적용하는 기회를 제공함으로써 학교에서의 학습이 학생의 삶에 의미 있는 학습 경험이 되도록 한다.
↓	
탐구 방법의 학습 및 학습에 대한 학습	• 학생에게 교과의 탐구 방법을 익히고 자신의 학습 과정과 학습 전략을 개선하는 기회를 제공하여 스스로 탐구하고 학습할 수 있는 자기주도 학습능력을 함양토록 한다.

출처: 교육부(2022), 2022 개정 교육과정 총론 해설: 중학교

5) 평가 계획 수립하기

- 평가 기준(성취기준)과 평가 요소, 온오프라인 평가 방법 및 평가 도구, 채점 기준, 피드백 방안 등을 계획한다.

나 교수·학습 과정안(수업안) 작성

교수·학습 과정안이란 학습자가 특정한 목표에 도달할 수 있도록 내적·외적 환경을 체계적으로 조성해 주기 위하여 어떠한 내용을 어떤 과정이나 방법으로 지도할 것인가를 예상하고 작성한 수업의 설계도로 수업안, 수업 지도안, 학습 지도안 등으로도 불린다.

수업 지도안은 계획을 위한 계획이 되지 않아야 하며 학습목표 달성을 위한 논리적이고 체계적인 수업 설계안이 되어야 한다.

1) 좋은 교수·학습 과정안의 조건

- 교수·학습 과정안은 학습 내용, 교재의 종류, 학습자의 요구 수준, 학습 환경 등을 고려하여 계획하며 필요에 따라서는 임시로 학습지도 계획을 변경할 수 있도록 융통성 있게 작성하여야 한다. 또한 수업 경험이 적은 경우에는 다양한 세안을 작성하는 훈련을 하는 것이 좋으며 특히, 연구 수업을 준비할 때는 세밀한 수업안이 도움이 된다.

- 예상했던 학습목표 달성의 결과에 대해 설명이 되어 있어야 한다.
- 이전 학습과 연결되어야 한다.
- 학습내용 및 시간 분배가 적절해야 한다.
- 학습목표와 내용 및 평가가 일체화를 이루어야 한다.
- 구체적인 평가 계획이 포함되어 있어야 한다.
- 교육 주제에 적절한 교수·학습 방법을 적용한 수업안이어야 한다.
- 물리적 교육 환경, 수업 자료와 준비물이 고려된 수업안이어야 한다.
- 연구 수업, 공개 수업 등의 경우 참관자를 배려하는 수업안이어야 한다.

2) 교수·학습 과정안의 형식

- 교수·학습 과정안은 명칭, 형식 등이 다양하므로 정형화된 틀을 고집하기보다는 각 학교에서 주로 사용하는 형식이나 수업 주제와 맞는 형식을 사용하면 된다. 다양한 형식에서 공통적인 요소를 들어보면 ① 단원 ② 단원의 개관 ③ 단원의 목표 ④ 단원의 전개, 계획, 평가, 유의점 ⑤ 실태 분석 ⑥ 교재 연구 ⑦ 수업자의 의도 ⑧ 본시 교수·학습 과정안 등이 있다.
- 수업안의 형식은 수업 형태에 따라 크게, 약안, 세안, 세세안으로 분류할 수 있다. 약안은 본시 수업안만 간략하게 작성하는 것이고, 세안과 세세안은 기재되는 내용은 같지만 본시 수업안이 일반적이면 세안이고, 본시 수업안을 T.S(Teacher.Student)안으로 작성되면 세세안이라고 할 수 있다. 수업을 치밀하게 시나리오식으로 하고 싶은 경우에 T.S형식의 세세안을 작성하면 도움이 많이 된다.

교수·학습과정안(예시)

단원명(차시)		학습주제		교사명	
일시		대상		장소	
성취기준	초등학교 성취기준은 중학교 교육과정의 성취기준을 참고하여 작성할 수 있다.				
학습목표	구체적인 목표를 1~2개 진술한다.				
교과 역량	□ 건강관리 역량 □ 건강옹호 역량 □ 건강문제해결 역량				
평가 방법					
평가 기준 (성취수준)	평가 요소:	A			
		B			
		C			
평가 유의점					
지도 중점 및 유의점					

단계	교수·학습 활동 내용	교수·학습 자료
도입	선수학습 상기 동기 유발 학습목표 제시	예) 관련 영상 자료, 신문기사, 사진, 도서 등
전개	새로운 정보 제시 학습 안내 수행 유도, 연습 피드백 제공	예) 교과서, 디벗, 활동지 붙임쪽지. 사인펜, 가위 실습모형 등
정리	파지 및 전이 촉진 형성평가 다음 차시 예고	예) 다양한 디지털 평가, 평가지, 보고서 등

5 2026학년도 범교과 학습 주제 교육과정 반영 시수

범교과 학습 개요

- (운영근거) 「초·중등학교 교육과정 총론」 Ⅲ. 학교급별 교육과정 편성·운영의 기준
- (운영방법) 범교과 학습 주제 간 통합 운영, 관련 교과 교육과정을 재구성한 연계·운영 등 교육활동 전반(교과, 창의적 체험활동 등)에 걸쳐 탄력적으로 운영
- (관련자료) 범교과 학습주제 적용 관련 자료 「에듀넷·티-클리어」에 탑재

범교과 학습주제	세부 주제	기준 시수	의무 여부	편성·운영 방법
① 안전·건강	생활안전, 교통안전 폭력예방 및 신변보호, 약물 및 사이버(인터넷) 중독예방, 재난안전, 직업안전, 응급처치	51	의무	• 교육과정과 연계한 안전교육 편성 프로그램과 안전교육 자료 적극 활용 ※ 학교안전정보센터(www.schoolsafe.kr) 참고 • 최근 학생안전사고가 증가하는 자전거, 전동형킥보드 등 개인형이동장치(PM)에 대한 교육 필수 편성 ◦ (교육과정 내) 학교급별 교육과정 수업시간의 1/3 이상을 교육한 경우 1차시로 인정 ※ 초등학교 10분, 중고등학교 15분 이상 ◦ (교육과정 외) 수업 전·후, 방과후, 행사 등에서 1회 5분 이상, 총 5회 이상 정기적으로 실시하는 교육은 1차시로 인정 ※ 단, 교육시간(단위: 차시)은 반드시 공문 및 계획 등 입력 근거에 의해서 실시된 것만 인정 가능
	소방 안전교육	연 1회	의무	• 안전교육 통합 운영 및 교과교육 연계(소방훈련 별도)
	양성평등교육	15	의무	• 안전·건강교육, 인성, 민주시민교육 등과 통합하거나 교과 및 창의적 체험활동과 연계 • 법정의무교육(성폭력, 가정폭력, 성매매 예방)을 위한 시수 필수 편성 ※ 디지털 성폭력예방을 위한 교육 별도 편성 권장
	보건교육	17	의무	• 한 개 학년 이상 최소 17차시 이상 편성 • 교육부지침(연도별 학생건강증진분야 주요업무 추진방향)에 따라 시도교육청은 보건교육계획을 수립하고, 학교는 교육청의 지침에 따라 보건교육을 계획·실시
	건강한 식생활 및 영양교육	연 2회	의무	• 교과 및 창의적체험활동 연계·운영 • 안전·건강 교육과 통합 운영 가능
	생명존중 및 자살예방교육 (사회정서교육)	6	의무	• 안전교육, 인성교육 등과 통합하거나 교과교육과 연계 운영할 경우 시수 인정
	학교폭력 예방교육	11	의무	• 교과·창의적 체험활동과 연계 운영하거나 안전교육, 인성교육 등 관련 주제와 통합 운영할 경우 시수 인정 • 어울림(사이버어울림) 프로그램'을 활용한 교육 실시

범교과 학습주제	세부 주제	기준 시수	의무 여부	편성·운영 방법
② 인성	인성교육	의무	의무	• 도덕, 실과, 기술·가정, 정보 등 관련 교과를 통해 세부 주제 통합 운영 권장
	교육활동 침해행위 예방교육	연 1회	의무	• 교과 및 창의적 체험활동과 연계 운영하거나 인성교육, 민주시민교육, 안전교육 등 관련 주제와 통합 운영할 경우 시수 인정
	디지털 시민교육	의무	의무	• 교과 및 창의적 체험활동, 학교자율시간 등 학교급별 교육과정과 체계적으로 연계하여 실시
③ 진로	진로교육	의무	의무	• 교과(중고는 '진로와 직업' 포함), 창의적 체험활동(진로활동), 중학교 자유학기(진로탐색활동) 등 학교급별 교육과정과 체계적으로 연계된 진로교육 실시
④ 민주시민	민주시민교육	–	권장	• 통합교과(바·슬·즐), 국어, 사회, 도덕, 통합사회 등 관련 교과를 통해 세부 주제 통합·운영 ※ 선거 교육 시, 중앙선거관리위원회 선거연수원 교육자료(새내기유권자 연수 등) 적극 활용
⑤ 인권	장애인식 개선교육	2	의무	• 인권교육, 교과교육과 연계하거나 장애인의 날 및 장애이해수업과 연계할 경우 시수 인정
⑥ 다문화	다문화 이해교육	2	의무	• 교과교육 연계 및 세계인의 날(5.20.)과 연계할 경우 시수 인정
⑦ 통일	통일교육	의무	의무	• 통일교육주간(5월 4주)과 연계 운영 • 도덕, 사회 등 관련 교과와 통합·운영 • 통일부 찾아가는 학교통일교육 등 적극 활용 ※ 5시간 이상 운영 권장(소관 부서에서 별도 안내 예정)
⑧ 독도	독도교육	10시간 이상	권장	• 교과, 창의적체험활동 등 학교급별 교육과정과 통합 • 독도교육주간과 연계하여 운영
⑨ 경제·금융	경제·금융교육	–	권장	• 사회, 실과, 기술·가정, 경제, 통합사회, 실용경제 등 교과와 통합·운영
⑩ 환경· 지속가능발전	환경·지속가능한 발전교육	–	의무	• 환경, 사회, 실과 등 관련 교과와 통합·운영

Ⅲ

학생 건강검사 추진·결과 관리

단위업무	주요내용	참고·서식자료
계획	1. 건강검사 계획 수립 (3월 31일까지) ▪ 2026년 학생 건강관리 추진계획 반영 ▪ 전(前)학년도 건강검사 결과 평가 및 반영 ▪ 건강검사 소요 예산 파악, 검진비용 확인 ▪ 학생건강검진 방법 결정(출장·방문검진, 1개 기관선정 등) ▪ 학생건강검사 결과 기록 및 추후 관리 사항 2. 검진기관 선정 ▪ 학교운영위원회 심의 또는 자문 가능함	•2026 학생 건강검사 추진·결과 관리계획(p.64) •2026 건강검사 검사항목별 검진비용 (p.74)
운영	1. 신체의 발달상황(3~7월, 모든 학년, 학교자체측정*) * 단, 건강검진 실시 학생은 검진기관에서 실시할 수 있음 ▪ 초등: 키·몸무게 측정, 비만도 산출 ▪ 중·고등: PAPS연계 ▪ 결과처리 – NEIS 신체발달통계 생성 및 8월 30일까지 보고(NEIS제출) – 과체중 이상 비만학생: 학생·학부모에게 통보, 별도프로그램 운영	•신체의 발달상황에 대한 검사항목 및 검사방법 (p.83) •예시자료 (p.84) – 신체발달상황·시력검사 실시기안, 계획, 결과기록부, 가정통신문
	2. 건강조사 (3~7월, 모든 학년, 학교자체조사) ▪ 학교건강검사규칙 별표 1의 2(건강조사 항목 및 방법): 2026년 학생건강관리추진계획 서식 「건강조사 설문지 초·중등용」 활용 ※ 건강검진 문진표(검진기관용 문진표) 사용 불가 ▪ 건강검진 대상자 포함하여 모든 학년 실시 – 초등학생: 가정에서 작성하여 제출토록 안내 ▪ 신입생 건강조사, 응급처치 동의서와 연계 조사 ▪ 건강조사 결과 요보호자 선정→요보호자 명단작성→상담 및 기록 ▪ 건강조사 실시 후 관련 항목에 따라 관련 업무담당교사(학교폭력/상담/담임교사) 의뢰	•건강조사 항목 및 방법 (p.75) •건강조사 설문지 (초등용) (p.76) •건강조사 설문지 (중등용) (p.78) •요보호 학생 선정 (p.98) •요보호 학생 관리 명단 (p.99) •요보호 학생 건강상담 기록 카드 (p.100)
	3. 학생건강검진(3~11월, 초1·4/중·고1학년, 검진기관) ▪ 검진기관 방법 결정(출장, 방문검진 등 승인요건) ◦ 2개 이상의 검진기관 선정: 건강검진기본법에 따라 지정된 기관선정 ◦ 1개 기관 선정 가능한 경우 : 지역내 검진 1개 또는 검진참여기관 1개, 100명 이하의 검진인원 ◦ 출장검진 – 승인신청가능 학교: 학교 소재 지역 검진기관의 미참여, 기숙사 학교, 건강검사 표본학교 – 승인요청 제외(당연 출장검진 처리) : 학교 소재지역 검진기관이 없는 경우, 특수학교 ▪ 검진기관 선정 및 계약 ▪ 건강검진 실시 – 검진기관 문진표 활용: 건강검진 문진표, 구강검진 문진표 – 학교보건법 제7조, 학교건강검사규칙에서 정한 항목 이외의 검사 금지 ▪ 건강검진 및 구강검진 통보서 수령 및 발송 – 검진기관에서 발급한 결과통보서 발송 및 보관 : 출력물 1부 학교 보관(5년), 1부 학생·학부모 발송 ▪ 만족도 조사 실시, 만족도 조사 결과 홈페이지 공개 ▪ 건강검진 결과 유소견자 사후관리(2차 검진, 정밀검진, 조기치료 등) – 유소견자가정통신문 발송 및 학부모 회신문 수합 ◦ 요보호자 추가 관리 ◦ 학생 건강검진 결과 분석 후 차기년도 건강관리계획에 반영	•학생 건강검진 기관 선정 완화 승인요건 (p.69) •학생 건강검진 승낙서 (p.80) •건강검진 항목 및 방법 (p.82) •예시자료 (p.89) – 학생건강검진안내 가정통신문 – 유소견자 안내 가정통신문 – 초등 구강검진 안내 – 초등 구강검진 재검진 안내 •학생 건강검사 추진실태 점검표 (p.93) •학생건강검진 기관 만족도 조사 및 결과분석 (p.97)

단위업무	주요내용	참고·서식자료
운영	4. 학생구강검진 (3월~11월, 초2・3・5・6, 검진기관) ▪ 검진기관선정: 검진기관의 자격요건에 따라 별도선정여부 결정 – 종합병원(의과+치과)의 경우 별도의 구강검진기관 선정 불필요 – 일반병원(의과)의 경우 별도의 구강검진기관 선정하여야 함 5. 별도의 검사 (소변검사, 시력검사, 결핵검사) [하단표 참고] ▪ 소변검사: 비영리 검사기관 또는 검진기관 중 선정 ▪ 시력검사: 학교 자체 검진 - 측정자: 교직원 ▪ 결핵검사: 대한결핵협회 3월~12월 6. 건강검사 관련 추진실적 보고	•2026 학생 건강검사 추진·결과 관리계획(p.64) •결핵검진 지역별 일정 (p.88) : 중・고등학교 : 학교별 세부일정 추후안내 : 연락처 ☎ 042-252-9860
평가	1. 사후 관리 ▪ 결과확인, 정밀검사안내, 학부모 회신서 확인 (종합감사 대비하여 사후 관리 철저) 2. 학생건강기록부에 검진 내용 입력 ▪ 건강기록부(NEIS) 관리 안내자료: 4세대 지능형 나이스 사용자 설명서 ※ 충청남도교육청누리집 – 부서별누리집 – 체육건강과(학교보건자료실) – 345번 참고 (4세대 지능형 나이스(NIES) 사용자 설명서(보건)) ▪ 학생의 재·전·편입학, 상급학교 진학시 건강기록부 전산(NEIS) 이송, 학생건강검사결과통보서 및 구강검진결과통보서 별도 이송하지 않음 ▪ 학생건강기록부 점검(매년): 학생기록부의 누락, 입력착오 등 확인 후 변경사항 발생시 건강기록부 정정 조치 3. 사후관리 대장 활용 및 건강 상담 실시	[서식5] 학생 건강검사 추진현황 [서식6] 학생건강검사 결과처리현황 [나이스제출] 신체발달상황 통계표 [서식7] 학생건강검진 통계표 •학생건강기록부 기록방법 (p.103) •학생 건강기록부 점검 및 정정대장(P.107) ※ 학기말 건강기록부 마감처리 (4세대 지능형 나이스(NEIS) 사용자 설명서(보건))

1 2026년 학생 건강검사 추진·결과 관리계획

가 기본방침

- 성장기 학생들의 올바른 생활습관 및 건강상태를 파악하고, 질병을 조기에 발견·치료하여 건강한 삶 도모
- 개선이 필요한 건강행태 또는 건강문제, 질병이 발견된 학생에 대해서는 교육 및 건강 상담, 치료 및 보호 등 적절한 대책 강구

나 추진방향

학교건강검사규칙 제2조

○ 학교의 장은 학교보건법 제7조에 따른 건강검사를 원활하게 실시하기 위하여 건강검사에 필요한 소요 예산을 포함한 구체적인 건강검사 실시계획을 매년 3월 31일까지 수립하여야 한다.

- 학생 건강검사는 「학교보건법」 제7조, 「학교건강검사규칙」에 따라 실시
- 학생·학부모의 선택권을 보장할 수 있도록 검진기관 선정 추진
- 검사 결과 적극 활용과 유증상자에 대한 사후관리 철저
- 신체발달 측정 및 건강조사 1학기 내 완료 (2020년 「학교건강검사규칙」 개정)

다 추진근거 및 현황

- 초·중·고등학교에서는 「학교보건법」 및 「학교건강검사규칙」에 따라 학생에 대한 건강검사를 실시하고 있으나, 학생건강증진계획 수립 시 학생 건강검사 조사결과 활용도 미흡
- 인스턴트 섭취율 증가, 신체활동 저하 등의 사유로 코로나19 이후 과체중 및 비만 학생의 비율이 30% 수준을 유지하고 있는 것으로 확인

※ 연도별 비만군(과체중 + 비만) 학생 비율: ('19) 235.8% → ('21) 30.8% → ('22) 30.5% → ('23) 29.6% → ('24) 29.3%

– 영유아부터 성인에 이르기까지 전생애 주기 건강검진 결과 관리 체계 구축, 학생·학부모의 건강검진기관 선택권 확대, 학교 업무 경감 기대

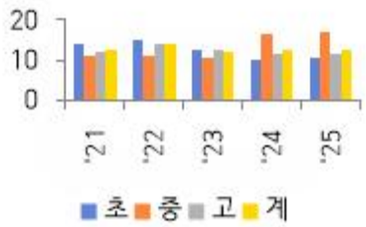
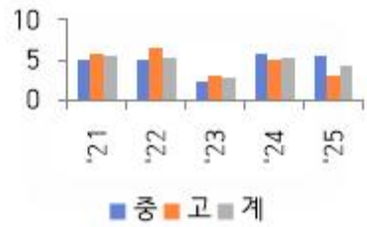
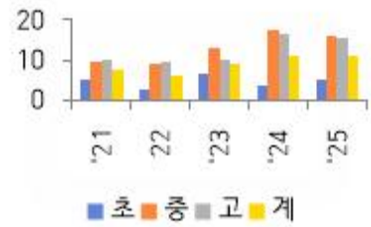
※ 학생 건강검진 제도개선 TF 구성('23.6월) → 건보공단 위탁형태의 시범사업 추진('24~'25)

- 학생건강검진 제도개선을 위한 「학교보건법」 개정('25.12.10. 법사위 의결)
- 구강검진 현황

2021-2025년 학교급별 구강질환

(단위: %)

구분	치아우식증				치주질환			부정교합				비고
	초	중	고	계	중	고	계	초	중	고	계	
2025년	10.5	17.1	11.5	12.6	5.4	3.0	1.2	5.0	16.0	15.3	10.9	
2024년	10.2	16.6	11.5	12.3	5.8	4.9	5.3	3.6	17.4	16.7	10.8	
2023년	12.4	10.5	12.5	11.9	2.3	3.0	2.7	6.3	12.8	10.2	9.1	
2022년	15.2	11.2	14.1	14.0	4.1	6.5	5.3	2.7	9.0	9.5	5.9	
2021년	13.8	10.9	12.1	12.6	5.0	5.7	5.4	5.1	9.7	9.9	7.4	

치아우식증 현황	치주질환 현황	부정교합 현황
		

- 치아우식증은 2022년(14.0%) 이후 전반적으로 감소하는 경향을 보였으나, 2025년 12.6%로 2024년 12.3% 대비 0.3%p 소폭 증가
- 치주질환은 2022년(2.7%) 이후 2023년(6.3%) 급증하였다가 2024년 3.6%로 감소, 2025년에는 5.0%로 다시 증가하는 등 증감을 반복하는 양상을 보임
- 부정교합은 전체적으로 2022년 이후 증가 추세를 보이고 있으며, 2025년에도 높은 수준(중학교 16.0%, 고등학교 15.3%)을 유지

[대 책]

- 치아우식증 등 구강질환을 예방하기 위해서는 어릴 때부터의 바른 구강관리 습관이 요구됨.
- 바람직한 구강위생 습관형성을 위한 실천 위주의 구강 보건교육 실시
- 점심 식사 후 이 닦기 실천 교육 강화

• 시력검사 현황

2021-2025년 시력검사

(단위: 명, %)

연도	교정대상 학생수 비율	교정한 학생수 비율
2025년	20.3	30.8
2024년	20.8	29.0
2023년	24.8	29.8
2022년	24.2	29.3
2021년	23.8	26.6



- 2021년~2025년 동안 교정 대상 학생 비율은 대체로 20~25% 사이를 유지하고 있음
- 교정 시행 비율은 2021년 26.6% → 2025년 30.8%로 점진적 증가 추세를 보임.

[대 책]

- 시력에 대한 지속적인 관심과 관리가 요구되며, 시력관리에 대한 보건교육 필요
- 학교와 가정에서 근시 예방을 위한 생활습관교육 실시
- 교실 내 조도 개선 및 조도 관리 준수

학생 건강검사

1) 건강검사 실시계획 수립

가) 학교장은 만족도 등 작년 건강검진 실시 현황을 참고하여 학생 건강검사에 필요한 소요 예산을 포함한 구체적인 실시계획을 매년 3월말까지 수립하여 시행

나) 「학교보건법」 제7조 및 「학교건강검사규칙」에서 정한 건강검사 및 별도검사 항목 이외의 검사 금지

■ 건강검사 대상학년, 실시기관 및 검진항목

검사항목	대상학년	실시기관	검진항목 및 방법
신체의 발달상황	초 1·4 / 중 1 / 고 1	학교자체/검진기관	키, 몸무게, 비만도 <Ⅲ-2-다. 신체의 발달상황에 대한 검사항목 및 검사방법>
	초 2·3·5·6 / 중 2·3 / 고 2·3	학교자체(교직원)	
건강조사	초·중·고 전학년	학교자체(교직원)	건강조사 <Ⅲ-2-나. 건강조사항목 및 방법>
건강검진	초 1·4 / 중 1 / 고 1	검진기관	일반, 구강검진
	초 2·3·5·6	검진기관	구강검진

■ 별도검사 대상학년, 실시기관 및 검진항목

검사항목	대상학년	실시기관	검진항목 및 방법
소변검사	초 2·3·5·6 / 중 2·3 / 고 2·3	검진(사)기관	요단백, 요잠혈
결핵검사*	고2·3	대한결핵협회 대전세종충남지부	X-ray 직접촬영
시력검사	초 2·3·5·6 / 중 2·3 / 고 2·3	학교자체(교직원)	공인시력표에 의한 측정

※ 중 3학년 학생은 별도검사 대상은 아니지만, 집단 결핵검사를 통한 결핵환자 발견사업 대상으로 충청남도가 지원하여 검사 실시 및 서식에 포함하여 작성

※ 중 2학년 학생은 결핵이동검진 대상에서 제외(최근 3년간 신환자발견수: 0건)

■ 건강검사 및 별도검사 검사비용 및 결과처리

항목		학년	실시기관	기간	검사비용(인당)	검진항목 및 방법	결과처리
건강검사	건강조사	초·중·고 전학년	학교	3~7월	·	• 건강조사설문지에 의한 조사 <Ⅲ-2-나. 건강조사설문지> • 건강검진 문진표로 갈음할 수 없음 • 초등: 가정에서 작성하여 제출	• 통계 및 결과 분석 후 학교 보건관리에 반영 • 학교폭력/상담/담임교사와 공유 • 건강상담, 예방 및 치료 등 보호대책마련, 학부모 상담
	신체발달상황	초·중·고 전학년	학교	3~7월	·	• 키, 몸무게, 비만도[참고자료] • 건강검진실시 학년 (초1, 4, 중·고1): 검진기관에서 실시 가능	• NEIS 학생건강기록 입력 • 과체중이상(결과 통보) : 별도 프로그램운영
	건강검진	초 1, 4 중·고 1	검진기관	3~11월	1학년: 19,060원 4학년 일반: 19,060원 4학년 비만: 39,540원	• 내원 또는 출장검진 • 표본학교는 상반기 실시	• 결과통보서에 의한 학생건강기록부에 기록
	구강검진	초 2, 3, 5, 6	검진기관	3~11월	8,300원	• 내원 또는 출장검진	• 2차 검진, 정밀검진, 조기치료 등 사후관리
별도검사	소변검사	초 2, 3, 5, 6 중·고 2, 3	검진기관	3~11월	940원	• 요단백, 요잠혈 • 비영리 검사기관 또는 검진기관	• 유소견자: 학부모 통보 • 정밀검사 및 조기치료 안내
	시력검사	초 2, 3, 5, 6 중·고 2, 3	학교	3~11월	·	• 공인시력표에 의한 측정 • 좌우 각각 구별하여 검사 • 교정시력 검사	
	결핵검사*	고 2, 3	대한결핵협회	3~11월	지자체부담 학교회계부담없음	• 흉부 X-ray • 대한결핵협회 출장촬영 진행	

항목	신체의 발달상황(비만도)	학생 건강검사 표본학교
대상	• 초·중·고·특수 모든 학교 (표본학교 포함)	• 표본학교 (초 15교, 중 22교, 고 27교)
제출방법 (나이스 제출)	• [학생건강검사관리 – 통계관리 – 신체발달통계생성]탭 → 통계구분 '전체'로 선택 • 통계생성 → 오류데이터 확인 → 통계조회 → 승인요청(학교장 결재) → 교육청 전송 버튼 선택	• [학생건강검사관리-통계관리-학생건강검사통계생성]탭 → 통계구분 '표본'으로 선택 ※주의: [통계관리-신체발달통계생성]탭 아님 • 성별/키/몸무게 오류 확인 → 데이터 확인 → 통계생성 → 승인요청(학교장 결재) → 담당자명 및 연락처 입력 → 교육청 전송 버튼 선택
제출일	– 2026. 8. 28.(금)	– 2026. 9. 30.(수)

건강검사 실시

1) 신체의 발달상황

- 기간: 3~7월까지
- 대상: 초·중·고등학교 전 학년
- 측정항목: 키(㎝), 몸무게(㎏), 비만도
- 측정방법: 당해 학교 교직원이 측정 <Ⅲ-2-다. 신체의 발달상황에 대한 검사항목 및 검사방법>

※ 단, 건강검진을 실시하는 학생에 대한 신체의 발달상황에 대한 검사는 검진기관에서 실시할 수 있음.「학교건강검사규칙」제3조제3항

- 결과처리

– 교육정보시스템의 학생건강기록부에 입력

– 과체중 이상 비만학생은 학생·학부모에게 통보하여 별도 프로그램* 운영

* 움직이는 교실! 건강한 학교! 비만예방 자체 프로그램 외 지역사회 유관기관 협조 등을 통해 별도 프로그램 운영

2) 건강조사

- 기간: 3~7월까지
- 대상: 초·중·고등학교 전 학년(초1·2·3·4·5·6학년 / 중1·2·3학년 / 고1·2·3학년)

※ 모든 학년 1학기 내 건강조사 실시(건강검진 시 시행하는 문진표로 갈음할 수 없으며, 건강조사서와 문진표 각각임)

- 조사항목: 예방접종의 실시 여부, 건강행태 및 생활습관 등 <Ⅲ-2-나. 건강조사항목 및 방법>
- 조사방법: 학교 교직원이 설문지를 활용하여 실시 <Ⅲ-2-나. 건강조사설문지>

– 전교생을 대상으로 설문조사를 실시하되 초등학생의 경우 학부모의 도움이나 확인이 필요한 사항이 있으므로 가정에서 작성하여 제출토록 안내

- 결과처리: 건강조사 결과는 관련 담당교사(학교폭력 담당교사, 상담교사, 담임교사)와 공유, 설문결과 통계작성 및 결과 분석 후 건강 상담, 질병의 예방조치 및 치료 등의 보호 또는 대책이 필요한 학생은 학부모 상담 등 학교 보건관리에 반영

3) 건강검진

- 기간: 3~11월까지 완료
- 대상: 초등학교 1·4학년, 중·고 1학년(단, 초등학교의 구강검진은 2·3·5·6학년을 포함하여 실시)
- 방법: 학교장은「건강검진기본법」에 따라 지정된 검진기관 중에서 현장 확인 등을 실시하여 학생들이 검진하기에 적정한지 여부를 판단하여 적합한 2개 이상 기관을 선정·계약 체결한 후 실시

※ 검진기관과 계약 시「건강검진기본법」에 따른 '건강검진기관' 여부 확인

건강iN(http://hi.nhis.or.kr) ➔ 건강모아 ➔ 검진기관/병원찾기 ➔ 검진기관 찾기

– 2개 이상 선정하는 것을 말하며, 의과와 구강검진이 가능한 기관(종합병원)일 경우 각각의 1개 검진기관으로 함

※ 일반검진기관(병원, 의원)을 개설한 의사가 구강검진 기관인 치과병원과 치과의원을 개설한 치과의사와 계약을 하여 고용할 수 없음

❶ 2개의 병원(의원)과 2개의 치과병원(의원) ☞ 치과가 개설되지 않은 검진기관을 2개 선정 시 치과 검진기관을 2개 이상 선정
❷ 종합병원(의과 + 치과)과 1개의 병원(의원)과 1개의 치과병원(의원) ☞ 치과가 개설된 검진기관 1개를 선정하고, 치과가 개설되지 않은 검진기관 1개를 선정하였을 경우 치과 검진기관을 1개 이상 별도 선정
❸ 종합병원(의과 + 치과)과 종합병원(의과 + 치과) ☞ 치과가 개설된 검진기관 2개 선정한 경우 별도의 치과 검진기관 선정 불필요

– 검진기관 선정은「초·중등교육법」제31조의 규정에 의한 학교운영위원회 심의 또는 자문 가능

– 학생의 수업결손 방지와 편의제공 등을 위하여 사전예약제, 여름방학이나 공휴일에도 검사를 받을 수 있도록 방안 강구

– 1개 검진기관 선정 및 출장검진 실시

▹ 2개 이상의 검진기관을 선정할 수 없는 지역에 소재한 학교의 장은 교육장의 승인을 얻어 1개의 검진기관을 선정하여 실시

▹ 검진기관을 방문하여 건강검진을 받아야 하나 부득이 지역 형편상 방문검진이 어려운 학교의 장은 교육장의 승인을 얻어 1개 검진기관만을 선정하여 출장검진 실시

※ 권한 위임:「충청남도교육감 행정권한 위임에 관한 조례」제5조

※ 지역 내 검진기관이 없는 학교, 특수학교 등에서는 1개 검진기관에 의한 출장검진 가능(「학교건강검사규칙」 제5조의2(건강검진의 절차 등) 제4항)

– 단, 초등학교의 구강검진은 학교보건법 제7조 제2항의 규정에 의거 출장검진기관 선정 또는 1개 검진기관 선정을 이미 승인 받은 것으로 간주함

☞별도 승인 절차가 필요 없이 학교 실정에 맞게 자율적으로 실시

❖ 학생 건강검진 기관 선정 완화 승인요건 ❖

❑ 출장검진 기관 승인요건
- 학교가 소재한 지역(읍·면·동)검진기관이 있으나, 검진기관이 학생 검진사업에 미참여
- 검진대상 학년이 기숙사 생활을 하고 있는 학교
- 학교 건강검사 표본학교
- 그 밖에 부득이한 사유로 출장검진이 불가피 하다고 교육감이 승인한 경우

❑ 출장검진 승인요청 제외
- 학교가 소재한 지역(읍·면·동을 말한다)에 검진기관이 없는 경우

☞ https://www.nhis.or.kr 국민건강보험공단에서 검색 후 검진 기관이 없는 경우 출장검진 승인요청 제외

- 「장애인 등에 대한 특수교육법」에 따른 특수학교

☞출장검진 승인요청 제외 대상학교는 별도 승인요청 및 승인 없이 출장검진 실시

❑ 1개 검진기관 선정(내원검진)
- 학교가 소재한 지역에 검진기관이 1개 이하인 지역에 소재한 학교
- 2개 이상의 검진기관이 있으나, 1개 검진기관만 학생 건강검진사업에 참여하는 지역에 소재한 학교
- 검진 인원이 적어 2개 이상의 검진기관 선정 부적절한 경우(100명 이하)

• 검진 시 주의사항

– 학교장은 건강검진에 누락되는 학생이 없도록 관리 철저

☞특히, 현장실습, 취업, 결석 등의 이유로 건강검진을 실시하지 않는 사례가 발생하지 않도록 한다.

– 출장검진으로 승인을 받은 학교의 검진대상자가 내원검진을 원하는 경우 내원검진이 가능하도록 업무 추진

– 형식적인 검사가 되지 않도록 1일 검진인원과 검진기간 등 적절히 조정하여 학생과 의사와의 충분한 진찰 및 상담이 이루어질 수 있도록 노력

– 학생 건강검진 관련 민원이 발생할 경우 단위학교에서 검진기관에 해당 민원에 대한 설명 및 적극 개선요청

• 검진결과 처리

– 검진기관으로부터 통보 받은 학생건강검사(구강검진) 결과 통보서 1부는 학생건강기록부[별지 제1호 서식]에 기록하여 건강관리 자료로 활용하고, 학교보관용 자료는 개인정보 보호처리에 유념하여 5년 이상 보관 후 폐기 (「의료법 시행규칙」 제15조, 「국민건강보험공단 건강운영세칙」 제2장 제6조 제3항 의거)

– 검진결과 질환 의심학생에 대하여는 2차 검진(정밀검진) 및 조기치료를 받도록 안내(가정통신문 등), 건강관리에 대한 지도 및 교육, 상담 등 사후관리 철저

※ 학생 건강검진 자료를 학생의 건강관리에 활용할 수 있도록 가급적 1학기 내 검진 완료

– 검진결과와 관련하여 학생 개인 신상에 관한 사항이 공개되지 않도록 유념하고, 특히 건강이상자에 대하여는 소외감과 좌절감을 갖지 않도록 상담활동 등 특별지도 대책 강구

– 학생건강기록부 전산처리 및 관리(학생건강기록부 전산처리 및 관리지침)

▹ 고등학교 졸업 시 초 1년부터 고 3년까지 12년간의 학생건강기록부 출력물을 본인 또는 보호자에게 교부하고, 전산매체에 저장하여 「공공기록물 관리에 관한법률」에 따라 5년간 보존

▹ 휴학, 퇴학, 사망 및 중·고등학교 미진학 시 학생이 최종적으로 재적하였던 학교에서 5년간 보존

▹ 학생의 재·전·편입학, 상급학교 진학 시 건강기록부 전산(NEIS)으로 이송, 학생건강검사결과 통보서(구강검진 결과통보서 포함)는 별도 이송하지 않음

– 매 학년도가 종료되기 전 NEIS 학생건강기록부 기록의 누락, 입력 착오 등의 사항이 없는지 확인 후 변경사항 발생 시 정정 조치

※ 상급학교 진학 시, 해당학교 건강기록부 인적사항 반드시 확인할 것

<주요 민원 사례>

– 신입생 및 전입생의 건강기록부가 동명이인의 자료로 전송받은 사례
– 전년도 취학 후 예방접종이 누락된 사례
– 건강기록부의 신장 및 체중이 전년도 보다 줄어든 사례
– 전입 학생이 이전(전출)학교에서 건강검사나 신체발달을 실시하였으나 미기재상태로 전학 온 사례

• 유의 사항

– 각급학교 및 교육지원청에서는 학생 건강검사 계획을 누리집에 탑재, 안내문 발송 등으로 학생과 학부모, 검진기관의 이해를 도와 원활하고 민원이 발생하지 않는 학생건강검사 추진

– 학생 건강검사 관련 민원에 대한 적극적 대응

▹ 학교: 건강검진 관련 민원 발생 시 검진기관에 개선 요청하고, 필요시 학생 또는 학부모를 대상으로 검진의 문제점을 발견 등을 위하여 만족도 조사 실시 및 누리집 공개

▹ 교육지원청: 건강검진 관련 민원 발생할 시 학교 또는 검진기관을 방문하여 해당 민원에 대한 설명 및 개선 요청

– 일부 검진기관에서 학생건강검진결과를 임의 특정기관에 통계화 의뢰하는 것은 개인정보 보호에 위반되는 것으로 학교의 주의 요망

– 전년도 건강검진 대상학생이 건강검진을 미실시한 경우 다음 학년도 시작시 우선적으로 검진을 받도록 조치

※ 건강기록부(NEIS) 관리 매뉴얼: 충남교육청누리집/체육건강과/학교보건 자료실 탑재(4세대 지능형 나이스(NEIS) 사용자 설명서)

4) 학생건강검사 표본학교

• 학교 건강검사 표본학교 매뉴얼에 따른 건강검사 실시 시기 및 검사결과 제출 기한 준수 철저
• 기간: 3~9월
• 결과처리: 나이스(NEIS)를 통해 제출

※ 학교의 장 → 시도교육감: 9월 30일까지, 시도교육감 → 교육부장관: 10월 31일까지

• 2024~2026년도 표본학교(64교: 초 15, 중 22, 고 27)

검사결과의 적극 활용 및 유증상자에 대한 사후관리

• 학교의 장은 학생 건강검사의 결과를 평가하여 이를 바탕으로 학생 건강증진계획을 수립·시행 (「학교보건법」 제7조의2제3항)

– 모든 학생에 대한 건강검사를 실시하고, 그 결과를 바탕으로 학생의 건강행태를 개선할 수 있도록 보건교육 등 적극적인 건강증진 교육을 실시하고, 학교의 실정에 맞는 건강증진 프로그램 적극 운영

– 건강검진 결과에 따라 건강 상담, 질병의 예방조치 및 치료 등의 보호 및 별도의 관리가 필요한 학생에 대해서는 학부모 상담 등을 통한 적절한 대책 마련·추진

※ 학생 본인 또는 학부모에게 검진결과 발견된 질환에 대한 조치 및 결과 회신요청 시 충분한 상담 등을 통해 부담을 최소화 할 수 있는 방안 강구

❖ 학생 건강검진 준비 사항 ❖

❑ 검진 실시 전 준비 사항
- 학교장은 가정통신문 등을 통해 학생건강검진 실시 계획 안내
  – 학생건강검진의 취지와 내용, 검진기관 및 일정, 검진 시 준수사항, 검진 미실시 사례방지 등
- 학교장은 검진기관에 「학교 건강검진 결과 판정 및 기재방법 등에 관한 기준」에 의하도록 반드시 안내
- 학교장은 검진대상 학생의 명단을 검진기관에 송부 및 학교와 검진기관은 검진대상학생을 확인할 수 있는 방안(학생증 등) 강구
- 검진기관에서는 검진을 실시하기 전 학교건강검사규칙 제3조의 별지 제1호의2서식 내지 제1호의4서식의 문진표를 비치하고, 검진대상자에게 필요한 문진표를 작성 제출

※ 주의사항
  – 수검자가 검진 당일에 공복을 유지(검진 전날 21시 이후부터) 및 검진결과에 영향을 줄 수 있는 심한 운동 등은 2~3일 전부터 않도록 주의
  – 기숙사 생활을 하는 수검자일 경우 21시 이후에 기숙사에서 제공하는 간식도 먹으면 안됨

❑ 검진 실시
- 검진대상 학생은 학생증 등을 지참하고 학교에서 안내된 검진기관에 방문하여 검진 실시
  – 검진기관에서는 반드시 본인 여부를 확인한 후 검사 실시

❑ 검진 실시 후 필수사항
- 검진기관은 건강검사(구강검진) 결과 통보
  – 개인의 정보가 노출되지 않도록 주의
  – 수검자가 검사결과를 이해할 수 있도록 안내
- 학교장은 학생건강검사(구강검진) 결과통보서 중 검사 미실시 항목, 검사결과와 상이한 내용 발견은 즉시 정정 조치
- 검사결과 질환의심 학생(2차 대상자)을 확인하여 사후관리 철저

별도검사

1) 소변검사
- 기간: 3 ~ 11월까지
- 대상: 초 2・3・5・6학년, 중・고 2・3학년
- 검사기관: 비영리 검사기관 또는 건강검진 기본법 제14조에서 정한 검진기관 중 학교장이 선정
- 검사항목: 요단백, 요잠혈 (학생건강검진 '소변검사' 방법에 따라 검진)
- 검사비용: 1인당 940원 (전액 학교회계 부담)
- 결과처리: 유소견자로 판정된 학생에 대하여는 가정통신문 등으로 보호자에게 알려 정밀검사를 받도록 안내
- 기타: 소변검사 미실시 학생이 없도록 검사기관과 협의 및 추가 검사 실시

2) 결핵검사
- 기간: 3 ~ 7월까지 (변경가능)
- 대상: 고 2 ・ 3학년
- 검사기관: 대한결핵협회(대전・세종・충남지부)에서 학교 방문 검사
- 검사비용: 지자체 부담, 학교회계 부담 없음
- 검사일정: 지역별 학교 검진 일정 <Ⅲ-2-마. 결핵검진 지역별 일정>
- 결과처리: 검진결과 이상자로 판정된 학생에 대하여는 본인과 보호자에게 알려 정밀검사를 받도록 하고, 정밀검사결과 확인
- 기타: 학교 방문일 미검사 학생 발생 최소화 추진 (학교별 방문 일자 사전조율, 미검사 학생 해당 지역 보건소 방문검진 실시추진 등)

3) 시력검사

- 기간: 3 ~ 11월까지
- 대상: 초 2・3・5・6학년, 중・고 2・3학년
- 검사방법: 공인시력표에 의한 당해 학교 교직원이 측정
- 검사항목: 오른쪽과 왼쪽의 눈을 각각 구별하여 검사(안경, 렌즈 착용 학생은 교정시력으로 검사)

마 행정사항

- 학생 1・4학년 건강검진 및 별도검사 추진현황 제출 [서식5]
- 교육과정과 연계한 건강증진 활동 추진
  - 학교 교육계획에 반영하여 연중 효율적으로 운영되도록 추진
    ※ 일회성 행사가 아닌 연중 지속적으로 실시될 수 있는 프로그램으로 운영
  - 학생의 건강문제를 진단하여 우선순위를 정하고, 학교 교육과정 연계로 많은 학교 구성원이 참여하도록 독려
- 특정업무 담당자에게 업무가 편중되지 않도록 업무분담 활성화
  - 학생들의 건강증진 및 건강 문제를 해결하기 위한 활동이 보건·영양·체육·상담 등 개별 영역에서 복합적 시행 필요
- 다양한 교육자료 개발.활용 및 우수 교육자료 공유
  - 교육부 '학생건강정보센터(https://www.schoolhealth.kr/)'를 통해 다양한 학생 건강 정보 자료 공유 및 활용
- 학생건강증진계획 수립・추진
  - 사업 시행에 필요한 소요 예산을 사전 검토한 후 학교 실정에 맞는 연간 계획(학년도 시작 전)을 수립하고, 지난 학년도 추진 사업에 대한 자체 평가 결과 반영

바 기대효과

- 학생 건강관리 체계 강화로 건강한 학교 만들기
- 건강검사를 바탕으로 체계적인 건강관리로 학생 건강권 보호

2 학생건강검사

가 2026 건강검사 세부계획(예시)

건강검진 계획 수립 → 검진기관 선정 (운영위원회 심의 또는 자문을 받을 수 있음) → 검진안내 (가정통신문 및 홈페이지 탑재)

학생 건강검진 실시 → 검진 결과 통보 → 만족도조사 실시 및 조사결과 통보 검진비 집행 내역 및 검진 결과 통계 보고

※ 학교 내 담당자 및 역할은 학교 상황에 따라 자율적으로 정할 수 있음

구분	내용	기간	담당	참고
건강조사	건강조사 실시	3월	담임교사 보건교사	• 건강조사 설문지 기초 • 학급별 건강이상 학생 명단 • 요보호 학생 파악 및 상담 • 요보호 학생 건강상담록 작성
신체발달상황/시력검사	검사 계획 수립	3~4월	보건교사	• 건강기록부 입력 • 건강기록부 점검・확인 • 이상학생: 가정통신문
	검사 실시 및 나이스 입력	3~5월	보건교사 담임교사	
건강검진/구강검진	계획수립	3월	보건교사	
	관내 및 근교 건강검진 기관 현황 조사·검진기관 선정	3월(4월)	보건교사	• 건강보험공단 제공 자료 • 병원 현황 비교
	검진병원과 계약체결	3~5월	행정실	• 검진기관 선정 및 계약 • 체결 시 유의사항 준수
	건강검진 실시 안내	3~7월	보건교사 담임교사	• 가정통신문
	학생 건강검진 실시 (검진기관 방문 실시)	3~11월 (가급적 1학기 내 검진 완료)	검진병원	• '학생명렬표' 준비 (병원참고용) • 건강검진 항목 및 방법 • 건강검진결과 판정기준
	검진결과 통보 (학생, 학교)	검사 15일 이내	검진병원	• 학생 건강검진 결과통보서 • 학생 구강검진 결과통보서
	검진기관 만족도조사	검진 실시 후	보건교사	• 검진병원 평가 및 개선사항
	건강이상 학생 상담 및 재검진 독려 안내	결과 통보 후 즉시	보건교사	• 가정통신문 • 학생 상담
	검진결과 처리 – 건강기록부에 입력 – 건강검진 결과지 관리	결과 통보 후 즉시	담임교사 보건교사	• NIES 건강기록부 입력 • 학생 건강검진 결과 통보서 – 학생 전출・입 시 이송하지 않음
	검진 완료 파악 및 검진비 집행	검진완료 후	보건교사 행정실	• 건강검진 추진 현황 파악 (검진 인원, 검진 비용)
	건강검진통계 보고	11월	보건교사	• 학생건강검진통계표
	내년 건강검진비 예산 수립	익년 2월까지	보건교사	• 건강검사, 구강검사, 소변검사, 결핵검사
소변검사	요단백, 요잠혈	검진기관과 협의	학교 방문 검진	• 이상자: 재검사, 정밀검사 안내문 발송 및 회신서 관리
결핵검사	흉부간접촬영 (X-선 검사)	협회와 협의	학교 방문 검진	• 대한결핵협회 • 결핵환자(의심환자) 신고 및 관리

❖ 2026년도 검사항목별 검진비용 ❖

(전액 학교회계 부담)

(단위: 원)

항 목			초1	초4		중1		고1			
								남		여	
			일반 학생	일반 학생	비만 학생	일반 학생	비만 학생	일반 학생	비만 학생	일반 학생	비만 학생
건강검진 상담료 및 행정비용 – 척추 – 눈 (시력, 안질환) – 귀 (청력, 귓병), 콧병, 목병, 피부병 * 키, 몸무게, 비만도, 혈압 측정 포함			9,820	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820
구강(치아상태 및 구강상태)			8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300
병리검사	소변(요단백, 요잠혈)		940	940	940	940	940	940	940	940	940
병리검사	혈액	비만학생* [혈당, 총콜레스테롤, 고밀도지단백(HDL) 콜레스테롤, 중성지방, 저밀도지단백(LDL) 콜레스테롤**, 간세포 효소(AST, ALT)]			20,480		20,480		20,480		20,480
병리검사	혈액	고1 여학생: 혈색소								1,270	1,270
병리검사	결 핵 (촬영 및 판독료 + 재료대)	직촬(14″X14″)				9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720
병리검사	결 핵 (촬영 및 판독료 + 재료대)	직촬(14″X17″)				10,040	10,040	10,040	10,040	10,040	10,040
병리검사	결 핵 (촬영 및 판독료 + 재료대)	CR or DR				8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300
병리검사	결 핵 (촬영 및 판독료 + 재료대)	Full PACS				9,270	9,270	9,270	9,270	9,270	9,270
허리둘레(비만학생*)							–		–		–
계			19,060	19,060	39,540	27,360 ~ 29,100	47,840 ~ 49,580	27,360 ~ 29,100	47,840 ~ 49,580	28,630 ~ 30,370	49,110 ~ 50,850

– 산출근거: 국민건강보험법 시행령 제25조제5항에 따른 보건복지부 고시단가(2026.1.1.기준)

* 체질량지수 기준 비만도 95 백분위수 이상인 '비만'에 해당됨
[별첨–체질량지수 성장표 백분위수(2–18세) 참고]

** 비만학생 혈액검사 중 저밀도지단백콜레스테롤(LDL): 총 콜레스테롤, 고밀도지단백콜레스테롤(HDL), 중성지방 수치를 활용하여 계산한다(검진비용 제외)(「학교 건강검진 실시방법·결과 판정 및 기재방법 등에 관한 기준」[별표1] 건강검진 항목 및 방법)

❖ 학교급에 따른 일부항목 적용 범위 ❖

구 분	초1	초4	중1	고1	비 고
혈액검사(혈당, 총콜레스테롤, HDL, 중성지방, LDL 계산값, 간세포 효소(AST, ALT), 허리둘레	×	○	○	○	비만 학생
흉부 방사선 검사	×	×	○	○	
혈색소 검사	×	×	×	○	고1 여학생

건강조사 항목 및 방법

건강조사 항목 및 방법

「학교건강검사규칙」 제4조의2제2항관련 (별표1의2)

가. 조사항목 및 내용

조사항목	조 사 내 용
1. 예방접종/병력	가. 전염병 예방접종 나. 가족병력 다. 개인병력
2. 식생활/비만	가. 식습관 나. 인스턴트 및 그 밖에 식품의 섭취형태 다. 다이어트 행태
3. 위생관리	가. 손 씻기 나. 양치질
4. 신체활동	가. 근지구력 향상을 위한 운동 나. 심폐기능 향상을 위한 운동 다. 수면
5. 학교생활 / 가정생활	가. 가족 내 지지 정도 나. 학교생활 적응 정도 다. 교우관계
6. 텔레비전 / 인터넷 / 음란물의 이용	가. 텔레비전 시청 나. 인터넷 이용 다. 음란물에의 노출 여부 및 정도
7. 안전의식	가. 안전에 대한 인식 나. 안전사고의 발생
8. 학교폭력	가. 학교폭력에의 노출 여부 및 정도
9. 흡연 / 음주 / 약물의 사용	가. 흡연 나. 음주 다. 흡입제의 사용 여부 및 약물의 오·남용 여부 등
10. 성 의식	가. 성 문제 나. 성에 대한 인식
11. 사회성 / 정신건강	가. 사회성 (자긍심, 적응력 등) 나. 정신적 건강 (우울, 자살, 불안증, 주의력 결핍 등)
12. 건강상담	가. 건강에 대한 상담의 요구 등

나. 조사방법

시·도교육감은 위 조사항목 및 내용을 포함한 구조화된 설문지를 마련하고, 학교의 장을 통하여 조사할 수 있도록 한다.

※ 타 시·도교육청 건강조사설문지 활용 불가(충청남도교육청 건강조사 설문지 활용)

건강조사 설문지
(초등학생용)

수검자 인적 사항	학교명	초등학교	
	학년 / 반 / 번호	학년 반 번	
	성명 / 성별		남 여

조사항목	조 사 내 용					
1. 예방접종/병력	가. 감염병 예방접종	1) 지난 1년 동안 감염병 예방접종을 받은 적이 있습니까? 예( ), 아니오( ) 2) 예방접종을 받았다면 어떤 예방접종을 받았습니까? ① 일본뇌염 ② 인플루엔자 ③ 기타( ) ④ 모름				
	나. 가족병력	가족 중 질환을 치료받거나 진단받은 사람이 있으면 써주십시오.				
		질환명	나와의 관계			
	다. 개인병력	구 분		완치	치료중	치료내용
		지난 1년 동안 질병을 앓았거나 병원 진료를 받았습니까?	알레르기성 비염			
			아토피 피부병			
			천식			
			결핵			
			발작(경기 포함)			
			암			
			당뇨병			
			치과진료			
			소아 정신과 질환			
			기타질환( )			
		치료적 목적으로 학생이 계속 복용하는 약이 있습니까?				
		건강상 이유로 학교에서 특별히 배려해야 할 점이 있습니까? (선천성질환, 호흡기질환, 심장질환, 근골격계질환, 기타)				
		약물·식품 알레르기가 있는 경우 적어주세요.				

조사항목	조 사 내 용				
2. 식생활/비만	• 일주일 동안 다음 음식을 대체로 몇 번이나 먹습니까?				
	음식종류	① 안먹음	② 매일먹음	③ 1-2번	④ 3번이상
	라면				
	음료수(주스 제외)				
	패스트푸드 (피자, 햄버거, 튀김 등)				
	육류 (소고기, 돼지고기, 닭고기 등)				
	우유, 유제품				
	과일, 야채 (김치 제외)				

조사항목	조 사 내 용			
2. 식생활/비만	식생활	아침식사는 어떻게 합니까? ① 매일식사 ② 주1~2회 식사 ③ 주3회 식사		
	비 만	평소 체중관리에 대해 생각을 많이 합니까?	예	아니오
3. 위생관리	밥을 먹기 전이나 외출에서 돌아와서 비누로 손을 씻습니까?		예	아니오
	하루에 이를 몇 번 닦습니까? ① 하루 1회 ② 하루 2회 ③ 하루 3회 이상			
4. 신체활동	일주일에 숨이 차거나 땀이 날 정도의 운동을 몇 번 합니까? ① 거의 매일 ② 주1~2회 ③ 주3~5회			
	하루 몇 시간 정도 잡니까? ① 5시간 이하 ② 6-7시간 ③ 8시간 이상			

조사항목	조 사 내 용		
5. 학교생활/ 가정생활	우리 가족은 나의 이야기를 잘 들어주고 나의 감정을 존중해 줍니까?	예	아니오
	평소 자주 맞는다고 생각합니까?	예	아니오
	지난 1년 동안 친구에게 괴롭힘이나 따돌림을 당한 적이 있습니까?	예	아니오
6. 텔레비전/ 인터넷/ 음란물의 이용	텔레비전을 하루에 몇 시간 정도 봅니까? ①1시간 이내 ②1-3시간 ③3시간 이상		
	인터넷이나 게임을 하루에 몇 시간 정도 합니까? ①1시간 이내 ②1-3시간 ③3시간 이상		
7. 안전의식	자동차를 탈 때 항상 안전벨트를 맵니까?	예	아니오
	길을 건널 때 교통신호를 잘 지킵니까?	예	아니오
	인라인스케이트, 롤러블레이드, 스케이트보드, 자전거 등을 탈 때 헬멧이나 보호구를 착용합니까?	예	아니오
8. 학교폭력	돈을 빼앗는 친구가 있습니까?	예	아니오
	친구가 언어적, 신체적 위협을 한 적이 있습니까?	예	아니오
9. 흡연/음주/ 약물의 사용	지난 6개월 동안 나는 술을 마셔 본 적이 있습니까?	예	아니오
	지난 6개월 동안 나는 담배를 피워 본 적이 있습니까?	예	아니오
	함께 사는 가족 중에 흡연하는 가족이 있습니까?	예	아니오
10. 성 의식	지난 1년 동안 성에 대한 교육을 학교 및 기타 교육 기관에서 배운 적이 있습니까?	예	아니오
	싫다고 하는데 나의 몸을 자주 만지는 사람이 있습니까?	예	아니오
11. 사회성/ 정신건강	내가 잘 할 수 있는 일이 두 가지 이상 있다고 말 할 수 있습니까?	예	아니오
	화가 나면 난폭한 행동을 합니까?	예	아니오
	항상 외롭다고 느낀다.	예	아니오
	차분하지 못하고 지나치게 활동적이다.	예	아니오
	학교를 가고 싶지 않을 때가 자주 있다.	예	아니오
12. 건강상담	지난 1년 동안 1회 이상 구강 검진이나 상담을 받은 적이 있습니까?	예	아니오
	지난 1년 동안 1회 이상 시력을 측정했거나, 상담을 받은 적이 있습니까?	예	아니오
13. 기타	o 학교 상황에 따라 조사하여야 할 사항을 (기타)에 첨가 할 수 있음 예) 부모님과 연락이 닿지 않는 경우 보호자 부재시 연락 가능한 전화번호 학교내 응급환자 관리에 대한 동의서 등		

⊙ 학교 내 응급환자 관리에 대한 동의서 ⊙ (예시)

♦ 응급상황 발생시

병원 의뢰가 필요한 경우 <응급증상 및 이에 준하는 증상> 등으로 위급하거나 위독할 때를 제외하고는 학 부모님께 연락 하여 인계함을 원칙으로 합니다. 단, 응급상황이거나 연락이 안 될 경우 인근병원이나 119 구조대, 학생이 주로 이용하는 병원으로 이송함에 동의합니다.

사고 발생 시 응급처치(일반의약품 및 부상처치)에 대한 권한을 귀교에 위임할 것을 동의합니다.

□ 예 □ 아니오

♦ 개인정보 수집·이용 목적: 학생건강상태조사, 응급이송 및 보건일지를 기록, 건강검사

◦ 보유 및 이용 기간: 당해 학년도 종료일까지

◦ 위의 개인정보 수집·이용에 동의합니다.

– 학년, 반, 성명, 성별, 생년월일, 보호자 성명/연락처, 건강문제, 예방접종 현황 □ 예 □ 아니오

◦ 민감정보(질환 등) 수집·이용에 동의합니다. □ 예 □ 아니오

◦ 개인정보를 검진기관(제3자)에 제공하는 것에 동의합니다.

– 본교 및 해당 검진기관, 응급의료기관 □ 예 □ 아니오

(※ 동의를 거부할 권리가 있으나, 거부에 따른 불이익에 대한 책임은 본인에게 있습니다.)

20 년 3월 일 보호자: (서명)

• 건강조사 내용에 대하여 비밀을 보장

• 답변내용에 따라 상담교사, 학교폭력담당교사, 담임교사 등은 생활지도에 참고 가능합니다.

• 학생 개인병력은 요보호자 선정시 활용됩니다.

건강조사 설문지
(중·고등학생용)

수검자 인적 사항	학교명	학교	
	학년 / 반 / 번호	학년 반 번	
	성명 / 성별		남 여

조사항목	조 사 내 용					
1. 예방접종/병력	가. 감염병 예방접종	1) 지난 1년 동안 감염병 예방접종을 받은 적이 있습니까? 예( ), 아니오( ) 2) 예방접종을 받았다면 어떤 예방접종을 받았습니까? ① 일본뇌염 ② 인플루엔자 ③ 기타( ) ④ 모름				
	나. 가족병력	가족 중 질환을 치료받거나 진단받은 사람이 있으면 써주십시오.				
		질환명	나와의 관계			
	다. 개인병력	구 분		완치	치료중	치료내용
		지난 1년 동안 질병을 앓았거나 병원 진료를 받았습니까?	알레르기성 비염			
			아토피 피부병			
			천식			
			결핵			
			발작(경기 포함)			
			암			
			당뇨병			
			치과진료			
			소아 정신과 질환			
			생리통(여학생)			
			기타질환( )			
		치료적 목적으로 학생이 계속 복용하는 약이 있습니까?				
		건강상 이유로 학교에서 특별히 배려해야 할 점이 있습니까? (선천성질환, 호흡기질환, 심장질환, 근골격계질환, 기타)				
		약물·식품 알레르기가 있는 경우 적어주세요.				
2. 식생활/비만	o 일주일 동안 다음 음식을 대체로 몇 번이나 먹습니까?					
	음식종류		① 안먹음	② 매일먹음	③ 1-2번	④ 3번이상
	라면					
	음료수(주스 제외)					
	즉석식품(피자, 햄버거, 튀김 등)					
	육류(소고기, 돼지고기, 닭고기 등)					
	우유, 유제품					
	과일, 야채(김치 제외)					
2. 식생활/비만	식생활	아침식사는 어떻게 합니까? ① 매일식사 ② 주1~2회 식사 ③ 주3회 식사				
	비만	체중조절을 위해 어떤 방법을 사용합니까? ① 아무 것도 안 함 ② 식사 조절한다. ③ 약을 먹는다. ④ 운동한다.				
3. 위생관리	밥을 먹기 전이나 외출에서 돌아와서 비누로 손을 씻습니까?				예	아니오
	하루에 이를 몇 번 닦습니까? ① 하루 1회 ② 하루 2회 ③ 하루 3회 이상					
4. 신체활동	지난 일주일 동안 숨이 차거나 땀이 날 정도로 운동이나 일을 했습니까? ① 거의 안 했음 ② 30분-1시간 정도 ③ 1-2시간 정도 ④ 2시간 이상					
	평소에 하루 몇 시간 정도 잡니까? ① 5시간 이하 ② 6~7시간 ③ 8시간 이상					

조사항목	조 사 내 용		
5. 학교생활/ 가정생활	부모님과 이야기가 잘 통한다고 생각합니까?	예	아니오
	지난 1년 동안 가출을 심각하게 생각해 본 적이 있습니까?	예	아니오
	지난 1년 동안 친구에게 괴롭힘이나 따돌림을 당한 적이 있습니까?	예	아니오
6. 텔레비전/ 인터넷/ 음란물의 이용	인터넷이나 게임을 하루에 몇 시간 정도 합니까? ① 1시간 이내 ② 1-3시간 ③ 3시간 이상		
	음란물(포르노, 야한 잡지, 야한 영화 등)을 보거나 성인사이트에 접속한 적이 있습니까? ① 거의 하지 않는다. ② 거의 매일 ③ 일주일에 3회 이상 ④ 한달에 3~4번		
7. 안전의식	자동차를 탈 때 항상 안전띠를 매며, 보행 시 교통규칙을 잘 지키고 있습니까?	예	아니오
	인라인스케이트, 롤러블레이드, 스케이트보드, 자전거 등을 탈 때 헬멧이나 보호구를 착용합니까?.	예	아니오
8. 학교폭력	주변에 돈을 빼앗는 친구가 있거나 돈을 뺏긴 경험이 있습니까?	예	아니오
	현재 가정이나 학교에서 폭력으로 인해 자신의 안전을 위협받고 있습니까?	예	아니오
9. 흡연/음주/ 약물의 사용	지난 한 달 동안 담배를 한 개비 이상 피운 날은 며칠 정도 됩니까? ① 전혀 피우지 않음 ② 매일 피움 ③ 일주일에 2-3일		
	지난 한 달 동안 술을 한 잔 이상 마신 날은 며칠 정도 됩니까? ① 전혀 마시지 않음 ② 한 달에 2-3일 ③ 일주일에 2-3일		
10. 성 의식	지난 1년 동안 성에 대한 교육을 학교나 기타 교육 기관에서 배운 적이 있습니까?	예	아니오
	피임법 또는 성과 관련한 감염병에 걸리지 않는 방법을 알고 있습니까?	예	아니오
	육체적·정신적 성폭력 피해를 받은적이 있습니까?	예	아니오
11. 사회성/ 정신건강	나의 장점을 2가지 이상 말할 수 있고, 내 고민을 들어줄 친구가 있습니까?	예	아니오
	최근 스트레스를 받은 가장 큰 원인은 무엇입니까? (가장 중요한 것 한 가지만 고르세요.) ① 학교성적과 학습량의 과중(학원, 과외수업, 숙제 등) ② 외모(얼굴, 몸무게, 키 등) ③ 집안의 경제적 문제나 가족의 건강문제 ④ 친구나 부모님, 선생님과의 관계		
	지난 한 달 동안 기분이 처지거나 우울하거나 희망이 없다는 느낌이 들어 고민하고 있습니까?	예	아니오
	지난 3개월 동안 구체적으로 자살 계획을 세운적이 있거나 자주 죽고 싶다는 생각이 든다.	예	아니오
	3개월 동안 한번이라도 심각하게 자살을 시도한 적이 있습니까?	예	아니오
12. 건강상담	지난 1년 동안 1회 이상 구강 검진이나 상담을 받은 적이 있습니까?	예	아니오
	지난 1년 동안 1회 이상 시력을 측정했거나, 상담을 받은 적이 있습니까?.	예	아니오
13. 기타	o 학교 상황에 따라 조사하여야 할 사항을 (기타)에 첨가 할 수 있음 예) 부모님과 연락이 닿지 않는 경우 보호자 부재시 연락 가능한 전화번호 학교내 응급환자 관리에 대한 동의서 등		

⊙ 학교 내 응급환자 관리에 대한 동의서 ⊙ (예시)

♦ 응급상황 발생시

병원 의뢰가 필요한 경우 <응급증상 및 이에 준하는 증상> 등으로 위급하거나 위독할 때를 제외하고는 학부모님께 연락 하여 인계함을 원칙으로 합니다. 단, 응급상황이거나 연락이 안 될 경우 인근병원이나 119 구조대, 학생이 주로 이용하는 병원으로 이송함에 동의합니다.

사고 발생 시 응급처치(일반의약품 및 부상처치)에 대한 권한을 귀교에 위임할 것을 동의합니다.

□ 예 □ 아니오

♦ 개인정보 수집·이용 목적: 학생건강상태조사, 응급이송 및 보건일지를 기록, 건강검사

◦ 보유 및 이용 기간: 당해 학년도 종료일까지

◦ 위의 개인정보 수집·이용에 동의합니다.

-학년, 반, 성명, 성별, 생년월일, 보호자 성명/연락처, 건강문제, 예방접종 현황 □ 예 □ 아니오

◦ 민감정보(질환 등) 수집·이용에 동의합니다. □ 예 □ 아니오

◦ 개인정보를 검진기관(제3자)에 제공하는 것에 동의합니다.

-본교 및 해당 검진기관, 응급의료기관 □ 예 □ 아니오

(※ 동의를 거부할 권리가 있으나, 거부에 따른 불이익에 대한 책임은 본인에게 있습니다.)

20 년 3월 일 보호자: (서명)

• 건강조사 내용에 대하여 비밀을 보장
• 답변내용에 따라 상담교사, 학교폭력담당교사, 담임교사 등은 생활지도에 참고 가능합니다.
• 학생 개인병력은 요보호자 선정시 활용됩니다.

다 학생 건강검진 승낙서

학생건강검진기관 계약 관련 서류 간소화 방안으로 마련한 '학생 건강검진 승낙서'에 대한 관계자 의견수렴 결과 작성된 서식(안)으로 학교 필요에 따라 검진기관 계약서류로 활용하실 수 있습니다.

학생 건강검진 승낙서

○ 학생 검진기관으로서 아래 계약내용, 학생건강검진 유의사항 및 준수사항 등 검진기관으로서의 책무를 성실히 이행할 것을 승낙합니다.(계약서 작성 생략)

□ 검진기관		(전화번호:)	
병원명		사업자등록번호	
주 소		원장성명	(인)

□ 계약내용			
계약건명	20 년도 ○○학교 학생 건강검진		
1인당 검진비용	1학년	4학년	4학년 비만학생
검진대상	1, 4학년 학생 명 중 방문학생		
검진기간	20 년 월 일 ~ 월 일	검진완료일	20 년 월 일
계약보증금	계약금액(검진대상 인원*검진비용)의 10%		
지연배상금	검진완료 후 30일 이내에 결과통보를 하지 않는 경우 매 1일마다 청구금액(검진인원*검진비용)의 1,000분의 2.5에 해당하는 지연배상금을 납부하여야 하며, 납부하여야할 금액은 계약대가에서 상계할 수 있다.		

□ 검진기관의 학생건강검진 유의사항 및 준수사항

1. 건강검진 항목 및 방법: 검진기관은 학교건강검사규칙 제5조제2항 관련 [별표2] 건강검진 항목 및 방법에 따라 적정한 의료장비를 사용하여 학생 개인별로 정밀하게 실시한다.

2. 건강검진 결과 판정 및 기재방법: 검진기관은 교육과학기술부 고시 [학교 건강검진 결과 판정 및 기재방법 등에 관한 기준]에 따라 검진결과를 판정, 기재한다.

3. 검진결과 통보: 검진기관은 건강주의, 질환의심 또는 유소견자의 경우 치료 등의 적절한 조치를 취할 수 있도록 건강검진 완료 후 30일 이내에 검진학생에 대하여 학생 건강검사(구강검진)결과통보서를 3부 작성하여 1부는 검진기관이 보관, 1부는 학생 또는 그의 보호자, 1부는 학교로 통보한다.

4. 검진기관 준수사항
   가. 검진기관은 검진실시에 앞서 검진에 필요한 일반검진문진표, 구강검진문진표, 검진안내서(검진장소, 검진시간, 검진절차 및 검진 시 유의사항 등) 등을 사전에 학생들에게 배부
   나. 검진기관의 「인력·시설 및 장비기준」을 반드시 충족하고 검진업무 수행
   다. 검진기관은 흉부방사선 검사를 위한 방사선발생장치 및 방어시설 검사성적서, 방사선발생장치 설치 및 사용신고필증 사본을 비치하고, 검진장비에 대한 정도관리 철저
   라. 무자격자(의사가 아닌 간호사, 치과위생사 등)의 검진행위 금지
   마. 검진결과 통보시기 준수
   바. 학생의 인적사항, 검진자료 등의 개인정보 보호 및 검진통계자료 보안관리 철저

5. 사고책임: 검진기관은 학생 건강검진에 따른 제반 의료사고 예방에 최선을 다하여야 하며, 검진과 관련하여 발생한 의료사고는 검진기관이 민·형사상 책임을 진다.

6. 기타 비용: 검진기관은 학생 건강검사에 따른 제비용을 부담하고, 계약금액 이외의 여하한 명목의 경비를 “갑”에게 요구할 수 없다.

7. 검진비용의 청구·지급: 검진기관은 검진비용을 청구할 수 있으며, 학교는 청구일로부터 7일 이내(토요일, 공휴일 제외)에 지급한다.

8. 손해배상: 검진기관은 상기 계약사항을 이행치 아니하였을 때 계약보증금을 학교에 납부하여야 한다. 또한, 검진기관이 “갑”에게 부당한 손해를 끼쳤을 때에는 이에 상응하는 보상을 한다.

9. 검진취소 등: 천재지변 또는 학교의 부득이한 사정에 의하여 학생 건강검진이 취소되거나 연기될 때에는 학교는 즉시 검진기관에 통보하여야 하며, 검진기관은 이에 따른 손해배상을 청구할 수 없다.

10. 계약조건: 이 계약에 명시되지 않은 사항은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법령, 지방자치단체 용역계약 일반조건(행정안전부 예규), ○○학교 청렴계약 특수조건을 적용한다.(청렴계약 특수조건은 학교에서 교부)

11. 계약 시 제출서류: 청렴계약이행서약서, 수의각서(학교에서 서식 제공), 통장사본

라 건강검진 항목 및 방법

건강검진 항목 및 방법

「학교건강검사규칙」 제5조제2항 관련(별표2)

검진항목		검진방법(세부항목)
1. 척추		척추옆굽음증(척추측만증) 검사
2. 눈	가. 시력측정	1) 공인시력표에 의한 검사 2) 오른쪽과 왼쪽의 눈을 각각 구별하여 검사 3) 안경 등으로 시력을 교정한 경우에는 교정시력을 검사
	나. 안질환	결막염, 눈썹찔림증, 사시 등 검사
3. 귀	가. 청력	1) 청력계 등에 의한 검사 2) 오른쪽과 왼쪽의 귀를 각각 구별하여 검사
	나. 귓병	중이염, 바깥귀길염(외이도염) 등 검사
4. 콧병		코곁굴염(부비동염), 비염 등 검사
5. 목병		편도선비대·목부위림프절비대·갑상샘비대 등 검사
6. 피부병		아토피성피부염, 전염성피부염 등 검사
7. 구강	가. 치아상태	충치, 충치발생위험치아, 결손치아(영구치로 한정한다) 검사
	나. 구강상태	치주질환(잇몸병)·구내염 및 연조직질환, 부정교합, 구강위생상태 등 검사
8. 병리검사 등	가. 소변	요컵 또는 시험관 등을 이용하여 신선한 요를 채취하며, 시험지를 사용하여 측정(요단백·요잠혈 검사)
	나. 혈액	1회용 주사기나 진공시험관으로 채혈하여 다음의 검사 1) 혈당(식전에 측정한다), 총콜레스테롤, 고밀도지단백(HDL) 콜레스테롤, 중성지방, 저밀도지단백(LDL) 콜레스테롤 및 간 세포 효소(AST·ALT) 2) 혈색소
	다. 결핵	흉부 X-선 촬영 및 판독
	라. 혈압	혈압계에 의한 수축기 및 이완기 혈압
9. 허리둘레		줄자를 이용하여 측정
10. 그 밖의 사항		제1호부터 제9호까지의 검진항목 외에 담당의사가 필요하다고 판단하여 추가하는 항목(검진비용이 추가되지 않는 경우로 한정한다)

※ 적용범위 및 판정기준

1. 다음 각 목의 검진항목에 대한 검사 또는 진단은 해당 목에 따른 학생을 대상으로 하여 실시한다.
   가. 위 표 제8호나목 1) 및 같은 표 제9호의 검진항목: 초등학교 4학년과 중학교 1학년 및 고등학교 1학년 학생 중 비만인 학생
   나. 위 표 제8호나목 2)의 검진항목: 고등학교 1학년 여학생
   다. 위 표 제8호다목의 검진항목: 중학교 1학년 및 고등학교 1학년 학생
2. 위 표에서 정한 건강검진 방법에 관하여 필요한 세부적인 사항 및 건강검진 결과의 판정기준은 교육부장관이 정하여 고시하는 기준에 따른다.
3. 위 표 제1호부터 제10호까지의 검진항목 외의 검진항목에 대한 검진방법 및 건강검진 결과의 판정기준은 「국민건강보험법」 제52조제4항 및 같은 법 시행령 제25조제5항에 따라 보건복지부장관이 정하여 고시하는 기준에 따른다.

마 신체의 발달상황에 대한 검사 및 별도검사

신체의 발달상황에 대한 검사 항목 및 검사방법

신체의 발달상황에 대한 검사항목 및 검사방법

「학교건강검사규칙」 제4조제2항 (별표1)

검사항목	측정단위	검 사 방 법
키	센티미터 (㎝)	1. 검사대상자의 자세 가. 신발을 벗은 상태에서 발꿈치를 붙일 것 나. 등·엉덩이 및 발꿈치를 측정대에 붙일 것 다. 똑바로 서서 두 팔을 몸 옆에 자연스럽게 붙일 것 라. 눈과 귀는 수평인 상태를 유지할 것 2. 검사자는 검사대상자의 발바닥부터 머리끝까지의 높이를 측정
몸무게	킬로그램 (㎏)	1. 옷을 입고 측정한 경우 옷의 무게를 뺄 것
비만도	-	1. 비만도는 학생의 키와 몸무게를 이용하여 계산된 체질량지수(BMI, Body Mass Index: ㎏/㎡)를 성별·나이별 체질량지수 백분위수 도표에 대비하여 판정한다. 2. 비만도의 표기방법은 다음 각 목과 같다. 가. 체질량지수로 백분위수 도표의 5 미만인 경우: 저체중 나. 체질량지수 백분위수 도표의 85 이상 95 미만인 경우: 과체중 다. 체질량지수 백분위수 도표의 95 이상인 경우: 비만 라. 가목부터 다목까지의 규정에 해당되지 않는 경우: 정상

※ 비고: 수치는 소수 첫째자리까지 나타낸다.
(측정값이 소수 둘째자리 이상까지 나오는 경우에는 둘째자리에서 반올림 한다.)

신체발달상황 및 시력검사 실시 기안(예시)

○ ○ 초 등 학 교

수신자　　내부결재

(경유)

제목　　20 학년도 신체발달상황 및 시력검사 실시 안내

---

1. 관련:　　-　　(20 . .)

2. 학교보건법 제7조 및 학교건강검사규칙에 의거하여 본교 2·3·5·6학년 학생들의 신체발달상황 및 시력검사를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 검사대상: 2·3·5·6학년 (1·4학년은 병원검진으로 대체)

나. 검사항목: 키, 몸무게, 시력

다. 검사일정

학년	2학년	3학년	5학년	6학년	미검학생
검사일정					

라. 검사 후 결과 처리

1) 각 가정에 결과를 발송

2) 결과 NEIS 건강기록부에 입력

3) 검사결과 비만학생 건강상담 실시

붙임 1. 신체발달상황 및 시력검사 실시 계획 1부.

2. 20 학년도 신체발달상황 및 시력검사 결과 기록부 서식 1부.

3. 20 학년도 신체발달상황 및 시력검사 결과 안내문 1부. 끝.

신체발달상황 및 시력검사 실시 계획서(예시)

신체발달상황 및 시력검사 실시 계획

○○초등학교

1. 검사대상: 2·3·5·6학년(1·4학년은 병원검진으로 대체)

2. 검사항목: 키, 몸무게, 시력

3. 검사일정

학년	2학년	3학년	5학년	6학년	미검학생
검사일시					

4. 결과 조치사항
   가. 검사결과를 가정에 발송
   나. 반별 결과표는 1부를 복사하여 학년별 취합 후 보건실로 제출
      (보건교사는 비만아동 상담 및 건강관리)
   다. 검사결과를 건강기록부(NEIS)에 입력: 키, 몸무게, 비만도(자동계산), 시력

5. 검사항목 및 검사방법(제4조 제2항 관련)

검사항목	측정단위	검 사 방 법
키	센티미터(㎝)	1. 자동 측정기기는 깜박거림이 멈추면 올라간다. 2. 검사대상자의 자세 가. 신발을 벗은 상태에서 등·엉덩이 및 발꿈치를 측정대에 붙인다. 나. 똑바로 서서 두 팔을 몸 옆에 자연스럽게 붙인다. 다. 눈과 귀는 수평인 상태를 유지한다. 3. 검사자는 검사대상자의 발바닥부터 머리끝까지의 높이를 측정
몸무게	킬로그램(kg)	1. 옷을 입고 측정한 경우 옷의 무게를 뺀다. 2. 체중이 노출되지 않도록 주의한다.
시력검사	공인 시력표에 의한 검사(3m용)	1. 시력표는 3m거리를 두고 1.0표시가 학생의 눈 위치에 오도록 설치한다. 2. 왼쪽 눈을 가리개로 가리고 오른쪽 시력을 먼저 측정하고 같은 방법으로 왼쪽 시력도 측정한다. 3. 안경을 착용한 학생은 안경을 착용한 상태에서 측정하여 교정시력에 기록한다. (나안시력은 측정하지 않음)

6. 측정 장소
   가. 키, 몸무게 – 각 반 교실 또는 지정 장소
   나. 시력 – 각 반 교실 또는 지정 장소

7. 측정시간 - 0~0교시(0교시 제외)

신체발달상황 및 시력검사 결과기록부(예시)

신체발달상황 및 시력검사 결과 기록부 (2·3·5·6학년용)

○○초등학교 (　　)학년 (　　)반　교사 :　　(인)

번호	이 름	성별	키(cm)	몸무게 (kg)	시력 (나안과 교정 중 해당항목)				비 고
					나안		교정(안경, 렌즈)		
					우	좌	우	좌	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

반별 통계	체중이상								시력이상					
	저체중		정상		과체중		비만		한쪽 시력이 0.7이하		교정중 (안경착용)		기타	
	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여

– 안경 및 렌즈착용 학생은 교정시력만 측정하고 나안 시력은 측정하지 않습니다.

신체발달상황 및 시력검사 결과 안내 가정통신문(예시)

	학생 신체발달상황 및 시력검사 결과 안내 가정통신문	제 호

안녕하십니까?

월 일에 실시한 귀 자녀의 신체발달 상황 및 시력검사 결과를 아래와 같이 알려드리오니 귀한 자녀의 성장을 관심 있게 지켜봐 주시고, 진료가 필요한 경우 가까운 병·의원을 방문하시어 건강한 학교생활을 할 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

제 학년 반 번 이름 :

구 분	측 정 치		
키	cm	몸무게	kg
비만도	저체중, 정상, 과체중, 비만(비만도 %)		
나안시력	좌: 우:	교정시력	좌: 우:
측정된 시력이 0.7이하면 안과검진 요망			
기타 진료할 사항			

20 . . .

○○○○ 학 교 장

결핵검진 지역별 일정

※학교별 세부일정 추후 안내

결핵검진 지역별 일정 안내

(단위: 명, 일)

지역	고등학교			중학교			비고
	검진목표	검진일수	검진기간	검진목표	검진일수	검진기간	
계	35,000	87	3.11 ~ 6.25	19,000	141	4.22 ~ 10.13	
천안시 서북구	6,000	15	3.11 ~ 6.4	2,900	15	4.23 ~ 9.11	
천안시 동남구	5,600	14		3,600	18		
공주시	2,100	5	3.26 ~ 4.20	650	9	8.24 ~ 9.21	
보령시	1,100	3	4.6 ~ 4.8	650	7	9.17 ~ 10.13	
아산시	6,500	15	3.11 ~ 6.4	4,000	21	4.23 ~ 9.11	
서산시	2,500	6	6.8 ~ 6.25	1,600	11	6.16 ~ 9.9	
논산시	2,300	5	3.12 ~ 5.8	725	8	4.22 ~ 7.13	
계룡시	700	2	3.12 ~ 5.8	550	3	4.22 ~ 7.13	
당진시	2,500	6	6.8 ~ 6.25	1,650	12	6.16 ~ 9.9	
금산군	550	2	3.12 ~ 5.8	325	4	4.22 ~ 7.13	
부여군	650	2	3.26 ~ 4.20	300	6	8.24 ~ 9.21	
서천군	750	2	4.9 ~ 4.10	250	4	9.17 ~ 10.13	
청양군	300	1	3.26 ~ 4.20	150	3	8.24 ~ 9.21	
홍성군	1,500	4	4.13 ~ 4.16	650	8	4.27 ~ 6.11	
예산군	1,300	3	4.17 ~ 4.22	700	7	4.27 ~ 6.11	
태안군	650	2	6.8 ~ 6.25	300	5	6.16 ~ 9.9	

※상기일정은 학교 및 협회 사정으로 변경될 수 있고 상호조정 가능함 (연락처: ☎ 042-252-9860)

학생건강검진 가정통신문(방문검진 - 예시)

20 학년도 학생건강검진 안내

안녕하십니까? 학교건강검사규칙에 따라 1학년과 4학년(중·고 1학년) 학생들은 지정된 병원에 개별 방문하여 건강검진을 받게 되어 있으며 학교운영위원회의 심의에 따라 본교는 ○○병원, ○○병원에서 건강검진을 실시하게 되었습니다. 학교와 검진기관과의 사전예약제가 시행됨에 따라 각 병원과 다른 학교들과도 검진시기가 정해져 있어 뒷장의 정해진 날짜에 건강검진을 모두 받아야 함을 양해하여 주시기 바랍니다.

비용	무료 – 학교운영비로 지급되어 본인 부담은 없습니다.
목적	성장기 학생에 대한 정기 건강검사를 통하여 질병 또는 건강상 결함의 예방, 조기발견 및 치료지도, 건강상담 등 적절한 보호대책을 강구하여 건강하고 안전한 학교생활을 도모하기 위함입니다.
항목	– 척추, 눈·귀, 콧병, 피부병, 구강, 병리검사 등 – 초 4학년(중·고 1학년) 비만학생(혈액검사, 허리둘레 측정 – 8시간 금식) – 고등학교 1학년 여학생: 혈색소 검사 추가
시기	– 월 일 ~ 월 일(휴일 및 시간은 병원별 일정에 따름)
주의사항	– 검진 당일 공복유지(검진 전날 21시부터) – 선정된 검진기관 중 희망하는 검진기관 한 곳을 방문하여 검진을 받습니다. – 반드시 병원검진 먼저 받으시고, 검진병원에서 안내하는 '치과'에서 구강검진도 받아야 합니다. – 검진 전 점심시간이나 지연시간 확인 위해 검진기관에 미리 전화통화 하시고 방문하시면 더욱 편하게 이용하실 수 있습니다. – 검진 후 이상소견이 발견된 경우에는 추후 자비로 진료 및 검사를 받으셔야 합니다. – 학교에서 배부 해 드린 문진표를 작성하시오 함께 지참하여 병원에 방문하여 주십시오. ※ 기타 궁금한 사항은 학교보건실 ☏○○○-○○○○로 문의

◎ 검진기관 안내 ◎

검진기관		
위치		
전화번호		
검진시간		
교통편		
결과처리	– 건강검진 결과는 검진기관 ⇒ 학교 ⇒ 학생 편에 가정으로 배부합니다. – 보호자님은 반드시 결과를 확인하시고, 건강검진 결과 이상이 발견되면 정밀검사 등 가정에서 적절한 조치를 취하기 바랍니다.	

1. 학생건강검사는 선택이 아니라 법에 의거하여 실시하는 의무사항입니다.
2. 건강검진이 가능한 날짜와 시간을 확인하고 가세요.
3. 가정에서 교통안전 지도 및 안전사고 예방에 대하여 주의를 기울여 주시기를 바랍니다.

20 . . .

○ ○ ○ ○ 학 교 장

학생건강검진 유소견자 가정통신문(예시)

	건강검진 결과 유소견자 안내 가정통신문	제 호

학교 학년 반 이름 :

학부모님 안녕하십니까?
학부모님 가정에 평안이 가득하시기를 기원합니다.
검진기관에서 실시한 학생 건강검사 결과 귀댁 자녀는 (예>고지혈증: ○○○) 유소견자로 나왔습니다. 이에 가정통신문을 발송 하오니 가까운 병·의원을 방문하시어 진료를 받게 해주시고, 아래 회신문에 검사결과를 병·의원에서 직접 기입 받아 보건교사에게 보내주시기 바랍니다. 병·의원에 가실 때는 검진기관에서 통보한 검사결과지를 지참하시고 가시기 바랍니다.

20 년 월 일

○○○○학 교 장

---

* 진료내용 및 검진결과는 의료인이 직접 기입하여 주시기 바랍니다.

병·의원 검사결과 회신문

학교 학년 반 이름 :	
진료내용	
검진결과 및 소견	
검진기관	검진기관명: 검진일: 20 년 월 일 확인자: 성명 (인)

○○○○ 학 교 장 귀하

◆ 개인정보 수집·이용 목적: 건강검진 재검 결과 확인
- ○ 보유 및 이용 기간: 제출 후 5년(건강검진 후 추후관리에 대한 종합감사시 활용)
- ○ 개인정보 수집·이용에 동의합니다. □ 예 □ 아니오

보호자 성명 : (인)

초2·3·5·6학년 구강검진 안내(방문검진－예시)

	가정통신문	제 호
	대상: 2·3·5·6학년	

학부모님, 안녕하십니까?
『2·3·5·6학년 학생 구강검진』에 대하여 안내해 드리니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

1. 검진 대상: 본교 2·3·5·6학년 학생
2. 검진 기간: 20 년 월 일( ) ~ 20 년 월 일( )
3. 검진 비용: 무료 (학교 예산에서 지급)
4. 검진 기관: 국민건강보험공단에 등록된 건강검진 기관

검진기관명	전화번호	주 소	검진가능시간
○○치과의원	000－0000	○○동 ○○번지	평일 09:00 ~ 17:00 (점심 13:00 ~ 14:00)
○○ 치과의원	0000－0000	○○동 ○○번지	평일 09:30 ~ 18:30 (점심 13:00 ~ 14:00)

☆ 주의사항: 반드시 1개 기관에서만 검진을 실시하며, 착오로 중복검진시 추가비용은 학부모님 부담입니다.

5. 검진 방법
 1) 학교에서 지정한 병원 중에서 1곳을 선택한 후, 지정된 검진일에 보호자와 함께 방문하여 검진합니다.
 2) 구강검진 문진표를 작성하여 검진 기관에 제출합니다.
 3) 만일 지정된 검진 일에 검진을 받지 못했을 경우
  ① 타 학년반 검진기간 종료 후 미검자 검사일로 지정된 기간(0월 0일~0일)에 검진(권장)
  ② 토요 휴업일 오전 또는 타 학년반 검진일에 검진(다른 내원객들과의 혼잡예상)

6. 검사 항목: 치아우식, 결손치아, 구내염, 부정교합, 구강위생상태 등

20 년 월 일

○○○○학교장

절취선

<학교제출용>

학년 반 번 이름:

구강검진 확인서	
검사일	년 월 일
검진병원명	

* 검진 후 확인서를 담임선생님께 제출해주시기 바랍니다.

○○○○학교장 귀하

구강검진결과에 따른 재검진 안내(예시)

20○○학년도 2·3·5·6학년 구강검진결과에 따른 재검진 안내

보호자님의 관심과 협조덕분으로 2·3·5·6학년 학생구강검진이 완료되었습니다.
아래의 충치를 예방하는 생활 습관을 참조하시어 학생의 치아 건강을 위해 평소 꾸준한 관리를 해주시기를 부탁드립니다.
또한 구강검진 시 이상소견을 들으신 경우 치료를 받으시고 결과 혹은 향후치료(관리) 계획을 아래 회신문에 작성하여 담임선생님께 ○월 ○일(○)제출하여 주시기 바랍니다.

※ 구강검진 시 이상소견을 들은 아동의 경우에만 제출해 주세요. 치료는 자비부담이며 원하는 병원에서 받으면 됩니다.

※ 충치를 예방하는 생활습관
학교에 칫솔을 가지고 다니며, 하루 4번 이상(식사/간식 후, 잠자기 전) 양치질을 합니다.
- 6개월마다 치과 검진을 받습니다.
- 단 음식은 적게 먹고 채소, 칼슘이 포함된 음식 등을 섭취합니다.
- 청량음료(콜라 등)는 자제하고 마셔야 할 경우는 빨대로 마시고 물로 가볍게 헹궈내며 30분 후에 양치를 합니다.

20 . . .

○ ○ ○ ○ 초 등 학 교 장

——————————————— 회신문 ———————————————

<table>
<tr><td rowspan="5">구강검진 후
치료현황</td><td colspan="2">구강검진 결과</td><td colspan="2">치 료 결 과</td></tr>
<tr><td>충치</td><td></td><td colspan="2" rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>부정교합</td><td></td></tr>
<tr><td>기타</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">* 진료일자
(추후 예정된 치료일)

: 20○○. ○. ○.</td><td colspan="2">* 치과명(치료 실시 혹은 예정인 병원명)
(　　)

* 보호자 성명:　　(인)</td></tr>
</table>

○○○○초등학교장 귀하

학생 건강검사 추진 실태 점검표(학교용)

학생 건강검진 추진실태 점검표[학생]

1. 일반 현황: ☎ ( ) – OO학교

학 교 명	학교장	전 체 학생수	건강검사 실시 현황(○, X)				
			건강검진	구강검사	시력검사	소변검사	결핵검사

2. 점검 사항

내 용	확인결과			조치사항(비고)
	양호	보통	미흡	
1. 건강검사 실시계획 수립여부 및 타당성 – 소요예산, 건강검사 결과 후속조치 등				
2. 적정 건강검진기관 선정 여부 – 국민건강보험법 규정의 등록된 검진기관 선정 – 학운위 심의 또는 자문 등 학부모 의견수렴 등				
3. 검진기관 2개 이상 선정여부/출장검진, 2개 기관 이상 미 선정시 교육장의 사전승인 여부				
4. 5검진항목 및 방법, 비용, 각종서식(문진표, 건강조사, 결과통보서 등) 준수 여부				
5. 학생건강기록부 관리 – 교육정보시스템 등록 여부(전년도) – 결과통보서 관리 여부(전년도)				
6. 건강검사 결과 후속조치 적정여부 – 해당학생(학부모)에게 통보 – 치료, 보호, 휴학 등 요양 조치 및 대책 등				
7. 별도검사 실시 시기·방법 등의 적정 여부(시력, 소변, 결핵검사 등)				

위의 사항이 틀림없음을 확인함

20 년 월 일

점검자 : 직) 성명)

확인자 : 직) 성명)

학생 건강검사 추진 실태 점검표(건강검진용)

학생 건강검진 추진실태 점검표[검진기관용]

1. 일반 현황: ☎ (　　) 　　-　　OO교육지원청

기관명	대표자	주소	검진 구분		
			의과검진	구강검진	의과 검진 + 구강검진

2. 점검 사항

내　　용	확인결과			조치사항(비고)
	양호	보통	미흡	
1. 국민건강보험법 규정에 의한 검진기관 지정 여부				
2. 학생들의 수업결손 및 편의제공 여부 – 공휴일, 검진시간 조정 등				
3. 건강검진 실시요령 안내자료 배부 여부 – 검진대상자 본인임을 확인(학생증 등) – 공복 유지 및 주의사항 안내				
4. 검진인력 및 검진장비, 검진방법 등 확인				
5. 각종서식(문진표, 건강조사, 결과통보서 등) 준수 여부 – 결과통보서 뒷면 별도검사 기록서식 인쇄 확인				
6. 건강검진 결과 통보 적정 여부 – 해당학생(학부모)과 학교장에게 통보 – 검사 후 통보까지의 소요기간 적절성 여부 – 검사결과에 따른 사후관리 명시 여부 (수검자가 이해할 수 있도록 안내)				

위의 사항이 틀림없음을 확인함

20　년　　월　　일

점검자 :　　직)　　성명)

확인자 :　　직)　　성명)

학생 건강검진 기관 만족도 조사(예시)

학생 건강검진 기관 만족도 조사(예시)

조사 일자: 20 . . (요일)
학교명: OOOO학교

본 설문지는 학생건강검진의 질 향상과 개선을 위하여 학생(학부모)의 건강검진 기관에 대한 만족도를 파악하고자 작성된 것입니다.(성의 있는 답변 부탁드립니다)

건강검진 받은 해당 병·의원을 V표 하세요

일반 건강검진 기관		치과 건강검진 기관	
○○보건소	v	○○치과	
성○○의원		△△치과	
□□병원		□□치과	v

○ 학생건강검진 만족도에 관하여 해당란에 V표 하세요

조사 내용	일반검진					치과검진				
	매우 만족	만족	보통	불만	매우 불만	매우 만족	만족	보통	불만	매우 불만
1. 검진 기관과의 거리	v					v				
2. 검진 시 대기 시간정도				v				v		
3. 병원 직원의 친절도			v					v		
4. 검진기관에서 보유하고 있는 검진장비의 청결도			v				v			
5. 검진기관의 탈의실 및 대기실 등 검진환경 쾌적함 정도	v						v			
6. 종합적인 만족 정도		v					v			

○ 기타의견을 구체적으로 적어 주세요

※ 만족도 조사 내용은 학교 실정에 맞게 수정하여 사용 가능

학생 건강검진 기관 만족도 조사결과(누리집 공개용)

학생 건강검진 기관 만족도 조사결과

조사 일자: 20 . . (요일)

20 년도 우리학교 _____학년 건강검진에 대한 학생(학부모)의 건강검진 기관 만족도 설문 조사를 실시한 결과입니다. 앞으로 학생건강검진의 질 향상과 개선을 위해 더욱 노력하겠습니다.

○ 학생건강검진 만족도

(단위: 명)

조사 내용	일반검진					치과검진				
	매우 만족	만족	보통	불만	매우 불만	매우 만족	만족	보통	불만	매우 불만
1. 검진 기관과의 거리	V									
2. 검진 시 대기 시간 정도		V								
3. 병원 직원의 친절도		V								
4. 검진기관에서 보유하고 있는 검진장비의 청결도	V									
5. 검진기관의 탈의실 및 대기실 등 검진환경 쾌적함 정도	V									
6. 종합적인 만족 정도		V								

※ 내용별 만족도에 대한 응답자 수 기재

학생 건강검진 기관 만족도 조사 기안 및 결과분석

○ ○ ○ ○ 학 교

수신자 수신자 참조
(경유)
제목 20 학년도 학생 건강검진 기관 만족도 조사 결과

1. 관련: 학교-20 (. . .)
2. 만족도 조사 결과를 학교 홈페이지에 탑재하고, 차기년도 건강검진 기관 선정에 참고하며 좀 더 내실 있는 건강검진이 될 수 있도록 검진기관에 통보하고자 합니다.

붙임 1. 건강검진 기관 만족도 설문조사 결과(OOOO병원, OOOO치과)
2. 건강검진 기관 만족도 설문조사 결과(OOOO병원, OOOO치과) 끝.

학생 건강검진 기관 만족도 조사 결과

1. 검진기관 만족도 조사 결과(0000병원, 0000치과) 총 명

조사 내용	일반검진					치과검진				
	매우 만족	만족	보통	불만	매우 불만	매우 만족	만족	보통	불만	매우 불만
가. 검진 기관과의 거리										
나. 검진시 대기 시간의 길이										
다. 병원 직원의 친절도										
라. 검진기관에서 보유하고 있는 검진장비의 청결도										
마. 검진기관의 탈의실 및 대기실 등 검진환경 쾌적함 정도										
바. 종합적인 만족 정도										
계(%)										

2. 조사 결과 분석
가. 검진기관 만족도 조사 결과(0000병원, 0000치과) 총 명
- 기타의견으로 치과 의사의 불친절, 혈압측정 요원의 불친절, 대기시간 길어짐, 대기실 부족 등의 의견이 나왔음
- 항목별 만족도는 1, 2, 4번 항목은 대체적으로 높게 나왔고 나머지 항목이 낮게 나왔음

나. 검진기관 만족도 조사 결과(0000병원, 0000치과) 총 명
- 기타의견으로 화장실 이용불편(화장실수 절대부족, 채혈요원의 불친절, 대기시간 길어짐, 대기실 부족, 치과검진 부실 등의 의견이 나왔음
- 항목별 만족도는 1, 2번 항목은 대체적으로 높게 나왔고 나머지 항목이 낮게 나왔음

3. 종합의견
- 대체적으로 ○○병원이 ○○병원보다 만족도가 높게 나왔고 ○○병원은 치과의사의 불친절을, ○○병원은 채혈요원의 불친절을 개선사항으로 많이 지적함

※ 이 결과는 각각의 병원에 통보할 예정이며 학교 홈페이지 보건게시판에 공개하고 내년도 건강검진 계획수립 시에 반영 예정임

3 요보호 학생 관리

가 요보호 학생 선정

출처: 서울시교육청(2024), 2024년 한눈에 보이는 보건업무 길라잡이

구분	추진 절차	세부 내용
요보호 학생파악	건강실태조사	• 3월 학년 초, 전교생, 「건강조사 설문지」 가정통신 발송 • 학교응급환자 관리체계에 대한 안내와 함께 보호자의 응급관리 동의, 연락처, 원하는 이송병원 파악(보호자 날인 확인) • 「건강조사 설문지」는 학생 상담 및 건강관리자료로 활용, 1년 후 폐기
	학급별 건강이상 학생 명단 작성 및 건강 상담 대상자 선별	• 담임교사: 「학급별 건강이상 학생 명단」 작성 후 보건실로 제출 • 보건교사: 「학급별 건강이상 학생 명단」 검토 후 건강 상담이 필요한 학생 선별 ※ 요보호 학생 명단은 보안 ⇒ 문서 암호 설정할 것
	건강이상 학생 상담	• 학생 개별상담, 학부모 상담, 전화상담 등
	요보호 학생 선정	• 지속적인 추후관리와 건강 상담이 필요한 학생을 요보호자로 선정및 관리 • 요보호 학생 건강상담록 작성: 병력, 현재 건강문제, 진료병원, 응급 시 연락처, 투약 관련에 관한 내용, 학교 중점 관리 사항, 특이사항 등 기록 • 내부결재 받은 후 교직원 연수 실시
요보호 학생에 대한 교직원 연수 실시	교직원 연수	• 전체 교직원에게 요보호 학생 명단을 배부하고 학생의 건강상태 및 지도 시 주의사항, 관찰 사항 등을 연수하여 학교 교육활동에 참고하도록 함 • 외부노출 되지 않도록 개인정보보호 관리 철저 안내
요보호 학생 관리	정기, 비정기 건강상담 및 상담록 관리	• 정기 및 필요시 건강 상담 실시와 건강상담록 기재 • 필요시 학생 및 학부모에게 건강정보를 제공, 병원진료에 대한 지도 및 조언

요보호 학생의 개념

- 신체 허약이나 만성질환으로 학교 교육활동 중 건강상 문제가 발생할 가능성이 있어 지속적인 추후 관리가 필요한 학생
- 3개월 이상의 장기입원 또는 통원치료 등 계속적인 의료적 지원이 필요한 학생
- 요보호 학생 선정 시에는 아래와 같은 경우를 참고로 선정

TIP!

- 약이나 음식물로 인한 알레르기가 있거나, 병원치료를 자주 받는 경우
- 현재 면역억제제나 호르몬제 치료를 받고 있는 경우
- 심혈관계질환(심장병, 고혈압)의 진단 및 치료를 받고 있거나 받았던 학생
- 근육 및 골격계 질환의 치료(교통사고 포함)를 받은 적이 있는 경우(단, 병결석계를 진단서 첨부하여 학교에 제출한 적이 있는 학생)
- 신장계통의 질환으로 1주일 이상 입원치료 혹은 매일 투약 중인 학생
- 간질환으로 의사의 처방 하에 약을 복용하고 있는 경우
- 만성소모성질환(결핵, 당뇨 등)으로 규칙적인 치료 및 투약 중인 학생
- 뇌수술, 뇌전증, 정서장애, 기타 심한 행동장애(틱 장애)가 있는 학생
- 미세먼지 관련 기저질환(천식, 알레르기, 호흡기질환, 심혈관질환 등) 보유 학생
- 기타 학교생활 전반에 걸쳐 건강상태를 고려하여 운동 제한을 요하는 학생
- 현재 병원치료를 요하는 학생(특히 정신과 약물복용 중이거나 또는 상담중인 학생)이나 그 외 특이질환이나 희귀병 등을 앓고 있는 학생

20 학년도 요보호 학생 명단

연번	학년/반/번	이 름	병 명	현재 건강 상태	주의 사항
1			다발성 골절 (교통사고 '20)	골반뼈 이상	체육시간 활동 어려움
2			청각장애(1급)	인공와우이식	머리에 심한 충격 주의 의사소통 시 눈맞춤 배려
3			모야모야병	현재 일상생활 가능	과호흡주의 (리코더불기, 울기, 힘든 체육활동), 증상- 팔, 다리마비, 눈앞 흐려짐, 두통, 구토 시 학부모에게 연락(병원 의뢰 고려)
4			(우)무릎 성장판 수술	양쪽 다리 길이 다름	다리 강한 자극 금지, 뜀틀 금지, 달리기 가능, 안전사고 주의
5			천식	천식(강)	미세먼지, 심한 감기, 심한 운동 시 증상 악화됨 체육시간 심한 운동 시 고려 요망
6			척추측만증	양쪽 다리 길이 다름	교정용 신발 착용 중 통증 유발에 따른 체육활동 고려
7			저신장증	저신장증 호르몬 요법중	초등에서 집단 따돌림 당함, 행동 느림
8			공황장애	심계항진(빈맥)	3개월 전부터 처방약 복용 중 사람 많은 곳, 강한 운동 중 조절 되지 않는 빈맥, 전신 떨림 증상 심한 운동 주의 대중교통 이용한 교외활동 시 배려
9				허약체질	쓰러지는 증상 있음, 진단 없음
10			턱관절염	턱관절 통증	턱관절 충격 주의

※ 요보호 학생 명단은 대외비로 관리 요망, 위 학생들은 눈에 띄는 차별을 하지 않도록 유의 바람
※ 요보호 학생 명단은 보안⇒문서 암호 설정할 것

다 요보호 학생 건강상담 기록 카드

<table>
<tr><td rowspan="2">이 름</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td rowspan="2">남, 여</td><td rowspan="2">연락처</td><td>학생</td><td></td></tr>
<tr><td>보호자
(관계)</td><td></td></tr>
<tr><td>학 년</td><td>1학년</td><td>2학년</td><td>3학년</td><td colspan="2">4학년</td><td>5학년</td><td>6학년</td></tr>
<tr><td>학 급</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>담임교사</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>병명 및 증상</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">최초 발병일</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">현재
건강 문제</td><td colspan="3" rowspan="3"></td><td colspan="2">진료 병원</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">복용 약물</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">치료 내용</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">학교 중점
관리사항</td><td colspan="3" rowspan="3"></td><td colspan="2">수업시간</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">체육시간</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">학교활동</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>가족 병력</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>상담일</td><td colspan="7">상 담 내 용</td></tr>
<tr><td>20 . . .</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>20 . . .</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>20 . . .</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

가 학생 건강기록부 법정서식

[별지 제1호서식]

학생건강기록부

(앞쪽)

1. 인적사항

성명		성별	□ 남 □ 여	주민등록번호	~

학교	학 년	반(이수과정 / 학과)	번 호	담임성명

2. 감염병 예방접종

가. 취학 전 예방접종

대상 감염병	접종여부					비고
	1차	2차	3차	4차	5차	
디프테리아						
백일해						
파상풍						
홍역						
유행성이하선염						
풍진						
회색질척수염(polio)						
결핵						
일본뇌염						
수두						
B형 간염						

나. 취학 후 예방접종

대상 감염병	학교 / 학년	접종일	대상 감염병	학교 / 학년	접종일
일본뇌염					
디프테리아					
파상풍					
사람유두종바이러스					

3. 건강검사 실시현황

가. 신체의 발달상황

구분	초등학교						중학교			고등학교		
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	1	2	3
키(㎝)												
몸무게(㎏)												
비만도												

나. 신체의 능력

구분		단위	초등학교			중학교			고등학교		
			4	5	6	1	2	3	1	2	3
왕복오래달리기		회									
오래달리기-걷기 (초5~고3)	1,000m(초)	분 : 초	공란								
	1,600m (중·고/남)	분 : 초	공 란								
	1,200m (중·고/여)	분 : 초	공 란								
스텝검사		PEI	공란								
앉아윗몸앞으로굽히기		cm	공란								
종합유연성		점									
(무릎대고)팔굽혀펴기(중·고)		회	공 란								
윗몸말아올리기		회									
악력		kg									
50m 달리기		초									
제자리멀리뛰기		cm									
체지방률		%									
신체의 능력점수		점									
신체의 능력등급		등급									

다. 건강검진 현황

구분		초등학교						중학교	고등학교
		1학년	2학년	3학년	4학년	5학년	6학년	1학년	1학년
건강검진	검진일		공 란			공 란			
	검진기관		공 란			공 란			
구강검진	검진일								
	검진기관								

라. 별도검사 현황

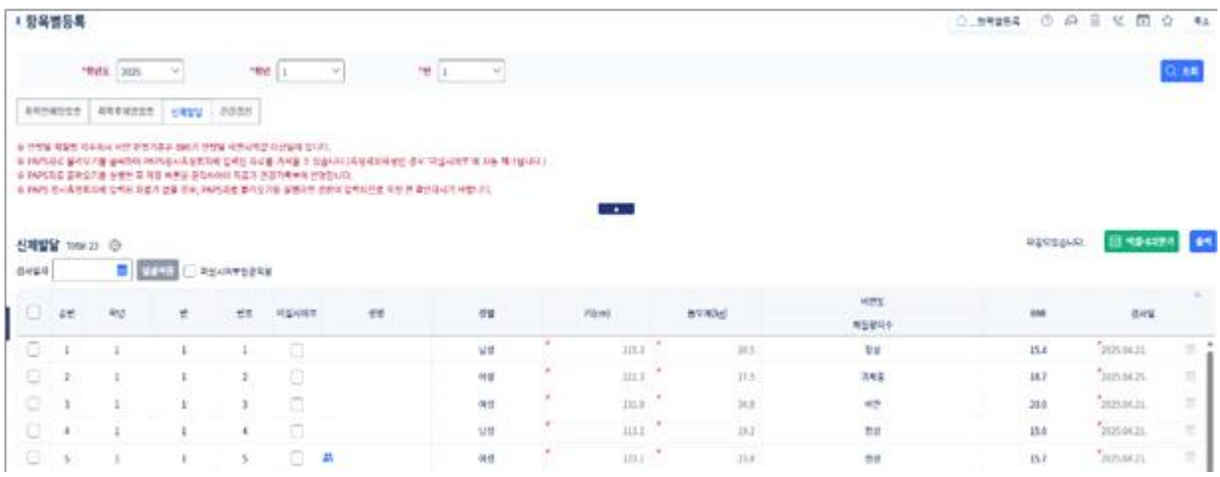
검사일												
검사명												
검사기관												

나 NEIS 건강기록부 기록방법

* 건강기록부(NEIS) 관리 매뉴얼: 4세대 지능형 나이스(NEIS) 사용자 설명서(교육부, KERIS)
※ 충청남도교육청누리집 – 부서별누리집 – 체육건강과(학교보건자료실) – 345번(4세대 지능형 나이스(NEIS) 사용자 설명서(보건))

신체발달 등록 (보건–건강기록부관리–항목별등록–신체발달)

* 학교 별 (보건) 탭 명칭이 상이할 수 있음



- [신체발달] 탭을 선택하면 해당 반 학생들의 신체발달 상황이 키, 몸무게, 비만도(체질량지수, BMI, 검사일 순으로 나타남
- 등록하고자 하는 학생들의 키와 몸무게를 입력하고 저장하면 비만도(체질량지수, BMI)가 계산되어 나타남
- 학생을 선택한 후【PAPS자료 불러오기】버튼을 클릭하여 PAPS에 등록된 신체발달 자료를 가져올 수 있음
- 초등학교, 중·고등학교 1학년의 경우【건강검진 검진일 불러오기】버튼을 클릭하여 건강검진에 등록된 검사일을 가져올 수 있음. 건강검진, 건강검사, 구강검사에 입력된 동일 검진일 또는 입력된 항목의 검진일이 나타남

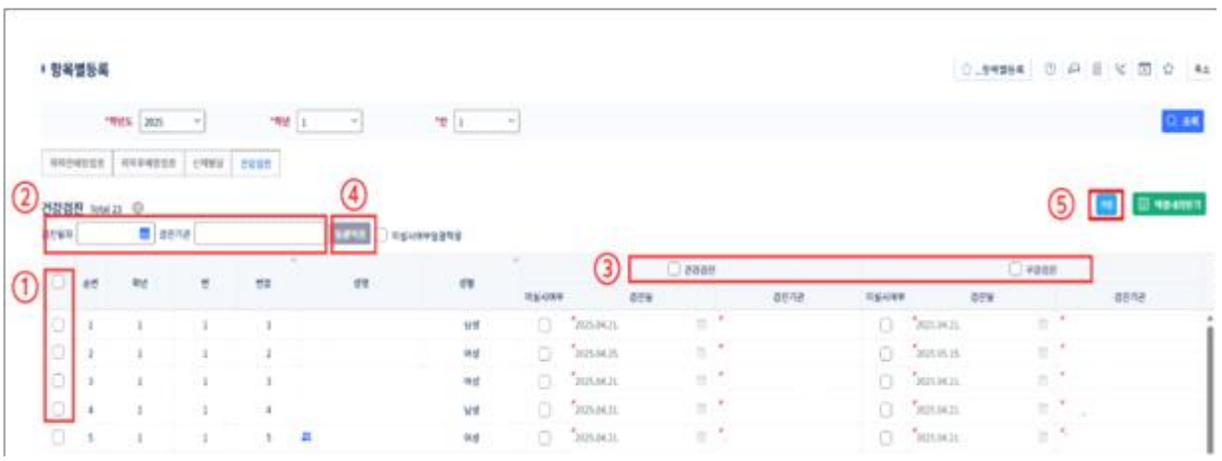
<올리기, 내리기>를 활용한 자료 등록방법

– [항목별등록] > 학년·반 조회 > 해당 항목 클릭(건강검진, 신체발달)
– 내리기:【내리기】> 엑셀파일 열림 > 엑셀파일에 자료 기록 및 저장
– 올리기:【올리기】> 팝업창 '확인' > 팝업창에서 파일선택(내리기하여 기록·저장한 파일) > 수정된 자료가 업로드 됨 > 저장



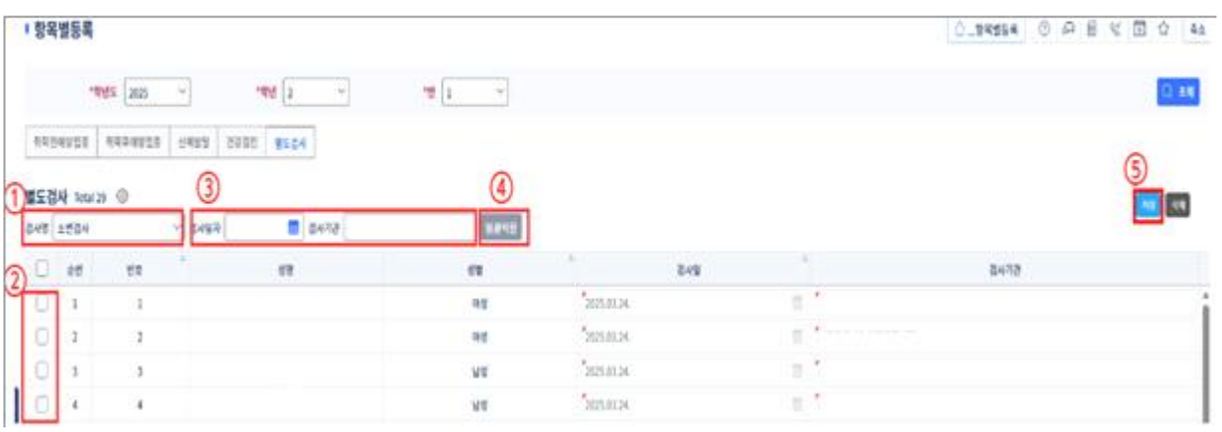
건강검진 등록 (보건-건강기록부관리-항목별등록-건강검진)

* 학교 별(보건) 탭 명칭이 상이할 수 있음



- [건강검진] 탭을 선택하면 해당 반 학생들의 건강검진 내용이 나타남
- 건강검진을 실시하지 않는 학년의 경우 [건강검진]탭은 보이지 않는다.
- ① 등록하고자 하는 학생들을 선택하고 ② 목록상단의 검진일자, 검진기관을 입력한 후 ③ 건강검진과 구강검진 체크박스를 통해 원하는 항목을 선택한다.
- 건강검진과 구강검진의 내용이 같다면 체크박스에 두 항목 다 체크해서 함께 일괄 적용 할 수 있으며, 각각 적용도 가능하다.
- ④【일괄적용】 버튼을 클릭하면 선택된 학생들의 검진일자와 검진기관이 일괄로 적용된다.
- 건강검진과 구강검진의 검진일과 검진기관을 모두 입력하고 ⑤【저장】 버튼을 클릭하여 저장한다.

별도검사 등록 (보건-건강기록부관리-항목별등록-별도검사)



- 등록 방법: ①【검사명】 검색(소변검사, 시력검사, 결핵검사) - ② 해당 학생 체크 - ③【검사일자】,【검사기관】 입력 - ④【일괄적용】 - ⑤ 저장
- 기존에 검사일, 검사기관 등이 입력되어 있는 학생에 대해 검사일, 검사기관 등을【일괄적용】 하면 "유효한 데이터가 존재합니다. 계속 진행하시겠습니까?"라는 안내 메시지 창이 뜬다. ➔ 체크박스에 체크를 해제하고【저장】 버튼을 클릭하여 입력내용을 저장한다.

학년말 건강기록부 마감

1) 자료검증단계 및 반별마감(담임마감): 보건 – 건강기록부관리 – 반별등록 – 자료검증



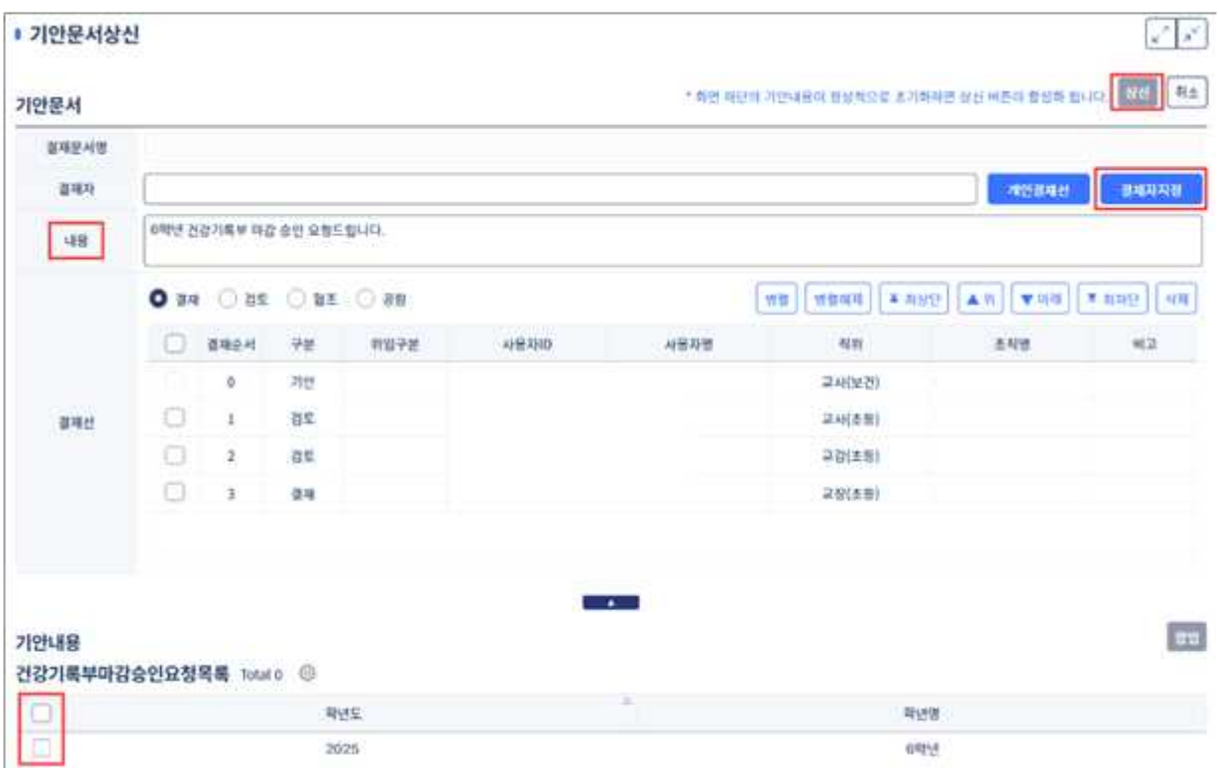
- 담임: 【자료검증】 버튼을 클릭하면 팝업으로 학생들의 건강기록부 자료의 등록여부가 나타난다.
  – 자료검증 가능한 경우: 자료검증 클릭 > 자료검증창의 미등록 '학생 및 항목 확인 > 팝업창(자료검증) 닫기 > 자료검증 대상 학생 클릭 > 미등록 항목 등록 ⇒ 마감 버튼이 생성되면 마감 시행
  – 자료를 입력할 수 없는 경우: 해당 학생 클릭 > '자료검증대상제외'를 클릭하여 자료검증에서 제외시킴
  ⇒ 마감 버튼이 생성되면 마감 시행
- 담임: 미등록된 자료들을 등록하면 【자료검증】 버튼 대신 【반별마감】 버튼이 보인다.
- [반별등록] > 학년·반 조회 > 마감: 마감 후 '마감취소' 버튼이 생성되므로, 추가 및 변경 사항 발생 시 마감 취소 후 기록 가능
  (졸업대상자는 졸업일정에 맞추어 진행, 졸업대상자외 학생은 2026.2.28.까지 반별마감 및 전체마감 처리 가능)
- 건강기록부 최종마감: 「반별등록」 메뉴에서 【반별마감】 > 「건강기록부 마감」 메뉴에서 【전체마감】



2) 전체마감(업무담당자마감): 보건 – 건강기록부관리 –건강기록부마감



- 마감하고자 하는 반을 조회하여 체크박스를 선택한 후【마감】,【마감취소】버튼을 누르면 해당 반의 전체마감/전체마감취소를 할 수 있다.
  – [건강기록부 마감] > 학년 또는 전체 조회 > 선택 ☑ > 마감
  – 마감 후 변경사항이 있으면 '마감취소' 버튼으로 취소 가능
  – 반별마감이 완료된 후에 학년 또는 전체 마감이 가능
  – 졸업학년은 진학과 관련하여 마감일정이 더 빠르므로 일정확인 후 시행
- 전체 마감을 하기 위해서는 반별마감이 선행되어야 하며 이는【반별등록】에서 할 수 있다.
- 최종 마감: 해당 학급 체크박스 선택 – 승인요청



건강기록부 점검 기안문 - 연 1회 건강록부 점검

OOOO학교

수신 내부결재
(경유)
제목 학생건강기록부 점검 실시

---

1. 관련: 학교- (20 . .)
2. 학생 건강기록부 점검을 아래와 같이 실시하고자 합니다.
   가. 기간: 20 . . .(월) ~ . .(금)
   나. 대상: 1~6학년 건강기록부[NEIS]
   다. 내용: 현재 년도 및 과년도 인적사항, 건강검진 입력 상황 등 [붙임 1]를 활용하여 점검 실시하며 아래 항목에 유의하여 실시한다.

• 전년도 건강검진 날짜 및 기관이 누락되거나 신체발달 상황이 미입력 된 경우 • 입력된 신체발달상황(키, 몸무게, 비만도)이 전년도에 비해 현저하게 줄어든 경우 • 외국에서 학교를 다니다 국내로 재취학, 편입학을 한 경우

   라. 점검자: 담임교사
   마. 확인자: 보건교사
   바. 방법
   ① 담임교사가 1차로 점검을 하고 [붙임1] 작성하여 보건교사에게 제출
   ② 보건교사는 점검자료를 받은 후 2차 점검을 실시 후 지원청 보고
   사. 주의사항: 이상이 있는 경우에는 확인 자료를 첨부하여 건강기록부 수정

붙임 학생건강기록부 점검 항목 1부. 끝.

OOOO학교장

학생건강기록부 점검 항목

OOOO학교

▣ 학년 반: _____ ▣ 학생수: _____명 ▣ 점검일시: 20 . .

.

순	항 목	내 용	확 인 (이상없을 시 ○표시, 이상 있을 시 학생이름과 내용 기재)	조치사항 기재
			점검자	확인자
1	인적사항	① 학생의 성명, 성별, 주민등록번호	*이상 있을 시 학생이름과 내용 기재*	
		② 학교, 학년 반, 담임 성명	*담임은 학년별 최종담임 1명만 입력되어야 함*	
2	예방접종	① 취학 전 예방접종	*이상 있을 시 학생이름과 내용 기재*	
		② 취학 후 예방접종	*이상 있을 시 학생이름과 내용 기재*	
3	신체발달 상황	키, 몸무게 입력 여부	*이상 있을 시 학생이름과 내용 기재*	
4	건강검진 및 별도검사	① 건강검진 일자, 검진기관(내과, 구강검사)	*이상 있을 시 학생이름과 내용 기재*	
		② 별도검사(구강, 결핵, 시력, 소변검사 등),일자, 기관	*이상 있을 시 학생이름과 내용 기재*	
5	기타 (신체능력 검사 결과, 전출입 여부 등)			
6	점검교사	1차 점검교사: 담임교사 2차 점검교사: 보건교사		

위와 같이 점검하였음을 확인합니다.

점검자(1차 점검자) : (서명)

확인자(2차 점검자) : (서명)

건강기록부 정정대장

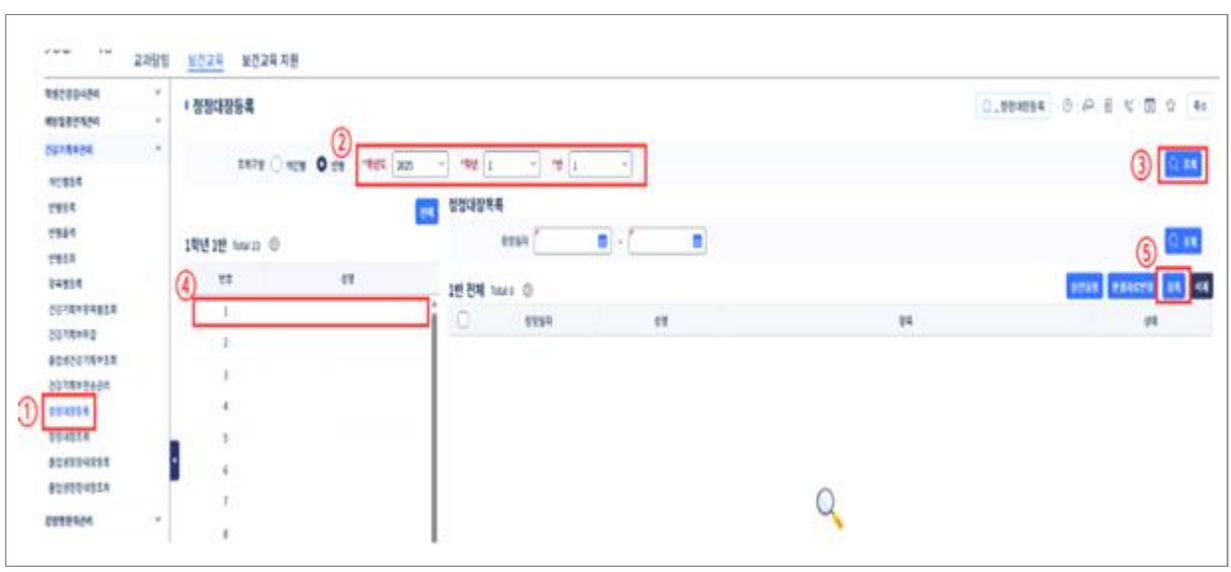
♣ 건강기록부 정정을 위한 진행 단계 및 증빙서류

① 건강기록부 점검: 1차 담임교사, 2차 보건교사 – 학급별 '건강기록부 점검항목'에 따른 점검실시
② 오류항목에 대한 사실여부 확인
ex) 키, 몸무게, 시력검사 - 건강검사기록 또는 신체발달상황 수기부
③ 건강기록 정정을 위한 근거 서류 편철: 학년말 반드시 비전자문서처리 필요
– 수정 전 건강기록부 출력물 1부 ★ 정정대장【완결자료반영】전 반드시 미리 출력해야 함
– 증빙서류 각 1부: 사안에 따라 필요한 서류(건강(구강)검사결과통보서, 신체발달상황·시력검사 수기부 등)
※ 전입생의 경우 전출교에 해당 서류 공문으로 요청(전출교 학년/반은 생활기록부 확인 필요)
– 수정 후 건강기록부 출력물 1부
④ 나이스 건강기록부 정정대장 작성 – 보건 > 건강기록부관리 > 정정대장 등록: 항목별 수정 진행
⑤ 결재 상신: 반드시 4단 결제 – 담임(기록자) > 부장 > 교감 > 교장
⑥ 결재 완료 후 정정대장완결자료 반영: 【완결자료반영】을 클릭하여 반영 후 건강기록부 출력
⑦ 권고사항: 건강기록부 점검결과 및 건강기록부 정정대장 결과 보고 기안 상신
※ 해당 학년도 건강기록부는 정정대장 없이 수정가능
이전 학년도 건강기록부 내용은 '건강기록부 정정대장'을 통해서만 수정가능
단, 취학전 예방 접종내역은 정정대장 없이 수정가능

1) 건강기록부 정정대장 1단계 입력

- 메뉴경로: [나이스] – [보건] – [건강기록부관리] – [정정대장등록]
- [정정대장등록] > ② 학년, 반 설정 > ③ 조회 > ④ 학생목록에서 학생 성명 선택 > ⑤ 등록 > ⑥ 팝업창에서 '개별등록' 탭 선택 > ⑦ 학생 이름 선택 ☑ > ⑧ 수정하고자 하는 항목 선택 ☑, 오류내용, 정정내용, 정정사유 입력 > ⑨ 저장

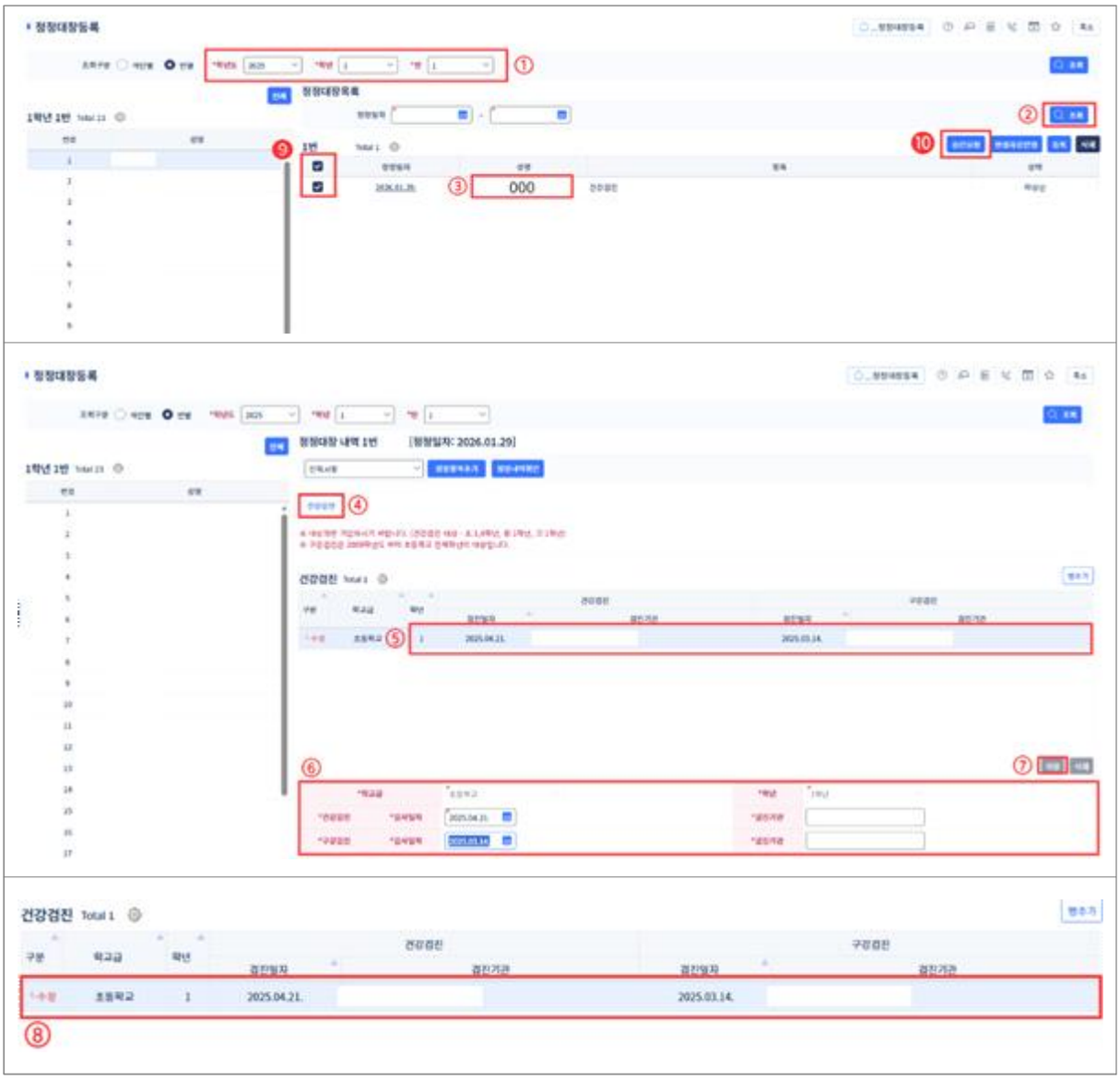
※ 다수 학생의 공통된 항목 수정을 할 경우 팝업창에서 '일괄등록' 탭 선택
※ 항목 추가 또는 삭제를 원할 경우 ②, ③ 후 정정일자 클릭하면 정정대장의 수정화면이 팝업되며 수정 가능함
– 항목을 추가, 삭제 가능하나 이미 정정내역이 있는 항목은 수정할 수 없음
– 이미 정정내역이 있는 항목 수정을 위해서는 해당 정정내역을 삭제하고 다시 진행해야 함





2) 건강기록부 정정대장 2단계 입력 - 항목별 수정값 입력

- 메뉴경로: [나이스] – [보건] – [건강기록부관리] – [정정대장등록]
- ① 학년 반 선택 및 ② 조회 > ③ 해당 학생 이름 클릭 > ④ 해당 항목 탭 선택 > ⑤ 수정할 학년 클릭 > ⑥ 수정내용 입력 > ⑦ 저장 > ⑧ 수정내용 확인 > ⑨ 해당 학생 선택 ☑ > 승인요청(반드시 4단 결제)

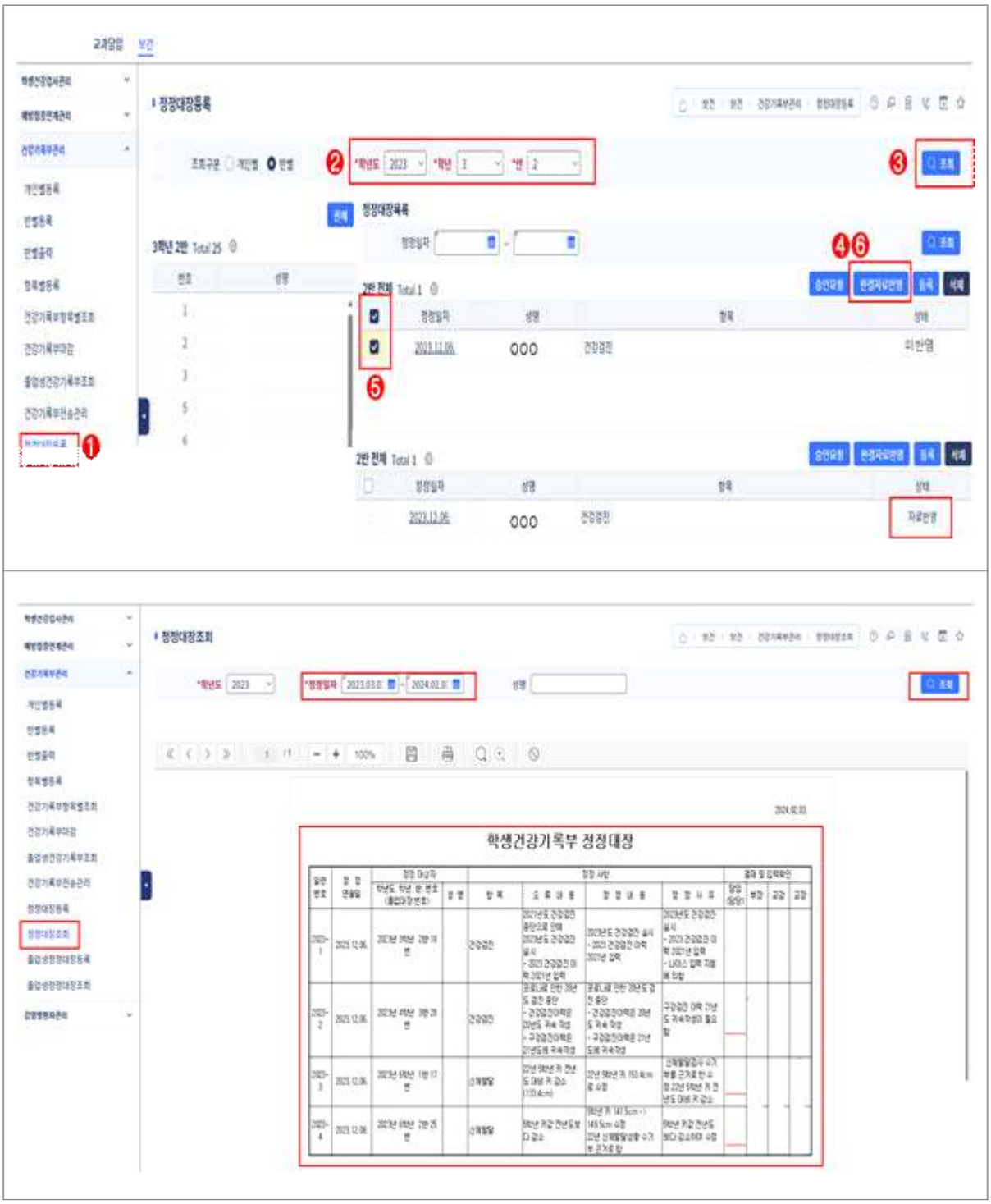


3) 건강기록부 정정대장 완결자료반영

- 메뉴경로: [나이스] – [보건] – [건강기록부관리] – [정정대장등록]
- [정정대장등록] > ② 학년, 반 설정 > ③ 조회 > ④【완결자료반영】버튼 클릭: 반영여부 확인 > ⑤ 미반영된 정정대장 선택 ☑ > ⑥【완결자료반영】버튼 클릭 > 상태란이 미반영에서 자료반영으로 수정됨

※ 수정된 건강기록부을 출력하여 다른 정정대장 증빙자료와 함께 편철하여 비전자문서처리 해야 함.

※ 정정대장 조회: 건강기록부 정정대장 목록을 확인하고자 할 경우
[나이스] – [보건] – [건강기록부관리] – [정정대장등록] 활용, 저장 및 출력 가능


정정대장등록
정정대장목록
3학년 2반 Total 25
2반 전체 Total 1
2반 전체 Total 1
1
2
3
4
5
6
000
000
정정대장조회
학생건강기록부 정정대장

건강기록부 점검결과 보고 및 가정통신문 발송(예시)

OOOO학교

수신 내부결재
(경유)
제목 20 학년도 건강기록부 점검결과 보고

---

1. 관련: 학교- (20 . .)
2. 건강기록부 점검을 실시하고 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

붙임 1. 건강기록부 점검항목(학급별) 1부.
2. 건강기록부 점검결과 1부. 끝.

OOOO학교장

건강기록부 점검결과(예시)

연번	학년	반	번	이름	오류내용			오류확인 내용	정정대장 대상여부	처리 방향
					오류항목	오류 인적사항	내용			
1	*3*	*3*	*4*	*OOO*	*신체발달 (몸무게)*	*1-4, 4 2-4, 7*	*몸무게감소 1학년 27.8kg 2학년 20.2kg*	*수기부 및 건강검사 결과통보서 확인 1학년 27.8kg 2학년 30kg*	*O*	*건기부 정정*

전입생 건강기록부 정정을 위한 기안문 및 서식(예시)

OOOO학교

수신 내부결재
(경유)
제목 학생건강기록부 누락 내용 정정자료 요청

---

1. 관련: 학생건강기록부 전산처리 및 관리지침 제4조
2. 귀교의 전출생의 건강기록부를 검토한 바, 귀교 재학 당시 기재 사항 중 정정대상항목이 발견된 바, 이에 대한 증빙서류 확인을 다음과 같이 요청드리오니 협조부탁드립니다.
   가. 송부방법: 업무관리시스템으로 공문발송(증빙자료 원본대조필 후 스캔)
   나. 근거 자료가 있을 경우 붙임의 <서식1> 작성 후 증빙 자료와 함께 송부, 근거 자료가 없을 경우 붙임의 <서식2> 작성 후 송부하여 주시기 바랍니다.

순	정정대상자		해당학년도 학적사항		정정사항	
	현재 학년반	학생명	학년도	학년반	항목	오류내용
1	*4-1*	*OOO*	*20 년*	*3-1*	*별도검사 (시력검사)*	*20 학년도 별도검사 항목 중 시력검사 실시일 누락됨*

붙임 학교건강기록부 정정 및 보완 내용 확인서 양식(서식1, 서식2) 1부. 끝.

OOOO학교장

서식 1 오류 항목에 대한 자료를 보낼 수 있는 경우

수신: 학교장
발신: 학교장

건강기록부 정정 및 보완 내용 확인서

귀교에서 요청한 _____학생의 건강기록부 오류 및 누락 내용에 대한 정정·보완 근거 자료와 증빙자료를 아래와 같이 송부합니다.

연번	정정 대상자		해당학년도 학적사항		정정사항				확인사항 및 증빙자료
	성명	현재 학년반	학년도	학년반	항목	오류내용 (정정전)	정정내용 (정정 후)	정정사유	
1	*OOO*	*4-1*	*20*	*3-1*	*시력 검사*	*시력검사 실시일 누락*	*실시일 기재요망*	*시력검사 실시일 누락에 따른 정정*	*증빙자료명 기재*

붙임 정정 증빙자료 사본(원본대조필:교감) 1부. 끝.

작성자 : 학교 직위 교사 성명 (인)

확인자 : 학교 직위 교감 성명 (인)

20 . . .

학교장(직인)

※ 참고(증빙서류): 증빙자료 사본에 반드시 원본대조필 필요

서식 2 오류 항목에 대한 자료를 보낼 수 없는 경우

수신: 학교장

발신: 학교장

건강기록부 정정 및 보완 내용 확인서

귀교에서 요청한 _____학생의 건강기록부 오류 및 누락 내용에 대한 정정·보완 근거 자료와 증빙자료를 아래와 같은 사유로 송부할 수 없음을 확인합니다.

연번	정정 대상자		해당학년도 학적사항		정정사항				확인사항 및 증빙자료 미첨부 사유
	성명	현재 학년반	학년도	학년반	항목	오류내용 (정정전)	정정내용 (정정 후)	정정사유	
1	*OOO*	*4-1*	*20*	*3-1*	*시력 검사*	*시력검사 실시일 누락*	*확인 불가*	*정정 불가*	*미첨부사유기재*

작성자 : 학교 직위 교사 성명 (인)

확인자 : 학교 직위 교감 성명 (인)

20 . . .

학교장(직인)

※ 참고(증빙서류): 증빙자료 사본에 반드시 원본대조필 필요

건강기록부 정정 및 반영결과 알림(예시)

OOOO학교

수신 내부결재
(경유)
제목 20 학년도 건강기록부 정정 및 반영결과 알림

---

1. 관련: 학생건강기록부 전산처리 및 관리지침 제17조(자료의 정비)
2. OO학년도 건강기록부 점검결과 건강기록부의 오류 및 누락이 확인된 바, 건강기록부를 다음과 같이 정정하였음을 보고합니다.

가. 건강기록부 수정 대상자

1) 건강기록부 정정대장 대상자: 명

2) 건강기록부 예방접종 항목 누락자: 명

나. 결과처리 결과

1) 건강기록부 정정대장: 대상자 명 중 명 수정입력 및 정정대장 반영완료

– 명 중 명 증빙서류 미비로 인한 정정불가

2) 건강기록부 예방접종 입력: 누락자 명 중 명 건강기록부 예방접종 입력 및 반영완료

– 명 중 명 증빙서류 미비로 예방접종 입력 불가

붙임 1. 20 학년도 건강기록부 점검결과 및 처리현황 1부.
2. 학생건강기록부 정정대장(나이스 출력물) 1부.
3. 건강기록부 정정 증빙서류(별첨) 1부. 끝.

OOOO학교장

단위업무	주요내용	참고·서식자료
계획	1. 표본학교 건강검사 계획(학생 건강검사 표본학교 매뉴얼) ■ 표본학급 선정 • 신체발달상황: 전학년(초1·2·3·4·5·6, 중1·2·3, 고1·2·3) 1반(첫째 반) 선정 • 건강조사: 전학년(초1·2·3·4·5·6, 중1·2·3, 고1·2·3) 1반(첫째 반) 선정 • 건강검진(구강+의과): 초1·4, 중1, 고1 학년 1반(첫째 반)선정 • 건강검진(초등구강): 초2·3·5·6 학년 1반(첫째 반)선정 ※ 남녀분반인 경우 남·여 각각 첫 번째 반 선정 ■ 표본학교 건강검사 계획 • 표본학교 건강검사 실시 계획 수립 – 검진기관선정: 지역교육청 출장검진승인요청 – 건강검사 실시 시기 및 검사결과 제출 기한 준수 철저 – 기간: 3~9월 – 결과처리: 나이스[NEIS]를 통해 제출, 9월 30일까지	•학생 건강검진 표본학교 명단(p.118)
운영	1. 표본학생 등록 ■ 나이스[NEIS] 입력 방법 –「보건 – 표본학생관리 – 표본학생등록(건강검사)」 → 남자·여자 인원수를 작성 → 표본반여부 체크 ■ 주의사항 – 표본학생등록(신체발달) 메뉴 아님 – 표본학생등록을 서두를 필요 없음 (전학·전출 학생이 생길 시 수정 번거로움) – 미검자 발생이 예상 되는 학생은 학교 자체 판단하여 표본학생수에서 제외 가능 (예: 원적교가 본교로 되어 있으면서 각종학교에서 건강검진을 받는 경우, 재택교육(특수학생)으로 학부모님 건강검진 실시거부 학생, 장기 무단결석으로 연락이 닿지 않나 건강검진 진행이 어려운 경우 등)	•표본학생 등록 방법 (NEIS) (p.119)
	2. 건강검사 결과 입력 방법 ■ 엑셀파일을 만들어 한 번에 업로드 하는 방법 • 일괄등록 및 파일내리기 – NEIS 메뉴명: 보건–학생건강검사관리–일괄등록 및 파일 내리기 – 건강검사 항목을 선택 후 '내리기' 선택하여 엑셀파일(양식)을 다운로드하여 작성 후 '올리기' 선택하여 시스템에 등록 ※ 건강검진기관에 엑셀파일(양식) 제공 후 작성토록 요청 ■ 학생 개개인별로 나이스 입력 • 반별건강검사등록 – NEIS 메뉴명: 보건–학생건강검사관리–반별건강검사등록 • 항목별건강검사등록 – NEIS 메뉴명: 보건–학생건강검사관리–항목별건강검사등록 ※ 엑셀파일을 업로드한 경우에도 반별건강검사등록, 항목별건강검사등록 화면에 각각 자료가 연계되어 확인·수정이 가능	•건강검사 결과 입력 방법 (p.120)

<table>
<tr><th>단위업무</th><th>주요내용</th><th>참고·서식자료</th></tr>
<tr><td rowspan="3">운영</td><td>3. 학생건강검사 실시
▪ 신체발달상황
– 학교에서 교직원이 실시(초1·4, 중·고1 학년은 검진기관에서 가능)
▪ 건강조사: 학교에서 교직원 실시
– 2020년도부터 건강검진의 문진표와 건강조사를 분리함에 따라 검진 해당 학년(초1·4, 중·고1) 건강조사도 학교의장이 실시
▪ 건강검진(구강+의과): 검진기관에서 실시
▪ 건강검진(초등구강): 검진기관에서 실시</td><td></td></tr>
<tr><td>4. 건강검사 결과 입력
▪ 나이스[NEIS] 입력 방법
• 일괄입력시 주요 오류사례
– 생년월일, 키, 몸무게, 혈압, 비만학생 혈액 검사 입력시 오류
– 건강조사 입력시 주요 오류 항목: 다이어트문항
‣입력방법: 다이이트경험1 에 답변 시 1만 입력
다이어트경험2 에 답변 시 2만 입력
다이어트경험3 에 답변 시 3만 입력
다이어트경험4 에 답변 시 4만 입력
‣오류예시: 다이어트경험2 에 ‘1’ 입력시 오류 발생
– 건강조사 입력시 주요 오류 항목: 다이어트문항
– 건강검진시 입력시 주요 오류: 각 항목에 기재 내용의 용어가 다르면 오류, 건강검사기록지 참고하여 용어 통일
‣오류예시: 안질환 입력시: 결막염(O), 좌결막염(X)</td><td>•일괄입력 시 주요 오류 사례(p.123)</td></tr>
<tr><td>5. 통계생성 및 교육청 제출
▪ 통계생성 및 교육청 제출방법 : 「보건 – 학생건강검사관리 – 통계관리 – 학생건강검사통계생성」 /통계구분 ‘◉표본’으로 선택
①【성별/키/몸무게 오류확인】버튼을 실행→정상입력 여부를 확인
② 데이터 확인→③【통계생성】버튼→④ 담당자명 및 연락처 입력→⑤ 승인요청(학교장 결재)→⑥【교육청】버튼 선택
▪ 마감취소요청
– 학교에서 교육지원청으로 자료 전송한 후, 교육지원청에서 마감을 하면 학교에서는 수정이 불가, 교육청 전송 후 자료 수정이 필요한 경우, 교육지역청 담당자에게 연락 → 마감취소 요청
<table>
<tr><th>보고내용</th><th>학교→교육지원청</th><th>교육지원청→교육청</th><th>보고방법</th></tr>
<tr><td>표본학교 건강검사 결과보고</td><td>9월 30일까지</td><td>10월 14일까지</td><td>나이스 전송</td></tr>
</table></td><td>•통계생성 및 교육청 제출 방법(p.124)</td></tr>
<tr><td>평가</td><td>사후관리는 학생 건강검진과 동일함
1. 사후 관리
– 결과확인, 정밀검사안내, 회신서 확인(종합감사 대비하여 사후 관리 철저)
2. 학생건강기록부에 검진 내용 입력
– 충청남도교육청누리집 > 부서별누리집 > 체육건강과(학교보건자료실) > 4세대 지능형 나이스(NEIS) 사용자 설명서(보건)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>3. 사후관리 대장 활용 및 건강 상담 실시</td><td></td></tr>
</table>

학생건강검진 표본학교 명단(2024~2026)

순	초 (15교)	중(22교)	고(27교)
1	천안-직산초등학교	천안-천남중학교	천안-북일고등학교
2	천안-천안가온초등학교	천안-천성중학교	천안-천안공업고등학교
3	천안-천안미라초등학교	천안-천안북중학교	천안-천안불당고등학교
4	천안-천안신대초등학교	천안-천안불당중학교	천안-천안상업고등학교
5	천안-천안호수초등학교	천안-천안월봉중학교	천안-천안여자상업고등학교
6	보령-주포초등학교	천안-환서중학교	천안-천안오성고등학교
7	아산-모산초등학교	공주-공주대학교사범대학부설중학교	천안-천안중앙고등학교
8	아산-한들물빛초등학교	공주-공주여자중학교	공주-공주금성여자고등학교
9	서산-서산예천초등학교	보령-대천여자중학교	공주-공주대학교사범대학부설고등학교
10	논산-논산중앙초등학교	아산-설화중학교	공주-한일고등학교
11	논산-은진초등학교	아산-온양신정중학교	보령-충남해양과학고등학교
12	당진-당진초등학교	아산-온양중학교	아산-설화고등학교
13	당진-조금초등학교	아산-탕정중학교	아산-온양고등학교
14	금산-신대초등학교	서산-서산중학교	아산-온양용화고등학교
15	홍성-내포초등학교	논산-연무여자중학교	서산-부석고등학교
16		계룡-엄사중학교	서산-서일고등학교
17		당진-당진중학교	논산-건양대학교병설건양고등학교
18		당진-송산중학교	논산-논산대건고등학교
19		청양-청양중학교	논산-논산여자고등학교
20		홍성-내포중학교	당진-당진고등학교
21		예산-대흥중학교	당진-송악고등학교
22		태안-태안여자중학교	당진-합덕고등학교
23			청양-청양고등학교
24			홍성-충남드론항공고등학교
25			홍성-홍주고등학교
26			예산-예산예화여자고등학교
27			서천-서천고등학교

나 표본학생 등록 및 건강기록부 관리

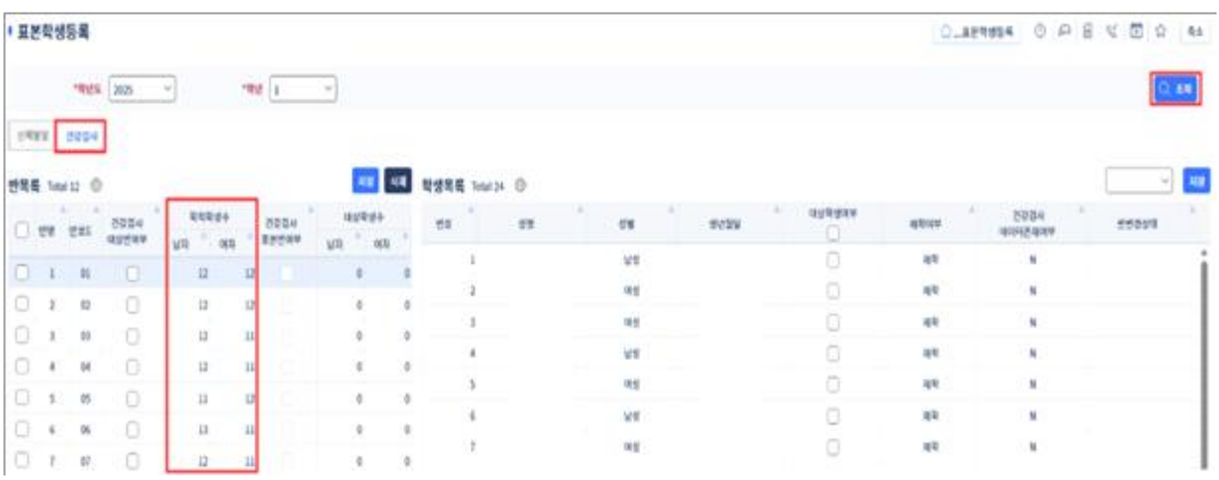
표본 학생 등록방법 - 나이스(NEIS) 입력방법

- 표본학급을 등록한다.



- 「보건 – 학생건강검사관리 – 표본학생등록(건강검사)」 순으로 선택한 후, 아래 화면에서 표본학급의 ① 남자·여자 인원수를 작성하고, ② 표본반여부를 체크

※ 주의사항: '표본학생등록(신체발달)' 메뉴 아님



건강검사 결과 입력 방법「보건 – 표본학생관리 – 학생건강검사관리」

학생건강검사 결과를 입력하는 방법은 크게 2가지입니다.

(첫번째) 엑셀파일을 만들어서 한 번에 업로드 하는 방법

→NEIS 메뉴명: 보건 - 학생건강검사관리 – 일괄등록 및 파일내리기

(두번째) 학생 개개인별로 나이스 화면상에 입력하는 방법

→NEIS 메뉴명: 보건 - 학생건강검사관리 - 반별건강검사등록

→NEIS 메뉴명: 보건 - 학생건강검사관리 - 항목별건강검사등록

※ 두 메뉴(반별·항목별)는 기능은 동일하고, 화면 구성만 다릅니다.

※ 첫번째 방법을 선택하여 엑셀파일을 업로드한 경우에도 반별건강검사등록·항목별건강검사등록 화면에 각각 자료가 연계되며 확인·수정이 가능합니다.

• (선택1) 엑셀파일을 이용하여 반 전체 자료를 한 번에 업로드 하고 싶으면, '일괄등록 및 파일내리기' 선택

① 건강검사항목 선택 → ② '내리기' 선택하여 엑셀파일(양식)을 다운로드 → ③ 엑셀파일을 작성 → ④ '올리기'를 선택하여 시스템에 등록

※ ① 주의사항: '종합' 서식에 '건강조사'는 미포함으로 별도 서식 작성 필요

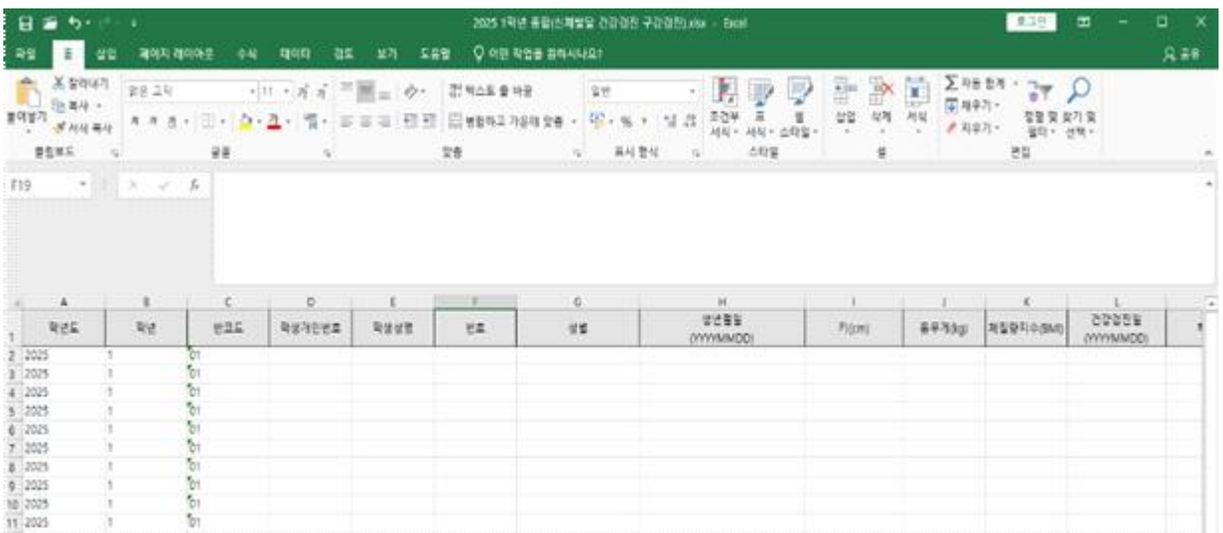
※ ③ 주의사항: 엑셀파일 작성 시 반드시 코드목록을 참고하여 작성

※ ④ 주의사항: 엑셀파일을 업로드(파일올리기)할 경우, 선택한 건강검사항목과 일치하지 않을 경우 오류 발생

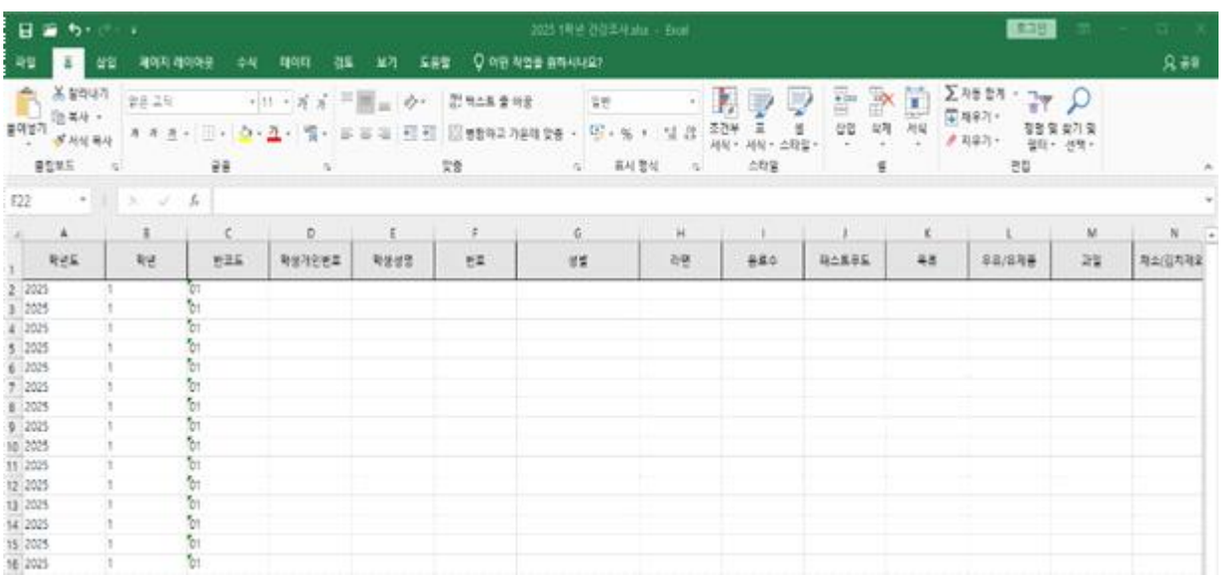
ex) '종합' 선택 → '종합' 파일 올리기 (O) / '종합' 선택 → '신체발달' 파일 올리기(X)



□ 종합 (신체발달, 건강검진, 구강검진)



□ 건강조사



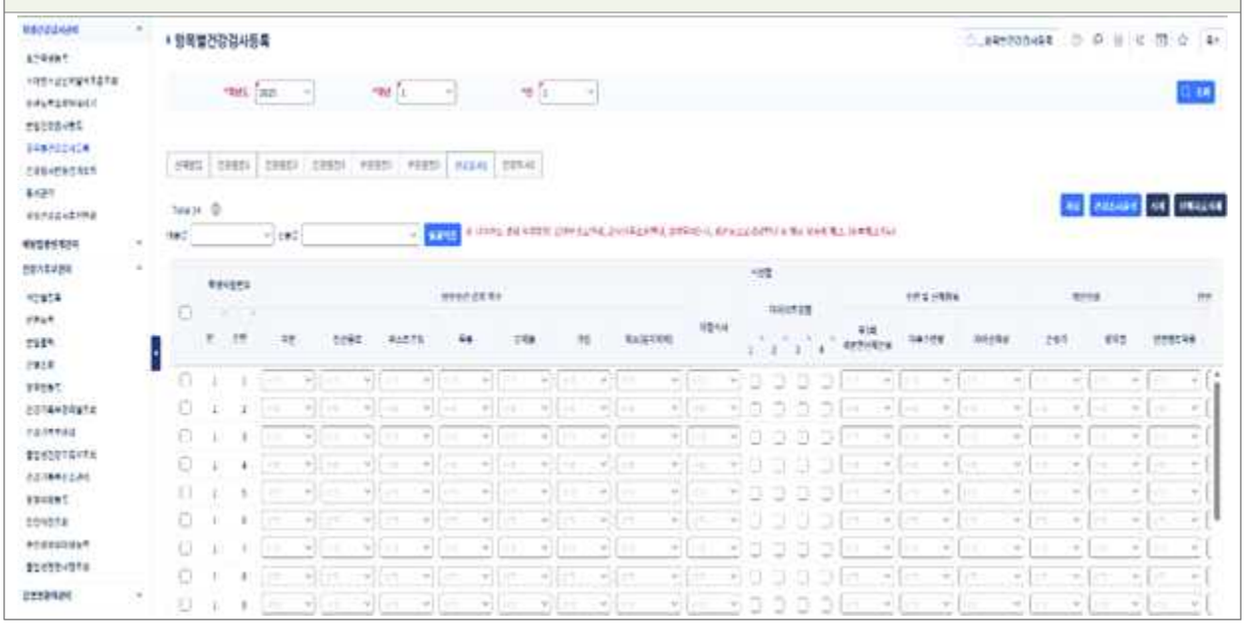
※ 검진기관이 요구할 경우 서식 전달, 신체발달·건강조사 서식 학교 담당자 사용

- (선택2) 학생 개개인별로 나이스 화면에서 직접 입력하고 싶으면, '반별건강검사등록' 또는 '항목별건강검사등록' 선택 – 내용작성 – 저장(두 메뉴는 화면 구성만 다르고 개인별 입력하는 점은 동일함)

반별건강검사등록을 선택했을 경우 화면 예시



항목별건강검사등록을 선택했을 경우 화면 예시



일괄입력 시 주요 오류 사례

1) 생년월일, 키, 몸무게, 혈압, 비만학생 혈액 검사 입력시 오류

결과값 오류 사례
1. 결측값 ○ 대상자 전체: 학교 전체, 학년 전체 누락 ○ 특정 검사: 검진결과, 비만학생 혈액검사 누락, 특정 개별 항목 누락 2. 이상값 ○ 생년월일: 검사일자로 잘못 입력, 모든 학생 동일한 일자 입력, 8자리숫자(YYYYMMDD) 외의 다른 형태로 입력 ○ 키, 몸무게: 키, 몸무게를 동일한 값으로 입력하거나 바꿔서 입력, 비현실적인 값 입력 (예시: 키 217.2cm / 몸무게 25.9kg) ○ 시력: 한 쪽 시력만 기재, 나안 시력이 교정시력 보다 더 좋은 경우

2) 건강조사 입력시 주요 오류: 다이어트 문항

N	O	P	Q
다이어트경험1	다이어트경험2	다이어트경험3	다이어트경험4
1			
	2		
		3	4
			4

※ 다이이트경험1 에 답변 시 1만 입력
다이어트경험2 에 답변 시 2만 입력
다이어트경험3 에 답변 시 3만 입력
다이어트경험4 에 답변 시 4만 입력
– 다이어트경험2 에 '1' 입력시 오류 발생

3) 건강검진 입력시 주요 오류

O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
정_좌	시력_교정_우	안질환	청력_좌	청력_우	귓병	콧병	목병	피부병	요단백	요잠혈	혈당(식전)(mg/dl)	총콜레스테롤(mg/dl)

※ 각 항목에 기재 내용의 용어가 다르면 오류, 건강검사기록지 참고하여 용어 통일
안질환 입력시: 결막염(O), 좌결막염(X)

통계 생성 교육청 제출 방법

건강검사 통계 생성 → 교육청 제출

항목	신체의 발달상황(비만도)	학생 건강검사 표본학교
대상	– 초·중·고·특수 모든 학교 (표본학교 포함)	– 표본학교 (초 15교, 중 22교, 고 27교)
제출 방법 (나이스 제출)	– [학생건강검사관리–통계관리–신체발달통계생성]탭 → 통계구분 '전체'로 선택 – 통계생성 → 오류데이터 확인 → 통계조회 → 승인요청(학교장 결재) → 교육청 전송 버튼 선택	– [학생건강검사관리–통계관리–학생건강검사통계생성]탭 → 통계구분 '표본'으로 선택 ※주의: [통계관리–신체발달통계생성]탭 아님 – 성별/키/몸무게 오류 확인 → 데이터 확인 → 통계생성 → 승인요청(학교장 결재) → 담당자명 및 연락처 입력 → 교육청 전송 버튼 선택
제출일	– 2026. 8. 28.(금)	– 2026. 9. 30.(수)

– 「보건 – 학생건강검사관리 – 통계관리 – 학생건강검사통계생성」 순으로 선택한 후 통계구분을 '◉표본'으로 선택

① 성별/키/몸무게 오류확인 버튼을 실행하여 통계 필수 입력값인 성별/키/몸무게 정상입력 여부를 확인

② 데이터 확인

③ 통계생성 버튼을 실행

④ 담당자명 및 연락처를 입력

⑤ 승인요청 (학교장 결재)

⑥ 교육청전송 버튼 차례로 선택. (끝)

※ (성별/키/몸무게 오류확인) 입력값이 없는 학생 명단을 보여주는 기능
(데이터확인) 생성할 통계자료를 미리 보여주는 기능



'한 눈에 쏙'
건강하고 행복한 학교 만들기를 위한
2026 건강관리업무

Ⅳ

감염병 예방관리

<table>
<tr><th>단위업무</th><th>주요내용</th><th>참고·서식자료</th></tr>
<tr><td>계획</td><td>1.「학교 감염병 예방관리 계획」 수립
■ 평상 시 및 감염병 발생 시 대응 준비
• 내용: 감염병 환자 발생에 대비하여 대응체계 구축 (관리조직 구성, 계획 수립 – 매년 3월 말까지)
• 수립 내용: 학교 감염병 관리조직 구성, 예방접종 관리, 감염병예방교육, 학교 내 감염병 발생 시 보고 및 대응, 수동감시체계 운영, 일시적 관찰실 지정, 방역활동 ➔ 교직원 연수 실시(사전 내부결재 및 공람)</td><td>•학생 감염병 예방·위기 대응 매뉴얼 3차 개정판 (교육부, 2023.12)
•2026 건강관리 추진 계획 –교내 감염병 예방 관리 강화 (충남도교육청)</td></tr>
<tr><td>운영</td><td>1. 감염병 예방 관리
■ 감염병 예방교육
• 감염병 및 약물의 오·남용 예방 등 보건위생관리 교육 의무화 (연간 10시간)
• 관련 교과 및 창의적 체험활동 연계를 통한 감염병예방교육 연간 최소 4시간 이상 마련 및 교육효과 제고를 위한 교육방법 다양화
• 상시 감염병 예방교육: 월별 빈발 감염병 정보제공, 유행 시 해당 감염병 예방을 위한 집중교육, 심리적 피해 예방교육
– 올바른 손 씻기 요령, 기침예절 등 개인위생관리 교육
– 가정통신문, 방송교육, 게시판, 실습, SNS, 홈페이지 활용 등
• 교직원
– 교내 학생 감염병 위기대응 모의훈련 정례화
– 교육행정기관 공무원 및 직원 감염병 교육(의무/1시간 이상)
■ 예방접종관리
• 초등학교 및 중학교 입학생 예방접종 확인 사업
– 나이스–예방접종통합관리시스템 연계 및 확인
– 초6: 만11~12세에 실시하는 추가 접종여부 (Td/Tdap, 일본뇌염 5차, HPV1~2차) 확인 및 완료지도
• 인플루엔자 국가예방접종 적극 홍보
• 해외재취학·편입학시 예방접종 증명서 7종 확인 및 접종 지도
(나이스 입력: A형간염, B형간염, 폴리오, MMR, 수두, 일본뇌염, Tdap/Td)
• 보건당국 협조요청 시 예방접종 실시
■ 방역소독 및 방역물품 비축
• 학교 방역물품 비축 권장기준 모형에 근거하여 비축·보고
• 정기소독 연 5회 이상 계획, 실시 후 보고
<table><tr><td>1월–3월</td><td>4월–5월</td><td>6월–7월</td><td>8월–9월</td><td>10월–12월</td></tr><tr><td>1회 이상</td><td>1회 이상</td><td>1회 이상</td><td>1회 이상</td><td>1회 이상</td></tr></table>
2. 감염병 발생 대응 및 확산 방지
■ 학교 내 감염병 확진 및 의심환자 발생 시 등교중지 및 보고
– 등교 중 의심환자 발생: 일시적 관찰실 이동 및 격리, 하교조치
※ 일시적관찰실: 의료기관 진료 전까지 한시적으로 격리 및 관찰
– 감염병환자 나이스 보고 및 완치 후 수정보고
– 교육청 및 보건소에도 즉시 보고 해당 감염병: 결핵·홍역·콜레라·장티푸스·파라티푸스·세균성이질·장출혈성대장균감염증·A형간염
– 감염병 예방교육 및 확산 방지 교육</td><td>•「아동복지법」 제31조, 동법 시행령 제28조, [별표6]
•충청남도교육청개발자료 – 충청남도교육청홈페이지 ➔ 부서별 누리집 ➔ ① 2022년 감염병예방 교육자료(감염병예방 및 대응) ② (초중고) 감염병교육 자료 및 지도서
•학생 예방접종관리(p.133)
•나이스 예방접종관리(p.148)
•예방접종안내(가정통신문)(p.150)
•학교방역물품 비축모형(p.137)
•학교 감염병 대응 단계(p.138)
•법정 감염병 종류(p.143)
•나이스 감염병 발생 보고 방법(p.144)</td></tr>
</table>

단위업무	주요내용	참고·서식자료
운영	■ 등교중지 실시(담임교사) 및 행정처리(학사관리팀) • 출석인정: 출결상황관리 및 학교생활기록부 기재요령,「학생생활기록작성 및 관리지침」 제8조 별지 제8호의 제2호 나목(6)에 따름 • 대상: 감염병예방법 제2조에 규정된 감염병(의심) 환자, 의사의 진단에 의하여 전염성이 강한 질환에 전염되었다고 인정되는 자 – 감염병환자(확진): 등교중지 기간동안 출석인정 – 의심환자: 감염병확진결과 확인까지 등교중지 및 출석인정 – 국가위기상황(신종감염병 등): 자가격리 통보(증상 무관)를 받은 경우 포함 • 감염병(의심)환자 발생 – 등교중지 및 발생 보고(신고) – 격리 – 완치 후 등교 – 출석인정 및 완치보고 (진료확인서, 의사소견서, 진단서, 처방전(질병코드 확인) 중 1부 첨부) ※ 담임교사: 등교중지 및 출결처리, 대응 3단계 시에는 NEIS 감염병 환자 발생 등록 실시 ※ 보건교사: NEIS 감염병 보고, 감염병 예방교육으로 확산 방지	•학교 내 빈발 감염병의 종류와 특성(감염성 질환의 등교중지기간) (p.141) •등교중지 원칙과 절차 (p.142)
	3. 결핵예방 및 확산방지 ■ 학교 내 결핵 조기 발견 및 확산 방지를 위한 관리 강화 • 학생 및 교직원 대상 결핵 예방 교육(연1회 이상) • 학생 결핵검진사업 추진: 중3, 고 2,3학년 학생 결핵 검진사업 추진 (대한결핵협회/건강검사추진계획 참고) • 교직원 결핵검사 및 잠복결핵 감염검진(개별 및 단체검진 가능) – 결핵검사(흉부 X-ray): 매년(1.1.~12.31.) 1회 ‣ 다른 법령에 따라 건강진단을 받은 경우 받은 것으로 갈음 ‣ 신규채용(휴직·파견 등 포함)된 사람은 채용 1개월 이내 실시 ※ 채용 신체검사로 갈음 가능 단, 6개월 이내이며 검진일이 2026년 1월 1일 이후일 것 – 잠복결핵검사(혈액검사 인터페론감마): 재직기간 중 1회 실시 ‣ 신규채용(6개월 이상 휴직·파견 등 후 복직자 포함)된 사람은 채용을 한 날로부터 1개월 이내 실시 ■ 학교 내 결핵 발생 시 대처 • 신고 및 보고: 관할 보건소 및 교육청 전화, 보건소 공문 발송, 교육청 NEIS 보고 • 환자명부작성 및 유증상자 보건소 방문 검사 지도 • 상담 및 교육: 결핵환자 및 학생·교직원 교육, 가정통신문 발송 • 접촉자 관리: 접촉자 조사범위 참고 / 방역기관과 역학조사 공조 • 추구관리: 결핵환자 복약확인 등 수시상담 및 교육, 보건소장의 완치자 명단 통보 시 환자명부에 기록 후 종료	•학교 내 결핵환자예방관리 (p.158) •결핵검사 지역별 일정 (p.88)
평가	평가 및 차기년도 계획에 반영	

1 감염병 예방관리

가 감염병 관리의 기본방침

목적

학교 감염병 예방·관리 및 위기대응 역량을 강화하여 신종 및 기존 감염병의 위협으로부터 학생과 교직원을 보호하고 안전하고 건강한 학교 기능 유지

관련근거

가) 학교보건법 제10조(예방접종 완료 여부의 조사)

초등학교와 중학교의 장은 학생이 새로 입학한 날부터 90일 이내에 시장·군수 또는 구청장에게 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제27조에 따른 예방접종증명서를 발급받아 같은 법 제24조 및 제25조에 따른 예방접종을 모두 받았는지를 검사한 후 이를 교육정보시스템에 기록하여야 한다.

나) 학교보건법 제11조(치료 및 예방조치)

학교의 장은 제7조의 규정에 의한 건강검사의 결과 질병에 감염되었거나 감염될 우려가 있는 학생에 대하여 질병의 치료 및 예방에 필요한 조치를 하여야 한다.

다) 학교 보건법 제14조의 3(감염병예방대책의 마련 등)

라) 초·중등교육법 제24조(수업 등), 제64조(휴업 및 휴교명령)

마) 학교보건법 제8조(등교중지), 동법 시행령 제22조

바) 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제5조(의료인 등의 책무)

사) 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조(그 밖의 신고의무자)

아) 학교생활기록부 작성 및 관리지침(출석·결석 관련)

별지 제8호 출결상황 관리 – 2. 결석 – 나. 다음의 경우에는 출석으로 처리한다.
(1) 법정 감염병으로 출석하지 못한 경우
(2) 학교 내 확산 방지를 위해 학교장이 필요하다고 인정하는 비법정 감염병

자) 학생 감염병 예방·위기대응 매뉴얼 제3차 개정판(교육부, 2023.12)

차) 결핵예방법 제11조(결핵검진 등), 제11조의2(준수사항), 제34조(과태료)

카) 2026 학생건강증진 분야 주요업무 추진방향(교육부)

타) 2026 학생건강관리 추진 계획(교육청)

기본방침

- 코로나19 대응 경험을 토대로 「학교 감염병 예방 종합대책」을 수립하고, 개정된 법령과 학교 현장의 의견을 반영하여 마련한 「학교 감염병 예방·위기 대응 매뉴얼」에 따라 효율적인 감염병 예방관리 추진
- 감염병에 대한 선제적 예방과 교육기관 내 감염병 유입 시 안정적이고 체계적인 대응을 통해 학생과 교직원 건강 보호

- 학생·학부모 대상 지속적인 교육·홍보를 통한 감염병 예방수칙 준수 생활화

현황

2025년 인플루엔자 유행과 코로나바이러스감염증-19 발생 건수 증가

- 2025년 빈발 감염병 환자 발생 현황(출처: NEIS 감염병 발생통계, 비법정 제외)

(단위: 교, 명)

급성호흡기감염증		성홍열		수두		수족구병		코로나바이러스 감염증-19		인플루엔자	
학교수	학생수	학교수	학생수	학교수	학생수	학교수	학생수	학교수	학생수	학교수	학생수
56	85	60	102	159	479	179	647	388	1,983	606	2,5484

나 감염병 예방 관리 계획 및 운영

학생 감염병 예방·관리 연간계획 수립

업무담당자는 학기 초(매년 3월 말까지) 학교 감염병 관리조직을 구성, 예방 및 대응에 관한 추진계획을 수립하고, 전 교직원 연수를 실시한다. 교직원 연수에 포함할 내용은 법정 감염병 종류, 등교중지 학생 행정처리 방법, 감염병 관리조직 구성 및 역할 등을 연수하고 교직원 연수 자료는 사전 내부결재 후 전체 공람 처리한다.

계획 수립 내용: ① 학교 감염병 관리조직 구성, ② 예방접종관리, ③ 감염병 예방교육, ④ 학교 내 감염병 발생시 보고 및 대응, ⑤ 수동감시체계 운영, ⑥ 일시적 관찰실 지정, ⑦ 방역활동 등

1) 학교 내 감염병 발생 시 조기 대응체계 운영

- 학교에서 감염병 의심 혹은 확진환자가 1명이라도 발생 시 「학교 감염병 환자 발생 시 대응체계」에 따라 업무 수행

[감염병 유행의심 기준]

① 최대 잠복기 이내에 동일 학급에서 의심 또는 확진 환자 2명 이상 발생한 경우

② 최초 (의심)환자와 동일 학급은 아니지만 추가 (의심)환자가 이동식 수업이나 급식 등 공통된 공간에 노출되어 관련성이 의심되는 경우

- 사례1: 최초 (의심)환자와 같은 학급은 아니지만 추가 (의심)환자가 최초 (의심)환자가 발견된 당일 이동식 수업을 함께 들었음이 확인되면 유행의심 기준을 충족함
- 사례2: 서로 다른 학급 학생인 2명의 (의심)환자가 증상 발생 하루 전 학교 구내 매점에서 김밥을 먹은 것으로 확인되면 유행의심 기준을 충족함

* 유행의심 기준을 충족하는 겨우 대응 3단계로 격상

2) 학생 감염병 관리 조직 구성

- 기간: 매년 3월 말까지
- 운영시기: 대응 3단계 또는 국가위기 상황 주의단계 발령 시 운영(필요 시 조정가능)

※ 각 팀별 담당임무는 「학생 감염병예방·위기대응 매뉴얼」에 따르며 반드시 구성원별 역할 숙지 필요

[학교감염병관리조직 구성(예시)]



* 학생 생활 지도를 담당하는 부장급 교사(생활부장, 학생부장 등)

감염병 예방교육

1) 근거

- 학교보건법 제9조, 아동복지법 제31조, 아동복지시행령 제28조

2) 학생 감염병 예방교육

- 학생 감염병 예방을 위한 교육자료 활용 및 보건교육 강화
  - 초·중·고등학생용 감염병 교육자료(3차시, 워크북·지도서) 활용
    ※ 학생 빈발 감염병 5종(인플루엔자, 수두, 유행성이하선염, 수족구, 유행성 눈병)
    ※ 충청남도교육청 - 부서별누리집 - 학교보건자료실 -「충남교육청 개발 2022년 감염병예방교육자료(감염병예방 및 대응) 안내」
  - 관련 교과 및 창의적 체험활동 연계를 통한 감염병 예방교육 연간 4시간 이상 마련 및 교육 효과 제고를 위한 교육방법 다양화
    ※ 학교보건법, 아동복지법에 따라 유치원 및 초·중등학생 대상 교육 실시 의무
    ※ 감염병 및 약물의 오용·남용 예방 등 보건위생관리 교육 실시 의무화(연간10시간)
- 상시 감염병 예방교육 실시
  - 월별 빈발감염병 정보제공, 유행 시 해당 감염병예방을 위한 집중교육, 심리적 피해 예방교육

– 가정통신문, 방송교육, 게시판, 동영상 시청, 실습, SNS, 홈페이지 활용 등 학교 여건에 맞게 다양한 방법 활용

3) 교직원 감염병 예방교육

- 학교 감염병 위기대응 모의훈련

– 참여자: 학교 관리자 및 부장교사, 보건(담당)교사, 담임교사, 행정실장 등 교직원 참여

– 훈련시기: 학교 학사 일정을 고려하여 일정 조정, 가능하면 상반기 내에 훈련 진행

– 훈련방법: 훈련용 Workbook제공, 대응단계에 따라 구성원들이 서로의 역할 논의하여 대응방법을 찾는 도상훈련

- 전(全) 공무원 및 직원 감염병 교육(법정의무)

– 근거: 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제18조의5(감염병 교육의 실시)

– 대상: 학교, 교육(지원)청, 직속기관, 도서관 소속 공무원* 및 직원**

* 공무원: 6개월 이상 휴직중인 자 및 병역 의무 이행중인 자, 해외근무자는 제외

** 직원: 직군(직급)에 무관하게 1년 미만의 단기 계약직을 제외한 근로자

– '학교'의 경우 교육 대상 ▹「유아교육법」 제2조제2호의 유치원, 「초·중등교육법」 제2조 및 「고등교육법」 제2조의 학교 중 국립 또는 공립의 학교에서 근무하는 교원 및 교육공무직원이 대상이며, 직종 구분 없이 무기계약 근로자, 기간제 근로자, 단시간 근로자 모두 포함이며, 그 중 자원봉사자, 초단시간 근로자는 제외[출처: 감염병 교육 안내서(2025, 질병관리청-Q&A)]

– 이수 시간: 매년 1시간 이상

– 교육 방법: 집합교육, 온라인 교육, 기관 특성에 맞는 기타 방법 중 선택

▹온라인 교육 운영 기관 및 과정명

- 충청남도교육연수원: 2026. 3. 3. ~ 2027. 2. 12.
- 중앙교육연수원: 2026. 1. 25. ~ 2026. 12. 24.
- 교육 과정명(기관 공통): 감염병 교육 기본 과정

– 교육 내용: 감염병 위기 대응체계 및 관련 법령 현황, 감염병 유행 및 위기 대응 관련 주요 사례, 감염병 발생 및 전파 등에 대한 기본사항 등

– 교육결과 보고: 학교, 도서관 → 교육지원청
교육지원청, 직속기관 → 도교육청(체육건강과)

학생 예방접종 관리

1) 예방접종 확인 및 실시 절차(취학아동 예방접종 확인: 초·중 입학생 대상)

- 질병관리청과 협업을 통해 나이스(NEIS)와 예방접종정보시스템을 연계하여 초등학교 및 중학교 입학생에 대한 예방접종 이력을 자동으로 확인 및 등록: 추후 추가 공문을 통해 안내됨



구분	행정사항
초등학교 신입생 [11종]	① BCG ② B형간염 3차 ③ DTaP 5차 ④ 폴리오 4차 ⑤ b형 헤모필루스인플루엔자 4차 ⑥ 폐렴구균 4차 ⑦ MMR 2차 ⑧ 수두 1차 ⑨ A형간염 2차 ⑩ 일본뇌염 불활성화 백신 4차(또는 생백신 2차) ⑪ 인플루엔자(입학 전년도)
중학교 신입생 [3종]	① Tdap(또는 Td) 6차 ② HPV 1차(여학생만 대상) ③ 일본뇌염(불활성화 백신 5차 또는 생백신 2차)

[나이스-질병관리청연계 취학 전 예방접종 확인·등록 절차]

<table>
<tr><th>구분</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>초등</td><td>
<취학아동>
1. 취학 전 예방접종 일괄 입력 및 예방접종내역 확인 <Ⅳ-1-바. 나이스 예방접종 관리>
1) 학생명단 질병관리청 연계작업: 학생 정보 오류 확인 및 연계요청 자료 생성 후 질병관리청으로 전송
• ① [NEIS] 보건-예방접종연계관리-연계대상학생관리 > ② 연계요청학생생성: 학생목록 선택 >
③ 승인요청 > ④ 결제완료 후 연계요청
• 오류 학생 확인→주민등록번호 오류는 학적의 주민등록번호 수정→연계요청자료 재생성 후 연계요청
※ 오류 학생 명단 [오류목록엑셀다운로드]를 통해 학생목록 다운로드 가능
2) 예방접종내역 확인: 연계요청한 자료 수신확인 및 건강기록부 반영
• ① [NEIS] 보건-예방접종연계관리-예방접종수신내역관리 > ② 대상 학급 조회 및 특이사항 저장 > ③ 학생 선택 > ④ 건강기록부 반영 및 반영 확인(건강기록부 미리보기 가능)
2. 접종 미완료자에 대한 예방접종 실시 안내: '취학 전 예방접종 미등록 확인 안내' 가정통신문 발송
- 초등학교 신입생 대상으로 국가예방접종 11종 중 7종을 완료하지 못한 학생의 예방접종실시 독려
<table>
<tr><th>구분</th><th>행정사항</th></tr>
<tr><td>필수접종 대상[4종]</td><td>①DTaP 5차 ②폴리오 4차 ③MMR 2차 ④일본뇌염 사백신 4차(또는 생백신 2차)</td></tr>
<tr><td>권고대상[3종]</td><td>① A형간염 2차 ② B형간염 3차 ③ 수두 1차</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th colspan="2"></th><th>질병관리청-나이스 연계기간 종료 전</th><th>질병관리청-나이스 연계기간 종료 후</th></tr>
<tr><td rowspan="2">접종자</td><td>전산등록이 가능한 경우(보호자)</td><td>• 전산등록요청방법: 보호자가 신청
- 접종시행한 의료기관에 전산등록 요청
- 폐업한 경우 보건소에 전산등록 요청
- 보건소 방문시 접종증명서류(아기수첩 등) 지참 필요
• 전산등록 완료 후 NEIS에서 연계요청을 통해 재요청 및 수신확인</td><td>• 전산등록 후 예방접종증명서 학교로 제출
→증빙서류에 근거한 수동입력</td></tr>
<tr><td>전산등록이 불가능한 경우</td><td colspan="2">• 아기수첩 등 접종이력을 확인할 수 있는 증빙서류 학교로 제출
• 증빙서류에 근거한 수동입력 실시
- 증빙서류 비전자문서 처리 관리
- 스캔본은 원본으로 인정하지 않으므로 증빙서류는 폐기 불가
※ 증빙서류로 건강기록부에 수기입력 된 경우 질병관리청으로 연계되지 않음
➜ 예방접종도우미 사이트 및 정부 24에서 확인 불가능
➜ 전산등록을 원하는 경우 반드시 보호자가 의료기관 또는 보건소에 전산등록을 요구하여야 함
※ 질병관리청 시스템 미등록 자료를 건강기록부에 수기 입력한 경우 일괄반영과정에서 삭제될 수 있으니 연계 완료 후 입력하도록 함</td></tr>
<tr><td colspan="2">미접종자</td><td>• 예방접종 완료 후 전산등록 하도록 안내
• 전산등록 요청 후 NEIS에서 연계요청을 통해 재요청 및 수신확인</td><td>• 예방접종 완료 후 예방접종증명서 또는 아기수첩 등 증빙서류 학교로 제출
• 증빙서류에 근거한 수동입력</td></tr>
</table>
• 자녀 예방접종 전산등록 여부 확인방법: 보호자가 확인 가능
- 예방접종도우미 사이트(회원가입 및 자녀 정보등록 후 확인 가능), 모바일 예방접종 도우미 앱, 인터넷 정부24, 예방접종을 받은 의료기관 또는 보건소
<취학 후 아동>
• 예방접종명과 대상: 만11세~12세 아동 - ① 일본뇌염(만12세), ② Td 또는 Tdap(만 11세~12세), ③ HIV1~2차 예방접종(만12세 여학생)
• 나이스 입력하지 않고 적기에 접종을 실시하도록 독려함.(초등학교에서 입력한 정보와 질병관리본부로부터 제공받은 중학교 입학생의 예방접종 실시일이 다를 경우 같은 접종에 대하여 접종기록이 2건으로 중복 표기 될 수 있음)
• 중도입학생의 예방접종 등록은 보건소 방문하여 등록함(이때, 아기수첩이나 예방접종증명서 등을 지참)
</td></tr>
<tr><td>중등</td><td>
• 중학교 입학생: 초등학교 재학 중 실시한 예방접종(만 11세~12세 접종하는 일본뇌염, Td/Tdap 6차, HIV 1~2차)을 질병관리청으로부터 자료를 제공받아 NEIS에 자동 반영
➜ 질병관리청 연계작업은 초등과 동일하게 진행
</td></tr>
</table>

[학생 예방접종 관리 방안 및 대상별 예방접종 확인사항]

① 「학교보건법」 제10조 및 '취학아동예방접종확인사업' 에 따라 초·중학교의 장은 학생이 새로 입학한 날부터 90일 이내에 기 연계된 나이스-예방접종통합관리시스템을 통해 예방접종 완료 여부 확인

② 시스템 연계를 통한 예방접종력 확인 기간 종료 후에도 예방접종 미실시 학생에 대하여 예방접종을 실시하도록 학부모에게 지속 안내 <Ⅳ-1-바. 예방접종 안내(가정통신문)>, 질병관리청에서는 보건소를 통해 미실시 학생 대상 별도 접종 안내

③ 학교 내 예방접종 또는 학교단위 단체 예방접종 금지, 방역당국 주관의 예방접종 시에도 사전 예진 철저히 하여 부작용을 방지해야 함. ※ 근거: 「예방접종의 실시기준 및 방법」(질병관리청 고시 제2023-14호)

④ 인플루엔자 국가예방접종 적극 홍보
- 지원대상: 생후 6개월~만13세, 접종기간: 당해연도 9월 ~ 익년도 4월

【 만 4세 이후 표준예방접종 일정표(2026) 】

대상감염병	백신종류	만 4세	만 6세	만 11세	만 12세
디프테리아/파상풍/백일해	DTaP	DTaP(5차)			
	Td/Tdap			Td/Tdap	
폴리오(소아마비)	IPV	IPV(4차)			
홍역/유행성이하선염/풍진	MMR	MMR(2차)			
일본뇌염	JEV(불활성화 백신)		JEV(4차)		JEV(5차)
인유두종바이러스	HPV2			HPV 1~2차 (여학생)	HPV 1~2차 (여학생)
폐렴구균	PPSV	고위험군에 한하여 접종			
인플루엔자	IIV(불활성화 백신)	IIV 매년 접종			

대상	행정사항	접종 대상 예방접종
입학생	• 국가예방접종에 대한 접종완료 여부 확인과 미접종자 접종 실시 안내 • 미접종자 개별 접종 실시 후 전산등록 요청(연계 기간) 또는 예방접종증명서를 발급받아 제출·확인(연계 종료 후) • 의료기관 폐업으로 전산등록 불가능할 경우 보건소에 전산등록 요청 • 기타 증빙서류: 아기수첩 등 - 건강기록부 입력처리	• 필수접종대상(11종): BCG, B형 간염 3차, DTaP 5차, 폴리오 4차, b형 인플루엔자 4차, 폐렴구균 4차, MMR 2차, 수두 1차, A형 간염 2차, 일본뇌염 사백신 4차(또는 생백신 2차), 인플루엔자(입학전년도) • 미접종 학생 필수접종대상(4종): DTaP 5차, 폴리오 4차, MMR 2차, 일본뇌염 사백신 4차(또는 생백신 2차) • 미접종 학생 권고접종대상(3종): A형 간염 2차, B형 간염 3차, 수두 1차 ※ 근거: 「학생감염병 예방·위기대응 매뉴얼」 p.15
취학 후	• 만 11~12세 실시하는 예방접종 안내 및 확인 • 10월 독감예방접종 안내	• Tdap 또는 Td 추가 접종, 일본뇌염 5차, HPV1차 • 인플루엔자(매년)
해외전입생	• 국가예방접종 증명서 제출안내 - 예방접종 확인 및 NEIS에 입력	• A형간염, B형간염, 폴리오, MMR, 수두, 일본뇌염. Tdap/Td: 예방접종증명서 7종 제출

일시적 관찰실 지정

▪ 정의: 전파 우려가 있는 감염병 의심 학생이 의료기관에 진료를 받으러 가기 전까지 격리하여 관찰하는 곳

▪ 지정조건

- 1층에 마련이 원칙(1층 마련이 어려운 경우 층간 이동을 최소화하고 신속한 귀가가 가능한 장소)
- 문을 닫을 수 있고 환기가 잘 되는 공간
- 출입구에 안내문을 부착하여 다른 사람들의 접근 차단

※ 보건실 내 설치는 다른 사람과의 접촉 가능성이 있으므로 바람직하지 않음

– 부득이한 경우 다른 침대와 2m이상을 유지하거나 가림막(커튼, 파티션 등)으로 차단

▪ 담당자

- 학생의 심리적 안정을 위해 담임교사가 담당할 것을 권고하되 학교 상황에 따라 자율적으로 결정

– 고위험군(임신부 등) 및 보건교사 제외

▪ 방법

- 관찰실 내에서 교사와 학생은 2m이상의 거리 유지하며 학생을 안정시킨 상태에서 주의깊게 증상 변화 관찰
- 유증상 학생이 있는 경우: 복도 쪽 창문은 닫고, 실외 쪽 창문은 모두 개방
- 필요시 학생과 담당 교사 마스크 착용
- 사용 시설은 격리 해제 후 즉시 환기, 소독 실시

학교 내 소독 및 방역물품 비축

1) 학교 내 소독 철저

세부 지침		적용 범위 및 방법
정기소독		• 연5회 이상(소독 횟수와 소독 월 준수) 의무 실시 ※ 근거: 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행령 제24조, 같은 법 시행규칙 제36조 제4항 • 보고 사항: 학교 방역소독 실시 계획 및 현황 • 소독실시 횟수: 4~9월에는 2개월에 1회 이상, 10월~3월에는 3개월에 1회 이상(연 5회 이상) • 시행주체: 전문 소독업체 위탁
일상소독		• 학기 내 감염병 환자가 발생하였거나 유행 시 해당 공간에 대해 실시
임시소독	감염병 발생 시	• 소독 시기: 학교 내 감염병 환자 발생 또는 유행 시 해당 공간에 대해 실시 • 방법 – 소독업체 이용 시: 정기적 소독 지침에 준하여 실시 – 학교 자체 실시: 다빈도 접촉 공간 및 물품 등에 소독제나 소독티슈를 사용하여 표면소독 – 충분히 환기
	일시적 관찰실 소독	• 감염병 (의심)환자를 격리·관찰할 경우 해당 공간에 대한 소독 시행
보건실 소독		• 평상 시 보건실의 공간, 장비 및 물품 등의 소독 시행

2) 학교 방역물품 비축

- 방역물품은 학생 수 및 학급 수 등 학교 규모를 고려하여 발열 감시, 전파 차단, 소독을 위해 상시 비축
- 학기별 1회 물품별 비축현황을 파악한 후, 비축 기준 대비 부족분을 산출하여 향후 예산에 반영, 구비
- 교실 비축 물품(체온계, 마스크, 장갑, 알코올 손 소독제)은 학교 여건에 맞는 적정한 장소에 보관

하되, 가급적 학생의 손이 닿지 않는 곳에 보관

- 마스크, 장갑은 사용 후 위생적으로 폐기함
- 모든 방역물품은 제품 용기에 표시된 기한까지 사용하고 이 기간이 지나면 폐기하고 재구매 및 비축

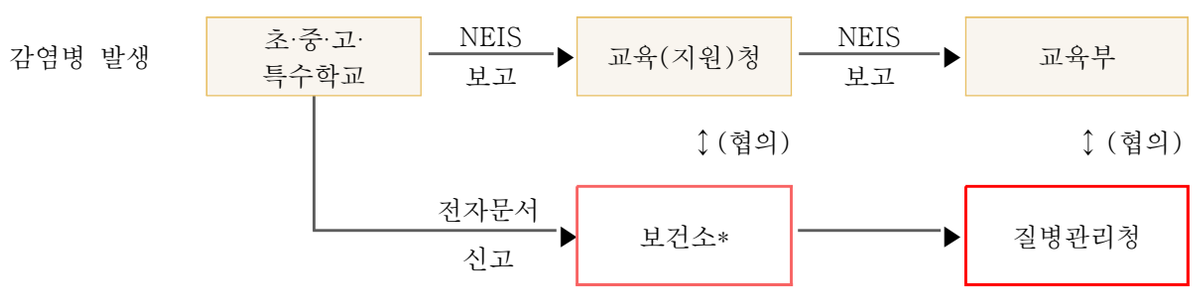
학교방역물품 비축모형

비축목적	방역물품	비축 우선순위[1]	비축기준[2]	
			비축장소	비축물량
발열 감시	고막 체온계	높음	교실	교실당 1개
			보건실	1개
	비접촉체온계		교실	교실당 1개
			보건실	1개
장갑	의료용 장갑[3]	높음	교실	교실당 5개
마스크	보건용 마스크 (KF80이상)	높음	교실	교실당 20개
			보건실	학생 10명당 3개
	수술용		교실	교실당 20개
			보건실	학생 10명당 3개
손소독	알코올 손 소독제	높음	교실	교실당 4개
			보건실	8개(250ml)
환경소독	락스[4]	높음	보건실	2개(5L)
	살균 티슈[5]		보건실	보건실 운영일 × 소독필요 물품 수

1) 비축 기준을 충족하지 못한 경우 동일 물품 중 우선순위가 높은 물품을 우선적으로 비축하되, 이미 우선순위가 낮은 물품을 비축 기준에 맞게 기보유한 경우에는 추가적으로 비축할 필요가 없음
2) 보건실이 없는 경우는 교육기관의 장이 자체적으로 결정한 장소에서 비축하고, 관리인력을 지정함
소규모의 초중고(예: 50명 미만)의 경우 장갑과 마스크에 대한 비축 기준은 상기표의 기준과 무관하게 의료용 장갑은 최소 10개에서 총원의 1/2만큼 비축하고, 마스크는 총원만큼 비축을 권장함
3) 라텍스 또는 니트릴 장갑이 권장되며 비닐장갑은 사용을 권하지 않음. 전파 위험이 있는 분비물(콧물, 농 등)이 나오는 학생과 접촉해야 하는 경우 사용
4) 염소 농도가 5.25~6.15%인 소독약품 1:500 비율로 희석한 후 용기에 담아 소독용 거즈와 함께 교실에 제공하여 교실 자체 소독 이용
5) 이소프로필 알콜이 70% 이상 함유된 제품을 권장 ※학생 감염병 예방·위기대응 매뉴얼(제3차 개정판) 19쪽 참고

다 평상 시 및 감염병 발생 시 대응체계

감염병 발생 보고(신고) 체계



- 학교 내 감염병 확진 및 의심 환자 발생 시 등교를 중지하고, 학부모에게 의료기관 진료를 안내하는 등 신속한 대응으로 학교 내 확산 방지
- 학교장은 교내 감염병 발생 시 지체 없이 NEIS 감염병 발생 보고 <Ⅳ-1-바. 나이스 감염병 발생 보고 방법>
- 보건소 즉시 신고 감염병: 결핵・홍역・콜레라・장티푸스・파라티푸스・세균성이질・장출혈성대

장균감염증・A형간염(8종)

- 환자 발생 시 조치내용 및 절차는 「학생 감염병 예방·위기대응 매뉴얼」에 따르며, 등교중지 및 출석 인정 등 출결 상황 관리는 「학교생활기록 작성 및 관리지침」 및 「학교생활기록부 기재요령」에 따름

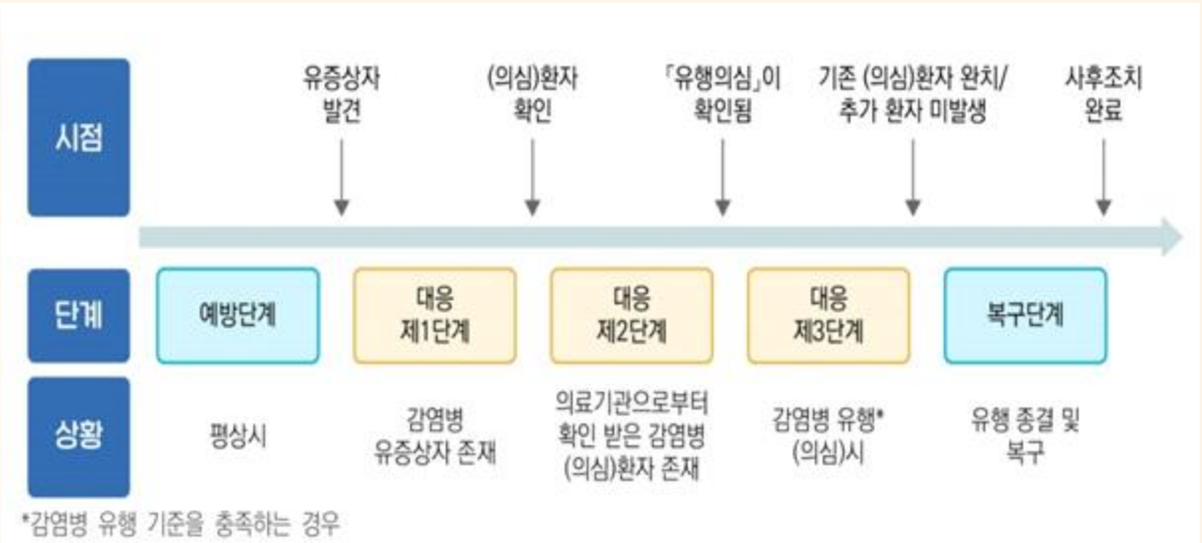
평상 시 및 감염병 발생 시 대응단계

- '평상 시': 예방단계, 학교에 감염병 발생이 없는 상황을 의미함

– 학교 내 감염병이 없거나 감기 혹은 단순 설사 등 특이사항이 없이 일반적인 상황을 유지하는 경우

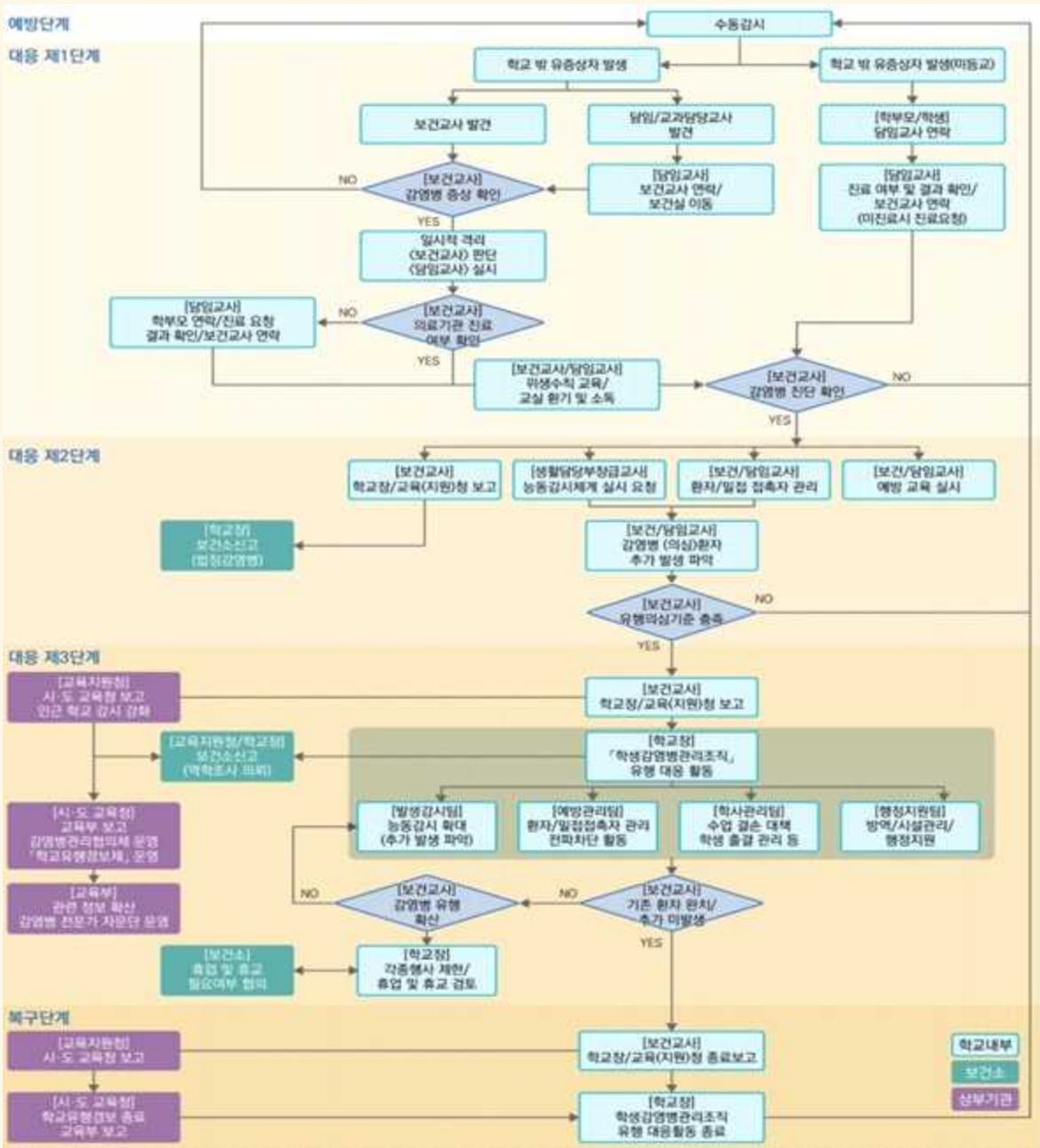
- '감염병 발생 시': 학교에 감염병(의심)환자의 발생, 유행, 확산, 종료 상황을 모두 포함함

[평상시 및 감염병 발생시 대응 단계]



단계	상황	시작 시점	종료 시점	후속조치
1단계	감염병 유증상 존재	유증상자 발견	의료기관 진료 결과 감염병(의심)환자 발생을 확인	대응 2단계
			감염병이 아닌 것으로 확인	예방단계
2단계	의료기관으로부터 확인받은 감염병 (의심) 환자 존재	의료기관 진료 결과 감염병 (의심)환자 발생 확인	추가 (의심)환자 발생 확인을 통해 유행 의심기준을 충족	대응 3단계
			기존 (의심)환자가 완치되고 추가(의심) 환자가 미발생	예방단계
3단계	동일 학급에 감염병 (의심)환자 2명 이상 존재	추가 (의심)환자 발생 확인을 통해 유행의심 기준 충족	기존 모든 (의심)환자가 완치되고 추가 (의심)환자가 미발생	복구단계
복구 단계	유행 종결 및 복구	기존 (의심)환자가 모두 완치되고 최대 잠복기까지 추가 (의심)환자 발생 없음	사후조치 완료	종료

[감염병 대응 흐름도]



<학교 내 능동감시체계 운영방안>

- 담당: 발생감시팀, 예방관리팀
- 운영시기: 대응 2, 3단계 / 시·도교육청「학교유행경보」발령 시 / 국가위기 상황 시 교육부의 요청이 있는 경우
- 운영방법: 보건(담당)교사가 능동감시 대상을 결정

대응 2단계: 일부만 실시	대응 3단계: 전체 학급으로 확대
• 감염병(의심)환자가 발생한 학급이 있는 동일한 층의 학급 • 이동식 수업 시 감염병(의심)환자와 함께 수업을 들은 학생들 전원 • 수인성 및 식품매개 감염병의 경우 (의심)환자와 같은 음식물 먹은 학생 전체	• 감시방법: 학생·보호자에게 대한 설문, 신체검사(발열측정 등) 중 적절한 방법으로 매일 1회 이상 파악
• 전체 학생 대상의 발열검사는 권장하지 않음 • 발열 감시가 필요한 경우, 각 학급별로 본인이 열이 있다고 한 학생들에 대한 선별적 검사 권고	

학교 감염병 발생 시 부서별 업무

학교의 구성원은 학교 내 감염병 유행이 종결될 때까지 아래 업무 분장표에 따라 해당 업무를 수행한다.

<감염병 유행이 의심될 경우 부서별 업무 분장표(예시)>

부서	책임자	업무영역	담당자	업무
발생 감시팀	학년 부장 (담임 교사)	학교 감염병 감시체계	담임 교사	• 유증상자 현황 파악: 결석학생, 유증상자 • 결석자 일일 원인별 동태 파악(가정과 연계)
			보건 (담당) 교사	• 학생/보호자→담임교사→학년부장→보건(담당)교사 보고체계 확립 ※ 교직원 감염(의심)환자: 복무담당자 →보건(담당)교사 • 보건실 이용자 일일 원인별 파악 및 환자현황(신규발병자, 완치자) 누계 작성 • 감염병 환자 교육청 보고 및 보건소 신고 ※ 대응 2단계부터 능동감시체계 운영
예방 관리팀 (의심/ 환자 관리)	보건 (담당) 교사	계획 사전수립	보건 (담당) 교사	• 감염병 예방관리 계획 수립
		환자관리	담임 교사	• 학급 유증상자 발견→보건실 의뢰 – 마스크 착용 필요 여부 확인 및 감염병(의심)환자 이동수칙 준수 • 등교중지 및 학원 등 다중이용시설 출입금지 안내 – '등교중지 안내문' 배부 및 출결처리를 위한 관련서류 제출 안내 – 대응3단계: 감염병 확진학생 NEIS 환자등록 • 보호자와 연락, 의료기관 진료의뢰 및 진단결과 확인 후 정보공유 • 개인위생 수칙 준수 및 가정학습에 대한 안내
			보건 (담당) 교사	• (의심)환자 및 유증상자 관리 총괄 • 보건실 방문 학생: 증상 확인하여 감염병 발병 가능성 조사 • 유증상자 일시적 관찰 필요성 판단 및 실시, 귀가 조치 • 담임으로부터 진료 결과 확인하여 감염병 발생 가능성 확인
			상담 (담당) 교사	• (의심)환자와 주변 학생의 불안감 해소 및 낙인효과가 발생하지 않도록 필요시 심리지원
		접촉자 관리	담임 교사	• 발병자와 긴밀한 접촉이 있는 학생 추적 관찰 – 밀접접촉자: (의심)환자가 포함된 학급 전체 • 접촉자 중 유증상자 발견 시 보건(담당)교사에게 알리고 진료 의뢰 • 보건학적 고위험군 보호자 연락, 조치 결과 보건(담당)교사에게 통보
			보건 (담당) 교사	• 담임교사에 밀접접촉자 관리 방안에 따른 조치 요청 • 보건학적 고위험군에 대한 관리대책 수립 및 파악, 담임교사에게 고위험군 관리 요청(환자/접촉자 관리, 위험 경고, 역격리 등)
		보건교육	보건 (담당) 교사	• 감염병 정보 및 개인위생에 관한 보건교육 및 홍보 제공 – 가정통신문, 학생 및 교직원 대상 감염병 예방교육 등
			담임교사	• 학급 조·종례 시간 등을 이용 감염병예방교육 실시
행정 지원팀	행정 실장	행정지원 및 방역	행정실장	• 학교 전체 방역·소독 활동 /위생시설 관리 • 예산 및 행정 지원
		방역	각실 담당자	• 충분한 환기 및 임시소독 실시 – 소독제를 이용하여 오염 가능성이 높은 물체표면 닦음
학사 관리팀	교무 부장	학업관리	교무 부장	• 상황판 작성 • 발병 학생 수업결손 대책 마련 • 단축수업 및 휴업 실시 여부 판단 • 수학여행, 교내 행사 등 단체 활동 자제
		출결처리	담임교사	• 완치 후 등교 시 등교중지 기간에 대한 출석인정 처리
	생활부장	생활지도	담임 교사	• 학생 생활지도 철저 및 감염병 예방요령 교육(휴업기간 동안 외출 자제, 학원, PC방, 만화방, 영화관 등 다중이용시설 금지) • 사회적 취약계층: 등교중지시 필요에 따른 급식제공 및 지자체복지 서비스 연계의뢰를 위한 부서와 협의

등교중지 (※ 학생 감염병 예방·위기대응 매뉴얼 제3차 개정판)

1) 학교 내 빈발 감염병의 종류와 특성

감염병	임상증상	감염가능기간	전파차단을 위한 등교중지기간[1]	잠복기	밀접 접촉자 파악	일시적 관찰실 이동[2]	마스크 착용
결핵	발열, 전신피로감, 식은땀, 체중감소	약물 치료 시작 후 2주까지	약물 치료 시작 후 2주까지	수년까지 가능 (50% 2년 이내)	○	○	○
수두	피부발진, 수포, 발열, 피로감	발진 1~2일 전부터 모든 피부병변에 가피가 생길 때까지	모든 수포에 가피가 형성될 때 까지	10~22일 (평균 14~16일)	○	○	○
수족구병	발열, 손·발바닥과 구강 내 수포 및 궤양	발병 후 7일간이 가장 전염력 강함 피부 수포에 가피가 생성될 때까지	수포 발생 후 6일간 또는 가피가 형성될 까지	3~7일	○	○	○
급성출혈성 결막염	충혈, 안통, 이물감, 많은 눈물, 눈부심, 눈곱, 결막하출혈	발병 후 4일~1주일	격리없이 개인 위생수칙을 철저히 지킬 것을 권장	8~48시간	○	○	X
유행성 각결막염		별병 후 14일까지		5~7일	○	○	X
유행성 이하선염	이하선 부종, 발열, 두통, 근육통	이하선염 발현 3일 전부터 5일 후까지	증상 발생 후 5일까지	12~25일 (평균 16~18일)	○	○	○
감기군	발열, 기침, 객담 등 호흡기계 증상	이환기간 내내	등교 중지 안 함	병원체마다 다양 (보통 2~14일)	X	○	○
인플루엔자	발열, 두통, 근육통, 인후통, 기침, 객담	증상 발생 1일 전부터 5일까지	유행차단을 위한 등교 중지는 의미 없지만 환자상태에 따라 실시[3]	1~4일 (평균 2일)	X	○	○
b형 헤모필루스 인플루엔자	수막염, 후두개염, 폐렴, 관절염 등	호흡기 분비물에 균이 존재하는 동안 전파 가능하며, 적절한 항생제 투여 후 24시간까지 전파가능	항생제 치료 시작 후 24시간까지	명확하지 않음	○	○	X
노로 바이러스	오심, 구토, 설사, 복통, 권태감, 발열	급성기부터 설사가 멈추고 48시간 후까지	증상 소실 후 48시간까지	24~48시간 (평균 33시간)	○	○	X
백일해	상기도 감염증상, 발작적 기침, 구토	2주가 전염력이 높으며, 증상 발생 4주 후에는 전염성이 소실	항생제 투여 후 5일까지	7~20일 (평균 5~10일)	○	○	○
성홍열	미만성 구진, 발열, 두통, 구토, 복통, 오한 및 인후통	항생제 치료 시작 후 24시간까지	항생제 치료 시작 후 24시간까지	1~3일	○	○	○
수막구균성 수막염	두통, 발열, 경부경직, 오심, 구토	항생제 치료 시작 후 24시간까지	항생제 치료 시작 후 24시간까지	2~10일 (평균 3~4일)	○	○	○
풍진	구진성 발진, 림프절 종창, 미열 등 감기증상	발진 생기기 7일 전 ~ 생긴 후 7일까지	발진 생기기 7일 전 ~ 생긴 후 7일까지	12~23일 (평균 14일)	○	○	○
홍역	발진, 발열, 기침, 콧물, Koplik 반점	발진 발생 4일 전 ~ 발진 발생 4일 후 까지	발진 4일 전부터 4일 후까지	7~21일 (평균 10~12일)	○	○	○

1) 등교 중지 기간은 휴일을 포함, 등교중지 여부 및 기간은 의사의 소견에 따름

등교 중지가 필요한 감염병이 의심되는 경우 확진 여부 확인 시까지 등교 중지

2) 전파우려가 있는 감염병 의심 학생이 의료기관에 진료를 받으러 가기 전까지 격리하여 관찰하는 것

3) 학교 빈발 감염병의 기본적인 지침은 위 표를 따르되, 방역당국이나 교육부에서 별도의 관리지침을 제시할 경우, 그 지침을 우선 적용함(예, **인플루엔자 관리 지침의 등교 중지 기간: 해열제 없이 정상 체온 회복 후 24시간이 경과할 때 까지**/중증의 증상이나 면역저하자 등의 경우 의사의 판단에 따라 등교중지 기간이 달라질 수 있음)

2) 등교중지 원칙과 절차

※ 국가의 감염병 위기상황시 출석인정 및 등교중지는 「라. 국가위기상황시 학교의 대비 및 대응」을 참고하여 처리한다.

등교중지 및 출석 인정 결석 대상	■ 등교 중지가 필요한 감염병으로 확진된 경우: 「전파차단을 위한 격리기간」 동안 등교중지 – 이때 격리기간은 원칙적으로 의사의 소견을 따름 ■ 등교 중지가 필요한 감염병이 의심되는 경우: 확진 여부를 확인할 때까지 등교 중지 ■ 진료 결과 감염병이 아니었다 하더라도 결과 확인까지의 기간은 출석으로 인정 ■ 신종감염병 유행 시 역학조사 실시 결과 자가격리 통보를 받은 경우(증상과 무관)
실시 절차	1) 감염병 확인을 위한 진료 요청 및 관련 서류 안내 ■ 감염병 의심증상으로 미등교 한 경우: 담임교사 • 보호자에게 의료기관 진료 안내 • '등교중지 안내문'을 학교 홈페이지(게시한 경우)에서 다운로드하여 이용하도록 안내<Ⅳ-1-바. 감염병등교중지안내문> ■ 학교에서 감염병 의심 학생 발견한 경우 • 담임교사: 보호자 연락하여 의료기관 진료 요청 + '등교중지 안내문' 출력물 배부 • 안내사항: 학교 복귀 시 출결처리를 위한 제출서류 안내 – '진료확인서', '의사소견서', '진단서' 중 1개 제출 – 부득이한 경우 '처방전'도 인정: 처방전은 KOICD 질병분류센터 웹사이트에서 질병코드 확인 후 인정 가능 2) 등교 중지 필요여부 및 기간 확인 ■ 담임교사가 보호자와의 통화를 통해 진료결과 확인 • 등교 중지 기간이 명시되어 있는 경우: 해당 기간동안 등교 중지 실시 • 등교 중지 기간 명시되어 있지 않은 경우: 보건(담당)교사가 질환명(의심 포함) 확인 후 「학교 내 빈발 감염병의 종류와 특성」을 참고하여 '전파차단을 위한 등교중지 기간'을 적용함 3) 등교 중재 해제 ■ 등교 재개 여부에 대한 판단: 원칙적으로 의사나 보건소의 의견에 따름 ■ 등교 재개 방법 • 교실복귀: 등교 중지 기간 종료 + 감염병 증상 소실 ➔ 담임교사; 학생이 등교한 당일 해당 사실을 보건교사에게 정보 공유함 ➔ 보건교사: 나이스 수정보고(나이스–보건–감염병환자관리–감염병환자조회 및 수정보고 제출) • 등교 중지 종료 시점 이전 등교를 원하는 경우 : 감염성이 소실되었다는 의사의 진료확인서 또는 소견서를 제시할 경우 등교 가능 • 등교 중지 종료 시점 이후 등교 중지기간 연장을 원하는 경우 : 감염병 증상이 남아 있는 경우, 진료확인서나 소견서를 제시하면 등교 중지 연장 가능

교내 확산 방지를 위한 감염병 환자(의심자 포함) 관리 강화

○ 감염병 환자(의심자 포함) 발생 시 등교를 중지토록 하고, 학부모에게 의료기관 진료를 안내하는 등 신속한 대응을 통하여 학교 내 확산 방지

※ 환자 발생시 조치내용 및 절차는 「학생 감염병 예방·위기대응 매뉴얼」에 따르며, 등교중지 및 출석인정 등 출결상황 관리는 「학교생활기록 작성 및 관리지침」 및 「학교생활기록부 기재요령」에 따름

《 등교중지 및 출석 인정 증빙서류 》
- 법정 감염병 또는 확산의 우려가 있는 감염병이라는 의사의 진단 결과가 기재된 진단서·의사소견서·진료확인서
- 이 외 「학교보건법」 제8조 또는 「학교생활기록 작성 및 관리지침」 별표8에 따라 학교장이 등교중지 시킬 경우 출석 인정 가능

3) 법정 감염병(2025.9. 기준)

: 제1급~제4급감염병, 기생충감염병, 세계보건기구 감시대상 감염병, 생물테러감염병, 성매개감염병, 인수공통감염병 및 의료관련 감염병으로 분류

구분	1급 (18종)	2급 (21종)	3급 (28종)	4급 (23종)
특성	생물테러감염병 또는 치명률이 높거나 집단발생우려가 커서 발생 또는 유행 즉시 신고, 음압격리와 같은 높은 수준의 격리가 필요한 감염병	전파가능성을 고려하여 발생 또는 유행시 24시간 이내에 신고하고 격리가 필요한 감염병	발생을 계속 감시할 필요가 있어 발생 또는 유행시 24시간 이내에 신고하여야 하는 감염병	제1급~제3급 감염병까지의감염병 외에 유행여부를 조사하기 위하여 표본감시 활동이 필요한 감염병
종류	1. 에볼라바이러스병 2. 마버그열 3. 라싸열 4. 크리미안콩고출혈열 5. 남아메리카출혈열 6. 리프트밸리열 7. 두창 8. 페스트 9. 탄저 10. 보툴리눔독소증 11. 야토병 12. 신종감염병증후군 13. 중증급성호흡기증후군(SARS) 14. 중동호흡기증후군(MERS) 15. 동물인플루엔자 인체감염증 16. 신종인플루엔자 17. 디프테리아 18. 니파바이러스감염증	1. 결핵 2. 수두 3. 홍역 4. 콜레라 5. 장티푸스 6. 파라티푸스 7. 세균성이질 8. 장출혈성대장균감염증 9. A형간염 10. 백일해 11. 유행성이하선염 12. 풍진 13. 폴리오 14. 수막구균감염증 15. b형헤모필루 인플루엔자 16. 폐렴구균감염증 17. 한센병 18. 성홍열 19. 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증 20. 카바테넴내성장내세균속균종(CRE)감염증 21. E형간염	1. 파상풍 2. B형간염 3. 일본뇌염 4. C형간염 5. 말라리아 6. 레지오넬라증 7. 비브리오패혈증 8. 발진티푸스 9. 발진열 10. 쯔쯔가무시증 11. 렙토스피라증 12. 브루셀라증 13. 공수병 14. 신증후군출혈열 15. 후천성면역결핍증(AIDS) 16. 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종 크로이츠펠트-야콥병(vCJD) 17. 황열 18. 뎅기열 19. 큐열 20. 웨스트나일열 21. 라임병 22. 진드기매개뇌염 23. 유비저 24. 치쿤구니야열 25. 중증열성소판감소증후군(SFTS) 26. 지카바이러스 감염증 27. 엠폭스 28. 매독	1. 인플루엔자 2. 회충증 3. 편충증 4. 요충증 5. 간흡충증 6. 폐흡충증 7. 장흡충증 8. 수족구병 9. 임질 10. 클라미디아감염증 11. 연성하감 12. 성기단순포진 13. 첨규콘딜롬 14. 반코마이신내성장알균(VRE)감염증 15. 메티실린내성황색포도알균(MRSA)감염증 16. 다제내성녹농균(MRPA)감염증 17. 다제내성아시네토박터 바우마니균(MRAB) 감염증 18. 장관감염증[1] 19. 급성호흡기감염증[2] 20. 해외유입기생충감염증[3] 21. 엔테로바이러스감염증 22. 사람유두종바이러스 감염증 23. 코로나바이러스감염증-19

1) 장관감염증: 살모넬라균 감염증, 장염비브리오균 감염증, 장독소성대장균(ETEC) 감염증, 장침습성대장균(EIEC) 감염증, 장병원성대장균(EPEC), 캄필로박터균 감염증, 클로스트리듐 퍼프린젠스 감염증, 황색포도알균 감염증, 바실루스 세레우스 감염증, 예르시니아 엔테로콜리티카 감염증, 리스테리아 모노사이토제네스 감염증, 그룹 A형 로타바이러스 감염증, 아스트로바이러스 감염증, 장내아데노바이러스 감염증, 노로바이러스 감염증, 사포바이러스 감염증, 이질아메바 감염증, 람블편모충 감염증, 작은와포자충 감염증, 원포자충 감염증

2) 급성호흡기 감염증: 아데노바이러스 감염증, 사람보카바이러스 감염증, 파라인플루엔자바이러스 감염증, 호흡기세포융합바이러스 감염증, 리노바이러스 감염증, 사람 메타뉴모바이러스 감염증, 사람 코로나바이러스 감염증, 마이코플라스마균 감염증, 클라미디아균 감염증

3) 해외유입기생충감염증: 리슈만편모충증, 바베스열원충증, 아프리카수면병, 주혈흡충증, 샤가스병, 광동주혈선충증, 악구충증, 사상충증, 포충증, 특소포자충증, 메디나충증

※ 출처: 감염병포털 / 2026 학생 건강관리 추진 계획(교육청)

라 감염병 관련 서식 및 참고자료

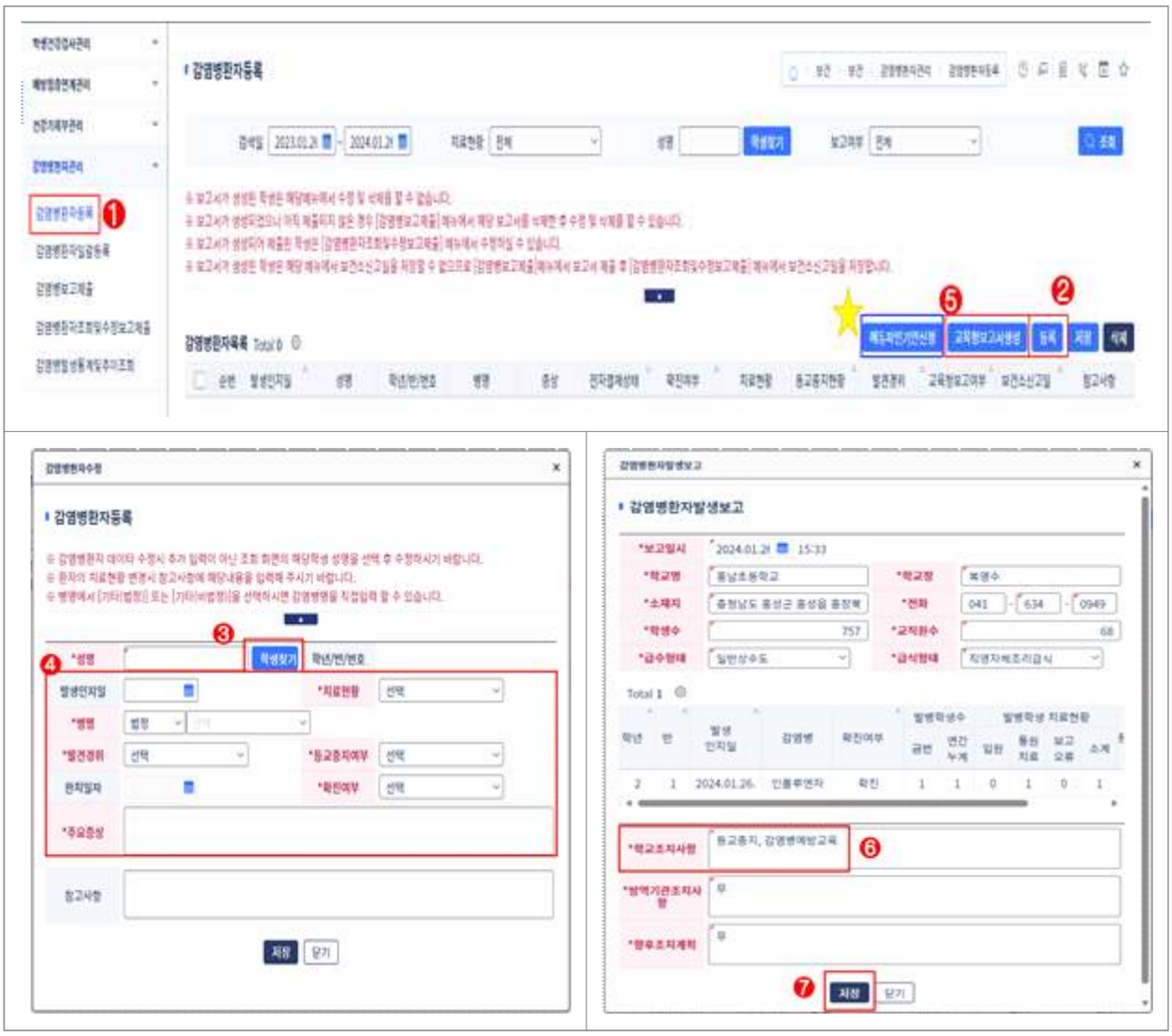
나이스 감염병 발생보고 방법(학생)

♣ 나이스 감염병 환자 발생 시 처리 순서

① 감염병 환자 등록 및 교육청 보고서 생성: 감염병 환자(학생)별 최초 보고, 교직원은 교육청 관리 지침에 따라 복무(병가)처리(복무담당자)
② 감염병 보고 제출: 생성된 교육청 보고서 제출
③ 감염병 환자 조회 및 수정보고제출: 감염병 환자별 변동 사항 보고 처리(완치, 오류 보고 등)

1) 감염병환자 등록 및 교육청 보고서 생성

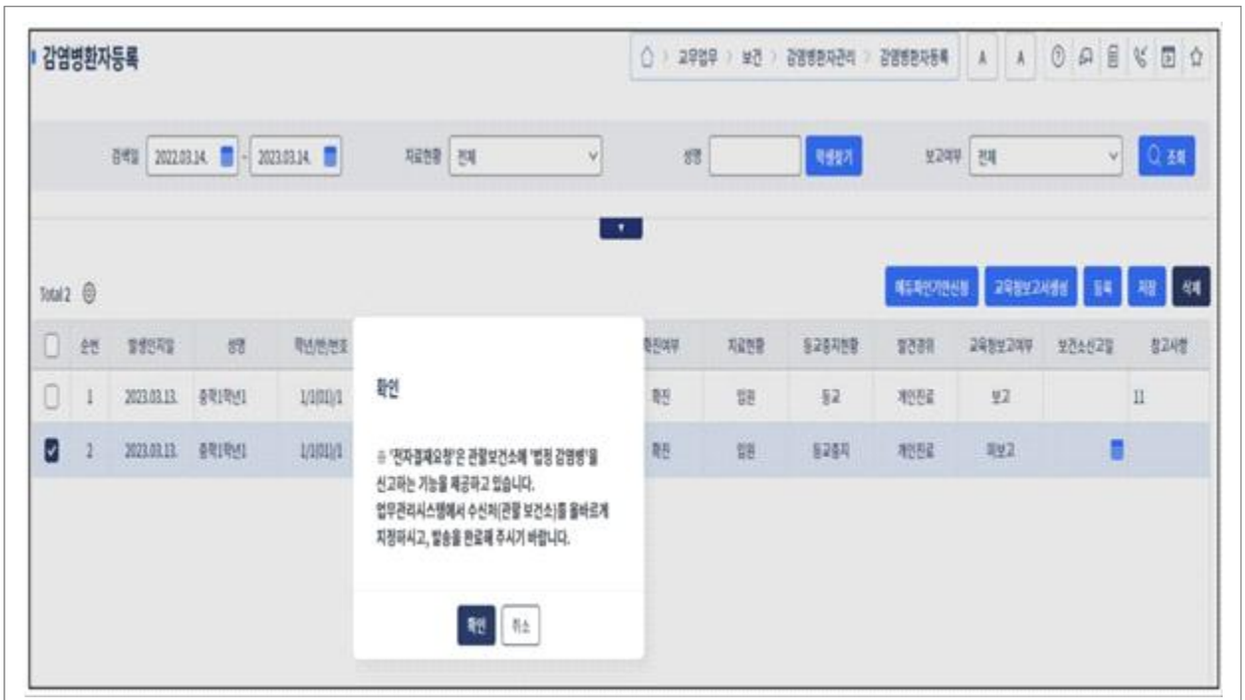
- 메뉴경로: [나이스] – [보건] – [감염병환자관리] – [감염병환자등록]
- [감염병환자등록] > ②【등록】클릭 > 팝업창에서 ③ 학생찾기 > ④ 항목 입력 > 저장
  ※ 필수입력사항: 성명, 발생인지일, 치료현황, 병명, 확진여부, 발견경위, 등교중지여부, 주요증상
- 학생 선택 ☑ > ⑤【교육청보고생성】클릭 > ⑥ 팝업창 보고서 내용 입력 및 확인 > ⑦ 저장 > [감명병보고제출] 메뉴에서 제출
  ※ 필수입력사항: 학교조치사항 반드시 입력(예: 환자 등교중지, 학교장 및 교육청 보고, 유증상자 모니터링, 감염병 예방 교육, 감염병 예방 가정통신문 발송, 일상 소독 및 환기 등)

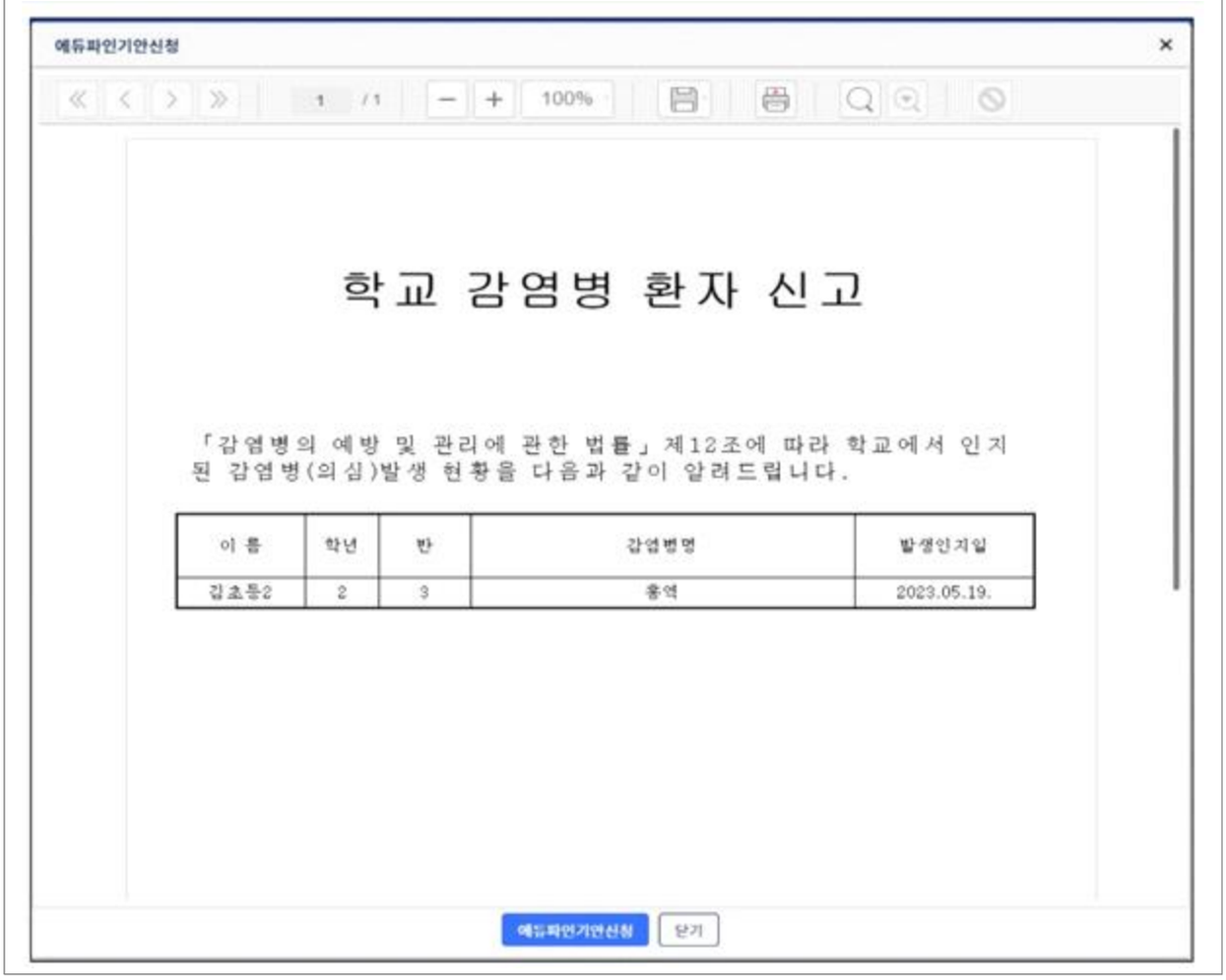


※ 에듀파인 기안신청: 보건소 신고대상 감염병 발생시 활용, 보건소 전자결재와 연동되어 있음

– 에듀파인 기안신청이 되면 전자결재 상태가 발송으로 변경됨

– 전자결재 상태가 미상신, 발송실패, 사용자ID 없음, 반송, 결재, 중단 상태의 항목에 대해서만 상신할 수 있음


감염병환자등록
확인
취소


예듬파인기안신청
학교 감염병 환자 신고
「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제12조에 따라 학교에서 인지된 감염병(의심)발생 현황을 다음과 같이 알려드립니다.
이 름
학년
반
감염병명
발생인지일
김초등2
2
3
홍역
2023.05.19.
예듬파인기안신청
닫기

2) 감염병환자 일괄등록 및 보고서 생성: 반별 감염병 환자 일괄등록

- 메뉴경로: [나이스] – [보건] – [감염병환자관리] – [감염병환자 일괄등록]
- 1단계: [감염병환자 일괄등록] > ②③ 학년·반 조회 > ④ 해당 학생 선택 ☑ > ⑤ 일괄적용항목 선택 ☑
  > ⑥ 첫번째 학생에 값 입력 > ⑦【일괄적용】클릭 > ⑧ 저장
- 2단계: [보건 – 감염병환자관리 –감염병환자등록] > 조회 > 학생 선택 ☑ > 【교육청보고생성】 클릭 > 팝업창 보고서 내용 입력 및 확인 > 저장



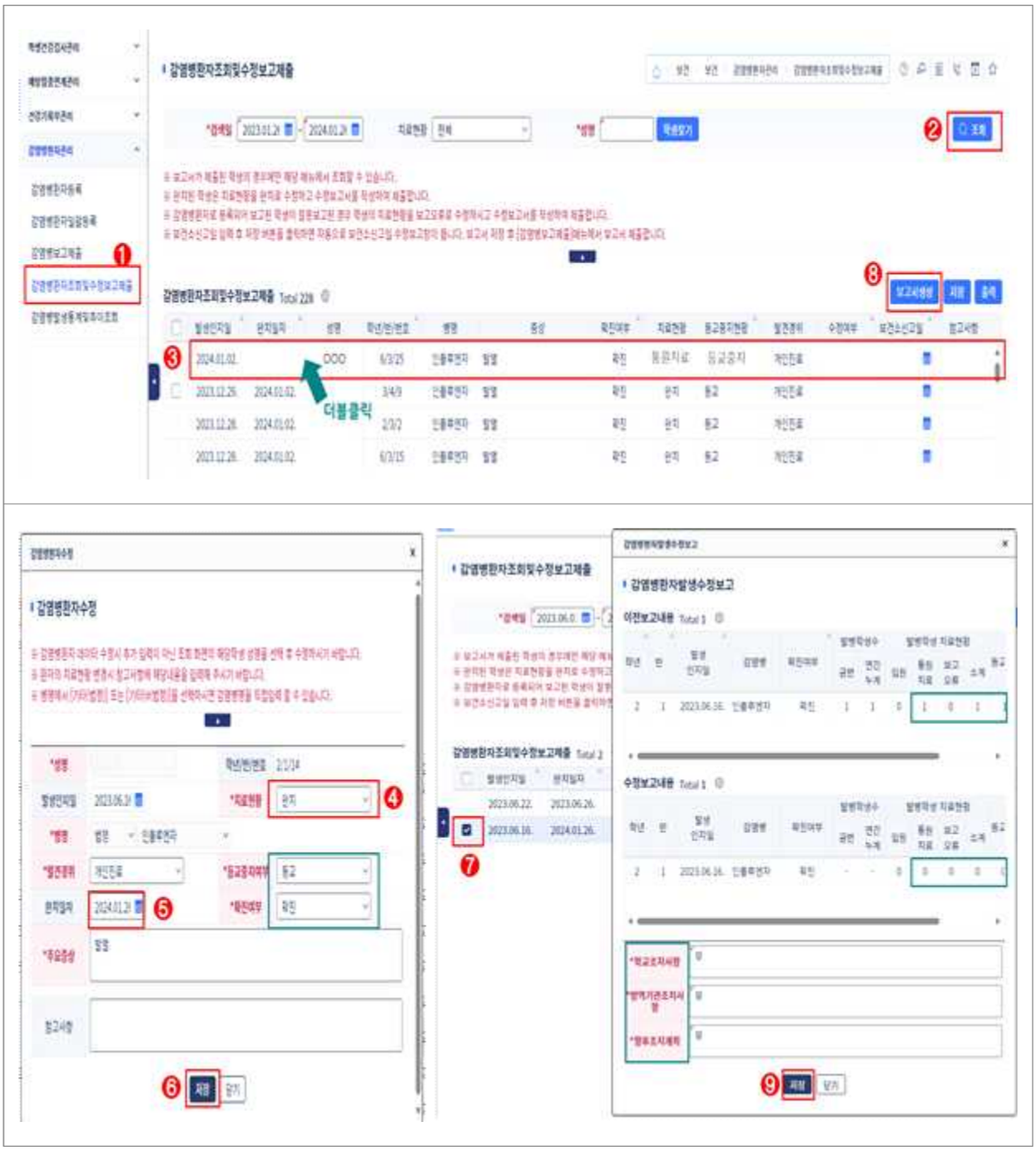
3) 교육청 제출(감염병보고 제출)

- 메뉴경로: [나이스]–[보건]–[감염병환자관리]–[감염병보고제출]
  – 사용 목적: [감염병환자등록] 및 [감염병환자 조회 및 수정보고제출]에서 생성된 보고서를 교육청으로 제출할 때
- ② 조회 > ③ 보고할 내용(미제출) 선택 ☑ > 【승인요청★】 > ④ 제출(승인요청한 경우 결제완료 전이라도 보고서 제출 가능)
  ※ 제출 전 결재 여부는 학교에서 결정함
  – 제출여부: '미제출 ⇒ 제출'로 변경되었는지 확인
  – 미제출 상태 보고서는 삭제 후 수정 가능
  – 최초 보고이면서 오류 입력한 경우 삭제 후 [감염병환자 등록] 메뉴에서 수정하여 교육청보고서 생성
  – 수정보고이면서 오류 입력한 경우 삭제 후 [감염병환자 조회 및 수정보고 제출] 메뉴에서 수정하여 보고서 생성



4) 수정 및 완치 보고

- 메뉴경로: [나이스]-[보건]-[감염병환자관리]-[감염병환자조회 및 수정보고제출]
  - 사용 목적: 보고서 제출 후 수정사항이 발생했거나 완치, 보고오류(삭제대상)을 교육청으로 보고해야 하는 경우 사용
- 1단계: ①[감염병환자조회 및 수정보고제출] > ②검색일 조회 또는 학생 찾기 > ③수정 대상 더블 클릭 > ④⑤ 팝업창 '감염병환자수정'에 수정내용(치료현황(완치), 완치일자, 등교중지여부(등교)) 입력 > ⑥저장 > ⑦학생 선택 ☑ 활성화 > 학생 선택 ☑ > ⑧【보고서 생성】> 수정보고서 내용 입력 > ⑨저장
  - '완치'로 수정하면 자동으로 등교중지 여부 값이 '등교'로 수정됨
  - 내용이 수정된 학생은 체크박스가 활성화 됨
  - 다수 수정 환자가 발생한 경우 활성화된 체크박스를 모두 체크 후 보고서 생성: 일괄 보고서 작성 가능
- 2단계: [감염병보고제출] > 조회 > 제출 자료(미제출, 수정 상태) 선택 ☑ > 제출



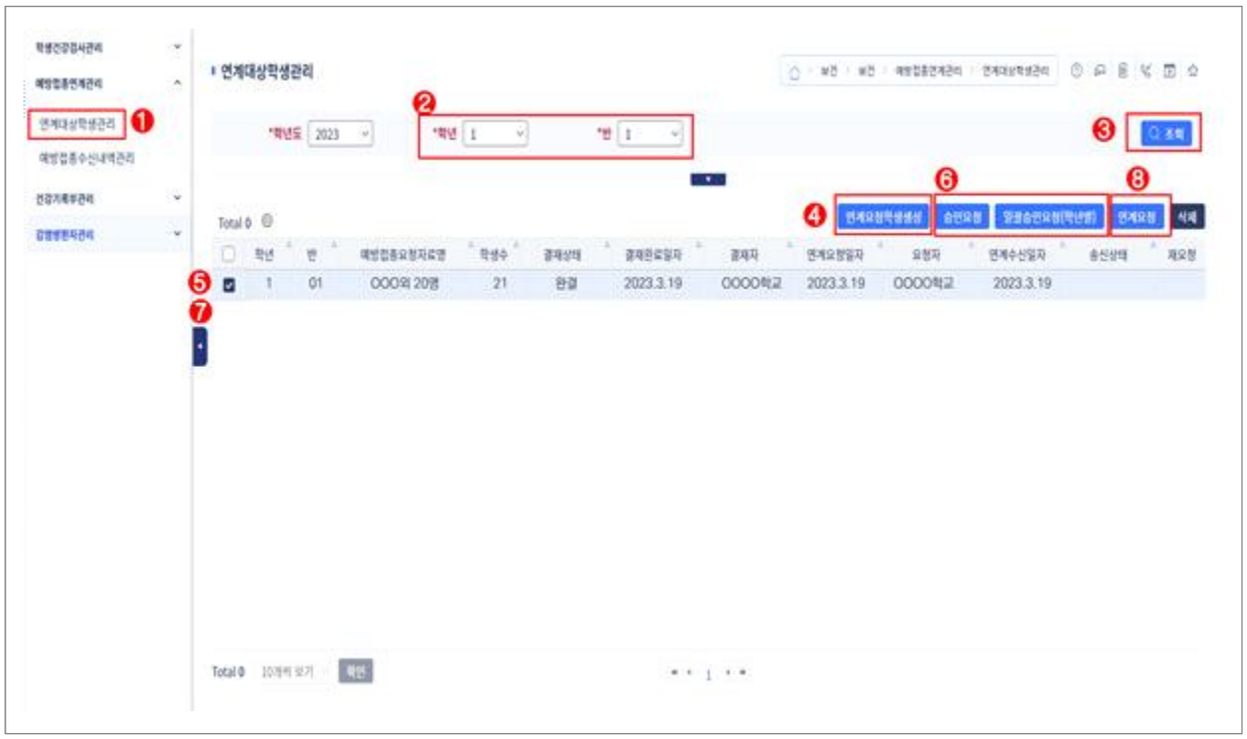
나이스 예방접종 관리

1) 예방접종연계 관리 - 질병관리청 연계 요청

- 메뉴경로: [나이스] – [보건] – [예방접종연계관리] –[연계대상학생관리]
- ① 연계대상학생관리] > ② 학년, 반 선택 > ③ 조회 > ④【연계요청학생생성】– 팝업실행 – 질병관리청 연계요청 학생 생성 > ⑤ 연계요청 자료 선택 ☑ > ⑥【승인요청】 결재 진행 > ⑦ 결재 완료 후 연계요청 자료 선택 ☑ > ⑧【연계요청】

※ 질병관리청 전송 실패 시 송신상태가 요청실패가 되며, 다시 보내기 위해【재전송】클릭하여 재전송

※ 송신상태가 완료일 경우 질병관리청으로 전송 완료



2) 예방접종연계 관리 - 오류 명단 확인 및 조치

- 【오류 안내】 > 검증실패오류 안내 팝업 실행 > 주민등록번호 검증결과에 대한 오류정보 확인

※【오류목록엑셀다운로드】 > 학생목록 다운로드: 오류정보 수정 후 질병관리청으로 연계요청 진행



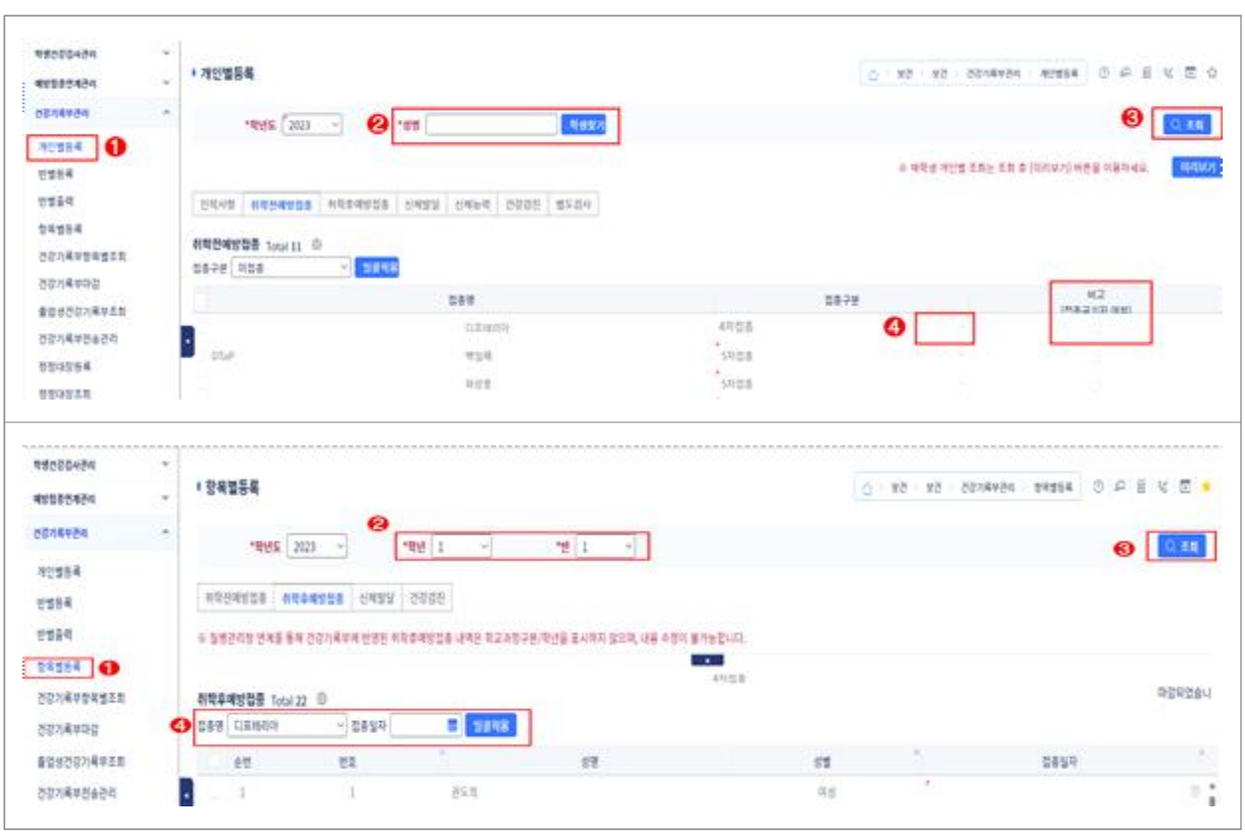
3) 예방접종수신내역관리 - 연계자료 확인 및 건강기록부 반영

- 메뉴경로: [나이스] – [보건] – [예방접종연계관리] – [예방접종수신내역관리]
- ① [예방접종수신내역관리] > ② 학년, 반 선택 > ③ 조회 > ④ 학생 선택 ☑ > ⑤【특이사항저장】 접종내역별 학생의 특이사항이 있는 경우 작성·수정 > ⑥ 학생 선택 ☑ > ⑦【건강기록부반영】 및 【건강기록부미리보기】



4) 예방접종이력 수동입력

- 메뉴경로: [나이스]–[보건]–[건강기록부관리]–[개인별등록] 또는 [항목별등록]
- ①[개인별등록] > ②【학생찾기】> ③조회 > ④접종항목 및 접종차수 선택
  ※ 접종금기자일 경우 (비고)란에 ☑ 표시
- 학급별 다수 학생 입력 시
  →[항목별등록] > 학년, 반 선택 > 조회 > 접종명, 접종일자 선택 > 해당 학생 선택 ☑ > 일괄적용



예방접종 안내(가정통신문 – 예시)

취학전(후) 예방접종 확인 사업 안내(예시)

초등(중등) 입학생 예방접종 확인 사업 안내문

학년 반 번 이름 : _____

안녕하십니까?

「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제24조(필수 예방접종) 및 제31조(예방접종 완료 여부의 확인), 「학교보건법」 제10조(예방접종 완료 여부의 검사) 규정에 의거, 초등(중등)입학생을 대상으로 예방접종 완료여부를 확인하여야 합니다.

1학년의 예방접종 내역확인은 월 일부터 월 일까지 질병관리청과 연계를 통한 전산확인이 이루어집니다. 따라서 예방접종 후 예방접종도우미사이트에서 전산기록이 이루어졌는지 확인하여 주십시오. 보호자께서는 다음 사항을 참고하여 자녀의 예방접종 완료 여부를 확인하시고, 미접종 내역이 있다면 접종을 완료할 수 있도록 협조를 부탁드립니다.

※ 예방접종 내역이 전산등록 되어 있는 경우 <예방접종증명서> 제출은 불필요합니다.
- 해당 기간내 예방접종 완료 후 전산등록시 학교에서 별도 서류 확인 없이 확인가능

※ 단, 질병관리청 연계기간(월 일까지) 종료 이후에는 <예방접종증명서, 아기수첩 등> 등의 증빙서류를 학교로 제출해주셔야 건강기록부 반영이 가능합니다.

1. 입학생 예방접종 확인 항목

구 분	내 용		
초등필수 접종 대상 [4종]	① DTaP 5차 (디프테리아, 파상풍, 백일해) ② IPV 4차 (폴리오) ③ MMR 2차 (홍역, 유행성이하선염, 풍진) ④ JE 사백신 4차 또는 생백신 2차 (일본뇌염)	초등권고 접종 대상 [3종]	① A형간염 2차 ② B형간염 3차 ③ 수두 1차
중학교 신입생[3종]	① Tdap(또는 Td) 6차 ② HPV 1차(여학생만 대상) ③ 일본뇌염(불활성화 백신 5차 또는 생백신 2차)		

2. 예방접종 전산등록 여부 확인 방법

<예방접종도우미 사이트, 인터넷 정부24, 모바일 접종도우미 앱, 예방접종을 받은 의료기관 또는 보건소에서 조회 가능>

전산 미등록 사유 예	이렇게 해주세요 (조치 사항)
미접종자 (예방접종을 완료하지 않은 경우)	① 가까운 의료기관 또는 보건소에서 접종을 완료 ② 예방접종도우미 누리집(https://nip.kdca.go.kr/) 회원가입 및 자녀등록 ③ 예방접종 도우미 누리집 조회 또는 정부24에서 조회
외국인 주민번호로 입력이 되지 않았을 경우	① 접종받았던 외국 의료기관의 <영문예방접종증명서> 또는 접종기관의 직인이나 공식사인 된 서류를 발급(팩스 또는 이메일 등) ② 보건소 전산등록 요청
전산 미등록자 (예방접종을 완료하였으나 전산 등록이 안 된 경우)	① 접종을 받았던 의료기관에 전산 등록을 요청 ② 폐업 등으로 의료기관에서 전산등록이 불가능한 경우 보건소에 전산 등록 요청(단, 아기수첩 등 접종증명서류 지참하고 방문)
예방접종 제외 대상자(금기자)	- '예방접종 금기자'는 접종(진단) 받은 의료기관에 <예방접종 금기사유> 전산등록 요청

3.‘예방접종 금기자’

– 의료기관에서 <예방접종 금기사유> 전산등록을 요청

■ 예방접종 금기자

○ 백신 성분에 대해서 또는 이전 백신 접종 후에 심한 알레르기 반응(아나필락시스)이 발생했던 경우

○ 백일해 백신 투여 7일 이내에 다른 이유가 밝혀지지 않은 뇌증이 발생했던 경우

○ 면역결핍자 또는 면역억제제 사용자

4. 예방접종이 지연 실시 된 경우 다음의 사항을 참고하시기 바랍니다.

1) 예방접종이 지연된 다음의 경우 만 4~6세 추가 접종이 생략됩니다.

◦ DTaP 4차 접종이 지연되어 만 4세 이후 실시된 경우 DTaP 5차 접종 생략

◦ IPV 3차 접종이 지연되어 만 4세 이후 실시된 경우 IPV 4차 접종 생략

◦ 일본뇌염 불활성화 백신 3차 접종이 지연되어 만 4~9세에 실시된 경우 4차 접종 생략

2) DTaP 백신 접종력이 불완전한 만 7~10세 어린이는 Tdap 백신을 1회 접종하고 만 11~12세에 추가접종(Tdap 또는 Td)을 합니다. 정확한 접종일정은 예진의사와 상담하시기 바랍니다.

20 . . .

OOOO 학교장

초등(중등) 입학생 전산 미등록 확인 안내문

보호자님 안녕하십니까?

질병관리청 연계를 통한 신입생의 취학 전 예방접종 내역 확인 결과, 귀 댁 자녀의 예방접종기록 중 미접종 내역이 확인되어 안내드립니다. 하단 회신서 부분의 미접종(또는 전산 미등록) 항목을 확인하시어 　월　 일(금)까지 접종 및 전산등록을 진행하여 주십시오.

※ 　월　 일까지 전산등록이 완료된 경우 <예방접종증명서> 제출은 불필요합니다.
단, 질병관리청과의 연계기간이 종료된 　월　 일 이후에는 별도로 증빙서류(예방접종증명서, 아기수첩 등)을 학교로 제출해주셔야 건강기록부에 반영이 가능합니다. 질병관리청 연계기간 만료 전 예방접종 및 전산등록을 완료해주십시오.

1. 입학생 예방접종 확인 항목

구 분	내 용	구분	내 용
초등 필수접종 대상[4종]	① DTaP 5차 (디프테리아, 파상풍, 백일해 ② IPV 4차 (폴리오) ③ MMR 2차 (홍역, 유행성이하선염, 풍진) ④ JE 사백신 4차 또는 생백신 2차 (일본뇌염)	초등 권고대상 [3종]	① A형간염 2차 ② B형간염 3차 ③ 수두 1차
중학교[3종]	① Tdap(또는 Td) 6차 ② HPV 1차(여학생만 대상) ③ 일본뇌염(불활성화 백신 5차 또는 생백신 2차)		

2. 미등록(미접종) 내역 조치방법

<예방접종도우미 사이트, 인터넷 정부24, 모바일 접종도우미 앱, 예방접종을 받은 의료기관 또는 보건소에서 조회 가능>

전산 미등록 사유 예	이렇게 해주세요(조치 사항)
미접종자 (예방접종을 완료하지 않은 경우)	① 가까운 의료기관 또는 보건소에서 접종을 완료 ② 예방접종도우미 누리집(https://nip.kdca.go.kr/) 회원가입 및 자녀등록 ③ 예방접종 도우미 누리집 조회 또는 정부24에서 조회 확인
외국인 주민번호로 입력이 되지 않았을 경우	① 접종받았던 외국 의료기관의 <영문예방접종증명서> 또는 접종기관의 직인이나 공식사인 된 서류를 발급(팩스 또는 이메일 등) ② 보건소 전산등록 요청
전산 미등록자 (예방접종을 완료하였으나 전산 등록이 안 된 경우)	① 접종을 받았던 의료기관에 전산 등록을 요청 ② 폐업 등으로 의료기관에서 전산등록이 불가능한 경우 보건소에 전산등록 요청(단, 아기수첩 등 접종증명서류 지참하고 방문)
예방접종 제외 대상자(금기자)	– '예방접종 금기자'는 접종(진단) 받은 의료기관에 <예방접종 금기사유> 전산등록 요청

20 . . .

OOOO 학교장

<취학 전(후) 예방접종 미확인 예방접종내역 안내 및 회신서>

(　　)학년 (　　)반 (　　) 번 　이름: (　　)

	미확인 예방접종이름	접종여부 (O,X)	사유 및 설명 ex) 접종완료: 전산등록 요청 완료 또는 전산등록 불가로 증빙서류 학교로 제출 미접종사유: 알레르기, 면역억제제 복용 등으로 접종불가 접종계획: 순차접종 중 또는 8월 이내 접종예정
1			
2			

OOOO학교장 귀하

취학전(후) 예방접종 전산 미등록 확인 안내(예시②) – 질병관리청 연계 기간

초등(중등) 입학생 전산 미등록 확인 안내문

학년 반 번호 이름:

보호자님 안녕하십니까?

질병관리청 연계를 통한 신입생의 취학 전 예방접종 내역 확인 결과, 귀 댁 자녀의 예방접종기록 중 미접종 내역이 확인되어 안내드립니다. 하단 미접종(또는 전산 미등록) 항목을 확인하시어 월 일(금)까지 접종 및 전산등록을 진행하여 주십시오.

※ 월 일까지 전산등록이 완료된 경우 <예방접종증명서> 제출은 불필요합니다.
단, 질병관리청과의 연계기간이 종료된 월 일 이후에는 별도로 증빙서류(예방접종증명서, 아기수첩 등)을 학교로 제출해주셔야 건강기록부에 반영이 가능합니다. 질병관리청 연계기간 만료 전 예방접종 및 전산등록을 완료해주십시오.

1. 미등록(미접종) 된 예방접종 내역(초등)

예방접종 항목	DTaP (디프테리아. 파상풍.백일해)	MMR (홍역, 볼거리, 풍진)	폴리오 (소아마비)	결핵	일본뇌염	수두	B형간염
접종 완료차수	5차 접종	2차 접종	4차 접종	1회 접종	사백신4차/ 생백신2차	1차 접종	3차 접종
미확인 접종차수							

1. 미등록(미접종) 된 예방접종 내역(중등)

예방접종항목	TaP또는 Td (파상풍. 디프테리아, 백일해)	일본뇌염(사백신)	HPV (사람유두종바이러스)
접종 완료차수	6차 접종	5차 접종	1차 접종
미확인 접종차수			

2. 예방접종 전산등록 여부 확인방법

<예방접종도우미 사이트, 인터넷 정부24, 모바일 접종도우미 앱, 예방접종을 받은 의료기관 또는 보건소에서 조회 가능>

전산 미등록 사유 예	이렇게 해주세요 (조치 사항)
미접종자 (예방접종을 완료하지 않은 경우)	① 가까운 의료기관 또는 보건소에서 접종을 완료 ② 예방접종도우미 누리집(https://nip.kdca.go.kr/) 회원가입 및 자녀등록 ③ 예방접종 도우미 누리집 조회 또는 정부24에서 조회 및 확인
외국인 주민번호로 입력이 되지 않았을 경우	① 접종받았던 외국 의료기관의 <영문예방접종증명서> 또는 접종기관의 직인이나 공식사인 된 서류를 발급(팩스 또는 이메일 등) ② 보건소 전산등록 요청
전산 미등록자 (예방접종을 완료하였으나 전산 등록이 안 된 경우)	① 접종을 받았던 의료기관에 전산 등록을 요청 ② 폐업 등으로 의료기관에서 전산등록이 불가능한 경우 보건소에 전산등록 요청(단, 아기수첩 등 접종증명서류 지참하고 방문)
예방접종 제외 대상자(금기자)	– '예방접종 금기자'는 접종(진단) 받은 의료기관에 <예방접종 금기사유> 전산등록 요청

20 . . .

OOOO 학교장

› 취학 전(후) 예방접종 미접종자 접종독려 안내(예시) – 질병관리청 연계기간 종료 이후

취학 전(후) 예방접종 미접종자 안내

학년 반 번호 이름:

학부모님 안녕하십니까?

학교 생활 중 발생할 수 있는 감염병을 사전에 차단하기 위하여, 1학년 신입생 학생들 대상으로 필수예방접종 완료여부를 확인하고 있습니다. 질병관리청 연계를 통한 전산자동등록 기간이 만료됨에 따라 예방접종을 증명할 수 있는 서류를 개별적으로 제출·확인이 필요합니다. 이에 하단의 미접종항목을 확인하시고 보건소 또는 의료기관에서 해당 예방접종을 실시 후 예방접종증명서 또는 아기수첩을 담임선생님께 제출하여 주십시오.

※ 법적 근거:「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」제24조(필수 예방접종) 및 제31조(예방접종 완료 여부의 확인),「학교보건법」제10조(예방접종 완료 여부의 검사)

1. 미접종 내역(초등)

예방접종항목	DTaP (디프테리아. 파상풍.백일해)	MMR (홍역, 볼거리, 풍진)	폴리오 (소아마비)	결핵	일본뇌염	수두	B형간염
접종 완료차수	5차 접종	2차 접종	4차 접종	1회 접종	사백신4차/ 생백신2차	1차 접종	3차 접종
미확인 접종차수							

1. 미접종 내역(중등)

예방접종항목	TaP또는 Td (파상풍. 디프테리아, 백일해)	일본뇌염(사백신)	HPV (사람유두종바이러스)
접종 완료차수	6차 접종	5차 접종	1차 접종
미확인 접종차수			

2. 미접종[미등록] 조치방법

전산 미등록 사유 예	이렇게 해주세요 (조치 사항)
미접종자 (예방접종을 완료하지 않은 경우)	① 가까운 의료기관 또는 보건소에서 접종을 완료 ② 예방접종도우미 누리집(https://nip.kdca.go.kr/) 회원가입 및 자녀등록 ③ 정부24에서 조회 및 발급 후 학교 제출
외국인 주민번호로 입력이 되지 않았을 경우	① 접종받았던 외국 의료기관의 <영문예방접종증명서> 또는 접종기관의 직인이나 공식사인 된 서류를 발급(팩스 또는 이메일 등) ② 보건소 전산등록 요청 및 <예방접종증명서> 발급 후 학교 제출
전산 미등록자 (예방접종을 완료하였으나 전산 등록이 안 된 경우)	① 접종을 받았던 의료기관에 전산 등록을 요청 ② 폐업 등으로 의료기관에서 전산등록이 불가능한 경우 보건소에 전산 등록 요청 (단, 아기수첩 등 접종증명서류 지참하고 방문) ③ 보건소 또는 정부24에서 <예방접종증명서> 발급 후 학교 제출 ※ 전산등록 불가능한 경우: 아기수첩 등 첨부하여 학교 제출 → 해당 증빙서류를 근거로 하여 건강기록부에 수동입력 가능 단, 건강기록부에 입력은 가능하나 예방접종도우미사이트 등과 연계되지 않음
예방접종 제외 상자(금기자)	■'예방접종 금기자'는 접종(진단) 받은 의료기관에 <예방접종 금기사유> 전산등록을 요청 ☞ <예방접종증명서> 발급 및 학교 제출

20 . . .

OOOO 학교장

감염병 등교중지 안내문(예시)

학년 반 번 이름 : _____

안녕하십니까?

위 학생은 감염병이 의심되므로(예시: 수두) 의료기관의 진료를 받아보시기 바랍니다. 진료 후 감염병으로 확진되었다면 본인의 질병 치유와 다른 학생의 감염을 예방하기 위하여 의사가 권고한 기간 동안 등교가 중지됩니다. 등교 중지 기간까지 완치되지 않는 경우 전염력이 없다는 의사의 진단일까지 기간을 연장합니다.

감염병으로 인한 등교 중지는 출석으로 인정되며, 출결처리를 위하여 완치 후 등교할 때는 의사소견서, 진료확인서, 진단서 중에서 1부를 담임선생님께 제출하여 주시기 바랍니다.

※ 부득이할 경우 처방전도 가능하나 질병코드를 확인 할 수 있어야 합니다.

그 외에 등교 중지 기간 동안 가정 내 생활수칙을 지켜주시고 학교 외에도 학원이나 사람이 많이 모이는 곳의 외출을 자제할 것을 지도 부탁드립니다.

등교 중지 시 출석인정 근거

- 학교보건법 제8조 (등교중지)
- 교육부 훈령 제393호 학교생활기록부 작성 및 관리 지침 제8조 (출결상황)

등교 중지 기간 가정 내 생활 수칙

- 준수사항(감염병에 따라 조금씩 달라질 수 있음)
  - 가능한 환기가 잘되는 독립된 공간에서 혼자 생활하며 창문을 열어 자주 환기
- 다른 사람과 접촉을 하지 않으며 불가피한 경우 서로 마스크를 쓰고 2m이상의 거리 유지
- 식사는 혼자서 하고, 화장실과 세면대가 두 개 이상인 경우 하나를 혼자 사용
- 화장실과 세면대를 다른 사람과 같이 사용하는 경우 다른 사람이 사용하기 전에 소독
- 수건, 식기류, 휴대전화 등 생활용품은 단독으로 사용, 의복 및 침구류도 별도 사용 및 세탁
- 30초 이상 손 씻기, 기침을 할 때는 휴지로 입과 코를 막는 등 개인위생 철저
- 학원 및 다중이용시설, 사람이 많은 곳 방문 자제

20 . . .

OOO 학교장

가정 내 건강관리 기록지 - '국가위기상황 시' 출결증빙서류로 활용 가능

가정 내 건강관리 기록지(예시)

학교/반/번호	학생 성명	보호자 성명	보호자 연락처

감염병 의심증상(해당 증상에 V표시)								
증상 없음	발열	기침	호흡 곤란	오한	근육통	두통	인후통	기타

내용 / 일자	체온(℃)	호흡기 증상 유무[1]	기타 증상 (두통, 근육통 등)	병원 진료 유무	보호자 확인
3월 24일	*36.3*	*X*	*무*	*무*	*홍길동*
월 일					
월 일					
월 일					

1) 기침, 호흡곤란, 인후통

가정에서 월 일 ~ 월 일까지 자가격리 후
증상이 소실되어 학교에 정상 등교합니다.

년 월 일
보호자 성명 (인)

20 . . .

OOO 학교장 귀하

출처: 교육부(2023), 학생 감염병 예방·위기대응 매뉴얼

7~18세 청소년 예방접종 따라잡기 지침

백신	첫 번째 접종 최소연령	최소 접종 간격		
		첫 번째 접종 후 두 번째 접종	두 번째 접종 후 세번째 접종	세 번째 접종 후 네 번째 접종
B형간염[1]	해당 없음	4주	8주(첫번째 접정 후 16주 후)	
폴리오[2]	해당 없음	4주	4주	6개월
A형 간염[3]	해당 없음	6개월		
MMR[4]	해당 없음	4주		
수두[5]	해당 없음	13세 미만: 3개월 13세 이상: 4주		
일본뇌염[6]	해당 없음	불활성 백신: 7일 생백신: 12개월(마지막 접종)	불활성화 백신: 6개월	불활성화 백신: 2년
Tdap/Td[7]	7세	4주	첫 접종을 12개월 미만에 받은 경우: 4주 첫 접종을 12개월 이후에 받은 경우: 6개월	첫 접종을 12개월 미만에 받은 경우: 6개월 첫 접종을 12개월 이후에 받은 경우: 10년
사람유두종 바이러스[8]	9세	권장 접종간격	권장 접종간격	

1) B형 간염 백신: 예방접종력이 없는 소아청소년에게 3회 접종한다. 세 번재 접종의 최소연령은 24주이다.
2) 폴리오 백신: 생후 6개월까지는 폴리오바이러스에 곧 노출될 것이 예상되는 경우에만 최소 연령과 최소 접종 간격으로 접종하고 그 외에는 권장간격으로 접종한다. 마지막 접종은 이전 접종과 6개월 이상의 간격을 두고 4세 이후에 한다. 세 번째 접종을 두 번째 접종과 6개월 이상의 간격을 두고 4세 이후에 받은 경우 네 번째 접종은 하지 않는다. 단, 첫 세번의 접종을 경구용 생백신 또는 주사용 불활성화 백신 중 한 가지로만 일관되게 접종받지 않은 경우는 네 번째 접종이 필요하다.
3) A형 간염 백신: 제품에 따라 1차 접종 6~18개월 후 2차 접종한다.
4) MMR(홍역・볼거리・풍진) 백신: 2차 접종은 4~6세에 접종하지만, 필요한 경우 그 전이라도 1차와 최소 4주 이상의 간격으로 접종할 수 있다.
5) 수두백신: 수두에 면역이 없는 소아청소년이 13세 미만인 경우에는 1회 접종하며, 13세 이상의 청소년은 4~8주 간격으로 2회 접종한다. 수두 백신을 이미 1회 접종을 받은 12개월~12세 소아가 유행하는 기관에 다니는 경우 첫 접종과 3개월 이상의 간격으로 두 번째 접종을 받을 수 있다.
6) 일본뇌염 백신: 불활성화 백신의 세 번째 접종을 4~9세에 할 경우는 12세에 네 번째 접종을 하고 종료하며, 세 번째 접종을 10세 이후에 할 경우는 다음 접종 없이 종료한다. 생백신은 첫 번째 접종과 두 번째 접종의 간격은 12개월이며, 두 번째 접종으로 종료한다.
7) Tdap/Td(청소년 성인용 파상풍・디프테리아・백일해/청소년 성인용 파상풍・디프테리아)백신
: Tdap/Td의 접종 횟수는 이전의 DTap접종 횟수를 포함한다. 7세 이후에는 Tdap또는 Td로 접종하는데, 이 중 한번은 Tdap으로 하되 Tdap을 먼저 접종하고 다음 순서를 Td로 접종한다.
8) 사람유두종바이러스: 전에 HPV 백신을 접종받지 않은 13~18세 여성에게 접종한다. 1차 접종 후 1개월(서바릭스) 또는 2개월(가다실)에 2차 접종, 1차 후 6개월 3차 접종 한다. 다른 방법으로 서바릭스는 13~14세 여성에게, 가다실은 13세 여성에게 1차 접종 후 6개월에 2차 접종하여 접종을 완료할 수 있다.

출처: 대한소아과학회(2015). 예방접종지침서 제8판

2 결핵예방관리 개요

가 결핵예방관리

학교 내 결핵 조기 발견 및 확산 방지를 위한 관리 강화

- 학생 및 교직원 대상 결핵예방 교육(연1회 이상)
  - ▸ 결핵예방교육 표준교육자료: 결핵ZERO 누리집(https://tbzero.kdca.go.kr)>교육/홍보자료>교육자료
- 학생 결핵검진 사업 추진: 중 3·고 2~3학년 학생 결핵검진 사업 추진
  - 기숙사 운영학교: 입소 학생 결핵검진과 예방교육 실시 권고(2026 국가결핵관리지침-기숙사 입소자 등 참고)
  - 보건소 지원 여부 확인 후 보건소 통한 무료 결핵검진을 받을 수 있도록 입소 전 학생 및 보호자에게 안내

◈ 2026 국가결핵관리지침 내 기숙사 입소 학생 결핵 검진사업 주요 내용

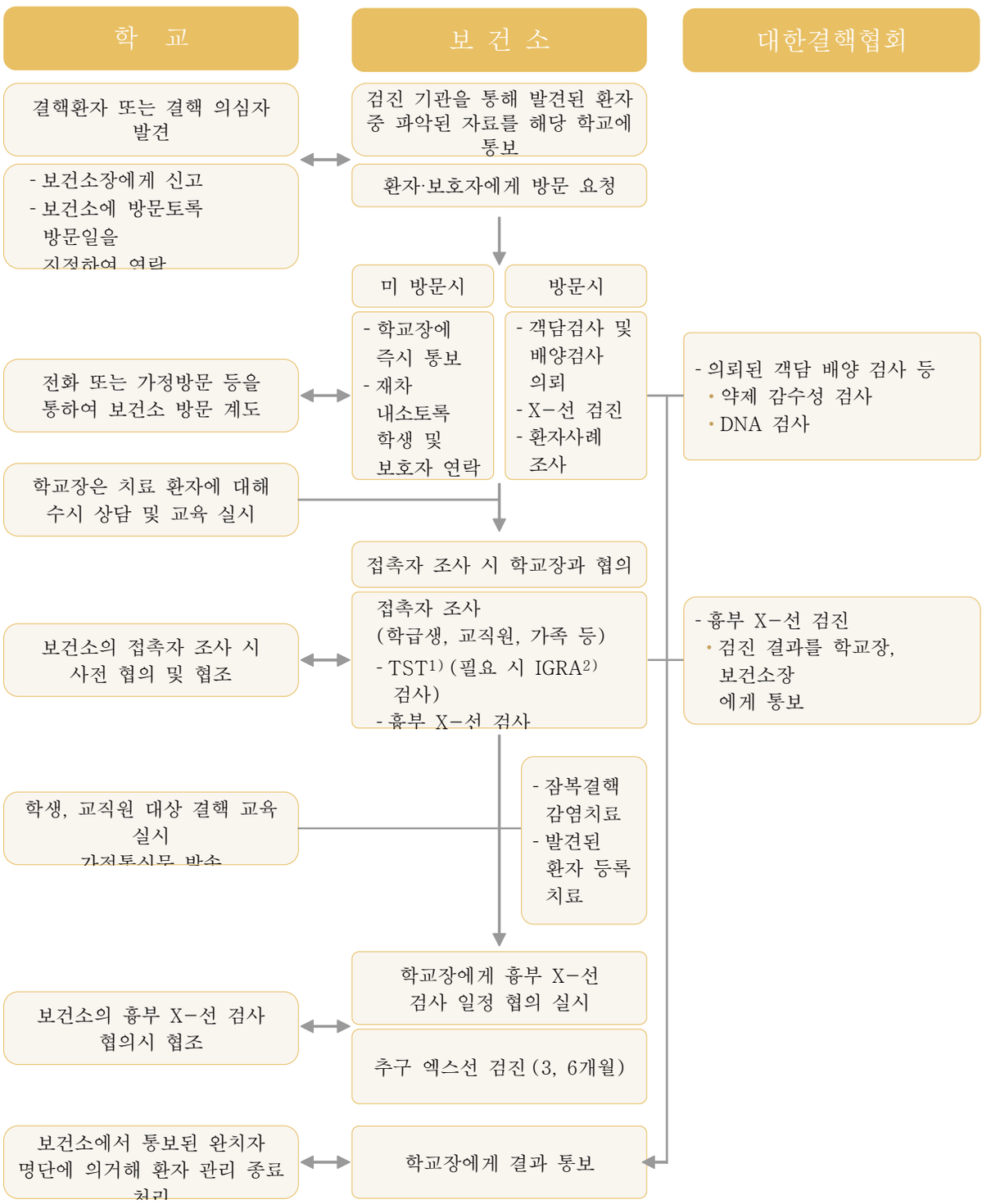
- ▸ 학교 기숙사 입소 학생(입소 예정 포함)은 입소 시 결핵 검진을 받도록 권고, 기숙사 입소 시 결핵검진을 받지 않은 경우 입소 중(빠른 시일 내)에 받도록 권고함
- ▸ 학생 건강검진 등을 통해 결핵 검진(흉부 X선 검사)을 실시한 경우 중복해서 검사할 필요 없음

- 학교 교직원 결핵 검진 및 잠복결핵 감염검진 관리

검진 시기	• 결핵검진: 매년 1회 ※ 신규교직원: 신규 채용을 한 날부터 1개월 이내 실시 ① 휴직, 파견 등의 사유로 6개월 이상 업무에 종사하지 아니하다가 다시 그 업무에 종사하게 된 경우 포함 ② 신규채용 6개월 이전에 기관·학교 등은 자체 채용건강검진이나 개인적인 결핵 검진을 받은 기록이 있다면 갈음 가능. ③ 다른 법령에 따라 건강진단을 받은 경우에는 이 법에 따른 결핵검진 등을 받은 것으로 갈음할 수 있음.(예. 채용전 신체검사, 건강검진, 보건증 등) ※ 단, 2가지 조건이 충족되어야 함. ① 6개월 이내 ② 검사시행일이 2026년 1월 1일 이후 • 잠복결핵감염검진: 기관, 학교 등에 소속된 재직 기간 중 1회 실시 – 신규 채용자: 채용일로부터 1개월 이내 – 기존 교직원: 2023. 6. 30.까지 검사 완료된 상태여야 함 ※ 결핵예방법 제11조제1항 제1호부터 제6호까지의 기관, 학교 등에 소속된 기관 (다른 기관, 학교 등으로 그 소속을 변경하여 근무한 기간을 포함한다) 중 1회
검진 대상	• 학교 교직원 및 종사자(공무원, 교육공무직, 기간제 교사 등) ※ 학교 교직원 및 종사자 직렬, 직종, 근로형태, 고용주체 등에 관계없이 법령에서 규정하고 있는 기관, 학교의 종사자 교직원은 모두 실시(단, 일회성 강사 등 업무 지속성이 없는 경우는 제외 가능)
검사 실시 방법	• 결핵검진 – 임상적, 방사선학적 또는 조직학적 검사 / 객담의 결핵균 검사 – 결핵감염의 위험정도를 고려하여 보건복지부장관이 정하여 고시하는 검사 • 잠복결핵감염검진: 면역학적 검사(IGRA(인터페론감마분비검사))
세부 사항	• 매년 결핵 및 잠복결핵감염 검진 대상 인원, 지역사회 결핵 및 잠복결핵감염 검진 의료기관을 파악하여 학교 교직원 검진 실시 • 교직원 결핵 및 잠복결핵감염 검진 실시 내용 등을 포함한 결핵감염 예방 및 관리 기준에 관한 사항을 작성, 비치 ※ 결핵감염 예방 및 관리 기준에 관한 세부사항은 결핵예방법 제4조의2 제1항 참조 • 교직원 또는 종사자에 대하여 결핵감염 예방 및 관리에 관한 교육 실시
예산 집행	• 학교 예산범위 내 운영비에서 편성・집행 가능함 : 학교장이 학교실정과 지역의 여건을 고려하여 예산편성 및 검진시기, 검진기관 결정 등의 계획을 수립하고 시행

나 학교 결핵환자 발생 시 대처

<학교 결핵 관리 체계>



1) TST(Tuberculin Skin Test, 결핵 피부 반응검사)
결핵의 감염 여부를 판단하는 검사로, 피부 바로 밑(주로 왼팔의 팔뚝 부분)에 작은 주사를 한 후 48~72시간 후에 부풀어 오르는 반응이 생겼는지 확인한다. 결핵균에 감염되었거나 BCG 백신 접종자에게 양성 반응이 나타날 수 있으며, 부풀어 오른 자리는 시간이 지나면 가라앉는다.

7) IGRA(Interferon-gamma release assay, 인터페론 감마 분비 검사)
결핵균에 감작된 T-세포만을 자극하는 특이항원을 사용하고 백혈구에서 유리되는 인터페론 감마 농도를 측정하여 결핵 감염 여부를 판단한다. 결핵균 특이항원을 사용하기 때문에 반응 특이도가 높다.

학교 내 결핵 환자(의심자) 발생 및 발견 통보

〔학교 ⇒ 보건소통보 서식〕

학교 내 결핵 환자(의심자) 발생 및 발견 통보

수신 : ○○ 보건소장
발신 : ○○ 학교장

보고 일시 _____ 보고자 _____

이름	학년/반	연락처	보호자 연락처	발견 근거	환자 구분	
					결핵	의사결핵

〔학교 비치용〕

결핵 환자 명부(학생, 교직원)

이름	성별	학년/반	연락처	주 소	발견 근거	발견 일자 (년, 월, 일)	보건소 등록 등 치료내역	완치여부	비 고

* 발견 근거: 학교 정기검진, 학교 별도검사, 개별검사 등으로 구분 기록
* 보건소 등록 등 치료내역: 보건소 등록 여부, 치료 과정 등을 간략히 누가 기록

〔보건소 ⇒ 학교통보 서식〕

학교 결핵환자 발견 및 치료내역(학생, 교직원)

수신 : ○○ 보건소장
발신 : ○○ 학교장

이름	성별	학년/반	연락처	발견 근거	발견 일자 (년, 월, 일)	도말 결과	보건소 등록 등 치료내역	치료결과	비 고

* 치료 결과는 치료 종결 시 송부

V

학교 내 응급상황 관리 및 건강취약학생 관리체계 강화

Ⅴ 학교 내 응급상황 관리 및 건강취약학생 관리체계 ※참고서식 클릭 시 해당 쪽으로 이동함

단위업무	주요내용	참고·서식자료
계획	1. 응급상황 관리체계 구축 및 계획 수립 ▪ 응급상황 관리 물품, 교구 등 현황 파악 ▪ 응급상황 관리 예산 파악 ▪ 전년도 응급환자 이송 및 진료 기록지 확인 ▪ 응급상황 대응 조직: 총괄책임자, 응급처치반 등 교직원 업무 분담 ▪ 보건(담당)교사 부재 시 업무를 담당할 업무대행자 지정	• 2026 학교 내 응급상황 및 건강취약학생 관리체계 강화 (p.163) • 학교 응급상황 대응 가이드라인(2025, 교육부)
	2. 응급처치 교육 교육계획 수립 ▪ 모든 학생을 대상으로 최소 2시간 이상 응급처치 교육 실시(심폐소생술 실습 교육 포함) ▪ 해당 교직원을 대상으로 이론·실습 교육 실시 ▪ 2026년 3월 31일까지 교육 계획 수립	
	3. 제1형 당뇨병 학생 지원 계획 수립 ▪ 건강검사(건강조사) 시 제1형 당뇨 학생 현황 파악 ▪ 제1형 당뇨 학생 재학교는 학교 내 지원조직(예시 건강증진부) 구성 ▪ 당뇨병 학생 건강관리 지원 요청 여부 확인 – 학생 및 학부모가 의료진과 함께 '건강관리 지원 요청서' 작성하여 제출 – '당뇨병 학생 건강관리 지원 요청서' 작성 시 보호자가 원할 경우 당뇨병 관리물품 제출 ▪ 문서를 공식화(학교장 결재)하고 관리조직 등 학교구성원과 학부모에게 공유	• 당뇨병 학생 지원 가이드라인(2025, 교육부)
운영	1. 응급처치 및 건강상담 ▪ 응급사고로 이송한 모든 사안은 기록으로 작성 보관 ▪ 담임교사는 학교안전공제회 보상 신청에 대해 학부모에게 정보 제공 ▪ 환자 이송 시 동행 교직원은 학교에 귀교 직후 출장처리 가능 ▪ 학생 복귀 기간이 필요한 경우 담임교사는 치료 경과에 대해 관리자 및 보건교사에게 정보 제공	• 응급상황 점검표 (p.174) • 응급환자 건강사정 및 응급처치(p.175) • 응급환자 이송 및 사고 기록지 (p.188) • 응급구급함 구성 물품 (예시) (p.190)
	2. 심폐소생술 등 응급처치교육 ▪ 모든 학생을 대상으로 최소 2시간 이상 응급처치 교육 실시(심폐소생술 실습 교육 포함) ▪ 해당 교직원을 대상으로 이론·실습 교육 실시 – 실습 2시간을 포함하여 최소 3시간 이상 실시 가능	• 학생건강정보센터(교육부) (www.schoolhealth.kr)
	3. 제1형 당뇨 학생 현황 파악 ▪ 학기 중 발생한 학생에 대해서는 건강상담을 통해 학교 자체 현황 파악 및 관리	
	4. 제1형 당뇨 학생 재학교 관리조직(예시: 건강증진부) 구성·운영 ▪ 기 보급된 「당뇨학생 지원 가이드라인」에 따라 학교장이 담임교사, 보건·영양·체육교사·사회복지사·상담교사 등으로 하여금 필요한 지원방안 마련·시행토록 조치	• 당뇨병 학생 지원 가이드 라인(2025, 교육부) • 학생건강정보센터(교육부) (www.schoolhealth.kr) • 충남교육청개발교육자료 (당뇨아나필락시스 이해와 대처) – 충남교육청 부서별누리집 – 학교보건자료실
	5. 제1형 당뇨병 학생 개별지원계획 교직원 대상 교육	
	6. 제1형 당뇨 학생 개별 건강상담 실시 ▪ 학생 및 보호자와 주기적으로 소통하여 학생 건강관리능력 향상 ▪ 제1형 당뇨 학생 개별 건강상담 및 보건교육 실시	
평가	1. 평가 및 차기년도 계획에 반영	
	2. 보고 ▪ 학교 심폐소생술 교육 실시 현황 보고 ▪ 당뇨 등 학생 재학 및 지원현황 보고	[서식10] 학교 심폐소생술 실시 현황 [서식9] 당뇨 등 학생 재학 지원 현황

1 2026 학교 내 응급상황 및 건강취약학생 관리체계 강화

가 목 적

- 「학교응급상황 대응 가이드라인」을 각급학교에 안내하여 모든 학교에서 응급상황 관리체계를 구축하고 응급상황 시 신속하게 대응할 수 있도록 조치
- 제1형 당뇨병 등 질병이나 장애로 인하여 특별한 보호·관리가 필요한 학생에 대한 지원체계 구축 및 응급상황 대응을 위한 심폐소생술 등 교육 철저

나 관련근거

- 학교보건법 제9조의2(보건교육 등)
- 학교보건법 제15의2(응급처치 등)
- 응급의료에 관한 법률 시행규칙 제2조(응급환자)
- 응급의료에 관한 법률 시행규칙 제38조의2(응급장비 설치 등에 관한 현황 파악)
- 응급의료에 관한 법률 시행규칙 제38조의3(응급장비의 관리)
- 2025년 학교 응급상황 대응 가이드라인(교육부)
- 2025년 당뇨병 학생 지원 가이드라인(교육부)
- 2026년 학생건강증진 분야 주요업무 추진방향(교육부)

다 현 황

- 충남 당뇨 학생 현황
  - 당뇨 학생 수, 재학교 2021년 이후 매년 증가
  - 당뇨 보호책 수립 필요성 대두
  - 학생-가정-학교 연계하여 학생을 실질적으로 보호하기 위한 지원체계 마련

연도	재학교(교)	학생 수(명)
2025	191	314
2024	197	316
2023	183	271
2022	166	229
2021	136	182



라 주요업무

1. 학생 및 교직원 심폐소생술 등 응급처치 교육 실시
   - 학교장은 모든 학생을 대상으로 매년 최소 2시간 이상 응급처치 교육을 실시하며, 반드시 최소 1개 학년 이상의 모든 학생을 대상으로 실습을 포함한 심폐소생술 교육 실시

     ※ 구체적인 학생 대상 심폐소생술 등 응급처치 교육은 「학교안전사고 예방에 관한 법률」 등 관련 법령 및 교육부 내 안전사고 관련 업무담당 부서 지침에 따라 시행

• 학교장은 모든 교직원을 대상으로 연간 최소 4시간* 심폐소생술 교육을 실시할 수 있도록 3월 31일까지 대상·내용·방법 등을 포함하여 해당 학년도의 응급처치 교육계획 수립

* 교육 여건 등 고려하여 실습교육 2시간 포함 최소 3시간 이상 실시 가능

※「학교보건법」 제9조의2제2항, 같은 법 시행규칙 제10조 및 별표 9

– 해당 학년도에 다른 법령*에 따라 심폐소생술 등 응급처치 관련 내용이 포함된 교육을 받았거나, 응급처치 교육 관련 법령에서 정한 교육 기준을 충족하는 외부 기관의 심폐소생술 등 응급처치 교육·연수를 받은 경우 생략(대체) 가능

*「응급의료법」, 「119법」, 「어린이안전법」 등

<교직원 중 교육대상자 선정 권고안>

1. 모든 교원(기간제 교사 포함)
2. 학교운동부 지도자, 스포츠강사 등 학교 스포츠 활동과 관련된 사람
3. 교육감 소속의 일반직 공무원

※ 그 밖의 교직원(시간강사 등 단기 상주 지원 포함)에 대한 교육실시 여부는 학교장이 해당 교직원의 학생 교육 참여 정도를 고려하여 교육대상 선정

※ 건강상의 문제로 실습을 수행하기에 어려움이 있는 교직원에 대해서는 별도의 계획에 따라 교육을 실시하는 방안 고려

› 응급처치교육의 내용·시간 및 강사

내용		시간	강사
이론 교육	1) 응급상황 대처요령 2) 심폐소생술 등 응급처치 시 주의사항 3) 응급의료 관련 법령	2시간	① 의사(응급의학과 전문의를 우선 고려해야 한다.) ② 간호사(심폐소생술 등 응급처치와 관련된 자격을 가진 사람으로 한정한다.) ③「응급의료에 관한 법률」 제36조에 따른 응급구조사 자격을 가진 사람으로서 응급의료 또는 구조·구급관련 분야(응급처치교육 강사 경력을 포함한다.)에서 5년 이상 종사하고 있는 사람
실습 교육	심폐소생술 등 응급처치	2시간	

• 원활한 학교 심폐소생술 교육을 위해 보건교사 대상 연수 실시

– 보건교사 대상의 전문적인 심폐소생술 교육을 통한 응급처치 역량강화

– BLS / KBLS Provider 교육 유효기간 2년으로 2025년, 2026년 이수자 제외

– 대한심폐소생술협회 홈페이지를 통해 개인별로 교육 신청 및 교육비 납부, 이수후 교육비 지급

2. 제1형 당뇨 학생에 대한 지원 및 관리체계 강화

1) 학생 당뇨·아나필락시스 보호대책 수립

• 학생건강검사(건강조사)를 실시할 때, 제1형 당뇨 학생 재학 여부를 조사하고 관리

※ 학생 또는 학부모(보호자)의 동의를 받아 관련 정보를 수집하여 학생 지원을 위한 기초자료로 활용

※ 당뇨・아나필락시스 학생 재학 및 지원현황 제출 [서식9]

• 당뇨·아나필락시스 학생 재학교 지원조직(예시: 건강증진부) 구성 및 운영

– 기 보급된 「당뇨병학생 지원 가이드라인」에 따라 학교장이 담임교사, 보건(담당, 업무 보조교사)·영양·체육교사·사회복지사/상담교사 등으로 하여금 필요한 지원방안 마련·시행

• 건강취약 학생(당뇨·아나필락시스) 개별지원 계획 수립

– 당뇨・아나필락시스 의료관리 조사(건강관리 지원 요청서 서식 활용) 실시

› 학생 및 학부모가 의료진과 함께 작성하여 제출

› 당뇨병 의료관리 조사 시 보호자가 원할 경우 당뇨병 관리물품 제출

– 건강취약 학생(당뇨・아나필락시스) 개별지원계획 작성 및 확정

・1형 당뇨 학생 지원

– 혈당관리기기(인슐린 자동 주입기, 연속혈당측정기 등) 구입 등 의료비 지원

– 초등학교 저학년(1~3학년) 1형 당뇨 학생 재학교에 보건교사 추가 배치로 건강관리에 공백이 없도록 지원(시간제 기간제) ※ 세부계획은 별도 안내

・학생 건강관리방법에 대한 교직원 및 학부모 대상 교육

2) 당뇨·아나필락시스 학생 개별 건강상담 실시

・학생 및 보호자와 주기적으로 소통하여 당뇨・아나필락시스 관리 어려움 파악

・당뇨・아나필락시스 학생 개별 건강상담 및 보건교육 실시

3) 당뇨·아나필락시스 학생 재학교 업무담당자 전문성 제고

・당뇨・아나필락시스 학생 재학교 대상 업무담당자 역량강화 연수

・혈당관리가 어려운 학생이 소속되어 있는 학교 대상 비대면 컨설팅 실시

・보건교사 미배치교 대상 요청 컨설팅 실시

4) 당뇨 학생, 학부모, 교직원이 함께하는 프로그램 운영

・당뇨 학생 학부모와 함께하는 당-당(당뇨+당당한 삶)한 캠프 운영

・당뇨에 대한 편견 해소 및 인식개선을 위한 학생, 학부모, 교직원 원탁토론

・당뇨 바로알기 교육, 캠페인 등 학교별 여건을 반영한 자율 프로그램 운영

3. 희귀난치질환 학생 지원

• 「초중등교육법 시행령」 제69조2항 및 제87조제2항에 따라 희귀질환 학생, 암, 1형 당뇨, 중증 난치질환 학생은 해당 학교군 내의 중학교 또는 고등학교 중 하나를 지정하여 입학 지원 가능

• 희귀질환목록은 '희귀질환헬프라인'에 매년 11월 말 업데이트된 질환목록 확인

• 중증난치질환은 보건복지부 고시 '본인일부부담금 산정특례에 관한 기준' 별표4의2 확인

• 2026년 난치병 학생 성금 지원: 추후 세부계획 별도 안내

[교직원을 위한 소아청소년 다빈도 희귀질환 안내서 목록]

구분	희귀질환 명	비고
유전의학	21삼염색체증 NOS(다운증후군)	
	핵형 45,X	
소화기영양	소장 및 대장 모두의 크론병	
	윌슨병	
신경계	상세불명 이분척추	
	신경섬유종증(비악성)	
	발작수면 및 허탈발작	
	척수공동증 및 연수공동증	
	자가면역 뇌염	
	모야모야병	
심혈관계	팔로네징후	
	관상동맥혈관의 기형	
혈액종양	특발성 무형성빈혈	
	저형성 빈혈 NOS	
면역계	연소성 류마티스 관절염	
이비인후과	소이증	

* 교직원을 위한 소아청소년 다빈도 희귀질환 안내서('25) 활용, 학생건강정보센터 탑재

마 행정사항

- 학생 심폐소생술 교육 만족도 조사 실시
  - 조사내용: 중·고등학교 표본학교 심폐소생술 교육 만족도 조사
  - 조사기간: 12월 중

바 기대효과

- 심폐소생술(CPR) 및 기본 응급처치 방법을 체계적으로 습득함으로써 위급 상황 발생 시 즉각적인 대응 가능
- 당뇨·아나필락시스 학생 건강관리 체계화를 통한 건강장애 학생의 건강하고 행복한 학교생활 도모
- 학생·가정(학부모)·학교가 공동으로 학생 건강을 위해 협력함으로써 학생 중심 건강관리 협력 체계 구축
- 희귀질환·암·1형 당뇨·중증 난치질환 학생의 건강 상태를 고려한 학습권 보장

가 학교 응급상황 대비 준비

응급의료, 응급처치, 응급환자 개념

1. 응급의료: 응급환자가 발생한 때부터 생명의 위험에서 회복되거나 심신상의 중대한 위해가 제거되기까지의 과정에서 응급환자를 위하여 하는 상담·구조·이송·응급처치 및 진료 등의 조치
2. 응급처치: 응급의료행위의 하나로서 응급환자의 기도를 확보하고 심장박동의 회복, 그밖에 생명의 위험이나 증상의 현저한 악화를 방지하기 위하여 긴급히 필요로 하는 처치
3. 응급환자: 질병, 분만, 각종 사고 및 재해로 인한 부상이나 그 밖의 위급한 상태로 인하여 즉시 필요한 응급처치를 받지 아니하면 생명을 보존할 수 없거나 심신에 중대한 위해가 발생할 가능성이 있는 환자 또는 이에 준하는 사람으로서 보건복지부령으로 정하는 사람

출처: 응급의료에 관한 법률 제1장 제2조 정의

4. 응급환자 및 응급상황 판단 기준

「응급의료에 관한 법률 시행규칙」 별표1, 응급증상 및 이에 준하는 증상 제2조 제1호

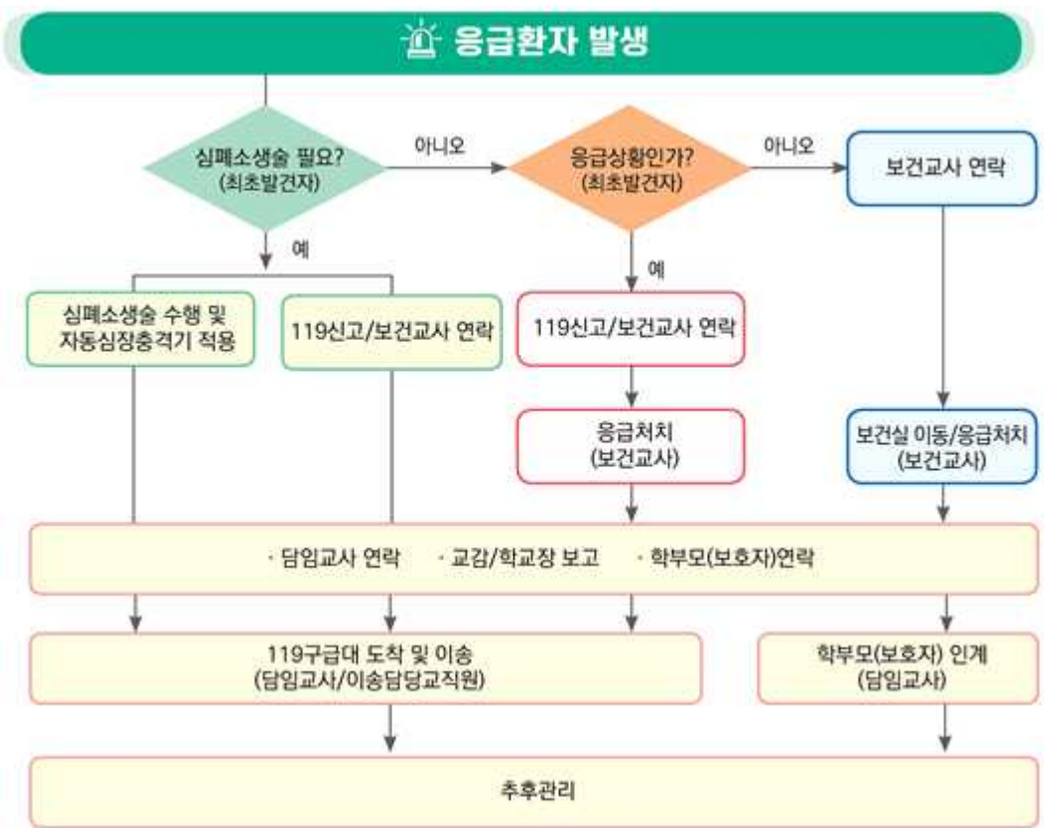
구분	응급증상	응급에 준하는 증상
신경학적 응급증상	급성의식장애, 급성신경학적 이상, 구토·의식장애 등의 증상이 있는 두부 손상	의식장애, 현훈
심혈관계 응급증상	심폐소생술이 필요한 증상, 급성호흡곤란, 심장질환으로 인한 급성 흉통, 심계항진, 박동이상 및 쇼크	호흡곤란, 과호흡
외과적 응급증상	• 개복술을 요하는 급성복증 (급성복막염·장폐색증·급성췌장염 등 중한 경우에 한함) • 광범위한 화상(외부 신체 표면적의 18% 이상), 관통상 • 개방성·다발성 골절, 또는 대퇴부 척추의 골절 • 사지를 절단할 우려가 있는 혈관 손상 • 전신 마취하에 응급수술을 요하는 증상, 다발성 외상	화상, 급성 복증을 포함한 배의 전반적인 이상증상, 골절·외상 또는 탈골, 그 밖에 응급수술을 요하는 증상, 배뇨장애
중독 및 대사장애	심한 탈수, 약물·알코올 또는 기타 물질의 과다복용이나 중독성 대사장애 (간부전·신부전·당뇨병 등)	–
출혈	계속되는 각혈, 지혈이 안 되는 출혈, 급성 위장관 출혈	혈관손상
안과적 응급증상	화학물질에 의한 눈의 손상, 급성 시력 손실	–
알러지	얼굴 부종을 동반한 알러지 반응	–
소아과적 응급증상	소아경련성 장애	소아 경련, 38℃ 이상인 소아 고열(의료서비스 제공이 어려운 때, 8세 이하)
정신과적 응급증상	자신 또는 다른 사람을 해할 우려가 있는 정신장애	–
산부인과적 응급증상	–	분만 또는 성폭력으로 검사 또는 처치가 필요한 증상
이물에 의한 응급증상	–	귀·눈·코·항문 등에 이물이 들어가 제거술 필요

학교 내 응급상황 관리체계 구축

- 학교 내 응급환자 발생 시 학생 및 교직원의 건강과 안전을 확보하며 신속하게 대처할 수 있도록 응급처치, 이송, 행정지원, 교육 등 필요한 사항을 정하고 운영하는 체계
- 매 학년 초 학교 교직원 및 인근 의료기관 현황 등을 고려하여 학교 운영 계획에 학교 응급상황 대응계획 반영
- 학교장은 업무분장 시 보건교사의 출장 등으로 인한 부재 시에 대비해 업무대행자를 지정하여 보건교사가 없는 상황에서도 응급상황에 대처할 수 있도록 준비

<학교 응급상황 대응계획 수립 시 필수 포함내용>

대응 조직도, 대응반별 역할, 담당자 부재 시 대리업무 지정자, 인근 병원 연락처, 건강 측면에서 관심이 필요한 학생 현황(알레르기 질환, 1형 당뇨병, 면역저하자 등) 등의 내용을 반드시 포함하여 상황 발생 시 신속하고 정확하게 조치할 수 있도록 준비



[그림 1-1] 학교 내 응급상황 관리체계

- 학교 내 응급환자 발생 시, 최초발견자는 즉시 환자의 상태를 확인하여 심폐소생술의 필요 여부를 판단함
- 심폐소생술이 필요한 경우, 최초발견자 또는 환자 주변에 있는 교직원은 심폐소생술을 시행하고 자동심장충격기(AED)를 사용하여 대응함. 동시에 119에 신고하고 보건교사에게 연락하여 추가적인 지원을 요청함
- 심폐소생술이 필요하지 않은 경우, 최초발견자는 응급상황 여부를 판단함. 응급상황으로 판단될 경우, 119 신고 및 보건교사에게 연락하며, 보건교사가 응급처치를 시행할 수 있도록 함
- 응급상황이 아닌 상황이라면 보건교사에게 연락 후 환자를 보건실로 이동시켜 응급처치를 받도록 함

  초기 대응이 끝난 후에는 담임교사에게 상황을 알리고, 교감 또는 학교장에게 보고하며, 학부모(보호자)에게 연락을 취함
- 119 구급대가 도착하면 담임교사 또는 이송 담당 교직원이 동행하여 환자를 병원으로 이송함.

만약 응급처치만 으로 상황이 종료될 경우 담임교사는 학부모(보호자)에게 발생상황을 설명하고 학생을 인계함

- 모든 절차가 마무리된 이후에는 응급상황에 대한 추후 관리를 진행함

응급상황 대응 조직 구성

– 학교 내 응급상황에 대응하는 조직은 [그림 1-2]와 같이 총괄책임자, 대책반장, 응급처치반, 환자 이송반, 행정지원반 등 학교 실정에 맞게 구성함



[그림 1-2] 학교 내 응급상황 대응 조직도

* 학교 응급상황 대응 가이드라인(2025, 교육부)

학교 내 응급상황 대응반별 주요업무

– 응급환자 발생에 대비하여 모든 교직원은 학교 내 응급상황 관리체계에 따른 명확한 역할 분담과 대응체계, 119 신고 방법, 지역 내 소방서 및 의료기관 연락처, 학교 비상 연락망 등 숙지 필요함

– 보건교사 출장 등 부재 시 대비하여 지명된 보건 업무 대행자는 응급상황 발생 시 대처요령을 사전에 숙지 필요함

– 보건교사는 보건수업 등 부재 시 보건실 문 앞에 시간표나 행선지, 연락처를 게시해 응급상황 시 연락을 용이하게 할 수 있도록 준비해야 함

– 불가피하게 학교 자체 이송담당 교직원이 직접 환자를 의료기관으로 이송해야 하는 상황에 대비하여, 환자 이송 차량을 미리 지정하고 차량 앞에 “의료기관 환자 이송 차량”임을 알 수 있도록 표시(해당 차량은 승용차 요일제 대상에서 제외하는 등 학교 상황에 맞게 운영해야 함) 해야 함

– 응급상황 관리체계의 분야별 교직원의 세부 업무는 <표 1-4>와 같이 나눌 수 있으며, 각 학교는 해당 학교의 인력 현황 및 여건을 고려하여 운영해야 함

<표 1-4> 응급상황 대응반별 주요업무

구분	담당자	업무
총괄책임자	학교장	• 응급상황 전반에 대한 총괄 책임 • 응급상황 관리체계 가동
대책반장	교감	• 필요한 행정적 지원 및 조치 등 실질적인 지휘·감독 • 교장에게 응급상황 보고 • 보건교사의 응급상황 대응에 따른 보건실 업무 대체 교사 배치 • 담임교사의 의료기관 이송에 따른 학급·수업 관리 대체 교사 배치 • 이송 교직원의 출장 처리, 경비 지원 등 필요한 행정업무 지시
응급처치반	보건교사	• 심장정지/응급상황 판단 및 119 신고 • 표준심폐소생술, 자동심장충격기 적용 등 상황별 응급처치 수행 • 담임교사에게 연락 • 119 도착 시 구급대원에게 응급처치 및 상황 인계 • 교감에게 응급환자 발생상황 및 처치 결과 보고 • 기록(응급환자 기록지/보건일지, 응급환자 이송 및 사고 기록지 등)
	최초발견자 및 인근 교직원 (2인 이상)	• 심장정지/응급상황 판단 및 119 신고 • 보건교사에게 연락 • 최초 발견자는 환자 인근 교직원에게 도움 요청 • 심장정지 시 가슴 압박소생술 수행 및 자동심장충격기 적용 • 보건교사의 심폐소생술 등 응급처치 지원 요청 시 협조 • 현장의 안전성 확인 및 관리
환자이송반	담임교사	• 학부모(보호자)에게 연락 • 교감에게 학생 응급상황 보고 • 의료기관 이송 시 학생과 동행, 학생 보호.관찰 및 학부모(보호자) 인계
	이송담당 교직원	• 의료기관 이송 동행, 직접 차량 운전(119 이송이 불가한 경우) • 담임교사 부재 시 학생 보호.관찰 및 학부모(보호자) 인계
행정지원반	행정실장	• 학교 내 응급환자 발생에 따른 제반 행정지원 업무 총괄
	행정담당 직원	• 이송 시 동행한 교직원의 출장 처리와 경비 지원 등 행정조치 • 필요 시 공제회 신고 및 공제급여 치료비 청구 등 처리

응급사고 발생 시 대처요령

1) 3C 응급처치

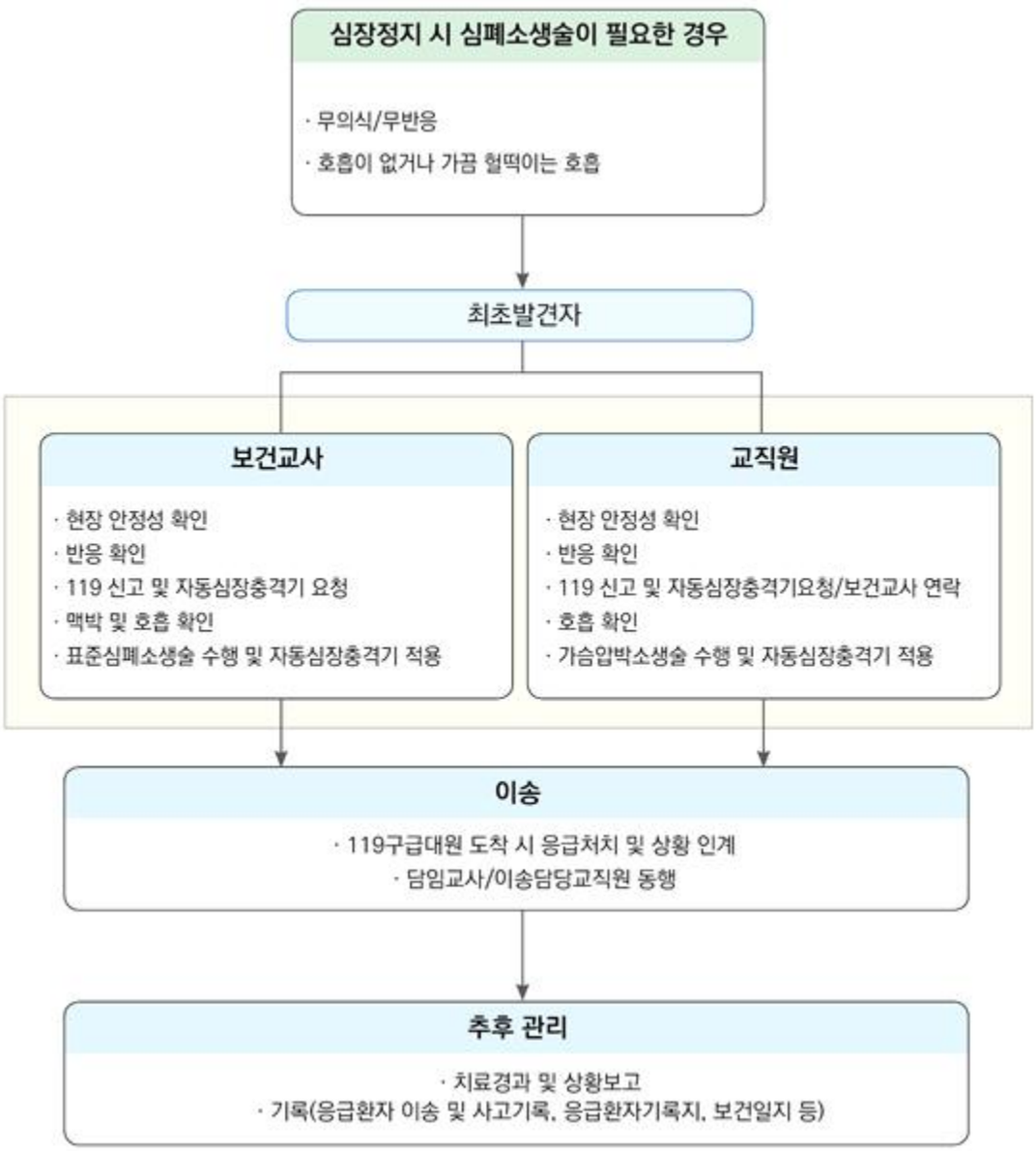
- 응급환자 발생 시 Check(상황판단) – Call(도움요청) – Care (응급처치)의 3C를 기억하면 더욱 신속하고 적절한 대처 용이
- 학교 내 심장정지 및 응급상황 발생 시 교직원의 대처요령 <표 1-5> 참고

<표 1-5> 심장정지 및 응급상황 발생 시 대처요령

담당자		구분	대처요령
최초 발견자	보건교사 외	Check	• 심장정지 및 응급상황 여부 판단 • 현장 안전 및 주변 응급처치 자원 판단
		Call	• 심장정지 및 응급상황 시 119 신고 및 도움 요청 • 보건교사 연락
		Care	• 심장정지 시 심폐소생술 수행 및 자동심장충격기 적용 • 환자 인근 교직원에게 도움 요청 • 보건교사의 현장 도착 시까지 현장 관리 • 보건교사에게 초기 응급상황 설명 • 보건교사의 지시 요청에 따라 응급처치 참여 및 현장 지원
	보건교사 (보건업무 담당교사)	Check	• 심장정지 및 응급상황 등 환자의 상태 평가 • 현장 안전 및 주변 응급처치 자원 판단 • 활력징후(체온, 맥박 호흡, 혈압) 측정 및 환자 상태 판단 (판단이 어려운 경우 119에 도움 요청)
		Call	• 심장정지 및 응급상황 시 119 신고 및 도움 요청 • 담임교사 연락
		Care	• 심장정지 시 표준심폐소생술 수행 및 자동심장충격기 적용 • 현장 안전 관리 • 응급환자 발생에 따른 필요한 상황에 맞는 초기 응급처치 수행 • 필요 시 심폐소생술 등 응급처치를 위한 교직원 지원 요청 및 협력 • 119구급대원 도착 시 응급처치 및 상황 인계 • 이송 중 응급처치 필요 시 보건교사 동행(학교 자체 차량일 경우) • 보고 및 기록
담임교사		Call	• 교감 연락 및 보고 • 학부모(보호자) 연락
		Care	• 의료기관 이송 시 동행 • 학부모(보호자) 인계까지 학생 보호.관찰
교감		Call	• 학교장 연락 및 보고
		Care	• 심폐소생술 등 응급처치 수행을 위해 응급처치반에 교직원 추가 배치 • 보건교사, 담임교사, 이송교직원 등 업무 공백 시 대체 교사의 배정 조치 • 행정지원반에 관련 행정업무 지원 요청
학교장		Call	• 학교 응급상황 관리체계 가동
		Care	• 응급상황 전반에 대한 총괄 책임
교직원		Care	• 보건교사의 지시 요청에 따라 응급처치 참여 및 현장 지원
이송담당교직원		Care	• 의료기관 이송 시 동행, 직접 차량 이송(119 이송이 불가한 경우) • 담임교사 부재 시 학부모(보호자) 인계까지 학생 보호・관찰
행정담당직원		Care	• 이송 시 동행한 교직원의 출장 처리와 경비 지원 등 행정조치 • 필요 시 공제회 신고 및 공제급여 치료비 청구 등 처리
행정실장		Care	• 학교 내 응급환자 발생에 따른 제반 행정지원 업무 총괄

2) 심장정지 발생 시 대처요령

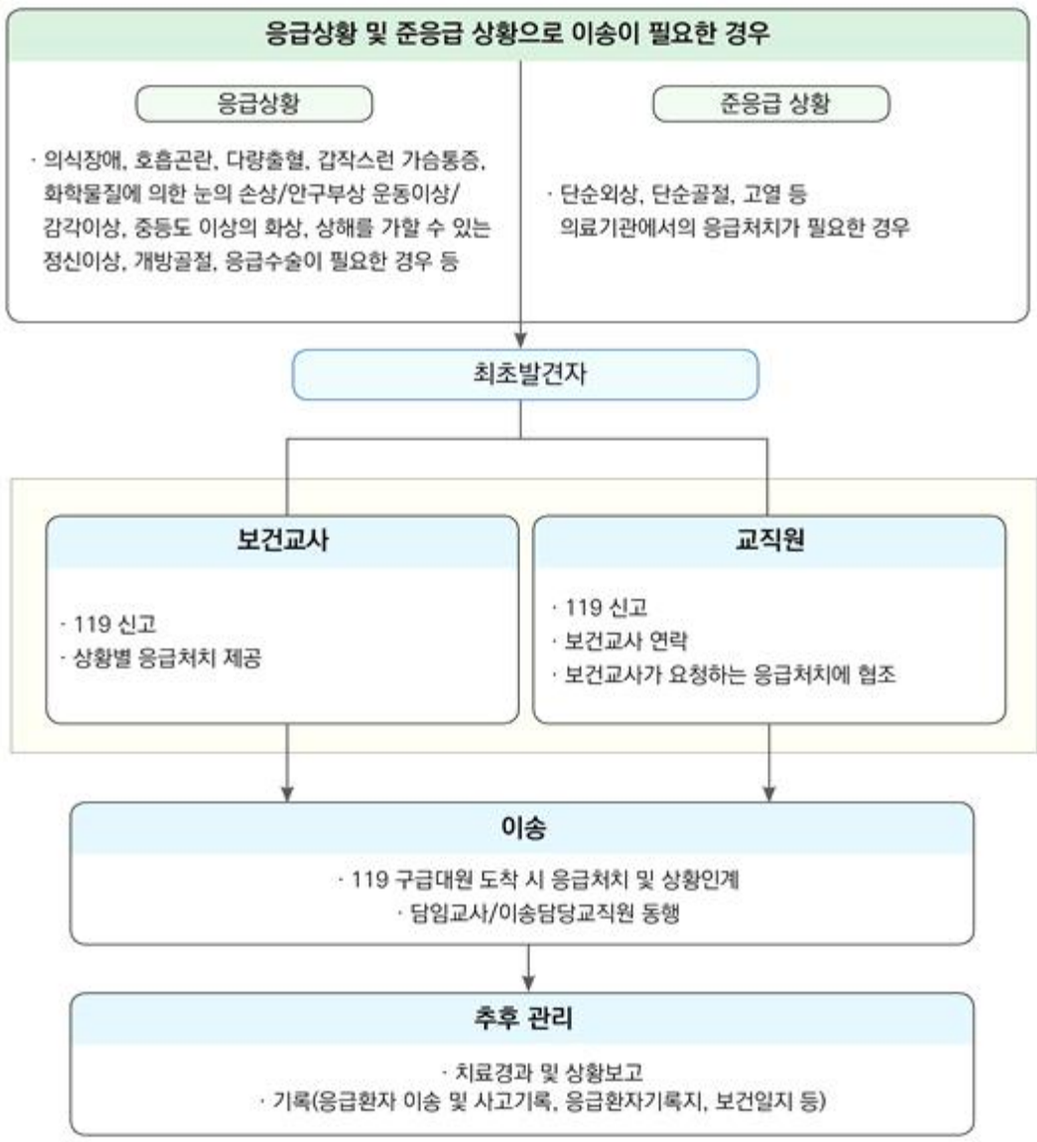
- 환자의 심장정지 상태에 대한 인지 및 판단은 보건교사의 경우 반응과 호흡 및 맥박을 확인하며, 교직원은 반응과 호흡을 확인
- 최초발견자가 먼저 119에 신고하고 자동심장충격기를 요청한 후 지체 없이 심폐소생술을 수행하며 자동심장충격기를 적용
- 학교 내 심장정지 환자 발생 시 대처 흐름도 [그림 1-3] 참고



[그림 1-3] 심장정지 발생 시 대처 흐름도

3) 응급상황 및 응급에 준하는 상황 발생 시 대처요령

- 학교 내에서 응급상황 및 응급에 준하는 상황의 환자가 발생하였을 때 대처요령 및 대응 절차는 최초 발견자가 먼저 119에 신고하고, 보건교사는 상황에 맞는 초기 응급처치 수행
  ※ 최초 발견자가 교직원인 경우 보건교사의 요청에 따라 응급처치 협조
- 학교 내 응급상황 및 준 응급상황 발생 시 대처 흐름도는 [그림 1-4] 참고



[그림 1-4] 응급상황 및 응급에 준하는 상황 발생 시 대처 흐름도

※ 부득이하게 지속적인 관찰 및 보호가 필요한 환자를 학교 자체 차량으로 이송하는 경우 보건교사는 운전자에서 제외

응급상황 점검표

[응급상황 점검표]

확 인 사항	결과 (V)		비 고
	예	아니오	
1. 활력징후(V/S) 및 의식상태(M/S)를 측정·기록 하였는가?			
2. 학생 과거병력에 대하여 확인 하였는가?			
3. 초기 응급처치는 적절하였는가?			
4. 응급환자 이송 및 진료 기록지를 작성하였는가?			
5. 초기 발견자를 확인하였는가? / 발견 시간은?			
6. 사건발생 배경에 대한 정보를 확인하였는가?			
7. 보호자에게 연락하였는가? / 연락 시간은?			
8. 교장(감)에게 보고하였는가? / 보고 시간은?			
9. 보건(담당)교사가 현장에 도착한 시간은?			
10. 119에 연락하였는가? / 연락 시간은?			
11. 119도착 시간은?			
12. 병원 이송 수단은 무엇인가?			
13. 이송 시 동행 교사는 누구인가?			
14. 응급환자 병원 도착시간은 언제인가?			
15. 보호자가 병원에 도착한 시간은 언제인가?			

나 응급환자 건강사정 및 응급처치

체계적인 신체사정

1) 현장 사정

- 혈액, 체액, 유해한 화학물질, 불안정한 구조물, 화재, 전선 등 접근하기 안전한 상황인지 파악
- 필요한 경우 보조 인력과 자동심장충격기(AED) 등 응급처치에 필요한 장비 요청

2) 속성 사정(ABC)

- 1차 사정은 생명을 위협하거나 장애를 남길 수 있는 응급 상황인가를 판단
- 1차 사정은 5분 이내로 신속하게 실시하고 환부를 노출하여 사정할 때 보온에 유의
- 속성 사정하여 보건실 방문 순이 아니라 위급한 학생부터 사정 및 처치

3) 1차 사정(C-ABCDE)

- 1차 사정은 생명을 위협하거나 장애를 남길 수 있는 응급상황인가를 판단
- 1차 사정은 5분 이내로 신속하게 실시하고 환부를 노출하여 사정할 때 보온 유의
- 신체 검진을 할 때는 혈액 등 체액에 노출되지 않도록 장갑 등 보호 장비를 착용

4) 2차 사정(FGHI)

- 1차 사정 후 생명을 위협하는 응급상황일 때 필요한 처치를 한 후 2차 사정을 시행
- 활력 징후는 응급상황 판단에 중요 지표이며 상대의 악화나 회복을 나타내는 의미있는 지표이므로 초기 활력 징후를 측정하여 기록
- 통증의 정도는 개인차가 있는 주관적 척도이나 간과해서는 안 되며 중재의 효과를 판단하는데 유용

단계		사정항목		
1단계	현장 사정	접근하기 안전한 상황인지 파악, 필요한 경우 인력 및 장비 요청		
2단계	속성 사정	A	Appearance(외양)	• TICLS(Tone/Interaction/Consolability/Look/Speech) – 근육강도/상호관계/심리적 안정도/시선처리/언어구사
		B	Breathing(호흡)	• 자세, 호흡 호흡근 견축, 코벌렁임, 무호흡
		C	Circulation to Skin (피부순환상태)	• 창백, 청색증(입술), 창백한 반점
3단계	1차 사정	C	Control hemorrhage	• 대량 출혈이 있는 경우 최우선으로 지혈
		A	Airway	• 자세, 호흡음, 이물질, 분비물, 말 가능 여부
		B	Breathing Circulation	• 호흡수, 깊이, 호흡 양상, 대칭성, 호흡음, 냄새
		C	Circulation CPR	• 맥박수, 맥박양상, 모세혈관 재충만 시간(정상: 2초 이내), 피부색, 온도, 습도 • 필요한 경우 CPR
		D	Disability(의식장애 및 신경학적 상태)	• 의식 수준 확인 AVPU ① Alert: 의식명료 ② Verval: 소리에 반응 ③ Painful: 통증에만 반응 ④ Unresponsive: 무반응 • 동공 상태 사정 PERR(pupils equal, round, and reactive to light) • 일시적 감각이상
		E	Exposure(환부상태관찰)	• 외상, 부종, 출혈, 변형(환자 보온에 유의)
4단계	2차 사정	F	Full vital signs	• 활력징후, 혈당 등 측정
		G	Give comfort/Pain	• 통증에 대한 사정 PQRST(Problem/Quality/Radiate/Severity/Timing) • 부위, 양상, 방사여부, 통증의 정도, 시각시간
		H	History Head to toe Focused PE	• 병력 사정 SAMPLE(Symptoms/Allergies/Medications/Past health history/ Last food/Events) 전신사정 환부집중사정
		I	Intervention Isolate	• 필요한 중재의 시행 • 감염병의 경우 격리

신체 사정 도구 및 주요지표

1) 심폐 기능 저하의 주요 증상

- 빈맥(쇼크의 초기 증상)
- 말초 맥박의 약화 또는 소실
- 의식상태의 변화
- 빠른 호흡/호흡곤란
- 창백증
- 저혈압, 서맥, 혈압측정 불가(말기)

2) 소아청소년의 나이에 따른 활력 징후

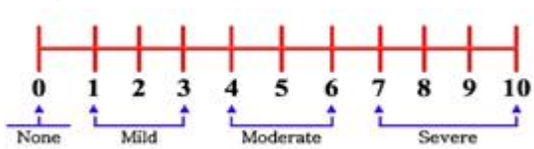
나이	PR	HR	BP
Neonate(birth~30 days)	30~60	100~180	60~90
Infant(1~12 months)	24~50	100~160	70~100
Toddler(1~3 years)	24~40	90~150	70~105
Preschooler(3~5 years)	20~30	80~140	75~105
School-aged(5~12 years)	18~30	65~120	80~120
Adolescent (12 Years and Older)	12~20	60~100	90~128

3) 통증 사정 방법(PQRST)

<table>
<tr><th>구분</th><th>사정사항</th></tr>
<tr><td>P</td><td>Problem: 통증부위
Provoke: 통증 악화 요인
Palliate: 통증 완화방법</td></tr>
<tr><td>Q</td><td>Quality: 통증의 양상</td></tr>
<tr><td>R</td><td>Radiate: 통증의 방사여부 및 부위</td></tr>
<tr><td>S</td><td>Severity: 통증의 정도(숫자나 그림 이용)
Sings: 통증과 동반된 객관적인 증상
Symptoms: 통증과 동반된 주관적인 증상</td></tr>
<tr><td>T</td><td>Timing: 통증의 시작 시간 및 양상</td></tr>
</table>

<숫자를 이용한 통증 정도 사정>

- 학령기 아동에 적용



– 의사소통이 가능하고 수 개념을 이해하는 환자에게 통증강도를 측정할 때 사용
– 환자로 하여금 자신에게 해당되는 통증의 강도를 점수화하게 하여 기록
– 통증의 강도는 경도(1~4점), 중증도(5~6점), 중증(7~10점)으로 구분

<그림을 이용한 통증 정도 사정>

- 3살에 학령기 이전 아동에 적용



4) 경피적 산소 포화도 SpO2

- 100~95% 정상
- 90% 이하 급성 호흡부전

건강 문제별 사정 및 처치

1) 두통 환자 사정 및 처치

사정

1. 활력징후: 체온(　℃), 혈압(　/　mmHg), 맥박(　　), 호흡(　　), 산소포화도(SpO2　　%)
2. 두통은 언제부터 시작하였는가?
3. 두통 양상/정도
   - 지속적, 간헐적, 주기적　/　심함, 보통, 약간
   - 언제 가장 많이 아픈가? (아침, 낮, 밤, 학교에서, 집에서)
   - 두통 부위
4. 현재 함께 나타나는 증상이 있는가?

① 발열	④ 속이 답답하다.	⑦ 시력, 시야 이상
② 어지러움	⑤ 감기증상	⑧ 눈부심
③ 오심	⑥ 인후통	⑨ 기타

5. 최근에 두통과 관련하여 약을 복용한 적이 있는가?
6. 타박이나 정신적 충격 등 관련이 있는가?
7. 최근에 두통과 관련한 다른 질환이 있는가?
   – 축농증, 비염, 중이염, 신경성 질환, 열성질환, 치아 부정교열, 턱관절 장애 등
8. 기타 참고사항
   ① 평소 두통을 경험했다면 어떤 방법으로 회복되었는가?
   ② 평소 자주 두통이 있는가?
   ③ 평소 언제 자주 아픈가? (밤, 낮)
   ④ 두통이 특정상황과 관련이 있는가?

처치

- 유발 원인이 있다면 원인별 중재
- 조용하고 어두운 방에서 안정, 휴식, 명상, 심호흡 등 이완요법 적용
- 두피 마사지
- 눈 위, 목 뒤, 머리에 냉찜질 적용
- 진통제 처방: 반복적이거나, 진통제 복용 이후에도 완화되지 않는 두통의 경우 병원진료 권유

병원 의뢰

- 최근에 갑자기 생긴 심한 두통이나 감전된 것 같은 통증
- 만성두통이지만 통증이 훨씬 더 심하고 발작적으로 빈번히 나타나는 두통
- 정상적인 활동을 할 수 없는 두통
- 경부 강직, 새벽통증, 오심, 구토, 의식장애 등을 동반하는 두통
- 시력 변화, 대화 곤란, 운동조정 문제, 팔다리 허약감 등을 동반한 두통
- 이차성 두통 의심 증상: 갑자기, 처음 또는 심해진, 외상관련, 악화요인 (기침, 누우면)
- 이차성 두통 소견: 의식장애, 많이 아파보임, 머리 외상소견, 발한, 피부이상, 동공과 시력 이상, 감각과 운동 이상, 경부 강직
- 의식장애, 감각과 운동이상, 이상행동, 중독물질 노출

2) 복통 환자 사정 및 처치

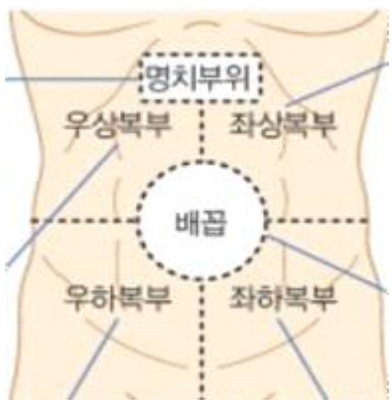
사정

1. 활력징후: 체온(　　℃), 혈압(　　/　　mmHg), 맥박(　　), 호흡(　　), 산소포화도(SpO2　　%)

2. 증상은 어떠한가? 안색, 통증 발생, 지속시간, 유형, 느낌, 뻗침, 악화요소, 통증경감 요소

3. 통증의 양상은 어떠한가?
   지속적, 일시적, 주기적 / 심함, 중간, 약함

4. 통증 부위는?
   우상복부, 좌상복부, 우하복부, 좌하복부, 명치부위, 배꼽주위, 서혜부



[출처: 네이버 이미지 파일]

5. 다른 증상이 있는가?
   ① 메스꺼움　　④ 변비
   ② 구토　　⑤ 소화불량
   ③ 설사　　⑥ 열, 기침

6 현재 증상이 있기 전에 있었던 일은 무엇인가?
   ① 식사는 했는가?　　② 음식 먹고 바로 운동 했는가?
   ③ 평소와 다른 음식을 먹었는가?　　④ 외식을 했는가?
   ⑤ 평소 이렇게 아픈 적이 자주 있었는가?

7. 가족 중에 같은 증상을 경험한 사람이 있는가?

8. 장염, 위염 등 경험한 질환이 있는가?

9. 현재 복용하고 있는 약이 있는가? (복통 관련)

10. 기타 참고사항 (평소 환자의 습관 확인)
   ① 평소 식사를 규칙적으로 하는가?
   ② 평소 배변을 규칙적으로 보는가?
   ③ 평소 배가 아플 때 본인이 취했던 방법은?
   ④ 평소 인스턴트 음식을 자주 먹는가? (피자, 빵, 햄버거 등)

처치

- 원인을 파악하고 원인중심 치료
- 의심 증상에 대한 긴급대처 (119도움요청)
- 급성복통일 경우 금식하며 증상 악화 시 병원 이송

병원 의뢰

- 심한 통증
  (의식감소, 얼굴 창백, 식은땀, 빈맥)
- 쉬지 않고 지속될 때
- 복막 자극 증상 (복부가 단단해짐)
- 잦은 구토
- 똑바로 눕지 못할 경우

- 복통의 원인: 질병, 배고픔, 과식, 설사, 식중독, 월경통, 정신적인 원인, 변비, gas pain, 임신, 부상
- 장음의 소실: 복부의 4사분면 전부에서 1분 동안 장음 없음, 정상 장음 1회/5초
- 배꼽이나 옆구리 주위의 퍼런 변색(Grey Turner sign): 복부 내부 출혈급성 출혈성 췌장염, 자궁외 임신의 파열 등
- 선홍색 혈변: 위장관 하부 출혈
  타르색 혈변: 위장관 상부 출혈
- 과민성대장증후군에 의한 복통은 온찜질 효과적
  복부의 염증성 질환의 경우 온찜질 금기
- 외상 후 좌상복부에서 왼쪽어깨로 방사되는 통증은 비장손상을 의심
- 충수돌기염: 배꼽부위에서 시작하여 우측하복부로 방사
- 담낭질환: 오른쪽 어깨로 방사

3) 발열 환자 사정 및 처치

사정

1. 활력징후:
   체온(　　℃), 혈압(　　/　　mmHg), 맥박(　　), 호흡(　　), 산소포화도(SpO2　　%)

2. 현재 함께 경험하는 증상은 무엇인가?
   ① 두통
   ② 메스꺼움, 구토
   ③ 감기 (콧물, 코 막힘, 재채기, 근육통)
   ④ 힘 없음
   ⑤ 인후통

3. 증상 시작 시간은 언제부터인가?

4. 해열제 및 다른 약을 복용했는가? (○ , X) 복용했다면? ① 복용약:　　② 복용시기:

5. 평소에 열이 날 때 본인이나 보호자가 취한 방법은 무엇이었는가?

6. 기타 참고사항
   ① 평소와 달리 본인이 열이 나게 된 이유가 무엇이라고 생각하는가?
   ② 평소 자주 두통이 있는가?
   ③ 평소 소변은 자주 보는가?
   ④ 평소 쉽게 지치고 피곤한가?
   ⑤ 면역 질환(결핍)이 있는가?

처치

- 충분한 수분섭취
- 1시간 간격으로 체온과 증상 기록
- 해열제 처방
- Warm massage (따뜻한 물을 수건에 적셔 닦아 줌)
- 가볍고 느슨한 옷, 소화가 잘 되는 기름지지 않은 가벼운 식이
- 증상에 따라 병원 의뢰

병원 의뢰

- 목이 뻣뻣하고 두통 동반 → 뇌수막염 의심
- 숨이 차고 기침 동반 → 폐렴, 심내막염, 판막염, 심근염 의심
- 눈 위나 뺨 쪽 통증 → 부비동염 의심
- 소변을 볼 때 아프거나 화끈거림 → 요로 감염 의심
- 복통, 구역, 구토 → 장염과 식중독 혹은 충수돌기염 의심
- 열이 설명되지 않는 증상 동반 / 새로운 약물을 복용한 후 발열
- 경련 동반 → 뇌수막염, 뇌혈관 기형
- 똑바로 눕지 못할 경우

4) 호흡곤란 환자 사정 및 처치

사정

1. 활력징후:
   체온(　　℃), 혈압(　　/　　mmHg), 맥박(　　), 호흡(　　), 산소포화도(SpO2　　%)
   호흡측정 시 청색증, 흉통, 불안, 혼돈과 같은 호흡기 문제 관찰

2. 호흡곤란 유형은 어떠한가?
   - 갑자기 발생했는가?
   - 숨을 내쉬기가 더 힘든가?
   - 호흡의 깊이: 얕음, 보통, 깊음
   - 흡기 시 흉곽팽창 대칭성, 늑간 함몰 여부 관찰-흉곽기형, 늑골 골절 폐 조직 위축 사정
   - 송곳으로 찌르는 듯한 가슴 통증을 동반하는가? (폐기종 의심)
     - 아픈 쪽 가슴을 자신의 팔로 눌러 감싸고 병원 이송
   - chocking sign(양쪽 손으로 목을 감싸 쥐는 행동) 확인: 질식확인(말을 할 수 있는지 확인)

3. 발견당시 상황 및 시진(목격자 진술도 포함)
   - 청색증(얼굴 창백, 입술 퍼런빛 또는 검은빛) 유무
   - 대답을 하는가?
   - 목의 하부나 배의 상부가 안으로 빨려 들어가 보인다.
   - 목 부분에 심한 wheezing sound(쌕쌕거림)가 들리는가? (천식 기존 질환 확인)

4. 전구증상(어떤 질환의 증후가 나타나기 전에 일어나는 증상)이 있었는가?
   ① 가슴 답답　　④ 힘이 빠짐　　⑦ 속상하거나 화가 났는가?
   ② 식은 땀　　⑤ 몸이 차가워짐　　③ 열감
   ⑥ 정신 희미해짐

5. 과다환기증후군 증상(호흡이 빠르고 적은 양의 호흡을 힘들게 함)을 보이는가?
   ① 숨을 매우 가쁘게 몰아쉬는가?
   ② 가슴이 답답하고 숨쉬기가 곤란하다고 호소하는가?
   ③ 손발의 마비 및 저림, 뒤틀림이 있는가?

6. 가족 중에 같은 증상을 경험한 사람이 있는가?　　질병명(　　)

7. 지금 환자가 경험하는 증상은 무엇인가?
   ① 두통　　③ 메스꺼움　　⑤ 힘없음
   ② 어지러움　　④ 구토　　⑥ 발열감

8. 기타 참고사항 (해당되는 곳에 ○표 하세요)
   ① 천식 치료, 호흡기 질환 치료 중
   ② 과거에도 이런 증상이 있었다.
   ③ 특정 상황에서 호흡곤란이 심해진다.
   ④ 자세에 따라 달라진다.

처치

- 원인을 파악하고 원인중심 치료
- 의심 증상에 대한 긴급대처 (119도움 요청)
- 산소 투여, 산소포화도 감시, 기관지 확장제 분무
- 과다환기증후군: 환자 안정 및 심호흡 유지
  봉투를 사용한 재호흡 요법은 혈중 산소분압의 감소가 더 심하게 나타나므로 산소공급이 더 효과적

5) 실신 환자 사정 및 처치

사정

1. 활력징후:
   체온(℃), 혈압(/ mmHg), 맥박( ), 호흡( ), 산소포화도(SpO2 %)

2. 발견당시 상황
   ① 자세 ② 의식소실 ③ 안구 편위(한쪽으로 기울어짐)
   ④ 언어표현 여부 ⑤ 경직 및 마비

3. 의식소실 기간은?

4. 환자 외모 점검

5. 경직 및 마비 증상 있는가?

6. 호흡상태 및 특징은 어떠한가?

7. 동공반사 측정

8. 전구증상이 있었는가?
   ① 가슴 답답함 ④ 힘이 빠짐 ⑦ 몸이 차가워짐
   ② 메스꺼움 ⑤ 하품 ⑧ 정신 희미해짐
   ③ 식은땀 ⑥ 어지러움

9. 지남력(사람, 장소, 시간) 또는 방향감이 있는가?
   – 본인의 이름, 주소, 연락처에 정확하게 대답하는가?
   – 실신 전후 사정을 기억하는가?

10. 사지 운동성은 어떠한가?
   – 환자의 양 손을 잡고 꽉 쥐어보게 한다.
   – 양 다리를 누르고 들어보게 한다.

11. 과거에 같은 증상 경험 및 기존 질환이 있는가?
   ① 특정질환이 있는가? 뇌전증, 저혈당, 뇌혈관 기형, 부정맥, 심장(판막)질환
   ② 특정상황이나 장소와 관련이 있는가?
   ③ 가족력이 있는가?

12. 지금 나타나고 있는 증상은 무엇인가?
   ① 두통 ③ 메스꺼움 ⑤ 힘없음
   ② 어지러움 ④ 구토 ⑥ 이상행동

13. 기타 참고사항(해당되는 곳에 ○표 하세요)
   ① 평소 자주 피곤함을 느낀다.
   ② 평소 자주 두통이 있다.
   ③ 최근 바꾼 약이나, 복용 중인 약이 있다.

처치

- 환자의 다리를 15-30cm 올려주고 조이는 옷과 허리띠는 느슨하게 풀어줌
- 활력징후, 산소포화도, 혈당 측정
- 정신이 들어도 20~30분간은 회복 자세 유지(지남력 확인)
- 환자가 쓰러질 때 다른 손상 입었는지 확인
- 이불 및 시트를 덮어 보온
- 의식이 없고 호흡이 정상이 아닌 때는 119도움요청, 심폐소생술 시행(호흡, 맥박 없을 시)
- 응급 진료 필요한 경우: 심장질환, 가슴통증과 두근거림, 누워있던 중 실신, 재발성 실신, 지속 발작, 지남력 장애, 선천성(심장, 혈관) 기형, 편측마비, 소아당뇨 환아 등 원인을 파악하고 원인중심 치료

6) 염좌, 탈구, 골절 환자 사정 및 처치

사정

1. 활력징후:
   체온(℃), 혈압(/ mmHg), 맥박( ), 호흡( ), 산소포화도(SpO2 %)

2. 발견 당시 상황

① 쓰러질 때 방향 및 자세는 어떠한가?
② 관절가동범위 제한과 탈구변형 여부가 있는가?
 – ROM, 탈구변형은 골절이나 탈구이다.
 (ROM: 관절가동범위, 사지를 움직일 때 측정한 관절의 운동범위)
③ 감각 및 운동성 이상 여부, 기능상실이 있는가?

3. 현재 나타나는 증상은?

① 변형	④ 부종 및 변색	⑦ 지남력 확인
② 개방상처	⑤ 불안 상태	⑧ 힘 없음
③ 동통 및 압통	⑤ shock 반응*	⑨ 기타

* shock 반응: 빈맥, 저혈압, 차고 축축한 피부, 소변량 저하, 의식상태 저

4. 기타 참고사항
① 다니는 병원이 있는가?
② 반드시 정형외과로 가도록
③ 귀가 후 통증과 부종이 있으면 병원진료를 받도록 반드시 지도한다.

처치

- 탈구일 경우 탈구된 상태로 둘레 고정 후 병원으로 이송
- 일반적인 골절, 염좌, 타박상의 응급처치
  – Rest(안정): 일어나거나 움직이지 않도록 함
  – Ice(냉찜질): 환부에 대주어 부종 및 통증 감소
  – Compression(압박): 탄력붕대로 환부를 적당한 강도로 압박, 고정
  – Elevation(높이기): 손상부위를 심장보다 높게 해주어 부종 예방
  – 부목을 대어 병원으로 이송
  – 변형된 사지는 정복하려 시도하지 말고 변형된 상태로 고정함
- 골절일 경우 염좌와 증상이 비슷하나 변형, 심한 통증, 부종, 운동 상실 특징이 있음
- 늑골 골절 시 선홍색 거품의 피가 입으로 흐를 때에는 골절처치를 하지 말고 호흡을 쉽게 할 수
  있도록 등 뒤에 고임을 넣어주고 안정 후 이송
- 골절 처치 후 30분 간격으로 혈액순환 여부 확인 / 말단부의 순환, 감각, 운동을 조사함
  (피부가 차거나, 창백, 얼룩, 손톱·발톱 부분의 색 변형·통증 등 유심히 관찰)

7) 추락 환자 사정 및 처치

사정

1. 활력징후:
   체온(　　℃), 혈압(　　/　　mmHg), 맥박(　　), 호흡(　　), 산소포화도(SpO2　　%)

2. 발생 당시 상황은 어떠한가?
   ① 자세　② 의식소실　③ 안구 편위
   ④ 언어표현 여부　⑤ 경직 및 마비　⑥ 추락 높이

3. 의식소실 확인
   - 추락 발생 당시 사건 전후 상황 기억하는지?
   - 기본 지남력 확인(이름, 주소, 전화번호 등)

4. 혈압, 맥박의 정도는 어떠한가?:
   참고) 혈압↓ + 맥박↓= shock, 혈압↓ + 맥박↑= 출혈소견 → 5분 간격으로 측정

5. 동공반사 측정:
   ① 불빛에 동공이 반응하지 않는 상태는 위험[pin point pupil(축동), full dilated pupil(산동)]
   ② 동공의 크기가 좌우가 다르면 중추신경이상 소견

6. 외부적인 소견은 어떠한가?
   ① 코나 귀에 분비물이 흐르는가?
   ② 오심 및 구토 증상 있는지?
   ③ 외부 출혈이 있는가?
   ④ 변형 및 골절이 있는가?
   ⑤ 사지를 움직이는가?
   ⑥ 얼굴색, 피부색은 어떤가?
   ⑦ 저체온, 피부 축축한가?
   ⑧ 동공반사 확인
   ⑨ 헛소리를 하는가?
   ⑩ 호흡이 불규칙적인가?

7. 사지 운동성 및 대칭성 확인:
   ① 자발적으로 움직이는가?
   ② 환자의 양 손을 잡고 꽉 쥐어보게 한다.

8. 기타 참고사항(해당되는 곳에 ○표 하세요)
   ① 추락 전에 다툼이나 충격이 있었는가?
   ② 주변의 목격자 확보하고 진술을 받았는가?
   ③ 평소에 자주 두통이 있었는가?(특히 밤에)

처치

- 현장주변에 추가적인 위험요소 유무 확인(차도, 고르지 않은 추락 지형, 유리)
- 의식 확인, 기도확보, 호흡과 맥박 확인, 119도움 요청
- 척추손상이 있을 수 있으므로 현장이 위험하지 않을 경우 이동하지 않음
- 이동이 꼭 필요한 상황이라면 경추보호대를 한 후 목을 최대한 움직이지 않도록 하며 들것에 의해 이동
- 출혈여부 확인 후 출혈상태에 따라 지압 및 드레싱(소독)
- 골절여부 확인 후 상태에 따라 고정, 냉찜질

8) 치아 손상 환자 사정 및 처치

사정

1. 활력징후:
   체온(　℃), 혈압(　/　mmHg), 맥박(　), 호흡(　), 산소포화도(SpO2 %)

2. 손상의 정도는 어떠한가?
   ① 완전히 빠졌는가?
   ② 살짝 빠졌는가?
   ③ 흔들리는가?
   ④ 부러졌는가?
   ⑤ 잇몸이 손상되었는가?
   ⑥ 구강내 출혈, 입술에 상처가 있는가?

3. 원인이 무엇인가?
   ① 부딪혔는가?
   ② 넘어졌는가?

4. 출혈의 정도 및 통증 확인

5. 턱, 얼굴뼈 골절 여부 확인
   ① 턱 얼굴뼈 모양의 변형이 있는가?
   ② 얼굴에 부종이 있는가?
   ③ 턱, 얼굴뼈 주변에 압통 등 통증이 있는가?
   ④ 입을 열고 닫을 때 턱관절에 통증이 있는가?

6. 빠지거나 부러진 치아의 상태 확인
   ① 이물질이 많이 묻었는가?
   ② 치아에 잇몸 조직이 묻어 있는가?
   ③ 손상된 치아가 유치인가 영구치인가?

처치

- 영구치가 부러지거나 완전히 빠진 경우
  - 119를 호출하거나 즉시 치과로 30분 이내 후송
  - 재이식이 60분 이내로 이뤄져야 성공률이 높음
  - 생리식염수 혹은 찬 우유 속에 넣어 즉시 병원 이송
    : 치아 보존액의 적합도 - 찬 우유(2~6시간) > 생리식염수(30분) >> 침 >>>>> 물
    : 침은 세균 감염의 위험이 있고, 물은 세포분해를 촉진하므로 사용자제
  - 치아 뿌리 쪽을 잡지 말 것
  - 빠진 치아를 문지르거나 치아에 남아있는 조직들을 제거하지 않음
  - 치아가 더러운 경우 우유나 생리식염수로 10초 이내로 가볍게 헹굼
- 치아가 살짝 빠진 경우
  - 절대로 혼자 밀어 넣지 말고 빠른 시간 내에 병원을 방문하여 원래 위치로 밀어 넣어야 함

9) 눈 손상 환자 사정 및 처치

사정	1. 활력징후: 체온(℃), 혈압(/ mmHg), 맥박( ), 호흡( ), 산소포화도(SpO2 %)	
	2. 손상의 원인은 무엇인가? 화학물질, 열, 타박 등	
	3. 시력 검사: 보이지 않는다, 뿌옇게 보인다, 붉게 보인다.	
	4. 눈의 겉모습에 변화가 있는가?: 눈꺼풀 부종, 결막 출혈, 동공 비대칭	
	5. 현재 눈의 증상이 생기기 전에 원인이 되는 사건이나 요인이 있었는가? ① 현재 안경 및 렌즈 착용하는가? ② 다른 알레르기 질병이 있는가? ③ 다쳤는가? ④ 수영장에 다니는가? ⑤ 자다가 아파서 깬 적이 있는가?	
	6. 증상이 있는 것에 ○표 하세요 ① 결막충혈 ② 안구통증 ③ 분비물, 눈곱 ④ 안검부종 ⑤ 열감 ⑥ 눈부심 ⑦ 시력저하 ⑧ 시야혼탁 ⑨ 동향주시	
	7. 시력 교정 기구(안경, 렌즈 등) 착용여부	
	8. 현재 먹고 있는 약이 있다면 기록하세요.	
	9. 기타 참고사항 ① 평소 눈이 자주 가려운가? ② 평소 눈을 자주 비비는 습관이 있는가? ③ 평소 눈곱이 자주 끼는가?	
처치	화학화상	• 눈 비비지 않고 20분 이상 충분히 세척(생리식염수 또는 수돗물, 외안각쪽으로) • 산, 염기성 물질은 중화하려고 해서는 안됨
	관 통 상	• 관통물질 제거 하지 않고 거즈를 물체 높이로 말아 물체주위에 놓고 고정하고 종이컵을 눈에 부착하여 보호 • 안구가 움직이지 않도록 다른 쪽 눈도 느슨하게 가려줌
	열 화 상	• 무리하게 눈을 벌려 시진하지 않음 • 각막화상 의심시 느슨하게 젖은 드레싱하고 냉찜질하면서 병원후송
	타 박 상	• 눈 비비거나 압박 하지 않고 단순타박상일 경우 압력을 주지 않으면서 냉찜질
	각막 찰과상	• 대부분 24~48시간내 완화되므로 눈을 감고 휴식을 취하되 심하면 병원진료 • 콘택트렌즈 제거
	이물질 삽입	• 이물질이 아래 눈꺼풀에 있고 보이는 경우, 면봉으로 제거 • 2번 시도 후 제거되지 않거나 다른 부위에 있는 경우 생리식염수나 물을 부어 제거
	안와골절 의심	• 코 풀지 말고 안정 취하면 후송 • 특별한 소견이 없더라도 안구출혈 의심하며 심신안정, 시력변화 관찰, 안과 진료
응급 상황	• 이물질이 금속가루로 의식되는 경우 • 눈, 머리, 얼굴의 심한 손상(관통상 등) • 갑작스런 시력 소실 • 부분적으로 안 보이는 경우(망막손상, 망막혈관 폐쇄 등 의심) • 갑작스런 복시, 동공 변화(뇌혈관질환 의심)	

10) 머리 손상 환자 사정 및 처치

사정

1. 활력징후:
   체온(℃), 혈압(/ mmHg), 맥박( ), 호흡( ), 산소포화도(SpO2 %)

2. 발생 당시 상황은 어떠한가?
   ① 자세 ② 의식소실 ③ 안구 편위
   ④ 언어표현여부 ⑤ 경직 및 마비

3. 의식소실 확인
   - 손상 전후 상황 기억하는가?
   - 기본 지남력 확인 (이름, 주소, 전화번호 등)

4. 의식 상태: 정상, 묻는 말에 반응한다, 통증 자극에 반응한다, 반응 없다

5. 동공반사 측정:
   ① 불빛 동공이 반응하지 않는 상태는 위험(pin point pupil, full dilated pupil)
   ② 동공의 크기가 좌우가 다르면 뇌의 이상 소견

6. 외부적인 소견은 어떠한가?
   ① 코나 귀에서 수양성 분비물이 흐르는가?
   ② 메스꺼움 및 구토 증상이 있는지?
   ③ 두통의 정도는 어떠한가?
   ④ 변형 및 골절 확인
   ⑤ 손발 등 사지를 움직이는가?
   ⑥ 두피열상 및 출혈정도는?
   ⑦ 저체온, 피부 축축한가?
   ⑧ 동공반사 확인
   ⑨ 헛소리를 하는가?
   ⑩ 호흡이 불규칙적인가?

7. 원인이 무엇인가?

8. 사지 운동성 및 대칭성 확인:
   – 자발적으로 움직이는가?
   – 환자의 양 손을 잡고 꽉 쥐어보게 한다.

처치

- 의식 및 호흡 상태에 따라 필요시 심폐소생술 시행
- 낙상 등 척추손상 의심 시 사고현장에서 최대한 움직이지 않도록 하며, 반듯이 눕히고 경추 보호대나 모래주머니 등으로 고정을 하고 119도움 요청 병원으로 이송
  – 급히 이송한다고 환자의 몸을 움직이면 손상을 악화시킬 수 있으므로 주의
- 뇌척수액이 누출되는 부위는 막지 말고 자연스럽게 흘러나오도록 누출 부위를 소독하고 소독 거즈로 살짝 덮어 줌
- 구토 시 환자를 옆으로 눕혀 구토물이 기도나 폐로 들어가지 않도록 함
- 두피 상처 및 열상의 경우 멸균드레싱 후 병원 이송
- 손상정도에 따라 119도움요청 등의 방법으로 즉시 병원 이송

11) 절단 환자 사정 및 처치

사정

1. 활력징후:
   체온(℃), 혈압(/ mmHg), 맥박( ), 호흡( ), 산소포화도(SpO2 %)

2. 쇼크로 인한 의식의 정도 확인
   정상적인 상태 ( )
   큰 말소리에 반응 ( )
   강한 자극에 약간 반응 ( )
   아주 강한 자극에 반응하나 행동은 못함 ( )
   어떠한 강한 자극에도 반응이 없음 ( )

3. 절단의 원인은 무엇인가?

4. 절단부위를 찾았는가?

5. 절단면의 상태는 어느 정도인가?
   ① 절단면이 깨끗한가?
   ② 절단부(떨어져 나간 면)는 깨끗한가?
   ③ 절단면의 골절 정도는 어떠한가?

6. 절단면의 출혈 정도는 어느 정도인가?
   ① 스며 나오는 듯한 출혈인가?
   ② 흐르는 정도인가?
   ③ 솟구치는 정도인가?

7. 현재 함께 나타나고 있는 증상은 무엇인가?

① 가슴 답답함	④ 몸에 힘이 빠짐	⑦ 몸이 차가워짐
② 메스꺼움	⑤ 하품	⑧ 정신 희미해짐
③ 식은땀	⑥ 어지러움	

처치

- 절단부위 확인(절단부위를 찾아서 병원 이송 시 가져가기)
- 절단부위를 직접 압박하여 지혈
- 절단부위를 심장보다 높게 거상하고, 거즈를 덧대거나, 붕대 적용
- 절단된 부위를 생리식염수 세척
- 생리식염수를 적신 후 꼭 짠 거즈로 절단부위를 감쌈
- 밀폐용기에 젖은 거즈로 감싼 절단부위를 넣음
- 밀폐용기를 얼음물에 담그거나 얼음주머니로 감쌈
- 절단된 부위가 얼음에 직접 닿아서 얼거나 물에 닿지 않도록 주의
- 접합 전문병원에서 빠른 시간에 수술 받을 수 있도록 119협조로 병원 이송

출처: 경기도교육청(2022), 학교보건실무 매뉴얼, 학교 응급상황 대응 가이드라인(교육부)

다 학교 내 응급상황 대응 관련 서식

응급환자 이송 및 사고 기록

응급환자 이송 및 사고 기록지 [예시 1]

※ 필요한 부분만 작성한다.

<table>
<tr><td>학년 반</td><td>학생 이름</td><td>성별</td><td colspan="3">보호자 전화번호</td><td>담임교사</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td>발생장소</td><td colspan="2"></td><td>최초목격자 및 목격시간</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>보건교사 확인시간</td><td colspan="2"></td><td rowspan="2">119</td><td>신고시간</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>도착시간</td><td></td></tr>
<tr><td>과거력</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>환자상태 (보행가능) 여부 등)</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6">활력징후</td></tr>
<tr><td>측정시간</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>혈압</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>맥박</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>호흡</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>체온</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>SpO_2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>동공반사</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>의식상태</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>응급처치 내용</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">이송시간 및 이송방법</td><td>이송시간</td><td></td><td>이송병원</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>이송차량</td><td></td><td>이송자 (응급처치자 및 차량운전자)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">비고</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td>기록일시</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>기록자</td><td colspan="2">(인)</td></tr>
<tr><td>사건개요</td><td colspan="5">기록일시: 기록자: (인)</td></tr>
</table>

응급환자 이송 및 사고 기록지 [예시 2]

※ 필요한 부분만 작성한다.

학년반	환자명	성별	보호자 전화번호	담임교사

주증상 및 환자 상태				인체모식도		
과거력						
환자 상태	근골격계	☐ 부종 ☐ 통증 ☐ 열상 ☐ 자상 ☐ 멍 ☐ 기타:				
	순환기계	☐ 흉통 ☐ 부정맥 ☐ 심계항진 ☐ 기타:				
	호흡기계	☐ 호흡곤란 ☐ 청색증 ☐ 기타:				
	신경계	☐ 시력장애 ( ) ☐ 청력장애 ( ) ☐ 마비(부위:) ☐ 경련		신체 전면	신체 후면	
	소화기계	☐ 오심 ☐ 구토 ☐ 토혈 ☐ 복부통증 ☐ 기타:				
	의식상태	☐ 정상(A) ☐ 언어반응(V) ☐ 통증반응(p) ☐ 반응 없음(U)		활력 징후		
				시간	:	:	:
발생장소 & 시간	발생장소			혈 압 mmHg			
	최초 목격자			맥 박 min			
	최초 발견시간	(AM, PM) 시 분		호 흡 min			
	보건교사 확인시간	(AM, PM) 시 분		체 온 ℃			
	119 신고시간	(AM, PM) 시 분		paO_2 %			
				동공반사			
사고 개요							
응급처치 내용							
이송시간 및 이송방법	이송시간	시 분					
	이송차량	☐ 구급차 ☐ 일반차량 ☐ 기타( )					
	이송자	☐ 119대원 ☐ 보건교사 ☐ 담임 ☐ 학부모 ☐ 기타( )					
	이송병원						
작성일 및 작성자	년 월 일 직: 성명: (인)						

☐ 응급구급함 구성 물품 및 비품 점검

응급구급함 구성 물품 예시

구분	항목	사용목적	비고
1	청진기	심음 또는 호흡음 관찰	
2	혈압계	혈압측정	
3	체온계	체온 측정	캡 여분 준비
4	펜라이트	동공반사 확인 및 밝게 비춤	
5	혈당측정기	혈당측정	필요시 포도당 사탕 추가
6	산소포화도측정기(Oximeter)	동맥혈 내 산소량 측정 및 맥박측정	정상 범위 94~100%
7	휴대용 산소	산소공급	잔량 부족 대비, 여분 준비
8	앰브백, 포켓마스크	CPR사용	
9	에어웨이	CPR사용 - 무의식 환자에게 사용	무리한 적용 금지
10	부목	상처 고정 및 골절, 염좌사용	다양한 사이즈 준비
11	경추보호대	상처 고정 및 골절 사용	무리한 적용 금지
12	삼각건	상처 고정 및 골절 사용	
13	아이스팩	통증, 부종, 염증완화	일회용
14	멸균 생리식염수	드레싱	
15	기타 드레싱 용품	소독약, 포비딘스왑, 거즈, 반창고, 밴드(다양한 사이즈), 알콜스왑 화상 드레싱 등	다양한 사이즈 준비
16	고정물품	탄력붕대, 코반 등	
17	안대	안구보호	
18	의료용 가위	드레싱	
19	의료용 장갑	드레싱	
20	응급환자 이송 및 진료기록지	처치 기록	
21	볼펜	처치 기록	
22	기타물품	여분 건전지, 종이 또는 비닐봉투	

응급비품 점검 체크리스트

구분	내용		확인	비고
매일	드레싱 카트의 청결 및 정리정돈			
	체온계의 정상 작동 및 캡의 청결 관리			
	침구 정리			
	구급가방 물품의 적절한 구비 및 접근의 용이성			
1주일	옥시미터의 정상 작동			
	펜 라이트의 정상 작동			
	혈압계의 정상 작동			
	휴대용 산소의 구비 및 잔량			
	냉동실 얼음 준비			
	처치기구(집게, 가위, 거즈, 거즈통 등)의 소독			
1달	응급 이동용 기구의 관리 (휠체어, 들것, 목발 등)	접근의 용이성		
		고장 여부		
		소독 및 청결		
	지속적인 CPR 실습			
	혈당측정기의 정상 작동			
	혈당측정 시 필요한 물품 구비 및 세트 보관 (사혈침, 일회용 알콜, 측정 스틱)			
	검안경, 검이경, 비경의 정상 작동			
	의료기구에 사용되는 건전지의 구비			
	신장/체중 자동 측정기의 정상 작동			
	침구류의 교환 및 세탁			
분기	약품의 구입 및 사용기한이 지난 약의 처리			
6개월	AED의 정상 작동 및 건전지의 잔량			

※ 자동심장충격기는 사용 가능 여부, 작동 상태, 배터리 성능, 패드 등의 상태, 유효기간 등을 항상 점검!

학생 건강조사 및 응급이송 동의서[예시]

학생건강조사 및 응급처치 동의 안내

인적 사항	학년 / 반 / 번호	학년 반 번		
	성명(성별)	☐남 ☐여		
	보호자명		보호자 연락처	

이 설문조사는 건강한 학교생활을 위해 학교 내 응급환자 관리체계 안내 및 학생들의 건강상태를 미리 알아보기 위한 것이며 학생 본인 또는 부모님(보호자)과 상의하여 작성하기를 바랍니다. 설문지는 ○월 ○일까지 담임교사에게 제출해 주세요.

※특이질환, 만성질환 등은 반드시 보건교사 및 담임교사에게 해당 질환에 대하여 알려야 합니다!

1. 병원에서 진단받고, 현재 치료 중이거나 추적관찰 중인 질환이 있습니까?	☐예 ☐아니오
1-1. 있다면 질환명을 기록하여 주십시오.( )	
2. 최근 1개월 이내에 복용하고 있는 약이 있습니까?	☐예 ☐아니오
2-1. 있다면 질환명, 약 종류를 기록하여 주십시오.( )	

3. 알레르기 질환이 있다면 표시하세요.(중복표시 가능)

☐아토피 피부염 ☐천식 ☐알러지성 비염 ☐알러지성 결막염 ☐약물 알러지

4. 부작용이 있는 약물이 있습니까?	☐예 ☐아니오
4-1. 있다면 기록하여 주십시오.( )	
5. 학생의 건강에 대하여 학교에서 배려나 주의가 필요한 것이 있습니까?	☐예 ☐아니오
5-1. 있다면 기록하여 주십시오.( )	

6. 다음의 학생 건강생활 행동에 대한 질문에 "V" 표시를 하여 주십시오.

항목	건강생활 행동	예	아니오
개인위생	하루 3회 이상(식사, 간식 후) 잇솔질을 합니까?		
	1830(하루 8번 이상 30초간) 비누로 손 씻기를 실천합니까?		
	기침, 재채기 시 기침예절(옷소매로 가리기)을 실천합니까?		
흡연 음주 약물	최근 1개월 이내에 담배를 피운 적이 있습니까?		
	최근 1개월 이내에 술을 마셔본 적이 있습니까?		
	동거인 중 담배를 많이 피워 걱정되는 사람이 있습니까?		
	동거인 중 술을 많이 마셔 걱정되는 사람이 있습니까?		
	평소 코로 숨쉬기가 불편하고 코가 자주 막힌다.		
식생활 신체활동	아침 식사는 대체로 먹는 편입니까?		
	1주일에 숨이 차거나 땀이 날 정도의 운동을 3회 이상 합니까?		

☞ 뒷면에 계속됩니다.

▸ 법정 감염병 등교중지 안내

– 법정 감염병이나 전염력이 강한 질병이 의심되면 감염병 확산을 막기 위하여 등교 중지해야 합니다.

– 감염병이 의심되면 학교에 출석하지 않고 담임교사에게 유선으로 연락 후 병원에 갑니다.

– 학교에서 감염병 의심으로 확인 시, 보호자에게 연락하여 병원 진료를 받도록 인계합니다.

– 완치 후 증빙서류를 담임교사에게 제출하면 '출석 인정'됩니다.

▸ 보건학적 고위험군(만성질환), 미세먼지 민감군, 생리통(월경) 출석 인정

– 자세한 내용 및 관련 증빙서류는 담임교사에게 문의 바랍니다.

▸ 학교 응급환자 관리 절차 안내

– 학교에서 아동들이 건강하고 안전하게 생활할 수 있도록 본교 교직원은 최선을 다할 것이나 부득이 응급상황이 발생할 경우 보건실 내 일반의약품 투여 및 신속한 응급처치가 이루어지도록 아래와 같이 동의를 구하고자 합니다.

① 학부모(보호자) 인계: 단순 골절, 염좌, 열성질환, 단순 외상, 발치 등으로 의료기관에서의 조치를 필요로 하는 경우

② 보건교사 동행 119 후송: 의식장애, 호흡곤란, 기도폐쇄, 약한 맥박, 심정지, 다량출혈, 개방골절 등 위급상황

*동의를 거부할 수 있으며, 동의 거부 시 학생 응급상황에서 병원 후송이 신속하게 이루어질 수 없습니다.

학생 응급처치 및 투약 동의서

학생 응급상황 발생 시 보호자 연락처로 연락이 안 될 경우, 「학교 내 응급상황 대응계획」에 따라 인근 병·의원으로 후송할 것에 동의합니다.
사고 발생 시 응급처치(일반의약품 및 부상 처치)에 대한 권한을 귀교에 위임할 것에 동의합니다.

보호자/법적 대리인: _____(서명)

☞ 뒷면에 계속됩니다.

▸ 보건실 이용 안내

보건실은 응급처치와 일시 안정을 위한 공간입니다.

1시간 이상의 안정 또는 잦은 증상 호소, 지속적인 관리가 필요한 상병인 경우 병·의원에서 전문적인 처치를 받도록 보호자에게 인계합니다.

▸ 학생건강검사 개인정보 이용 및 제3자 제공 동의서

1. 해당 사업 항목: 학생건강검진, 구강검진, 소변검사 등 학생건강검사, 응급이송 등
2. 제공받는 자: 본교 및 해당 검진 기관
3. 제공받는 자의 이용목적: 건강검진 대상 확인 및 검진 실시 여부 파악 및 응급 상황 대처
4. 제공하는 항목: 학년, 반, 성명, 성별, 생년월일, 보호자 성명/연락처, 건강문제, 예방접종 현황
5. 제공받는 자의 이용 및 보유기간: 당해 학년도 종료일까지
6. 동의를 거부할 수 있으며, 동의 거부 시 학생 건강검진을 받을 수 없습니다.

개인정보 수집·이용 동의(학교)	□ 예	□ 아니요
개인정보 제 3자 제공 동의(검진기관 제공)	□ 예	□ 아니요

보호자/법적 대리인: _____ (서명 또는 인)

20 년 3월 일

○ ○ 학 교 장

*출처: 학교 응급상황 대응 가이드라인(2025, 교육부)

학생 내 응급 투약(경구약, 주사) 의뢰서

학교 내 응급환자 투약에 대한 의뢰서

대상자 이름	학교 학년 반 이름
병 명	
약품 이름	
투약 용량	
투약 방법	
투약 위임자	① 보건교사 ② 교직원: 보건교사 부재 시 119 구급대 지시에 의해 투약 가능
보관 방법	
기타 필요한 사항	

학생의 응급상황 발생 시 병원에서 처방된 의약품의 투약행위에 대하여 위와 같이 자문합니다.

※ 개인정보보호법 시행에 따라 다음 항목에 대해 개인정보수집 동의 여부를 체크하여 주시기 바랍니다.

1. 이용목적: 응급상황 발생 시 정보제공
2. 개인정보항목: 병원명, 의사 성명, 병원소재, 연락처 등
3. 보유·이용기간: 20 년 3월 0일 - 학교 재학기간

**개인정보 수집 및 이용목적에 동의합니다. ☐ 동의하지 않습니다. ☐

20 년 월 일

병원명 (전화) 의사 성명 : (서명)

*출처: 학교 응급상황 대응 가이드라인(2025, 교육부)

자동심장충격기 자체 점검 체크리스트(매월 1회)*

자동심장충격기 자체 점검 체크리스트			
장비정보	제조사 : 제품명 또는 모델명 : 제조번호 : 제조 연월일 :		
장비유지기간	장비구매일자 : 년 월 일 본체유효사용가능기한 : 년 월 일 교체예정일자 : 년 월 일		
설치위치			
연번	점검항목	점검결과	
		이상있음	이상없음
1	본체 작동 상태 확인		
	① 전원 표시 상태등 점멸		
	② 환자 부착용 패드 유무		
	• 패드 교체 예정일자 : 년 월 일		
	③ 건전지 충전 상태		
	• 건전지 교체 예정일자 : 년 월 일		
2	본체 및 부속물 청결 및 손상상태		
3	보관함 상태		
	① 도난경보장치 작동 여부		
	② 보관함 각종 안내문구상태		
	③ 비상연락망 표시 여부		
	④ 사용자 매뉴얼 및 심폐소생술 방법 안내책자 여부		
	⑤ 환자부착용 패드 및 건전지 유효기간 표시 여부		
4	자동심장충격기 위치안내 표시		
	① 기관(건물) 입구 안내 표지		
	② 기관내 설치 위치 및 방향 표지		
5	지난 1개월간 사용실적 여부(있을 경우 추가기재)	있음	없음
	• 사용일시: 년 월 일 (시각 :) • 사용자: • 사용내용:		
6	관리서류 작성 및 비치 여부		
7	관리자 변경사항	있음	없음
	① 관리자 이름: 관리자 전화번호(비상연락처) : 010-0000-0000		
8	장비 사용 가능 시간		
	① 24시간 이용 가능 ② 24시간 사용 불가		
점검일: 년 월 일 점검자: (서명)			

* 중앙응급의료센터(https://portal.nemc.or.kr)-자동심장충격기(AED)관리탭에서 직접 입력 가능

*출처: 학교 응급상황 대응 가이드라인(2025, 교육부)

VI

마약류 · 흡연 · 음주 포함 약물 오 · 남용 예방

Ⅵ 마약류·흡연·음주 포함 약물 오·남용 ※참고서식 클릭 시 해당 쪽으로 이동함

<table>
<tr><th>단위업무</th><th>주요내용</th><th>참고·서식자료</th></tr>
<tr><td rowspan="2">계획</td><td>1. 마약류・흡연・음주 포함 약물 오·남용 예방교육 계획 수립
■ 학생 마약류・흡연·음주 포함 약물 오·남용 실태조사 및 분석
■ 예방교육에 대한 학교 자체예산 수립
■ 교육자료 및 프로그램 수집
■ 전년도 교육 평가 및 반성</td><td rowspan="2">•2026년 마약류 및 흡연·음주 포함 약물 오·남용 예방 계획(p.200)
•학생 흡연·음주·마약류 약물 오남용 실태조사 설문지 (p.204)
[서식8] 학생 흡연·음주·약물오남용 실태 보고</td></tr>
<tr><td>2. 학교흡연예방사업 계획 수립
■ 금연서비스 통합정보시스템 사업 계획서 탑재 (추후 안내)
■ 학교흡연예방사업 유형(심화형, 기본형) 선택 예산 신청 (추후 안내)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">운영</td><td>1. 마약류・흡연·음주 포함 약물 오·남용 예방교육 실시 운영
■ 모든 학생 대상으로 의무 실시(학교보건법 제9조)
■ 교육계획 수립 적극 반영(학교 안전교육 실시 등에 관한 고시)
■ 교육과정 내에서의 정규수업, 특별교육 등 실시
・법무부 지원 법교육, 식약처 한국마약퇴즈 운동본부 예방교육 등 전문강사 지원(추후 안내)
■ 가정과 예방교육 공감대 형성: 교육청 제공 카드뉴스 활용
■ 업무담당교원 역량강화 연수 실시(추후 안내)</td><td>•한국건강증진개발원 (www.khealth.or.kr) : 자료실–발간자료–지침/교육자료

•금연두드림 - 자료실 (nsk.khealth.or.kr)

•학생건강정보센터 자료 활용 (www.schoolhealth.kr)</td></tr>
<tr><td>2. 환경조성
■ 보건실 구비 의약품 관리 철저 및 불필요한 의약품 투여에 의한 오남용 예방
■ 운동장을 포함한 학교 전체에 대한 금연구역 지정·운영
■ 간접흡연으로부터 학생 건강권 보호 위한 학교 자체 규정 마련
・학교 내 흡연실 설치 금지 및 설치 학교 파악 후 관리
・외부 방문객 예외 없이 적용, 표지판 및 안내문 등으로 사전 안내
・위반 확인 시 관할 지자체에 통보
・학교 종사자의 경우 외부 금연프로그램 이수 권고
■ 교내 주류 반입 금지 등에 대한 내용 포함
■ 금연구역이 학교 주변 30미터까지 확대 적용(2024.8.17.)</td><td></td></tr>
<tr><td>3. 상담 및 치료 필요 학생 지원
■ 보건소, 충남금연지원센터 등 전문기관과 협력체계 구축
■ 학생 마약류 관련 상담채널 연계</td><td></td></tr>
<tr><td>4. 학교 흡연예방사업 실시 운영 [2026년 학교흡연예방사업 지침 추후 안내]
■ 학교흡연예방사업 유형에 따른 필수사업 시행
・특수학교의 경우 1개 이상을 필수로 수행하여야 함
<table>
<tr><th>구 분</th><th>기본형</th><th>심화형</th></tr>
<tr><td>활동준비 및 계획수립
– 사전조사 실시, 사업 계획수립</td><td>필수</td><td>필수</td></tr>
<tr><td>학교 선포식 운영</td><td>선택</td><td>필수</td></tr>
<tr><td>흡연예방 교육
– 초·중·고 흡연예방 표준 교육 프로그램(SENSE)
– 초등학생 흡연예방 프로그램(Jr.END) 등
– 자유학기제 연계 중학생 흡연예방 프로그램 등</td><td>필수</td><td>필수</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>단위업무</th><th>주요내용</th><th>참고·서식자료</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>구 분</th><th>기본형</th><th>심화형</th></tr>
<tr><td>흡연예방 활동(홍보 및 캠페인 포함)</td><td>필수</td><td>필수</td></tr>
<tr><td>흡연학생관리 및 청소년 금연 프로그램
– 중·고등학생 금연 프로그램(END)(8회기/2종)
– 흡연학생 3관왕 라이프코칭 프로그램* 등</td><td>선택</td><td>필수*</td></tr>
<tr><td>교직원 및 학부모 교육</td><td>필수</td><td>필수</td></tr>
<tr><td>교육청 연수 프로그램 참여(설명회 포함)</td><td>필수</td><td>필수</td></tr>
<tr><td>지역사회 협력사업 추진</td><td>선택</td><td>선택</td></tr>
<tr><td>특화사업 기획 및 운영</td><td>선택</td><td>필수</td></tr>
</table>
* 흡연학생이 없는 경우 ‘선택’으로 조정
• 예산편성 및 집행 시 학교흡연예방사업 지침 숙지하여 진행할 것
</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">평가</td><td>1. 교육 평가 및 차기년도 계획에 반영</td><td></td></tr>
<tr><td>2. 학교흡연예방사업 최종 실적입력(금연서비스 통합정보시스템 입력)
– 최종실적보고서(심화형 필수), 예산집행결과(전학교 필수)</td><td>[서식2] 학생 건강증진 교육 현황(실적)</td></tr>
</table>

1 2026 마약류 및 흡연·음주 포함 약물 오·남용 예방 계획

가 관련근거

- 국민건강증진법 제9조 제4항(학교 전체에 대한 금연구역 지정·운영)
- 청소년보호법 제2조(담배를 청소년 유해약물로 정의)
- 학교보건법 제9조(학생의 보건관리)
- 보건복지부 학교흡연예방사업 지침
- 충청남도교육청 청소년 유해약물 예방교육에 관한 조례 제5489호
- 2026년 학생건강증진 분야 주요업무 추진방향(교육부)

나 목 적

- 모든 학생을 대상으로 마약 및 흡연·음주 포함 약물 예방교육 강화
- 체계적인 단위학교 지원으로 흡연예방사업 활성화
- 마약 및 흡연·음주 포함 약물 예방교육 강화로 조기차단 및 홍보 강화
- 마약 및 흡연·음주 포함 약물 예방교육 기반 구축으로 건강한 학교 조성

다 현 황

- 2025년 청소년건강행태조사(교육부·보건복지부 공동조사, 2024년 제20차) 결과
  – 제21차 청소년건강행태조사 통계(교육부, 보건복지부, 질병관리청)

학생 흡연율

(단위: %)

연도	분석대상자수	충남흡연율	전국 흡연율	시·도 순위 (17개 시·도 중)	도 단위 순위 (9개 도 중)
2021	2,381	4.2	4.5	12위	8위
2022	2,234	4.2	4.5	11위	8위
2023	2,360	4.4	4.2	10위	7위
2024	2,627	4.3	3.6	5위	5위
2025	2,553	4.2	3.3	4위	4위

◈ '25년 청소년건강행태조사 결과
▲ 순위: 전북 > 충북 > 강원 > 충남 > 경북 > 광주 > 인천 > 제주 > 전남 > 대전,경기 > 대구,울산,경남 > 부산 > 서울 > 세종

학생 음주율

(단위: %)

연도	분석대상자수	충남 음주율	전국 음주율	시·도 순위 (17개 시·도 중)	도 단위 순위 (9개 도 중)
2021	2,381	12.7	10.7	4위	3위
2022	2,234	13.4	13.0	9위	7위
2023	2,360	12.5	11.1	5위	5위
2024	2,627	9.8	9.7	8위	6위
2025	2,553	10.0	8.0	3위	3위

◈ '25년 청소년건강행태조사 결과
▲ 순위: 충북 > 강원 > 충남 > 인천,경북 > 울산 > 경기,전남 > 광주,전북 > 대구 > 대전 > 제주 > 경남 > 서울 > 부산 > 세종

- 학생들의 흡연·음주 및 약물 오.남용은 성장기 청소년 건강에 악영향을 끼칠 뿐만 아니라 또 다른 일탈행위로 이어질 수 있는 가능성이 높은 실정
- IP추적이 불가능한 다크웹을 통한 불법광고·접촉, 가상자산을 통한 대금결재, 국제우편·던지기 등 관련 수법 다변화 등으로 인해 10대 마약범죄 증가 추세

※ ('19년) 239명 → ('23년) 1,477명 → ('24년) 649명 / 향정신성의약품 87%로 대다수

- 「학교 안전교육 실시 등에 관한 고시」 개정('23. 10월)을 통해 학교를 통한 마약류 예방교육 실시시간 확대
- 마약류 등 약물 오남용 예방교육 실시 관련 담당 교원 역량 강화를 위하여 별도의 연수과정 개설·운영('23. 5월~)
- 청소년 마약 예방 교육 강화 방안 권고(`23. 12. 18. 국민권익위원회)

※ (주요내용) 음주·흡연 예방교육과 구분한 마약예방 교육 실시 및 교원의 교육역량 강화 등

- 「마약류 관리법」 개정에 따라 청소년 마약중독예방교육과 학교교육 연계('24.1.2.)

※ (주요내용) 국가와 지방자치단체는 청소년 마약중독예방교육과 「교육기본법」에 따른 학교교육을 연계할 수 있도록 교육 콘텐츠 개발 등 필요한 시책 수립·시행

- 「학교보건법」 제9조의3개정으로 마약류 중독·오남용 예방교육 실시 강화('25.3.18.)

※ (주요내용) 교육부장관은 매년 마약류 중독·오남용 예방교육 계획 수립시행, 교육부장관과 교육감은 모든 초중등학교에서 교육실시

라 주요업무

1) 모든 학생을 대상으로 예방교육 강화

- 모든 학생을 대상으로 마약 및 흡연·음주 등 약물 오·남용 예방교육 의무 실시

– 학교 안전교육 실시 등에 관한 고시를 고려하여 교육계획 수립 적극 반영

※ 사이버 및 약물오남용 예방교육 10시간 중 학교급별 마약류를 포함한 약물오남용 예방교육 실시(유·초 5차시, 중 6차시, 고 7차시)

– 교육지원청은 관내 모든 학교에서 「학교안전교육 실시 등에 관한 고시」에서 정한 교육시간에 따라 마약류 및 약물 오·남용 예방교육이 체계적으로 실시될 수 있도록 계획 수립 여부 확인

– 마약·흡연·음주 등 포함 약물 오·남용 예방교육 미실시 학교에 대하여 지원장학 등을 실시하여 모든 학교에서 예방교육이 실시될 수 있도록 조치

2) 교육자료 개발 및 보급

- 마약류 및 음주·흡연·약물 오·남용 예방교육자료 및 프로그램 개발 시 학생건강정보센터(www.schoolhealth.kr)에 탑재하여 교육자료 공유 및 활용도 제고
- 마약류 관련 예방교육시 식품의약품안전처 운영 마약청정 대한민국(www.nodrugzone.mfdgs.go.kr)에 탑재되어 있는 마약류 폐해 영상, 카드뉴스, 학습만화, 홍보 리플렛 등을 교육 참고자료로 활용 가능

※ 교육자료가 필요한 교원은 누구나 회원가입 없이 자료를 내려받아 활용 가능

3) 담당교원 역량강화 및 전문강사 지원

- '학생 마약류 예방교육 지도역량 강화(원격)' 연수 과정와 한국마약퇴치운동부 협업을 통해 개설·운영하는 집합연수*(1~2월) 연수 과정 이수

  ※ 중앙교육연수원 및 충남교육청교육연수원에 개설

  – 시도교육청별 교육 장소 및 일정 등 세부사항에 대해서는 추후 별도 안내 예정

- 전문적인 마약류 예방교육 지원을 위하여 소정의 자격을 갖춘 전문강사(법무부 지원 법교육, 식약처 한국마약퇴치운동본부 예방교육 등) 지원

  ※ 지원 횟수: 한국마약퇴치운동본부 예방교육 ('25) 1,412회, 법무부 지원 법교육센터 ('25) 129회

◈ 학생 마약류 예방교육 강사 지원 관련 연락처 ◈

구분	주소지	연락처	강사수
충남·세종	충남 천안시 서북구 쌍용대로 251, 유성빌딩 3층	041-592-1341~5	47

※ 식약처 산하 한국마약퇴치운동본부에서 '25년 약 30,000건 이상의 교육 지원 예정
총 전문강사 수는 1,320명으로, 연중 온라인 사이트(edu.drugfree.or.kr)를 통해 강의 지원 신청 가능

4) 마약류 예방교육 중요성 인식을 위한 공감대 형성

- 마약류 접근 차단을 위한 자녀 지도요령, 마약류의 위험성 인식 제고를 위한 가정통신문 및 카드뉴스 안내, 학부모 교육 등 제공
- 학교 현장과의 소통 강화 및 실효성 있는 정책 마련 등을 위한 목적으로 '학교 마약예방교육 지원 자문위원회' 운영(교육부)

5) 상담 및 치료가 필요한 학생 지원

- 보건소 등 전문기관과의 긴밀한 협력체계 구축을 통해 흡연 학생이 금연할 수 있도록 적극 지원(보건소, 충남금연지원센터 등)
- 마약류와 관련하여 상담, 치료 등이 필요한 경우 전문기관 연계

◈ 학생 마약류 관련 상담채널 ◈

구분	기관	신고 및 상담채널
신고, 수사	검찰	1301
	경찰	112
청소년 마약예방, 재활상담	24시 용기한걸음센터	1342
마약중독치료	인천참사랑병원	032-572-9410
	국립부곡병원	055-536-6440
	국립법무병원	041-840-5400

※ 마음을 털어놓고 싶은 학생들은 365일 24시간 무료 익명채팅 상담 '다들어줄개' 접속
▶ ① '다들어줄개' 앱, ② 카카오톡 플러스친구, ③ 페이스북 메신저, ④ 문자(1661-5004)

6) 학교 금연구역 지정·운영(「국민건강증진법」 제9조 제4항)

- 유치원 및 초·중·고등학교 운동장을 포함하여 학교 전체는 금연구역
- 간접흡연으로부터 학생의 건강권 보호 위해 학교 자체 규정 마련(학생, 교직원 포함)

  – 교내 흡연구역 설치를 금지하고, 흡연실 설치 학교 현황을 파악하여 교직원의 교내 흡연이 학생들에게 목격되어 학생들에게 부정적인 영향이 끼치지 않도록 관리

– 금연구역의 준수는 외부 방문객에도 예외 없이 적용하도록 사전 안내(표지판 및 학부모 대상 협조 안내문 포함) 실시

– 학교 내외 금연구역에서는 누구든지 흡연 위반 확인 시 관할 지자체가 적절한 조치(금연지도, 과태료 부과)를 이행할 수 있도록 지자체에 통보

– 학교 내 간접흡연 피해 방지를 위해 종사자의 경우 외부 금연프로그램 이수 권고

※ 국민권익위원회 「아동·청소년 간접흡연 피해 방지방안」(2020.12.7.) 제도개선

※ 교직원 실내뿐만 아니라 실외에서도 흡연 금지, 이를 규정으로 명시해 놓는 것이 금연 분위기 정착에 도움이 됨(국민권익위원회 권고 사항)

• 모든 유치원 및 초·중등학교의 주변 30미터까지 금연구역 확대 적용('24.8.17)

※「국민건강증진법」 제9조제6항 개정(`24.8.17. 시행)으로 학교주변 금연구역 확대

구분	과거('24.8.16.까지)	현재('24.8.17.부터)
지정 대상	• 「유아교육법」에 따른 유치원	• 「유아교육법」에 따른 유치원 • 「초·중등교육법」에 따른 학교
지정 범위	• 시설 경계로부터 10미터 이내	• 시설 경계로부터 30미터 이내
지정 주체	• 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장	

• 「교육환경보호법」 제9조제18호를 개정하여 전자담배 자동판매기 설치 금지를 추가하고, 금지구역을 유치원 주변 교육환경보호구역까지 확대('26.2.15.시행)

• 2026년 학교흡연예방사업 예산 지원: 추후 세부 계획 안내

마 행정사항

• 학생 건강증진 교육 추진 현황 [서식2]

※ 마약류 예방교육을 별도 항목으로 추진 현황 조사

바 기대효과

• 체계적인 마약 및 흡연·음주 등 약물 오남용 예방교육으로 자기주도적인 건강한 학생 육성

• 흡연율 감소로 학생 2차 피해 및 건강권 보호

• 유관기관 연계 예방교육 활동으로 교육공동체 건강 기반 구축

2 학생 마약류 포함 흡연·음주 약물 오·남용 실태조사 서식

가 학생 흡연, 음주, 마약류 포함 약물 오남용 실태조사

본 설문지는 학생 흡연·음주·마약류 포함 약물 오남용 실태에 대한 정확한 조사를 통해 지도대책을 수립하고자 하는 것이니 솔직하게 응답해 주시기 바랍니다.

※ 해당번호 앞에 ∨표 해 주세요.

※ 문항 1~3번까지는 모든 학생이 응답하여 주시기 바랍니다.

1. (모든 학생 응답) 해당학년을 표시 해 주세요.
__① 초4 __② 초5 __③ 초6 __④ 중1 __⑤ 중2 __⑥ 중3 __① 고1 __② 고2 __③ 고3

2. (모든 학생 응답) 성별을 표시해 주세요.
__① 남학생 __② 여학생

3. (모든 학생 응답) 담배를 피워 본 경험이 있습니까?
(담배는 일반 담배뿐만 아니라 전자 담배, 가향 담배 등 모든 담배 종류 포함)
__① 있다 __② 없다

4. (모든 학생 응답) 현재 담배를 피우고 있습니까?
(담배는 일반 담배뿐만 아니라 전자 담배, 가향 담배 등 모든 담배 종류 포함)
__① 피운다 __② 피우다가 끊었다 __③ 안 피운다

5. (모든 학생 응답) 흡연 없는 청정학교를 만들기 위한 학생 금연 운동의 좋은 방안이나, 학교에 하고 싶은 말이 있으면 자유로이 적어 주십시오.

※ 문항 6~12까지는 현재 담배를 피우고 있는 학생만 응답하여 주시기 바랍니다.

6. 담배를 피우게 된 계기는?
__① 단순한 호기심에서 __② 친구나 선배의 권유로
__③ TV, 잡지, 광고 등을 보고 __④ 스트레스 해소를 위해
__⑤ 멋있게 보이기 위해 __⑥ 체중조절을 위해 __⑦ 기타

7. 담배는 하루에 얼마나 피웁니까?
__① 5개피 이하 __② 6~10개피 __③ 11~15개피 __④ 16~19개피 __⑤ 1갑 이상

8. 담배는 주로 어떤 담배를 피우고 있습니까?
__① 일반 담배 __② 가향 담배 __③ 전자 담배 __④ 기타

9. 담배는 주로 어디서 구입 합니까?
__① 가게 __② 자판기 __③ 친구를 통해 __④ 기타

10. 담배를 끊어 보려고 한 적이 있습니까?
__① 전혀 없다 __② 생각은 해보았으나 실천해 보지 않았다
__③ 끊으려고 하다가 힘들어서 그만두어 버렸다

11. 담배를 끊고 싶은 이유는 무엇입니까?
__① 건강이 나빠질 것 같아서 __② 부모님의 간곡한 권유로
__③ 이성친구가 끊으라고 요구해서 __④ 주변의 금연 분위기에
__⑤ 기타( )

12. 현재 금연할 의사는 있습니까?
__① 꼭 끊겠다 __② 가급적 끊겠다
__③ 아무 생각도 없다 __④ 별로 끊고 싶지 않다
__⑤ 절대로 끊고 싶지 않다

13. 학교에서 금연 멘토 프로그램 운영으로 담배를 피우는 학생들의 금연을 도와주려고 한다면 도움을 받을 의사가 있습니까?
__① 있다 __② 없다

※ 문항 13~17까지는 모든 학생이 응답하여 주시기 바랍니다.

14. 최근 30일 동안, 1잔 이상 술을 마신 날은 며칠입니까?
__① 최근 30일 동안 없다 __② 월 1~2일
__③ 월 3~5일 __④ 월 6~9일
__⑤ 월 10~19일 __⑥ 월 20~29일 __⑦ 매일

15. 최근 30일 동안, 정신을 잃거나 기억을 못 할 정도로 술을 마신 날은 며칠입니까?
__① 최근 30일 동안 없다 __② 월 1~2일
__③ 월 3~4일 __④ 월 3~4일
__⑤ 월 5일 이상

16. 치료목적을 제외하고, 지금까지 습관적으로 사용한 약물이나 물질이 있습니까?
※ 예시: 각성제, 신경안정제, 부탄가스, 본드, 부착형 마약류 진통제 등
__① 없다 __② 있다

17. 최근 1년(12개월) 동안 마약류 예방교육을 받은 적이 있습니까?
__① 있다 __② 없다

18. 최근 1년(12개월) 동안 음주 등 약물 오남용 예방교육을 받은 적이 있습니까?
__① 있다 __② 없다

‘한 눈에 쏙’
건강하고 행복한 학교 만들기를 위한
2026 건강관리업무

VII

건강증진

단위업무	주요내용	참고·서식자료
계획	1. 비만 예방 관리 계획 수립 ▪ 전년도 건강검사 결과를 평가하여 계획 수립 권고 ▪ 건강증진계획에 비만예방을 위한 계획 수립 권고 (학기 초 학교보건운영계획 내 포함 가능)	• 2026 비만 예방 추진 계획(p.210)
	2. 불균형 체형 예방 관리 계획 수립	• 2026 불균형 체형 예방·관리 지원 계획(p.214)
운영	**1. 비만 학생 현황 파악** ▪ 체질량지수로 산출한 비만 판정 결과로 비만 학생 파악	
	2. 비만 예방 관리 및 교육 실시 ▪ 교육과정과 연계한 비만예방 교육 – 각종 교내 행사 시 비만예방 활동 연계하여 추진 – 보건교사, 담임, 체육교사, 영양(교)사와 연계하여 지도·관리 ▪ 건강한 체중관리 방안 자체 마련 후 실시	• 도담도담 충남비만예방교육누리집(www.cne.go.kr/diet/main.do) • 학생건강정보센터(교육부)(www.schoolhealth.kr) • 학교보건자료실(충남교육청)(www.cne.go.kr)
	3. 비만예방사업「움직이는 교실!, 건강한 학교!」운영 ▪ 대상; 희망학교 운영(단위: 소규모 동아리, 개별 학급) ▪ 기간: 2026. 4. ~ 2026. 12, ▪ 내용 – 동아리·학급에서 소규모 비만예방 활동 실시 – 교과 교사(보건선택교과 등) 진로지도 연계 비만예방 활동 실시 – 비만예방 교육자료 신청하여 비만 사업 운영 – 비만예방을 위한 활동 예산 지원 ▪ 행정사항 – 운영신청서 제출 – 활동 종료 후 보고서, 사전·사후 비만율, 정산서 제출	[서식15-1] 운영 신청서 [서식15-2] 참여 학생 비만율 통계 [서식15-3] 운영 정산서
	4. 척추옆굽음증 1차 검사 실시 ▪ 초등학교 척추옆굽음증 검사 – 검진대상: 초등·특수학교 6학년 학생 – 검진기간: 2026. 4. ~ 10. – 검진기관: 대한결핵협회 대전·세종·충남지사 – 검진방법: 학교 방문 검진(X-선 촬영) – 검진비: 1인당 8,300원(도교육청에서 일괄 납부) – 협조사항 • 검진기관과 일정 협의 • 사전 가정통신문 발송, 검사 및 개인정보 동의서 징구 • 척추옆굽음증 의심 학생 가정에 결과 안내 및 상담 ▪ 중·고등학교 척추옆굽음증 검사 – 검진대상: 중학교 1, 3학년·고등학교 1, 2, 3학년 학생 – 검진방법: 건강검진과 결핵검사 시 검진	• 척추옆굽음증 1차 검진 가정통신문(예시)(p.219)

단위업무	주요내용	참고·서식자료
운영	**5. 척추옆굽음증 2차 검진비 지원** ■ 대상: 1차 검진 결과 의심 대상자 ■ 지원금액 – 단순검사: 1인당 50,000원 – 정밀검사: 1인당 500,000원 ■ 추진 절차 – 1차 검사 결과 의심 학생 상담 및 가정통신문 발송 – 학생 개별 검진 후 결과 및 증빙자료 수합 – 자료집계로 2차 검진비 신청 – 교부된 예산 집행	[서식] 척추옆굽음증 2차 검진비 지원 신청자 명단
	6. 보조기 지원 ■ 대상: 2차 검진 후 보조기 처방을 받은 학생 저소득층 학생을 우선 지원 ■ 지원금액: 100만원 ■ 추진 절차 – 자료집계로 보조기 지원비 신청 – 심사위원회 선정 결과 교부된 예산 집행	
	7. 불균형 체형 예방 및 관리 프로그램 운영교 ■ 대상: 초·중·고 34교 ■ 기간: 2026. 4. ~ 2026. 12. ■ 내용 – 학생 체형 분석 및 처방 – 학생 상황에 맞는 교육 및 운동 프로그램 운영 – 학교별 체육·보건·담임교사 등 학생 지원을 위한 지원 체계 구축 – 학생 불균형 체형 예방 및 관리 프로그램 개발·운영 결과 보급	• 불균형 체형 예방 및 관리 프로그램 운영교(p.217)
	8. 불균형 체형 예방 교육 ■ 교육자료 지원 – 대상: 초·중·고 50교 내외 – 기간: 2026. 11. – 내용: 척추 모형, 스트레칭 밴드 등 교육자료 구입비 지원 ■ 교육자료 안내 –「영상표시단말기 증후군 이해와 대처」교육자료 – 리틀이들과 함께하는 VDT(영상표시단말기)증후군 예방 스트레칭 알리미 – VDT(영상표시단말기)증후군 예방 운동 동영상	• 학생건강정보센터(교육부) (www.schoolhealth.kr) • 학교보건자료실(충남교육청) (www.cne.go.kr)
평가	1. 평가 및 차기년도 계획에 반영	
	2. 보고 ■ 학생 건강증진 교육 실시현황 보고	[서식] 학생 건강증진 교육 실시현황

1 2026 비만 예방 추진 계획

가 관련근거

- 학교보건법 제7조(건강검사 등)
- 학교보건법 제7조2(학생건강증진계획의 수립·시행)
- 충청남도교육청 학생 비만 예방교육 활성화에 관한 조례
- 2026년 충청남도교육청 학생 건강관리 추진 계획

나 추진배경

- 인스턴트 섭취율 증가, 신체활동 저하 등의 사유로 과체중 및 비만 학생 비율 등 증가
- 기존 학교 비만 예방 프로그램을 보완하여 표준화된 프로그램 개발 보급 필요
- 교육생태계 복원을 위하여 지역사회·가정 연계, 사제동행 비만 건강관리 필요성 대두

다 추진목적

- 학생 비만 예방교육 실시로 균형 잡힌 신체발달 촉진 및 건강한 생활 도모
- 교육생태계 복원을 위한 지역사회·가정 연계, 사제동행 비만 건강관리 활성화
- 「움직이는 교실! 건강한 학교!」 비만예방사업 운영을 통하여 충남 학생의 비만율 저하

라 기본방침

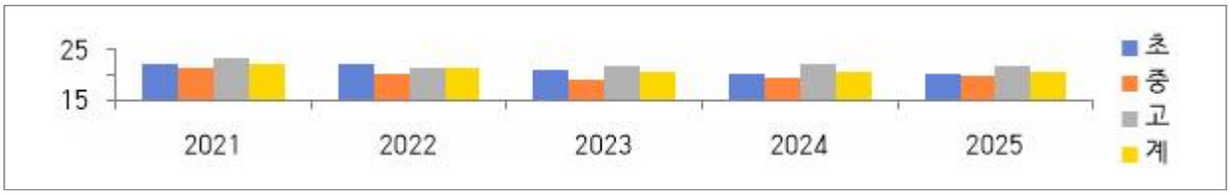
- 단위학교 비만예방교육 내실화
- 「움직이는 교실! 건강한 학교!」 통하여 교육공동체가 협력하여 비만예방교육 활성화 및 적극적 참여 유도
- 비만예방교육을 위한 담당교사 역량 강화 연수 실시
- 학년말 설문조사를 통한 사업결과 평가 및 개선방안 마련

마 현 황

학교급·성별 비만도 현황

(단위: %)

구분		2025년	2024년	2023년	2022년	2021년
초	남	23.5	23.7	24.7	26.1	26.3
	여	16.8	17.0	17.6	17.8	18.3
	계	20.1	20.4	21.2	22.1	22.4
중	남	23.4	23.0	22.2	23.7	26.0
	여	15.9	15.9	15.7	16.0	16.4
	계	19.7	19.6	19.1	20.1	21.3
고	남	25.4	25.0	24.5	25.0	27.1
	여	18.5	19.0	18.7	17.7	19.1
	계	22.0	22.2	21.7	21.5	23.5
총계	남	24.1	23.9	24.0	25.2	26.4
	여	17.1	17.2	17.4	17.4	18.0
	계	20.6	20.7	20.8	21.4	22.4

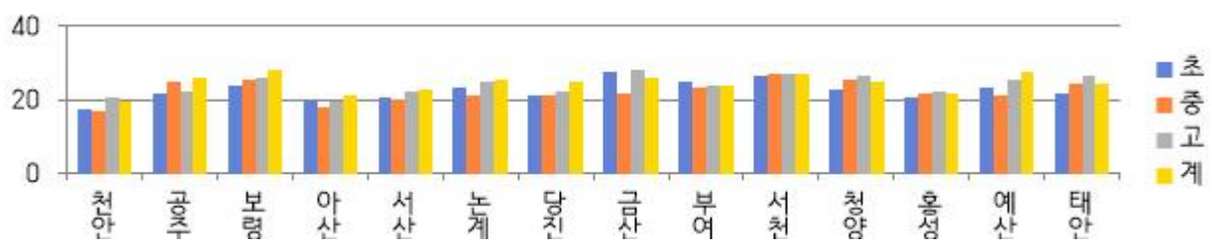


– 체질량 지수에 의한 비만도는 2021년 이후 비만도 감소추세를 보이고 있음
– 남학생이 여학생에 비해 비만도 높음
– 2025년 학교급별 비만도는 고등 > 초등 > 중등 순임

2025년 지역별 비만도 분석결과

(단위: %)

구분	천안	공주	보령	아산	서산	논산계룡	당진	금산	부여	서천	청양	홍성	예산	태안
초	17.4	21.8	23.9	19.4	20.8	23.1	21.4	27.7	24.8	26.7	22.8	20.8	23.2	21.9
중	17.1	24.8	25.2	17.9	20.0	21.3	21.4	21.7	23.1	26.8	25.5	21.8	21.2	24.5
고	20.5	22.3	25.8	19.6	22.4	24.7	22.3	27.9	24.0	27.2	26.5	22.2	25.4	26.7
특수	22.8	36	37.6	27.2	26.9	32.0	35.0						41.3	
계	19.5	26.2	28.1	21.0	22.5	25.3	25.0	25.8	24.0	26.9	24.9	21.6	27.8	24.4

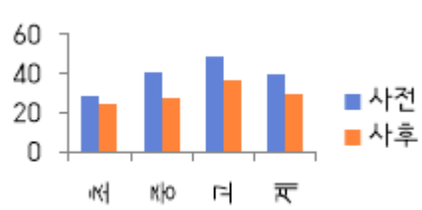


– 지역별 비만도는 보령 > 예산 > 서천 > 공주 > 금산 > 논산계룡 > 당진 > 청양 > 태안 > 부여 > 서산 > 홍성 > 아산 > 천안 순

2025년 「움직이는 교실!, 건강한 학교」 운영 결과

구분	참여교(교)	학생수(명)	비만 이상 (명/%) 사전	사후	증감
초	45	2488	585(28.6%)	527(24.9%)	−58(−3.7%)
중	11	366	128(40.8%)	82(27.2%)	46(−12.6%)
고	9	279	108(48.7%)	92(36.7%)	16(−12.0%)
계	65	3,133	821(39.4%)	701(29.7%)	120(−9.8%)
분석	비만 학생: −9.8%(−120명)↓				

비만 학생 사전·사후 비교(%)



대 책

- 체질량지수에 의한 학생 비만도는 2021년 이후 감소 추세를 보임. 2021년 ~ 2025년 「움직이는 교실! 건강한 학교!」 운영으로 비만율 제고에 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석됨
- 학교급별 비만도는 2023~2025년 고등 > 초등 > 중등 순으로, 별도 프로그램(사업) 운영율은 초등 > 중등 > 고등 순으로 나타남. 이는 입시위주의 교육과정으로 책상에 앉아있는 시간이 늘어남에 따라 고등학교 비만율이 높은 것으로 파악이 되며, 이를 반영한 비만예방 프로그램 개발을 마련하여야 할 것으로 보임.

바 세부 추진 계획

1) 비만예방교육

가) 학생 비만예방 교육 운영 방향

- 교육과정과 연계한 비만예방 교육으로 지속적이고 체계적인 교육 실시
  - 각종 교내행사 시 비만예방 활동 연계하여 추진
  - 보건교사, 담임, 체육교사, 영양(교)사와 연계하여 지도·관리
- 학생 비만 예방·관리 추진

※ 학교보건법 제7조의2 3항 의거 전년도 건강검사의 결과를 평가하여 이를 바탕으로 학생건강증진계획 수립·시행하여야 함. 건강증진계획에 비만예방을 위한 계획 수립 권고(건강증진계획은 수립 시기는 학교장이 결정, 학기 초 학교보건운영계획 내 포함 가능)

- 비만학생 현황 파악
  - 체질량지수로 산출한 비만 판정 결과로 비만 학생 파악

※ 2020년「학교건강검사규칙」개정에 의거하여 신체발달 측정 및 건강조사 1학기 내 완료

나) 적정체중 유지 및 비만 예방을 위한 건강한 체중관리 방안 마련

- 규칙적인 운동과 올바른 식습관 형성 교육 강화 및 학교별 자체 특성에 맞는 학생 건강관리 협의체 구성
- 학생 건강관리 및 건강한 체중관리를 위해 지역사회 자원 적극 활용

2) 비만예방사업「움직이는 교실!, 건강한 학교!」운영

가) 참여대상: 희망학교 운영(단위: 소규모 동아리, 개별 학급)

나) 운영기간: 2026. 4. ~ 2026. 12.

다) 운영 내용

- 동아리·학급에서 소규모 비만예방 활동 실시
- 교과 교사(보건선택교과 등) 진로지도 연계 학생과 함께하는 비만예방활동
- 비만예방 교육자료(올바른 성장 도담도담) 신청하여 비만 사업 운영
- 비만 예방을 위한 활동 예산 지원(57교, 120만원)
  - 비만예방교육의 일환으로 추진되는 교육·활동비 등 편성
  - 업무추진비 5% 이내
  - 충청남도교육청 학교회계 세출예산 집행지침 준수하여 집행
  - 유의사항
    - 교육활동과 관련없는 물품이나 비품구입 금지
    - 지원받은 예산은 특별한 사유가 없는 한 반납하지 않도록 함

라)「움직이는 교실! 건강한 학교!」세부영역 안내

「움직이는 교실! 건강한 학교!」 영역	필수	선택
• 「움직이는 교실! 건강한 학교!」 운영 신청서 [서식 15-1]	∨	
• 학생 대상 비만 예방 교육	∨	
• 교내 비만학생 현황 파악(신체발달상황 측정)	∨	
• 교내 비만학생 관리(아래 내용 중 학교 실정에 맞게 선택하여 실시)		∨
– 소규모 학교스포츠클럽 운영		∨
– 가정 연계 비만 사업 운영		∨
– 사제동행 비만 사업 운영		∨
– 보건소 연계 비만예방 사업 운영		∨
– 충남교육청 제공 8주 비만예방 교육 실시 (보면 볼수록 건강해지는 보건교육, 비만편, 2021. 1.)		∨
• 동아리·학급 단위 특색 운동 프로그램 실시(자체고안) ※ 예시) – 담임교사와 함께하는 아침 줄넘기 운동시간 – 건강걷기를 실천하는 맨발걷기 운동 – 우리 반 특색 비만예방 운동! 음악 줄넘기		∨
• 비만예방활동 자료 탑재 - 도담도담 누리집 (http://www.cne.go.kr/diet/main.do)	∨	
• 「움직이는 교실! 건강한 학교!」 사전·사후 비만율 제출 [서식 15-2]	∨	
• 「움직이는 교실! 건강한 학교!」 정산서 제출 [서식 15-3]	∨	
• 「움직이는 교실! 건강한 학교!」 결과 보고서 제출		∨

마) 시상계획

구분	훈격	내용
개인 (업무담당자) 기관	교육감 표창	– 「움직이는 교실! 건강한 학교!」 보고서 제출교 중 선정 ※ 응모편 수 고려하여 교육감 표창 수 조정 가능

사 행정사항(움직이는 교실! 건강한 학교! 운영교 해당)

제출 내용	구분	제출처	시기	제출방법/서식
운영교 신청서	필수	학교 → 도교육청	2026. 03. 13.(금)	자료집계/ [서식15-1]
활동참여학생 비만율 통계	필수	학교 → 도교육청	2026. 12. 04.(금)	자료집계/ [서식15-2]
정산서 제출	필수	학교 → 도교육청	2026. 12. 04.(금)	자료집계/ [서식15-3]
보고서 제출	선택	학교 → 도교육청	2026. 11. 06.(금)	

2 2026 불균형 체형 예방 및 관리 지원 계획

가 세부 추진 계획

- 충청남도교육청 학생 불균형 체형 관리 지원에 관한 조례(제5263호)
- 2026 충청남도교육청 주요업무계획
- 2026 충청남도교육청 학생 건강관리 추진 계획

나 추진배경

- 전자기기 사용증가 및 자세이상으로 인한 관련 질환 발생률 증가
- 학생들의 균형잡힌 신체발달을 지원하고 올바른 생활습관 교육 필요

다 추진목적

- 학생 척추옆굽음증 예방 및 조기 개입으로 건강한 학교생활 도모
- 불균형 체형 예방 교육으로 학생들의 건강관리 능력 강화

라 기본방침

- 초등학교 6학년 대상으로 1차 척추옆굽음증 검사 실시
- 협약기관인 대한결핵협회 대전·세종·충남지사의 방문 검진
- 단위 학교 별 초 6학년, 중·고등학생 중 의심 학생에 대한 2차 개별 검진 및 상담 실시
- 정밀검사 및 보조기 구입 관련 비용 지원으로 학생 및 학부모 부담 경감
- 학생 불균형 체형 예방 및 관리 프로그램 운영교 34교 지원
- 불균형 체형 예방교육을 위한 담당교사 역량 강화 연수 실시
- 학년말 설문조사를 통한 사업 결과 평가 및 개선방안 마련

마 실태분석

2025년 초등학교 6학년 척추옆굽음증 검사 결과

(단위: 명, %)

구분	검진인원	척추 유소견자 발견 현황		비고
		유소견자	비율	
계	17,636	199	1.1	
남학생	9,106	27	0.3	
여학생	8,530	172	2.0	

2021 ~ 2025 척추옆굽음증 유증상자 현황

(단위 : 명)

구분	2021	2022	2023	2024	2025
계	1,352	2,447	3,130	2,397	1,383
초	75	288	523	472	199
중	461	1,230	1,702	1,098	468
고	816	929	905	827	716

2025 척추옆굽음증 2차 정밀검사 및 보조기 지원 현황

(단위 : 명)

구분	2차 검진비 지원						보조기 지원		
	단순검사			정밀검사					
	전체	남학생	여학생	전체	남학생	여학생	전체	남학생	여학생
계	110	27	83	11	2	9	15	1	14
상반기	44	8	36	3	0	3	3	0	3
하반기	66	19	47	8	2	6	12	1	11

2024년 척추옆굽음증 검사 결과

구분	성별	전체(명)	1차검진 결과 척추옆굽음증 의심자 수(명)		
			건강검진	결핵검사(결핵협회)	전체
초6	남	9,106		27	27
	여	8,530		172	172
	계	17,636		199	199
중	남	20,737	48	30	78
	여	18,891	238	152	390
	계	39,628	286	182	468
고	남	19,874	100	104	204
	여	18,338	236	276	512
	계	38,212	336	380	716

시사점

- 초등학교 6학년 척추옆굽음증 검사 결과 여학생 발병율이 매우 높음
- 척추옆굽음증 유증상자 현황은 중학교에서 많이 발생
- 2025 척추옆굽음증 2차 정밀검사 및 보조기 지원 현황은 여학생이 매우 높음
- 척추옆굽음증 검사를 통해 바른 자세에 대한 관심 증가
- 생활환경, 예방교육, 신체활동 프로그램 등을 연계하여 추진해야 함

바 세부 추진 계획

1) 척추옆굽음증 검사 지원

가) 초등학교 6학년 대상 척추옆굽음증 검사

- 검진대상: 도내 초등학교 6학년
- 검진기간: 2026. 3.～10.
- 검진기관: 대한결핵협회 대전·세종·충남지사
- 검진방법: 학교 방문 검진(X-선 촬영)
  - 검진비: 1인당 8,170원(도교육청에서 일괄 납부)
- 협조사항
  - 검진기관과 일정 협의
  - 사전 가정통신문 발송, 검사 및 개인정보 동의서 징구
  - 척추옆굽음증 의심 학생 가정에 결과 안내 및 상담
  - 척추옆굽음증 의심 학생 2차 검진비 지원신청 및 지급

나) 척추옆굽음증 2차 검진비 지원

- 지원대상: 초 6, 중 1/3학년, 고 1~3학년
  - 1차 검진(중·고등학생은 건강검진과 결핵검사) 결과 의심 대상자
- 지원금액
  - 단순 엑스선 촬영(X-ray) 진행 시: 1인당 50,000원
  - 정밀검사(MRI 등) 진행 시: 1인당 500,000원
- 추진절차
  - 1차 검진 결과 의심학생 상담 및 가정통신문 발송
  - 학생 개별 검진 후 결과 및 증빙자료 수합(증빙자료)
  - 자료집계로 2차 검진비 신청(도교육청)
  - 교부된 예산 집행(진료비 지급 후 잔액 발생 시 관련 교육자료 구입)

※ 진행 순서

1차 검사	→	결과 안내 및 개별 검진	→	증빙자료 수합	→	2차 검진비 신청	→	교부 예산 집행
▸ 척추옆굽음증 검사(초 6) ▸ 건강검진(중1, 고1) ▸ 결핵검사(중3, 고2, 3)		▸ 의심학생 상담 ▸ 가정통신문 발송 ▸ 학생 개인별 2차 검진		▸ 2차 검진비 지원을 위한 증빙자료 수합 ▸ 대상자별 검진 내용 확인		▸ 도교육청 자료집계 신청		▸ 학교별로 교부된 예산을 품의하여 지출

다) 보조기 지원

- 지원대상: 2차 검진 결과 보조기 착용 처방을 받은 학생
  - 저소득층 학생을 우선 지원
- 선정방법: 심사위원회 구성하여 선정
- 지원금액: 100만원
- 예산집행: 교육지원청으로 배부

라) 추진일정

시기	내용	담당	비고
2026. 2.	학생 불균형 체형 예방 및 관리 지원 추진계획 안내	도교육청	
2026. 2.	교육과정과 연계한 예방교육 계획 수립	각급 학교	
2026. 3. ~ 10.	초 6학년 척추옆굽음증 검사	각급 학교, 검진 기관	
2026. 7. 3.(금)	척추옆굽음증 2차 검진비 신청	교육지원청별 수합 제출	초·중·고
2026 7. 10.(금)	2차 검진비 및 보조기 지원 결과 안내	도교육청	
2026. 11. 20.(금)	척추옆굽음증 2차 검진비 신청	교육지원청별 수합 제출	초·중·고
2026. 11. 27.(금)	2차 검진비 및 보조기 지원 결과 안내	도교육청	
2026. 12. 18.(금)	척추옆굽음증 2차 검사 결과 및 정산서 제출	교육지원청별 수합 제출	초·중·고

2) 학생 불균형 체형 예방교육을 위한 교육자료 지원

- 대상: 초·중·고 50교 내외
- 기간: 2026. 11. (추후 별도공문 안내)
- 내용
  - 척추 모형. 스트레칭 밴드 등 교육자료 구입비 지원

3) 학생 불균형 체형 예방 및 관리 프로그램 운영교

- 대상: 초·중·고 34교
- 기간: 2026. 4. ~ 2026. 12.
- 내용
  - 불균형체형 예방을 위한 활동 예산 지원(34교, 300만원)
    - 불균형체형 예방 교육의 일환으로 추진되는 교육·활동비 등 편성
    - 업무추진비 5% 이내
    - 충청남도교육청 학교회계 세출예산 집행지침 준수하여 집행
    - 유의사항
      - 교육활동과 관련없는 물품이나 비품구입 금지
      - 지원받은 예산은 특별한 사유가 없는 한 반납하지 않도록 함
  - 학생 체형 분석 및 처방
  - 학생 상황에 맞는 교육 및 운동 프로그램 운영
  - 학교별 체육·보건·담임교사 등 학생 지원을 위한 지원 체계 구축
  - 학생 불균형체형 예방 및 관리 프로그램 개발·운영 결과 보급
- 행정사항
  - 신청방법: 운영신청서 제출(자료집계)
  - 활동 종료 후 정산서 제출
- 추진일정

시기	내용	담당	비고
2026. 3. 13.(금)	학생 불균형 체형 예방 프로그램 운영교 신청	학교	자료집계
2026. 3. 27.(금)	운영교 확정 안내 및 예산 교부	도교육청	34교
2026. 4.	운영교 담당자 협의회	도교육청	추후 안내
2026. 4.	운영 계획 수립	학교	
2026. 4. ~ 12.	학생 불균형 체형 예방 프로그램 운영	학교	
2026. 4. ~ 12.	운영교 컨설팅	도교육청	희망교
2026. 11. 20.(금)	우수사례 보고서 및 정산서 제출	학교	교육감 표창

4) 업무담당자 전문성 강화 지원

- 도교육청 업무담당자의 컨설팅
- 담당자 연수: 세부계획 추후 안내

5) 사업 개선을 위한 설문조사 실시

- 대상: 업무 담당교사
- 시기: 12월 예정
- 내용
  - 척추옆굽음증 검사 지원사업 효과성 및 만족도
  - 학생 불균형 체형 예방 및 지원 관리 자료 개발에 관한 사항

사 기대효과

- 학생 척추옆굽음증 예방 및 관리 체계 구축으로 건강한 학교생활 도모
- 불균형 체형 예방교육 및 프로그램 운영으로 학생 건강관리 능력 강화
- 지역사회·가정 연계·사제동행 불균형체형 예방 프로그램 활성화로 건강증진교육 및 인성교육 통합

3 교육자료 안내

「올바른 성장을 위한 도담도담」 교육자료, [충청남도교육청 2021 개발]

- 탑재: 충남비만예방교육 누리집 도담도감 / 자료터 / 일반자료실 121번

「올바른 성장을 위한 도담도담, 다음이야기」 교육자료, [충청남도교육청 2022 개발]

- 탑재: 충남비만예방교육 누리집 / 체육건강과 학교보건 자료실 331번
- 탑재: 충남비만예방교육 누리집 도담도감 / 자료터 / 일반자료실 122번

「보면볼수록 건강해지는 보건교육-초등학생용」 교육자료, [충청남도교육청 2021 개발]

- 탑재: 충남비만예방교육 누리집 도담도감 / 자료터 / 비만예방교수학습자료 / 초등학교 35번

「보면볼수록 건강해지는 보건교육-중등학생용」 교육자료, [충청남도교육청 2021 개발]

- 탑재: 충남비만예방교육 누리집 도담도감 / 자료터 / 비만예방교수학습자료 / 중등학교 27번, 고등학교 6번)

「영상표시단말기 증후군 이해와 대처」 교육자료, [충청남도교육청 2022 개발]

- 탑재: 충남교육청 누리집 / 체육건강과 학교보건 자료실 328번

리틀이들과 함께하는 VDT(영상표시단말기)증후군 예방 스트레칭 알리미

- 탑재: 충남교육청 누리집/체육건강과 학교보건 자료실 327번
- 내용: 시원한 어깨 운동, 개운한 목 운동 등
- 개발처: 국민건강보험공단 제작, 2022

VDT(영상표시단말기)증후군 예방 운동 동영상

- 탑재: 충남교육청 누리집/체육건강과 학교보건 자료실 332번
- 내용: VDT증후군 예방을 위한 틈틈이 체조
- 개발처: 국민건강보험공단 제작, 2022
- 링크주소
  - 초등용 https://youtu.be/zX7OLFl4R9s
  - 중고등용 https://youtu.be/UnvuYjoCcMs

「세계 최강 거북목」 그림책

- 탑재: 충남교육청 누리집/체육건강과 학교보건 자료실 357번

척추옆굽음증(척추측만증) 1차 검진 실시 안내

척추옆굽음증(척추측만증)은 골격 성장이 왕성하고 성장이 완료되는 청소년기에 원인을 알 수 없는 특발성으로 주로 발병되며 요통·어깨통증·두통 유발, 갈비뼈·반뼈의 변형으로 심폐 기능 이상 유발, 호르몬과 소화기능 불균형 초래, 집중력과 성장 장애 유발 등 건강 및 학습 장애를 초래할 수 있습니다.

충청남도교육청에서는 척추옆굽음증(척추측만증) 학생 조기발견 및 지속적 추구 관리를 위하여 척추옆굽음증 예방교육, 척추옆굽음증 검진을 지원하는「학생 불균형 체형 예방 및 관리 지원」사업을 추진하고 있습니다.

이에 척추옆굽음증 1차 검진을 실시하고자 합니다. 검진을 희망하시는 학부모님께서는 아래 신청서와 개인정보 제3자 제공 동의서를 제출해 주시고 검진이 원활하게 이루어질 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

1. 일시: *2026년 ○월 ○일 오전 ○○:○○*
2 장소: *본교 주차장*
3. 방법: 이동검진차량에서 흉부 엑스선 촬영
4. 대상: 초등학교 6학년 학생
5. 1시행기관: 대한결핵협회 대전·세종·충남지부
6. 검사비용: 무료(충남교육청)
7. 준비사항: 당일 목걸이 등의 금속류를 하지 않아야 함.
8. 검사 후 결과처리
   - 정상인 경우 따로 통보하지 않으며 이상이 있는 경우에는 차후 가정통신문을 발송합니다.
   - 검사결과 척추측만증으로 의심되는 학생은 개별로 병원을 방문하셔서 2차 검진을 실시해 주시기 바랍니다.(2차 검진 비용 사후 지원 예정)

20 . . .

○○학교장

……〈절 취 선〉……

척추옆굽음증(척추측만증) 1차검진 희망 신청서

학교명	학년 반	번호	이름	동의 여부	보호자 서명
○○초등학교	*4-1*	*1*	*○○○*		

척추옆굽음증(척추측만증) 1차 검진 결과 안내

학부모님 댁내 평안하신지요?

알려 드릴 말씀은 자녀분에 대하여 실시하였던 척추옆굽음증(척추측만증) 검사 결과 척추옆굽음증(척추측만증) 의심자로 확인되었습니다.

척추옆굽음증(척추측만증)은 원인을 알 수 없는 특발성척추옆굽음증(특발성척추측만증) 환자가 85~90%이며, 골격성장이 왕성하며 성장이 완료되는 청소년기에 주로 발병 됩니다. 청소년기 척추옆굽음증(척추측만증)은 요통·어깨통증·두통유발, 갈비뼈·골반뼈의 변형으로 심폐 기능 이상 유발, 호르몬과 소화기능 불균형 초래, 집중력과 성장 장애 유발 등 건강 및 학습 장애를 초래할 수 있습니다.

특발성측만증은 전 인구의 2~3%까지 달하는 매우 흔한 질환이지만 다행히 대부분의 경우(90% 이상)에서 건강과 일상생활에 영향을 미치지 않으므로 치료가 필요하지 않지만, 치료 필요성을 확인하기 위해 전문의에게 진료를 받아 보는 것이 좋습니다.

아울러 충청남도교육청에서는 학생들의 불균형 체형 예방 및 관리를 지원하기 위해 2차 검진비를 지원하오니, 2차 검진비 지원을 희망하시는 학부모님께서는 가까운 병원에서 개별 검진 후 해당 서류를 학교에 제출하여 주시기 바랍니다.

[증빙서류]
※ 단순 엑스선 촬영(X-ray) 진행 시
① 진료비계산서(영수증), ② 2차검진 확인서 ③ 개인정보 제3자 제공동의서 제출
※ 정밀검사(MRI) 진행 시
① 진료비계산서(영수증), ② 2차검진 확인서, ③ 진단서 또는 소견서, ④ 개인정보 제3자 제공동의서 제출
※ 2차 검진비 신청을 위한 개인정보제공동의서는 중·고등학교 학생만 해당, 초등학교는 1차 검진 시 제출한 동의서로 갈음

20 . . .

○○학교장

……〈절 취 선〉……

「척추옆굽음증(척추측만증) 2차검진 확인서」

항목	학교명	학년 반	번호	이름	검진 소견	보호자 서명	병원명 (전화번호)	담당의사 확인(서명)
X-ray	*○○초등학교*	*4-1*	*1*	*○○○*	*만곡의 각도가 20도*			
MRI								

○○학교장 귀하

개인정보 제3자 제공동의서

[제공하는 개인정보의 항목]

가. 학교는 아래와 같은 내용으로 개인정보를 충청남도교육(지원)청, 대한결핵협회 대전·충남·세종에 요청(제공)하고자 합니다.

- 학교명, 학년 반, 생년월일, 성명, 성별, 척추옆굽음증(척추측만증) 진단명, 치료 내역

[개인정보 제공 목적]

가. 학교는 다음과 같은 이유로 개인정보를 요청(제공)합니다.

- 2026년 충청남도교육청 척추옆굽음증(척추측만증) 검사 비용 지원, 보조기 지원, 교육자료 제공, 척추옆굽음증 추구관리 등)의 효과적인 추진을 위함

[개인정보 보유기간]

가. 수집된 개인정보의 보유기간은 당해 학년(1년) 또는 개인정보 삭제 신청 시까지입니다.

나. 또한 삭제 요청시 개인의 정보를 재생이 불가능한 방법으로 즉시 파기합니다.

※ 귀하는 이에 대한 동의를 거부할 수 있으며, 동의가 없을 경우 이와 관련된 업무 진행이 불가능할 수 있음을 알려 드립니다.

개인정보의 제3자 제공에 동의하십니까?	□ 동의함	□ 동의하지 않음

※ 개인정보는 정보주체의 동의 없이 동의한 내용 외의 다른 목적으로 활용하거나 제3자에게 제공되지 않습니다.

성 명 : (인)

※ 만 14세 미만 아동인 경우 반드시 법적대리인의 동의가 필요합니다

년 월 일

보호자(법정대리인)성명 : (인)

연 락 처 :

관 계 :

'한 눈에 쏙'
건강하고 행복한 학교 만들기를 위한
2026 건강관리업무

VIII

부록

1 행정사항 및 보고서식

※ 상기 보고사항에 대한 학교 제출방법은 교육지역청별 자료집계 탑재 여부 반드시 확인
※ 엑셀 보고서식은 충청남도누리집 – 부서별누리집 – 체육건강과 – 학교보건 게시판 탑재

순	보고 목록	보고기한		보고서식
		학교 → 교육지원청 (자료집계)	교육지원청 → 교육청 (공문)	
1	• 보건교육 실시 현황(보건과목 선택 포함) * 하반기 보고: 1년 실적 누적	<계획> 2026. 06. 26.(금)	2026. 07. 03.(금)	[서식 1]
		<실적> 2026. 12. 11.(금)	2026. 12. 18.(금)	
2	• 학생 건강증진 교육 실시현황 * 마약류 포함한 약물오남용 교육 * 하반기 보고: 1년 실적 누적	<상반기> 2026. 06. 26.(금)	2026. 07. 03.(금)	[서식 2]
		<하반기> 2026. 11. 27.(금)	2026. 12. 04.(금)	
3	• 보조인력 배치현황	2026. 05. 01.(금)	2026. 05. 08.(금)	[서식 3]
4	• 출장검진·1개 검진기관 승인 신청·결과	2026. 03. 13.(금)	2026. 04. 17.(금)	[서식 4]
5	• 학생 1·4학년 건강검진 및 별도검사 추진현황	2026. 11. 20.(금)	2026. 12. 04.(금)	[서식 5]
6	• 학생건강검진 결과처리 현황	2026. 11. 20.(금)	2026. 12. 04.(금)	[서식 6]
7	• 신체의 발달상황(비만도) 통계표	2026. 08. 28.(금)	2026. 09. 11.(금)	NEIS 제출
8	• 학생건강검진 통계표	2026. 11. 20.(금)	2026. 12. 04.(금)	[서식 7]
9	• 학생 흡연·음주·약물오남용 실태보고	2026. 06. 05.(금)	2026. 06. 12.(금)	[서식 8]
10	• 당뇨 등 학생 재학 지원 현황 * 희귀난치성 질환 등 건강장애 학생 포함	2026. 03. 20.(금)	2026. 03. 27.(금)	[서식 9]
11	• 학교 심폐소생술 교육 실시 현황 * 학생 심폐소생술 교육 실시 현황(2회보고) – 12월 실시현황 보고: 누적보고 * 교직원 심폐소생술 교육 실시현황(1회보고)	<학 생>		[서식 10]
		상반기	2026. 06. 26.(금) / 2026. 07. 03.(금)	
		하반기	2026. 12. 04.(금) / 2026. 12. 11.(금)	
		<교 직 원>		
		2026. 12. 04.(금)	2026. 12. 11.(금)	
12	• 보건실 설치 현황	2026. 04. 03.(금)	2026. 04. 10.(금)	[서식 11]
13	• 학생 감염병 예방·관리 계획 수립 현황	2026. 04. 10.(금)	2026. 04. 17.(금)	[서식 12]
14	• 방역물품 비축현황(1학기) • 방역물품 비축현황(2학기)	2026. 04. 10.(금) 2026. 09. 11.(금)	2026. 04. 17.(금) 2026. 09. 18.(금)	[서식 13]
15	• 감염병 발생에 따른 조치현황	역학조사, 언론보도 등 특이사항 발생시		[서식 14]
16	• 「움직이는 교실! 건강한 학교!」 – 운영교 신청서 – 활동참여학생 비만율 통계 – 보고서 제출 – 정산서 제출	2026. 03. 13.(금) 2026. 12. 04.(금) 2026. 11. 06.(금) 2026. 12. 04.(금)		[서식 15]
17	• 척추옆굽음증 2차 검진비 지원 신청자 명단		1차 2026. 07. 03.(금)	[서식 16]
			2차 2026. 11. 20.(금)	
18	• 척추옆굽음증 2차 검진 결과 및 정산서		2026. 12. 18.(금)	[서식 17]
19	• 학생 불균형 체형 예방 프로그램 운영 – 신청서 제출 – 보고서 제출	2026. 03. 13.(금) 2026. 11. 20.(금)		[서식 18]
20	• 자동심장충격기 사용에 따른 조치현황 보고	자동심장충격기 사용 시		[서식 19]
21	• 학교보건(건강관리) 분야 유공자 표창	추후 안내		

서식 1 대상: 초·중·고(고등기술)·특수·분교(본교에 포함)

보건교육 실시 현황(보건과목 선택 포함)

학교급별	학교명	보건 과목 선택학교수	보건교육 현황 (해당학년 보건수업 총시수 / 해당학년 학급수)						최소 1개학년 17차시 이상 실시 학교수
			1학년	2학년	3학년	4학년	5학년	6학년	
초									
중									
고									
특수									
각종									

※ 2022개정교육과정 적용 학년은 16차시 이상

※보건교육 현황: 교과 또는 창의적 체험활동 시간을 이용하여 실시한 연평균 학급당 보건수업 평균 시수

서식 2 대상: 초·중·고(고등기술)·특수·각종(드림, 다사랑)·분교(본교에 포함)

학생 건강증진 교육 실시 현황

1. 교육실시 학교

지역	학교급	학교명 (정식 명칭)	구분	교육실시 여부	유관기관 협력 교육 실시 여부 (보건소, 약사회, 병원 등)	별도 프로그램(사업) 운영 여부
				실시: 1 미실시: 0	실시: 1 미실시: 0	실시: 1 미실시: 0
			마약류			
			흡연예방			
			음주예방			
			기타 약물 오남용 예방			
			건강한 체중관리 (저체중 및 비만 예방)			
			구강관리교육			
			감염병 예방			

※학생을 대상으로 수업시간, 방송교육, 강당 등에서 실시한 교육을 모두 포함(단순 자료 배포는 제외)

2. 마약류를 포함한 약물 오남용 예방교육

지역	학교급	학교명 (정식 명칭)	마약류 단독 주제 연간 예방교육 실시 시간			마약류를 포함한 약물오남용 연간 예방교육 실시 시간			
			1~2시간	3~4시간	5시간 이상	5시간	6시간	7시간	8시간 이상
	초								
	중								
	고								
	특								
	각종								

[참고]

* 마약류를 포함한 약물오남용 예방교육 : 마약류 예방 단독 주제의 교육, 마약류가 포함된 약물 오남용 예방교육, 유해약물 예방교육 등을 모두 포함하는 약물 오남용 예방교육

서식 3

보조인력 채용현황('26. 4. 1.)

지역	학교급	학교명	보조인력 채용 인원 수	채용 목적			
				희귀질환	중증 난치질환	1형 당뇨 학생지원	그 외의 질병이나 장애학생 지원

※ 희귀질환학생: 「희귀질환관리법」제2조, 중증난치질환학생:「본인일일부담금 산정특례에 관한 기준」 별표4의2

서식 4

출장검진·1개 검진기관 승인 요청

학교급	학교명 (정식명칭)	검진 분야	승인 구분	건강검진 대상 학생수			학교 소재지	국민건강 보험공단의 건강검진기관 확인 여부(O, X)	사 유
				1학년	4학년	계			
		의과+구강	출장검진						
		구강	1개 검진기관						

1) 검진분야: 의과, 구강, 의과(구강 포함) 구분하여 작성 (구강검진은 중·고등학교에 한해 승인 신청함)
- 의과: 구강검진은 2개 이상 기관에서 실시하고 의과만 1개 검진기관이나 출장검진을 신청할 경우 '의과'로 기재
- 구강: 의과는 2개 이상 기관에서 검진하고 구강검진만 1개 기관 또는 출장검진을 할 경우 '구강'으로 기재
- 의과 + 구강: 의과와 구강 모두 1개 기관이나 출장검진으로 신청하고자 할 경우 '의과 + 구강'으로 기재

2) 승인 구분: 출장검진, 1개 검진기관 중 선택 (학생 건강검진 기관 선정 완화 승인기준 확인)

3) 분교는 별도학교로 작성하여 신청 (본교, 분교 따로 작성)

4) 사유는 학생 건강검진 기관 선정 완화 승인기준에 부합되는지 확인

※ 제출방법 및 승인: 각급 학교는 관할 교육지원청으로 정해진 기한 내 제출, 교육장이 승인

서식 5 대상: 초·중·고(고등기술)·특수·긱종(드림, 다사랑)·분교(본교에 포함)

학생 1·4학년 건강검진(2·3·5·6학년 구강검진 포함) 및 별도검사 추진 현황

1. 건강검진 관련 공통사항 작성

지역	학교급	학교명	1. 건강검진 관련 공통사항 작성 (모든학교 작성)											
	초·중·고 특수·각종 고등기술 中 택1	정식 학교명 기재	전체 학생 수											
			1학년		2학년		3학년		4학년		5학년		6학년	
			남	여	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여

2. 학생 1, 4학년 건강검진 실시 (의과 + 구강)

지역	학교급	학교명	2. 건강검진 관련 (모든학교 작성)							
	초·중·고 특수·각종 고등기술 中 택1	정식 학교명 기재	건강검진 실시여부	검진완료 학생수 (구강+의과)				검진소요비용 (의과+구강)	
				1학년		4학년			
			실시: 1 미실시: 0	남	여	남	여	1학년 (천원)	4학년 (천원)

3. 구강검진 관련(초2·3·5·6) 학생수

지역	학교급	학교명	3. 구강검진 관련(초2·3·5·6) 학생수(초등학교만 작성)												
	초·중·고 특수·각종 고등기술 中 택1	정식 학교명 기재	초등 구강검진 실시여부	구강검진 완료 학생수											
				2학년			3학년			5학년			6학년		
			실시:1 미실시:0	남	여	검진 소요 비용 (천원)	남	여	검진 소요 비용 (천원)	남	여	검진 소요 비용 (천원)	남	여	검진 소요 비용 (천원)

4. 별도검사 실시현황

지역	학교급	학교명	4. 소변검진 실시								5. 시력검사 실시								6. 결핵검진 실시현황			
	초·중·고 특수·각종 고등기술 中 택1	정식 학교명 기재	소변검사 실시현황								소변검사 실시현황								소변검사 실시현황			
			2학년		3학년		5학년		6학년		2학년		3학년		5학년		6학년		2학년		3학년	
			총검사 인원	총비용 (천원)	총검사 인원	총비용 (천원)	총검사 인원	총비용 (천원)	총검사 인원	총비용 (천원)	총검사 인원	총비용 (천원)	총검사 인원	총비용 (천원)	총검사 인원	총비용 (천원)	총검사 인원	총비용 (천원)	총검사 인원	결핵 학생수 (결핵확진 또는 의심되어 치료중인 (치료를 받은) 학생, 폐결핵에 한함	총검사 인원	결핵 학생수 (결핵확진 또는 의심되어 치료중인 (치료를 받은) 학생, 폐결핵에 한함

[참고]

※ 전체 학생수, 검진학생수: 제출 당시 나이스에 있는 학생 수 기준
- 학교수에 본교만 기재
- 학생수 = 본교의 학생수 + 분교의 학생수

※ 각종학교: 드림학교는 '각종' 학교에 기입, 여해/다사랑학교는 학교수 불포함, 학생수는 원적교에 포함시켜 과정별 산출

서식 6 대상: 초·중·고(고등기술)·특수·각종(드림, 다사랑)·분교(본교에 포함)

학생 건강검사 결과처리 현황 (학생수: 보고당일 기준)

1. 학년초 학생건강증진 계획 수립시 전년도 건강검사 결과 반영 현황 및 학생건강검진(구강검진) 결과에 따른 조치현황

지역	학교급	학교명	1. 학년초 학생건강증진 계획 수립시 전년도 건강검사 결과 반영 현황		2. 학생건강검진(구강검진) 결과에 따른 조치현황	
	초·중·고 특수·각종 中 택1	정식 학교명 기재	1. 학년도 건강증진계획* 수립 학교 (전년도 건강검사 결과 반영)	2. 학년초 건강검진계획** 수립 학교	검진결과이상소견*** 학생이 있는 학교수	이상소견 학생에 대하여 조치한 학교
			※ 수립: 1, 미수립: 0	※ 수립: 1 미수립: 0	※ 이상소견 있는 학교의 경우: 1	※ 이상소견 학생에 대하여 조치한 경우: 1 (학부모통보, 학교 내 상담, 의료기관 연계)

* 건강증진계획: 전년도 건강검사의 결과를 평가하여 이를 바탕으로 학생건강증진계획 수립·시행(학교보건법 제7조의2 3항 의거), 수립시기는 학교장이 결정 (학기초 학교보건운영계획 내 포함 가능)
** 건강검진계획: 만족도 등 작년 건강검진 실시 현황을 참고하여 학생 건강검사에 필요한 소요 예산을 포함한 구체적인 실시 계획을 매년 3월말까지 수립·시행(2022년 학생 건강검진 추진계획 의거)
→ 모든 학교는 학교보건법 및 충남교육청 계획에 의거하여 건강증진계획, 건강검진계획 수립하고 추진하여야 함

2. 학생건강검진 관련 민원발생 현황

지역	학교급	학교명	3. 학생건강검진 관련 민원발생 현황	
	초·중·고 특수·각종 中 택1	정식 학교명 기재	민원발생 여부****	민원발생 조치 여부*****
			※ 발생교: 1, 미발생교: 0	※ 조치교: 1, 미조치교: 0

[참고]

※ 학생수: 제출 당시 나이스에 있는 학생수 기준
※ 각종학교 – 드림학교: '각종' 학교에 기입 – 여해/다사랑학교: 학교수 불포함, 실적은 원적교에서 작성
*** 검진결과 이상소견: 학교건강검진 결과 판정 및 기재방법 등에 관한 기준 별표2)에 따른 "정상(경계)" 및 "정밀검사 요함" 판정
**** 민원발생 사유: 형식적 검진, 긴 대기 시간, 계약한 검진기관 수 부족, 검진기관과의 거리, 추가검진 권유 등
***** 민원발생조치: 검진기관 통보하여 시정, 검진기관 변경, 검진기 추가 등 조치한 경우

서식 7 대상: 초·중·고(고등기술)·특수·각종(드림, 다사랑)·분교(본교에 포함)

학생건강검진 통계표 (학생 수: 제출 당시 나이스에 있는 학생 수 기준)

학교급	학교명(정식명칭)	학년	성별	검진대상학생수	검사인원	기본항목검사결과														각종검사결과									
						눈			귀		콧병	목병	피부병	구강			혈압	소변		혈액1 - 경도비만 이상(초4~고)					혈액2 -고1 여자		결핵 - 중 · 고	
						착추	시력		안질환	청력장애				충치	치주질환	부정교합	고혈압	요단백	요잠혈	검사인원	혈당(식전)	총콜레스테롤	HDL, 중성지방, LDL 계산값	AST, ALT	검사인원	혈색소	검사인원	결핵
							교정대상	교정한 학생수																					
		초1	남																										
			여																										
		초4	남																										
			여																										
		중1	남																										
			여																										
		고1	남																										
			여																										

※검진 대상 학생수, 검사인원: 제출 당시 나이스에 있는 학생 기준
※초·중·고·특수·각종학교 포함 과정별 산출 작성
※이 통계표는 항목별 질환 또는 이상이 있는 학생수만 기재합니다.
– 시력의 교정대상은 어느 한쪽의 맨눈 시력이 0.7이하인 학생수를 기재합니다.
※허리둘레 측정 결과는 학생 건강관리를 위한 참고자료로 활용하며, 학생건강검진 통계표에는 검사인원만 기재합니다.

서식 8 대상: 초·중·고·고등기술·분교(본교에 포함)

학생 흡연·음주·약물오남용 실태 보고

지역	학교급	학교명	전체 학생수			조사 학생수			흡연 학생수			흡연율(%)			전자담배 사용학생수			전자담배 흡연율(%)			흡연경험 학생수			음주 학생수			음주율(%)			약물오남용 학생수			약물 오남용율(%)			흡연실 설치유무
			남	여	계	남	여	계	남	여	계	남	여	계	남	여	계	남	여	계	남	여	계	남	여	계	남	여	계	남	여	계	남	여	계	설시:1, 미설치:0

[참고]
* 학교급: 초·중·고
* 전체 학생수: 조사 대상 학년의 전체 학생수 (초 4~6학년 학생수, 중·고 1~3학년 학생수)
* 흡연율 = 흡연 학생수/조사 학생수 × 100 [참고자료. 학생 흡연·음주·약물오남용 설문지 4문항 참고]
*전자담배 사용율=전자담배 사용 학생수/조사학생수x100 [참고자료 2 학생 흡연·음주·약물오남용 설문지 8문항 참고]
* 음주율 = 음주 학생수/조사 학생수 × 100 [참고자료, 분자–학생 흡연·음주·약물오남용 설문지 14번 ②~⑦ 답변 학생 수]
* 약물오남용율 = 약물오남용 학생수/조사 학생수 × 100 [참고자료 2, 분자–학생 흡연·음주·약물오남용 설문지 16번 ② 답변 학생 수]
* 조사대상: 초4~6학년, 중·고 1~3학년

서식 9-1 대상: 초·중·고·특수·고기·각종·분교 (본교에 포함)

당뇨 등 학생 재학 및 지원현황

지역	학교급	학교명	보건교사 배치여부	당뇨 전체학생수	3. 당뇨 학생에 대한 학교의 지원현황 (당뇨 재학에 체크한 학교만 작성)					
	초·중·고 특수·각종 고등기술 中 택1	정식 학교명 기재	보건교사 배치 여부 (배치, 미배치)	당뇨 총 학생수	가. 전체현황 * 당뇨 재학 학생 중 (A)와 (B)에 해당되는 학생수를 각각 기재		나. 지원 항목별 학생수 (※ 중복표기가능) – <가의 전체현황>에 해당되는 학생들을 지원 항목별로 기재			
					학교의 지원을 받는 학생수(A)	보호자가 지원을 요청한학생수(B) (A)와 (B)의 수는 다를 수 있음	구분	학교의 지원을 받는 학생수(A)	보호자가 지원을 요청한 학생수 (B)	보호자의 지원요청 대비 지원 학생수* * 보호자가 지원을 요청한 학생에 대하여 학교가 지원하고 있는 학생수 * 보호자가 지원을 요청한 학생수보다, 학교의 지원을 받는 학생수가 많을 수 있음
							직접 주사			
							주사 보조			
							투약장소 제공			
							혈당 체크			
							인슐린 보관			
							글루카곤 보관			
		계					직접 주사			
							주사 보조			
							투약장소 제공			
							혈당 체크			
							인슐린 보관			
							글루카곤 보관			

[참고]

<지원항목>

1) 직접주사: 보건교사가 인슐린 주사를 직접투약 (학생 본인의 자가투약은 포함하지 않음)

2) 주사보조: 학생이 인슐린 자가 주사를 할 때 주사행위 지도

3) 투약장소 제공: 보건실 등 별도의 공간에서 인슐린 자가 주사를 할 수 있도록 장소 제공

4) 혈당체크: 보건교사 등이 직접 정기적으로 혈당을 측정해줌

5) 인슐린 보관: 학교에서 인슐린을 보관하여 줌

6) 글루카곤 보관: 학교에서 글루카곤을 보관하여 줌

서식 9-2 대상: 초·중·고·특수·고기·각종·분교 (본교에 포함)

당뇨·아나팔락시스 학생 재학 및 지원현황

지역	학교급	학교명	보건교사 배치여부	2. 당뇨 학생 정보						
	초·중·고 특수·각종 고등기술 中 택1	정식 학교명 기재	보건교사 배치여부 (배치, 미배치)	학년	성별	당뇨Type (1형, 2형)	혈당조절정도 (상·중·하) ※ 보건교사가 판단한 당조절정도, 혈당조절이 잘 되는 경우: 상	돌봄난이도 (상·중·하) ※보건교사가 판단한 학생 돌봄의 난이도, 학생관리가 수월한 경우: 하	혈당 체크 ※ 학교에서 혈당 검사하는 횟수	인슐린주사횟수 ※ 학교에서 인슐린 주사 횟수

지역	학교급	학교명	보건교사 배치여부	3. 아나필락시스* 학생 정보						
	초·중·고 특수·각종 고등기술 中 택1	정식 학교명 기재	보건교사 배치여부 (배치, 미배치)	학년	성별	에피네프린 펜 학교 보관 여부	아나필락시스 shock(쇼크) 유발요인 (해당사항에 1표시, 중복표시 가능)			
						보관: 1 보관하지않음 :0	음식	약물	운동	기타

[참고]

* 아나필락시스: 병원에서 진단을 받았거나, 아나필락시스 쇼크로 기절, 호흡곤란 등의 증상이 심각하게 일어난 경험이 있는 학생에 한하여 작성함

서식 9-3 대상: 초·중·고·특수·고기·각종·분교 (본교에 포함)

희귀난치병 등 학생 재학 및 지원현황 (세부내용)

지역	학교급	학교명	보건교사 배치여부					
	초·중·고 특수·각종 中 택1	정식 학교명 기재	보건교사 배치여부 (배치:1 미배치:0)	지원 항목별 학생수 (※ 중복표기 가능)				
				구분	재학 학생수	학교의 지원을 받는 학생	보호자가 지원을 요청한 학생수 (B)	보호자의 지원요청 대비 지원 학생수* * 보호자가 지원을 요청한 학생에 대하여 학교가 지원하고 있는 학생수 * 보호자가 지원을 요청한 학생수보다, 학교의 지원을 받는 학생수가 많을 수 있음
				1. 희귀난치성 질환				
				2. 석션(기도흡인)				
				3. 인공도뇨				
		계		1. 희귀난치성 질환				
				2. 석션(기도흡인)				
				3. 인공도뇨				

서식 9-4 대상: 초·중·고·특수·고기·각종·분교 (본교에 포함)

희귀난치병 등 학생 재학 및 지원현황 (세부내용)

지역	학교급	학교명	보건교사 배치여부	희귀난치병 현황		
	초·중·고 특수·각종 中 택1	정식 학교명 기재	보건교사 배치여부 (배치, 미배치)	학년	성별	질환명(진단명) * 해당 학생의 희귀난치병 질환명(진단명)을 적어주세요.

* 충청남도교육청 부서별 홈페이지 – 체육건강과 – 학교보건 자료실 – 희귀질환으로 검색 희귀질환 목록확인 후 진단명으로 기재

서식 10-1 대상: 초·중·고·특수·고기·각종·분교(본교에 포함)

학교 심폐소생술 교육 실시 현황(학생)

■ 학생 교육 실시현황

지역	학교급	학교명	전체 학생수	학생 심폐소생술 교육 현황																			
				1학년			2학년			3학년			4학년			5학년			6학년				
				교육실시 여부	교육대상 학생수 (A)	교육실시 학생수 (B)	교육실시 여부	교육대상 학생수 (A)	교육실시 학생수 (B)	교육실시 여부	교육대상 학생수 (A)	교육실시 학생수 (B)	교육실시 여부	교육대상 학생수 (A)	교육실시 학생수 (B)	교육실시 여부	교육대상 학생수 (A)	교육실시 학생수 (B)	교육실시 여부	교육대상 학생수 (A)	교육실시 학생수 (B)		

■ 교육방법 및 교육실시자(학생)

지역	학교급	학교명	교육방법 ('1'표시, 중복기재 가능)		교육실시자(강사) ('1'표시, 중복기재 가능)					
			학교자체 교육	외부기관 위탁	학교자체 교육			외부기관		
					보건교사	체육교사	기타 교직원	소방서 등 공공기관	민간기관	기타 (개인활동 강사 등)

* 반기별 실적제출 (6월, 12월)
* 12월 실시현황 보고: 누적보고
* 1개 학년 이상 실습 포함 심폐소생술 실시
  – 교육실시 학년: 심폐소생술을 교육 대상으로 선택한 학년

* 교육방법: 교육 병행했을 경우 중복기재 가능

서식 10-2 대상: 초·중·고·특수·고기·각종·분교(본교에 포함)

학교 심폐소생술 교육 실시 현황(교직원)

■ 교직원 교육 실시현황

지역	학교급	학교명	교직원 심폐소생술교육현황				교육방법 ('1'표시, 중복기재 가능)						교육실시자(강사) ('1'표시, 중복기재 가능)					
			교육실시여부	교육대상 교직원 (D)	교육이수 교직원 (E)	교 육 이수율 (F=E/D)	학교 자체 교육	외부기관 위탁					학교자체 교육			외부기관		
								교육(지원)청 연수원 포함	공공 기관	의료 기관	대학	민간 기관 등	보건 교사	체육 교사	기타 교직원	소방서 등 공공기관	민간 기관	기타 (개인활동 강사 등)

* 교직원 심폐소생술 교육 현황
 - 심폐소생술 교육 대상 교직원
  ① 모든 교원(기간제 교사 포함)
  ② 학교운동부 지도자, 스포츠 강사 등 학교 스포츠 활동과 관련된 사람
  ③ 교육감 소속의 일반직 공무원(그 밖의 교직원에 대한 교육 여부는 학교장이 해당 교직원의 학생 교육 참여 정도를 고려하여 교육대상 선정)
 - 교직원 심폐소생술 이수 조건: 이론과 실습 각 2시간이나, 이론 + 실습의 경우 최소 3시간 이상 교육
 - 교육 이수율(%): 교육이수 교직원수(E) / 교육대상 교직원수(D)*100
* 교육방법: 교육 병행했을 경우 중복기재 가능

서식 11 대상: 초·중·고·특수·고기·각종·분교(본교에 포함)

보건실 설치 현황

급별	설립별	학교명	보건교사 배치여부 (해당란에 '1'로 기재)		보건실 면적 (㎡)	보건실 설치 여부 (해당란에 '1'로 기재)		보건실 설치 시 운영 형태 (해당란에 '1'로 기재) A=B+C		보건교육실 현황 (해당란에 '1'로 기재)	비고
			배치	미배치		설치(A)	미설치	독립(B)	통합(C)	독립	

1. 독립: 보건실 용도로만 사용하는 공간이 있는 경우
2. 통합(다른교실과 병용): 보건실과 상담실로 같이 사용하는 등 한 공간에 여러 개의 실명이 있는 경우(※ 비고란에 '공동사용 실명' 기재)
3. 보건교육실의 경우 독립된 형태로 운영하는 학교만 기재

서식 12 대상: 초·중·고·특수·고기·각종

학생 감염병 예방·관리 계획 수립 현황

지역	학교급	학교명	학생 감염병 예방관리계획		비고
			학생 감염병 관리조직 (구성: 1, 미구성: 0)	감염병 예방 활동 계획 (수립: 1, 미수립: 0)	

* 교육지원청에서는 비고란에 미수립(미구성) 학교에 대한 지도내용 포함 작성.

서식 13 대상: 초·중·고·특수·고기·각종

학교 방역물품 비축현황

지역	학교급	학교명	학급수	학생수	방역물품 비축현황												비고
					체온계		의료용 장갑		마스크				알콜 손 소독제		소독약품(락스)		
									일회용		방역용(KF80 이상)						
					비축기준	비축수량	비축기준	비축수량	비축기준	비축수량	비축기준	비축수량	비축기준	비축수량	비축기준	비축수량	

* 작성방법
 - 학급수(특수학급 포함 작성), 학생수: 3.1.자/ 9. 1.자 학급편성 기준 적용
 - 비축기준은 [참고자료 24]에 의거 작성
 - 의료용 장갑: 라텍스 또는 니트릴 장갑을 말하며, 비닐장갑은 제외

– 교육지원청에서는 비고란에 비축기준 미달 학교에 대한 지도내용 포함 작성.

서식 14 대상: 초·중·고(고등기술학교 포함)·특수·각종

[감염병명] 발생에 따른 [조치현황/언론취재] 보고

< '25. 00. 00( ), 00교육지원청 >

◆ 보고 시기
○ 감염병 발생으로 역학조사를 실시한 경우
○ 교내 감염병 발생으로 인해 긴급 방역조치, 언론보도 등의 특이사항 발생 시
(법정, 비법정 구분없이 모든 감염병 대상)

◆ 보고 방법: 서면보고 원칙(사안에 따라 시급을 요하는 경우 유선보고 후 서면보고)

◆ 보고체계: 학교 → 교육지원청 → 교육청

□ 학교 현황

학교명	소재지	학교 규모		담당자(성명/연락처)		비고
		학생수	교직원수	학교	교육지원청	

□ 감염병 발생 및 역학조사 현황
(※ 작성 예시, 보고 내용 및 서식은 감염병 발생 상황에 따라 수정 가능)

역학조사 실시일	감염병명	발생 인원			나이스 보고일**	보건소 신고일**	다음 역학조사일
		환자수	직업	학년/반 (인원수)*			
'25.11.18.	*백일해*	*1*	*학생*	*2-1(1)*	*'25.11.18.*	*'25.11.18.*	*'25.11.129.*
'25.11.13	*결핵*	*1*	*학생*	*2-3 담임(1)*	*해당없음*	*'25.11.15.*	*미정*

* 교직원의 경우 직급, 담임 여부, 교과목 등을 기재
** 동일 감염병에 대하여 반복하여 보고(신고)한 경우 최초 보고(신고)일과 최종 보고(신고)일을 기재

□ 역학조사 결과보고 *(※ 작성 예시, 보고 내용 및 서식은 역학조사 상황에 따라 수정 가능)*

역학조사 실시일	조사단계	조사자 현황			조사결과	비고 (조치사항)
		직업	학년/반	조사인원		
3. 20.	*최초*	*학생*	*2-1*	*30*	*백일해 1명*	*백일해 환자가 발생한 학급*
		교원	*2-1담임*	*1*		

□ 기타 특이사항
○ *(학부모 설명회 개최, 민원 사항 등 특이사항이 있을 시 기재)*

□ 언론취재 상황
○ *(취재일, 취재 언론사, 취재내용, 언론사에 대응한 담당자 등 기재)*

서식 15-1

비만예방사업「움직이는 교실! 건강한 학교!」운영교 신청서

지역	학교급	학교명	소규모 단체명	체질량지수 사전 검사 결과						활동예정 내용					담당교사 정보			
				참여 인원수	사전 검사					해당사항에 1표시					성명	교과	사무실 번호	핸드폰 번호
					저체중	정상	과체중	비만	비만율 (%)	가정 연계	사제 동행	지역 사회 연계	특색 운동	기타				
서산	초	OO 초등학교	아줌숨 교실	20	5	10	10	5	16.6%	1		1	1		홍길동	초등	041-	010-
홍성	중	OO 중학교	움직 교실								1	1			김사랑	보건		
금산	고	OO 고등학교	건행모임 (건강,행복)								1	1			나사랑	영양		
천안	특수	OO학교										1	1		다사랑	수학		

※ 활동예정 내용 설명
- 가정연계: 가정과 연계하여 비만예방 활동실시 (예-가정통신문, 학부모 교육, 만보기 등을 활용한 부모연계 교육)
- 사제동행: 선생님과 학생이 함께하는 비만예방 활동실시 (예-선생님과 함께 운동하기, 교사도 함께 운동 등 참여)
- 지역사회 연계: 보건소 비대면 모바일 헬스케어 활동 참여, 국민건강보험공단 등 지역사회 연계 활동 실시
- 특색활동: 담당교사가 주관이 되어 특색 운동프로그램 운영 (예시-맨발걷기, 아침 줄넘기 하기 등)

서식 15-2

활동참여 학생 비만율 통계 (운영교 참여-필수제출-자료집계)

지역	학교급	학교명	소규모 단체명	체질량지수 검사 결과												
				검사 인원수		사전 검사 3~4월 중						사후 검사 (10월 이후 검사)				
	초 중 고 특수 각종 中 택1	정식 학교명 기재		남	여	저체중	정상	과체중	비만	비만율 (%)		저체중	정상	과체중	비만	비만율 (%)
서산	초	OO 초등학교	아줌숨 교실	15	15	5	10	10	5	16.6%		5	15	8	2	6.6%
홍성	중	OO 중학교	움직 교실													
천안	고	OO 고등학교	건행모임(건강,행복)													
천안	특수	OO학교														
천안	각종	OO학교														

※ 비만율(저체중, 정상, 과체중, 비만) 은 체질량지수의 성장도표 백분위수(보건복지부, 소아청소년 성장도표, 2017) 기준으로 작성

서식 15-3

「움직이는 교실! 건강한 학교!」비만예방사업 정산서 (운영교 참여-필수제출-자료집계)

연번	지역	학교급	학교명	교부액	학교예산	총집행액	항목	세부내역	집행금액	비고
1	홍성	초	OO초등학교	1,500,000	0	1,500,000	교육·활동 운영	발목 줄넘기 20개*5000원	100,000원	

※ 정산서
- 교부액: 총 예산 기준
- 비만예방사업 세부 지출내용 기재
- 업무추진비 5% 이내 사용 가능
- 잔액 발생되지 않도록 기재

서식 16

척추옆굽음증 2차 검진비 지원 신청자 명단(서식)

연번	지역	학교명	학생 정보			학교 담당자		2차검진비 신청 (해당란에 '1'기재)		2차검진 결과	보조기 지원 신청	
			학반	성별	성명	성명	연락처	단순 검사 (X-ray)	정밀 검사 (MRI 등)	진단소견	의사처방 (보조기명)	생활정도
1	*홍성*	*OO초등학교*	*3-5*	*남/여*	*김OO*	*김OO*	*000-0000-0000*	*1*		*만곡 각도 20도*	*밀워키 보조기*	*저소득 가정 학생*
2	*예산*	*OO초등학교*	*3-5*	*남/여*	*손OO*			*1*	*1*	*만곡 각도 30도*		*치료비가 많이 필요한 학생*

※ 제출기한(교육지원청에서 수합 제출일)
- 1차: 2025. 7. 4.(금) / - 2차: 2025. 11. 21.(금)

※ 2차 검진 시 CT, MRI를 실시한 학생은 정밀검사가 필요하다는 의사의 소견이 기재되어 있어야 지원 가능
- 진단에 의한 검사만 인정하고 본인 희망에 의한 검사는 불인정
- 사전 안내 철저

※ 보조기 지원
- 선정 기준 ▸만곡도가 심해 보조기를 꼭 해야 하는 저소득 가정 학생
  ▸척추옆굽음증 이외에 다른 질병도 있어 치료비가 많이 필요한 학생
- 의사 소견서를 정확하게 확인 후 신청, 심사를 위한 추가 자료를 요청할 수 있음

서식 17

척추옆굽음증 2차 검진 결과 및 정산서(서식)

연번	지역	학교급	학교명	정산서				검진결과					비고
				교부액 (단위:원)	항목	세부내역	집행금액	대상학생			2차검진 결과		
								학반	*성별*	*성명*	*진단소견*	*추구관리*	
1	*홍성*	*초*	*OO 초등 학교*	*550,000*	*정밀 검사*	*450,000원*1회*	*450,000*	*3-5*	*남/여*	*김OO*	*만곡 각도가 20도*	*X-ray 촬영 및 경과관찰 바른자세교육*	
					단순 방사선 및 진료	*5,000원*1회*	*5,000*	*3-5*	*남/여*	*손OO*	*만곡 각도가 30도*	*정밀검사 실시 OO대학병원에서 경과관찰*	
					커브 의자	*25,000원*1개*	*25,000*						

※ 정산서
- 교부액: 총 예산 기준
- 2차 검진 비용 세부 지출내용 기재
- 검사비 지출 후 잔액 발생 시 척추 건강 예방(교육)활동 또는 해당 학생 필요 물품 지급 가능(세부내역 정산서 기재)

※ 검진결과
- 개인별 지원 내역 기재

서식 18

학생 불균형 체형 예방 프로그램 운영교 신청서(서식)

지역	학교급	학교명	실태 (2022 척추옆굽음증 의심 학생 수)	활동예정 내용 해당사항에 1로 표시				담당교사 정보				비고
				가정 연계	사제 동행	지역사회 연계	특색	성명	교과	사무실 번호	핸드폰 번호	
금산	*초*	*00학교*	*10*	*1*	*1*		*1*	*나우리*	*보건*	*041-*	*010-*	
천안	*중*	*00고등학교*	*20*	*1*	*1*	*1*	*1*	*홍길동*	*체육*			

※ 활동예정 내용 설명
- 가정연계: 가정과 연계하여 올바른 성장교육 활동실시 (예-가정통신문, 학부모 교육 등을 활용한 부모연계 교육)
- 사제동행: 선생님과 학생이 함께하는 올바른 성장교육 활동실시 (예-선생님과 함께 운동하기, 교사도 함께 운동 등 참여)
- 지역사회 연계: 보건소 비대면 모바일 헬스케어 활동 참여, 국민건강보험공단 등 지역사회 연계 활동 실시
- 특색활동: 담당교사가 주관이 되어 특색 운동프로그램 운영 (예시-체형측정 검사, 스트레칭, 아침 줄넘기 하기 등)

※ 학생 불균형 체형 예방교육자료「영상표시단발기 증후군 이해과 대처」(2022. 11. 배부) 및「세계 최강 거북목」(2023. 12.) 활용

서식 19 대상: 초·중·고(고등기술학교 포함)·특수·각종

[자동심장충격기] 사용에 따른 [조치현황] 보고

< '26. 00. 00( ), 0000학교 >

◆ 보고 시기: 응급상황 발생 시 자동심장충격기(AED) 사용 후 보고
◆ 보고 방법: 서면 보고 원칙 (사안에 따라 시급한 경우 유선 보고 후 서면 보고)
◆ 보고 체계: 학교 → 교육지원청 → 교육청

□ 학교 현황

학교명	지역(00시 00면)	학교 현황			보고자 정보			비고
		학급 수	학생 수	학교장 성명	성명	직위	연락처	

□ 사고 발생 현황

(※ 작성 예시, 보고 내용 및 서식은 사고 발생 상황에 따라 수정 가능)

사고 발생 일시	장소	심정지 의심 학생				보호자연락		최초목격자		
		학년 반	이름	생년월일	성별	보호자 연락시간	보호자 도착시간	직위	이름	발견시간
'26.4.18. 11:20							*(학교, 병원)*			

□사고발생에 따른 조치

○심정지 의심 학생 활력징후 및 의식 상태, 초기 응급처치, *심폐소생술 실시 여부 등 기술)*

□ 자동심장충격기 사용 및 119 신고

AED 기기 사용				AED상태		충격 시행 횟수	AED 사용 후 상태			119신고		병원 이송			
설치 장소	사용 장소	시작 시간	종료 시간	정상	이상		호전	변화 없음	악화	119 신고일시	119 도착일시	이송 여부	이송 수단	동승자	이송병원 및 도착시간

□ 기타 특이사항

○ *(심정지 의심자의 병력, 의식 회복시간, 병원에서의 조치 등 기재)*

□ 언론취재 상황

○ *(취재일, 취재 언론사, 취재내용, 언론사에 대응한 담당자 등 기재)*



건강하고 행복한 학교 만들기를 위한

2026 건강관리업무

지도위원	이 은 상 (충청남도교육청 체육건강과 과장)
총 괄	염 은 영 (충청남도교육청 체육건강과 팀장) 이 은 영 (충청남도교육청 체육건강과 장학사) 윤 남 영 (충청남도교육청 체육건강과 보건교사)
편집· 개발위원	강 미 라 (내포초등학교 보건교사) 최 지 혜 (천안성성초등학교 보건교사) 강 정 희 (아산스마트팩토리마이스터고등학교 보건교사)

발 행 일	2026년 2월
발 행 처	충청남도교육청 (우) 32255 충청남도 홍성군 홍북읍 선화로 22 http://www.cne.go.kr
자료탑재	충청남도교육청누리집 (체육건경과/학교보건)